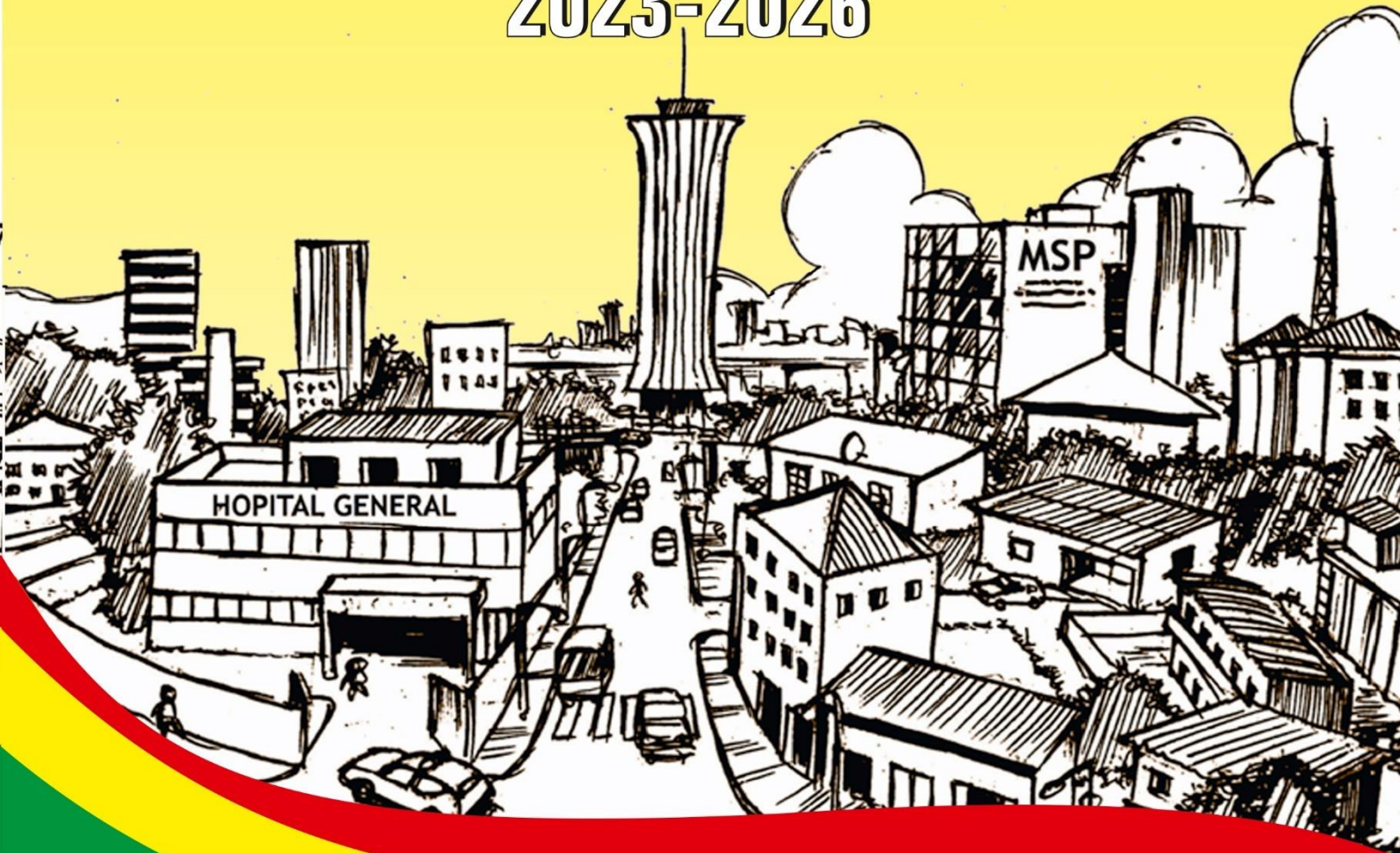


REPUBLIQUE DU CONGO  
MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION



# PLAN NATIONAL DE DEVELOPPEMENT SANITAIRE 2023-2026





## TABLE DES MATIERES

|                                                                                      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>RECONNAISSANCES .....</b>                                                         | <b>10</b> |
| <b>LISTE DES ABREVIATIONS .....</b>                                                  | <b>14</b> |
| <b>GLOSSAIRE DES TERMES TECHNIQUES UTILISES.....</b>                                 | <b>17</b> |
| <b>PREFACE.....</b>                                                                  | <b>21</b> |
| <b>LISTE DES TABLEAUX .....</b>                                                      | <b>22</b> |
| <b>LISTE DES FIGURES .....</b>                                                       | <b>22</b> |
| <b>RÉSUMÉ.....</b>                                                                   | <b>23</b> |
| <b>INTRODUCTION .....</b>                                                            | <b>25</b> |
| <b>CHAPITRE I : METHODOLOGIE D'ELABORATION DU PNDS 2023-2026 .....</b>               | <b>26</b> |
| I.1. Phase préparatoire.....                                                         | 26        |
| I.2. Phase d'élaboration proprement dite .....                                       | 26        |
| <b>CHAPITRE II : PROFIL DU PAYS.....</b>                                             | <b>28</b> |
| II.1. Contexte géographique et démographique .....                                   | 28        |
| II.1.1. Contexte géographique .....                                                  | 28        |
| II.1.2. Contexte démographique .....                                                 | 29        |
| II.2. Contexte politique et administratif .....                                      | 30        |
| II.2.1. Situation politique .....                                                    | 30        |
| II.2.2. Situation administrative.....                                                | 30        |
| II.3. Contexte socio-économique .....                                                | 30        |
| II.3.1. Situation économique et financière .....                                     | 31        |
| II.4. Contexte international .....                                                   | 31        |
| <b>CHAPITRE III : SYSTEME DE SANTE .....</b>                                         | <b>33</b> |
| III.1. Organisation du système de santé .....                                        | 33        |
| III.1.1. Organisation administrative.....                                            | 33        |
| III.1.2. Organisation de l'offre des prestations de soins et services de santé ..... | 34        |
| III.1.2.1. Premier échelon .....                                                     | 34        |
| III.1.2.2. Deuxième échelon .....                                                    | 36        |
| III.1.2.3. Troisième échelon.....                                                    | 37        |
| III.1.2.4. Programmes et projets de santé .....                                      | 38        |
| III.1.2.5. Médecine traditionnelle .....                                             | 39        |
| III.2. Performances du système de santé .....                                        | 39        |
| III.2.1. Gouvernance, leadership et pilotage du système de santé.....                | 39        |

|                                                                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| III.2.1.1. Cadre juridique du secteur de la santé.....                                                              | 39 |
| III.2.1.2. Politique Nationale de Santé et planifications stratégiques .....                                        | 40 |
| III.2.1.3. Engagements nationaux et internationaux.....                                                             | 40 |
| III.2.1.4. Coordination du système de santé .....                                                                   | 41 |
| III.2.1.5. Décentralisation des services.....                                                                       | 42 |
| III.2.2. Financement du Secteur .....                                                                               | 42 |
| III.2.2.1. Dépense totale de santé (DTS) .....                                                                      | 43 |
| III.2.2.2. La mobilisation des ressources.....                                                                      | 43 |
| III.2.2.3. Financement basé sur la performance (PBF) .....                                                          | 45 |
| III.2.2.4. Accessibilité financière et géographique aux soins et services de santé.....                             | 45 |
| III.2.2.5. Assurance maladie universelle en République du Congo .....                                               | 46 |
| III.2.3. Coopération et partenariat .....                                                                           | 47 |
| III.2.4. Système national d'information sanitaire (SNIS) .....                                                      | 48 |
| III.2.4.1. Gestion de l'information de routine .....                                                                | 48 |
| III.2.4.2. Carte sanitaire .....                                                                                    | 49 |
| III.2.4.3. Enquêtes et études sectorielles .....                                                                    | 50 |
| III.2.4.4. Fonctionnalité des bulletins .....                                                                       | 50 |
| III.2.4.5. Recherche en santé .....                                                                                 | 50 |
| III.2.4.6. Surveillance épidémiologique .....                                                                       | 51 |
| III.2.4.7. Processus de digitalisation .....                                                                        | 51 |
| III.2.5. Ressources humaines en santé (RHS).....                                                                    | 52 |
| III.2.5.1. Gestion des ressources humaines en santé (RHS) .....                                                     | 52 |
| III.2.5.2. Densité du personnel de santé .....                                                                      | 53 |
| III.2.5.3. Cadre organique et de gestion prévisionnelle des RHS .....                                               | 54 |
| III.2.5.4. Projection des besoins en personnels de santé .....                                                      | 54 |
| III.2.5.5. Production des ressources humaines de santé .....                                                        | 54 |
| III.2.5.6. Formation continue des RHS.....                                                                          | 56 |
| III.2.6. Médicaments, vaccins, produits sanguins et technologies.....                                               | 56 |
| III.2.6.1. Approvisionnement, stockage et distribution des médicaments et autres produits de santé .....            | 56 |
| III.2.6.2. Disponibilité des médicaments essentiels et génériques (MEG) dans les formations sanitaires (FOSA) ..... | 57 |
| III.2.6.3. Production locale des médicaments .....                                                                  | 57 |
| III.2.6.4. Vente illicite des médicaments et médicaments contrefaits .....                                          | 58 |
| III.2.6.5. Assurance qualité des médicaments .....                                                                  | 58 |
| III.2.6.7. Approvisionnement en produits sanguins sécurisés.....                                                    | 58 |
| III.2.7. Promotion de la santé.....                                                                                 | 59 |

|                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>CHAPITRE IV : ETAT DE LA SANTE DE LA POPULATION .....</b>           | <b>62</b> |
| IV.1. Principaux indicateurs de santé .....                            | 62        |
| IV.1.1. Espérance de vie .....                                         | 62        |
| IV.1.2. Fécondité .....                                                | 63        |
| IV.1.3. Mortalité générale .....                                       | 63        |
| IV.2. Santé maternelle .....                                           | 64        |
| IV.2.1. Mortalité maternelle et facteurs de risque .....               | 64        |
| IV.3. Santé de l'enfant .....                                          | 65        |
| IV.3.1. Mortalité néonatale .....                                      | 65        |
| IV.3.2. Mortalité infantile .....                                      | 66        |
| IV.3.3. Mortalité infanto-juvénile .....                               | 67        |
| IV.4. Santé des adolescents et jeunes .....                            | 67        |
| IV.5. Santé des personnes âgées .....                                  | 68        |
| IV.5.1. Morbidité et mortalité chez les personnes âgées .....          | 68        |
| IV.6. Santé sexuelle et reproductive .....                             | 69        |
| IV.4. Profil épidémiologique .....                                     | 70        |
| IV.4.1. Maladies transmissibles .....                                  | 70        |
| IV.4.1.1. Le VIH/SIDA .....                                            | 70        |
| IV.4.1.2. La tuberculose (TB) et co-infection TB/VIH .....             | 73        |
| IV.4.1.3. Le Paludisme .....                                           | 75        |
| IV.4.1.4. Les hépatites virales .....                                  | 77        |
| IV.4.2. Maladies non transmissibles .....                              | 77        |
| IV.4.2.1. Maladies cardiovasculaires.....                              | 78        |
| IV.4.2.2. Le diabète .....                                             | 78        |
| IV.4.2.3. Les cancers .....                                            | 79        |
| IV.4.2.4. La drépanocytose .....                                       | 79        |
| IV.4.2.5. Maladie mentale .....                                        | 80        |
| IV.4.2.6. Les maladies bucco-dentaires.....                            | 81        |
| IV.4.3. Maladies évitables par la vaccination .....                    | 81        |
| IV.4.3. 1. Surveillance des maladies évitables par la vaccination..... | 81        |
| IV.4.3. 3. La fièvre jaune .....                                       | 83        |
| IV.4.3. 4. Le Tétanos maternel et néonatal.....                        | 83        |
| IV.4.4. Maladies à potentiel épidémique (MPE).....                     | 83        |
| IV.4.4.1. La rage.....                                                 | 84        |
| IV.4.4.2. La Covid-19 .....                                            | 84        |
| IV.4.4.3. Les gripes.....                                              | 84        |

|                                                                                                 |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| IV.4.4.4. Le chikungunya .....                                                                  | 84         |
| IV.4.4.5. Le Monkey pox .....                                                                   | 84         |
| IV.4.4.6. La maladie à virus Ebola (MVE) .....                                                  | 85         |
| IV.4.4.7. Shigellose, choléra et fièvre typhoïde .....                                          | 85         |
| IV.4.5. Maladies tropicales négligées (MTN) .....                                               | 86         |
| IV.4.5.1. L'onchocercose.....                                                                   | 86         |
| IV.4.5.2. La filariose lymphatique.....                                                         | 86         |
| IV.4.5.3. La schistosomiase .....                                                               | 86         |
| IV.4.5.4. Les géo-helminthiases .....                                                           | 86         |
| IV.4.5.5. La trypanosomiase .....                                                               | 87         |
| IV.4.5.6. La lèpre.....                                                                         | 87         |
| IV.4.5.7. Le pian .....                                                                         | 87         |
| IV.4.5.8. L'ulcère de Buruli .....                                                              | 87         |
| IV. 5. Déterminants sociaux de la santé.....                                                    | 87         |
| IV. 5.1. Pauvreté et revenus des ménages .....                                                  | 87         |
| IV. 5.2. Éducation.....                                                                         | 88         |
| IV. 5.3. Accès à l'électricité.....                                                             | 89         |
| IV. 5.4. Accès à l'eau, hygiène, assainissement.....                                            | 90         |
| IV. 5.5. Facteurs climatiques .....                                                             | 91         |
| IV. 5.6. Consommation de drogue, d'alcool et du tabac .....                                     | 91         |
| <b>CHAPITRE V : PROBLEMES PRIORITAIRES.....</b>                                                 | <b>93</b>  |
| <b>CHAPITRES VI : CADRE STRATEGIQUE .....</b>                                                   | <b>106</b> |
| VI.1. Rappel de la vision de la politique nationale de santé 2018-2030 .....                    | 106        |
| VI.2. Alignement du PNDS 2023-2026 sur les engagements nationaux et internationaux .....        | 106        |
| VI.3. Principes directeurs du PNDS 2023-2026 .....                                              | 108        |
| VI.4. But et objectifs du PNDS 2023 - 2026.....                                                 | 108        |
| VI.4.1. But du PNDS.....                                                                        | 108        |
| VI.4.2. Objectifs .....                                                                         | 108        |
| VI.4.2. 1. Objectif Général .....                                                               | 108        |
| VI.4.2. 2. Objectifs spécifiques .....                                                          | 109        |
| VI.5. Orientations stratégiques du PNDS 2023 - 2026 .....                                       | 109        |
| VI.6. Résultats sectoriels attendus.....                                                        | 109        |
| VI.7. Actions prioritaires par programme du PNDS 2023-2026.....                                 | 110        |
| VI.7.1. Programme n°1 : Renforcement de la gouvernance et du financement du secteur santé ..... | 110        |

|                                                                                                                                    |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| VI.7.1.1. Sous-programme 1.1 : « renforcement du cadre juridique, administratif et financier .....                                 | 110        |
| VI.7.1.2. Sous-programme 1.2 : Amélioration de la coordination et du partenariat du secteur santé.....                             | 113        |
| VI.7.2. Programme n° 2 : Promotion d'un meilleur état de santé et du bien-être de la population.....                               | 113        |
| VI.7.2.1. Sous-programme 2.1 : Amélioration de la gouvernance et du pilotage en matière de la promotion de la santé .....          | 113        |
| VI.7.2.2. Sous-programme 2.2 : Amélioration du cadre et/ ou mode de vie des populations .....                                      | 114        |
| VI.7.3. Programme n°3 : Amélioration de l'accès équitable des populations aux paquets de services essentiels de qualité .....      | 114        |
| VI.7.3.1. Sous-programme 3.1 : Renforcement de l'offre de soins et services de santé..                                             | 114        |
| VI.7.3.2. Sous-programme 3.2: amélioration de l'accès financier aux soins et services de santé des populations.....                | 114        |
| VI.7.3.3. Sous-programme 3.3 : « renforcement des programmes de santé de la mère, de l'enfant, des jeunes et des adolescents. .... | 114        |
| VI.7.4. Programme n° 4 : Renforcement de la sécurité sanitaire, gestion des épidémies et autres situations d'urgence .....         | 115        |
| VI.7.4.1. Sous-programme 4.1 : gestion des épidémies selon le règlement sanitaire international (RSI). ....                        | 115        |
| VI.7.4.1. Sous-programme 4.2 : gestion des catastrophes et autres événements de santé en fonction des dispositions du RSI. ....    | 115        |
| VI.8. Théorie du changement général.....                                                                                           | 115        |
| VI.8.1. Théorie du Changement adaptée à chaque programme .....                                                                     | 116        |
| VI.8.1.1. Théorie du Changement du programme n°1 .....                                                                             | 116        |
| VI.8.1.2. Théorie du Changement du programme n°2 .....                                                                             | 117        |
| VI.8.1.3. Théorie du Changement du programme n°3 .....                                                                             | 117        |
| VI.8.1.4. Théorie du Changement du programme n°4 .....                                                                             | 118        |
| <b>CHAPITRE VIII : CADRE DE MISE EN OEUVRE DU PNDS .....</b>                                                                       | <b>167</b> |
| VIII.1 Cadre institutionnel de mise en œuvre du PNDS .....                                                                         | 167        |
| VIII.1.1. Les organes techniques de suivi du PNDS et son secrétariat .....                                                         | 167        |
| VIII.1.1.1. Le comité technique de suivi du PNDS (CTS-PNDS).....                                                                   | 167        |
| VIII.1.1.2. Le Secrétariat du comité technique de suivi du PNDS (SCTS-PNDS) .....                                                  | 167        |
| VIII.1.2. Les organes de coordination du PNDS.....                                                                                 | 167        |
| VIII.1.3. Responsabilités dans la mise en œuvre du PNDS .....                                                                      | 168        |
| VIII.1.4. Modalités de mise en œuvre du PNDS.....                                                                                  | 170        |
| VIII.1.5. Mesures et réformes nécessaires .....                                                                                    | 170        |
| VIII.1.6. Modalités de contrôle de gestion.....                                                                                    | 172        |

|                                                                      |            |
|----------------------------------------------------------------------|------------|
| VIII.1.7. Conditions de succès et gestion des risques .....          | 173        |
| VIII.1.7.1. Conditions de succès.....                                | 173        |
| VIII.1.7.2. Analyse et gestion des risques et menaces .....          | 173        |
| <b>CHAPITRE IX : ESTIMATION BUDGETAIRE .....</b>                     | <b>176</b> |
| IX.1. Hypothèse d'estimation des coûts.....                          | 176        |
| IX.2. Estimation des besoins en ressources financières.....          | 176        |
| IX.2.1. Budget global du PNDS 2023-2026 .....                        | 176        |
| IX.2.2. Budget par programme du PNDS 2023-2026.....                  | 177        |
| IX.1.3. Budget du PNDS 2023-2026 par sous-programme .....            | 178        |
| IX.2. Scénarii de financement du PNDS 2023-2026.....                 | 179        |
| <b>CHAPITRE X : PLAN DE SUIVI ET EVALUATION.....</b>                 | <b>181</b> |
| X.1. OBJECTIFS .....                                                 | 181        |
| X.1.1. Objectif général.....                                         | 181        |
| X.1.2. Objectifs spécifiques .....                                   | 181        |
| X.2. Cadre institutionnel de suivi et évaluation du PNDS.....        | 181        |
| X.2.1. Cadre institutionnel au niveau central .....                  | 182        |
| X.2.2. Cadre institutionnel au niveau départemental .....            | 183        |
| X.2.3. Cadre institutionnel au niveau périphérique.....              | 184        |
| X.2.4. Rôle des principales institutions et parties prenantes .....  | 185        |
| X.3. Mécanismes de contrôle, de suivi et d'évaluation .....          | 186        |
| X.3.1. Contrôle de la mise en œuvre du PNDS .....                    | 186        |
| X.3.2. Suivi de la mise en œuvre du PNDS .....                       | 186        |
| X.3.3. Supervision .....                                             | 186        |
| X.3.4. Revue.....                                                    | 187        |
| X.3.5. Evaluation .....                                              | 187        |
| X.4. Cadre conceptuel de suivi et évaluation du PNDS 2023-2026 ..... | 188        |
| X.5. Indicateurs de suivi et d'évaluation .....                      | 188        |
| X.6. Cadre des résultats du PNDS 2023-2026 .....                     | 189        |
| X.7. Source des données.....                                         | 205        |
| X.7.1. Données de routine.....                                       | 205        |
| X.7.2. Données d'enquêtes et d'études .....                          | 205        |
| X.8. Gestion des données .....                                       | 205        |
| X.8.1. Collecte des données .....                                    | 205        |
| X.8.1.1. Collecte de routine.....                                    | 205        |
| X.8.1.2. Collecte des données par enquête et étude .....             | 205        |



|                                                               |            |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| X.8.2. Base de données .....                                  | 205        |
| X.8.3. Traitement des données.....                            | 206        |
| X.8.3.1. Mécanisme de contrôle de la qualité des données..... | 206        |
| X.8.4. Analyse des données .....                              | 206        |
| X.9. Rétro information .....                                  | 206        |
| <b>CONCLUSION .....</b>                                       | <b>207</b> |
| <b>REFERENCES .....</b>                                       | <b>208</b> |

## RECONNAISSANCES

Le processus d'élaboration du PNDS 2023-2026 a débuté en septembre 2022 et a connu une approche inclusive impliquant la plupart des cadres clés des deux secteurs du système de santé, ceux des secteurs connexes et des partenaires techniques et financiers. Sa production n'a été possible que grâce à la coordination de Monsieur **Gilbert MOKOKI**, Ministre de la santé et de la Population. Aussi, les personnes dont les noms et prénoms sont cités ci-dessous ont contribué à sa rédaction. Il s'agit de :

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Coordination</b>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ M. Jean Ignace TENDELET, Directeur de cabinet du MSP</li> <li>▪ Dr Ludovic Anselme GNEKOU MOU LIBABA, Conseiller Technique du MSP</li> <li>▪ Dr Jean Claude MOBOUSSE, Conseiller à la Santé du MSP</li> <li>▪ Dr Jovial NKOUA OBA, Conseiller à la population du MSP</li> <li>▪ M. Saturnin Brice Roch MASSANA, DEP au MSP</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Consultants</b>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dr Noël NAHOUNOU Consultant international, Expert OMS</li> <li>▪ M. MAMADOU KONE, Consultant international pour la budgétisation du PNDS 2023-2026</li> <li>▪ M Auguste AMBENDET, Expert Senior Santé Publique, Consultant national</li> <li>▪ Dr Ange Clauvel NIAMA, Expert en Santé Publique, Enseignant d'Epidémiologie et de santé publique à l'Université Marien NGOUABI de Brazzaville, Consultant national</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Experts ayant contribué techniquement</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pr Henri Germain MONABEKA, DGSSSa</li> <li>▪ Pr Gilbert NDZIESSI, DGAR</li> <li>▪ Pr Richard BILECKOT, IGS</li> <li>▪ Pr Alexis ELIRA DOKEKIAS, Directeur Général du CNRD</li> <li>▪ Pr Franck OKEMBA, Directeur du PNLT</li> <li>▪ Pr Judith NSONDE MALANDA, Directrice du PNLC</li> <li>▪ Pr Alexis Thierry NGOMBE, Directeur Général du CHUB</li> <li>▪ Pr Bienvenu Roland OSSIBI IBARA, PNTA</li> <li>▪ Pr Fabien NIAMA, Directeur Général du LNSP</li> <li>▪ Pr Arnaud MONGO ONKOUO, Directeur du programme national de lutte contre les hépatites virales</li> <li>▪ Pr Donatien MOUKASSA, Personne ressource</li> <li>▪ Dr Paul OYERE MOKE, DGPOP</li> <li>▪ Dr Antoine LOUSSAMBOU, Directeur du PNLP</li> <li>▪ Dr NKAYA-TOBY, DG de l'environnement au Ministère de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche</li> <li>▪ Dr Boniface OKOUYA, DPM</li> <li>▪ Dr Max MAKOUNBA-NZAMBI, DG CAMEPS</li> <li>▪ Dr Alexis MOUROU MOYOKA, Directeur du PEV</li> <li>▪ Dr Jean AKIANA, Directeur des Technologies de la Santé</li> </ul> |

- Dr Michelle MOUNTOU, Directrice de la Santé de la Reproduction
- Dr Josiane SABAYE, Directrice de la Santé de l'Enfant
- Dr Jean Mermoz YOUNDOUKA, Directeur du PNLP
- Dr Jean Médard KANKOU, DELM
- Dr Cécile MAPAPA, Directrice du PNLS
- Dr Paul GANDOU, Directeur du Programme National de Santé Mentale ;
- Dr François MISSAMOU, Directeur du PNLO
- Dr Armel ITOUA, Directeur du Programme National de lutte contre la Schistosomiase
- Dr Benjamin ATIPO, Directeur exécutif du CNLSE
- Dr Axel ALOUMBA, Directeur du programme national de lutte contre la Lèpre, le Pian et l'Ulcère de Buruli
- Dr Jean Martin MABIALA, Directeur des Soins de Santé Primaires
- Dr Jean Claude EMEKA, Directeur de l'Hygiène et de la Promotion de la Santé
- Dr Lambert KITEMBO, Coordonnateur des Projets et Programmes (UCPP)
- Dr Rosa Chanelle OLLESSONGO INYONGUI, Directrice de la Pharmacie et du Médicament
- Dr Jean Pierre ELENGA OKANDZE, Coordonnateur du projet REDISSE IV
- Dr Daruis Eryx MBOU-ESSIE, Coordonnateur du Projet KOBIKISA
- Dr Liptia NDOUNDOU, DISER
- Dr Dieudonné BAKALA, Conseiller, bureau OMS-Congo
- Dr Michel MBEMBA-MOUTOUNOU, Conseiller, bureau OMS-Congo
- Dr Edouard NDINGA, Conseiller, bureau OMS-Congo
- Dr Cyr PASSI-LOAMBA, Conseiller, bureau OMS-Congo
- Dr Jeannette BIBOUSSI, UNFPA
- Dr Herman DIDI NGOSSAKI, UNICEF
- Dr Désiré DEKOU, Attaché à la santé
- M Cédric Slove KIKAYI DOKO, Chef de service de la Planification à la DEP/MSP
- M Gilbert Bruno Ernest MOKONGO AMOTONA, Chef de service des études à la DEP/MSP
- M May Fernandez BIYOU DI BANTSIMBA, Chef de service de la statistique à la DEP/MSP
- Mme Jacqueline NZALAKANDZI, Directrice de la Coopération au MSP
- Mme Elsa GATSONO, Personne Responsable des Marchés Publics au MSP
- M Euloge BOFOKO, Attaché technique au cabinet du MSP
- M Hervé MOUANDZIBI, Assistant du Directeur de Cabinet
- M Vivien Hilaire NYANGA, OMS-Congo

- M Bruno EDZOKO OLOUMBA, Chef de bureau à la DEP/MSP
- M Hermeland MBONO LIBOLI, Collaborateur à la DEP/MSP
- M Jacques Le Font GOMAH, Collaborateur à la DEP/MSP
- M Rosin Andoche KABA, Chef de bureau à la DEP/MSP
- Mme Emeldie MINGOLET BILONGUI, Chef de bureau à la DEP/MSP
- M Bertrand Fresnel NGAMPANA, Chef de bureau à la DEP/MSP
- M Dimitri BOTONGO MABEKI, Collaborateur à la DEP/MSP
- M MOTSE BOSSATSI Eureka, Chef de Bureau à la DEP/MSP
- M Thomas KIVOUELE, Chef de service de la médecine traditionnelle
- M Jean Blaise KOUNDIKA, Chef de service des Etudes, population et santé à la DGPOP
- M Christophe GNIMI, Chef de service Nutrition à la DHPS/MSP
- M Ghyslain KOUENDZE, Collaborateur à la DARH
- M Aimé Magloire EVONGO, DARH au MSP
- M Jérémie MOUYOKANI, Personne ressource
- M Jean de Dieu Bienvenu KONONGO BABACKAS, Personne ressource
- M Isaac VOUIDIBIO, Chef de bureau suivi et évaluation au PEV
- M Joseph ANINIYO, Collaborateur au PNLP
- M Bertin KIBA, DCFI-MPSIR
- M Serge ANGOUBOLO NDOH, Collaborateur au MPSIR
- Mme Ginette GUINDO YAYOS, Secrétaire particulière du MSP
- M Théophile GOMAH MOUNGHATY, Assistant particulier du Directeur de Cabinet
- M Prosper NGALI OYELET, Attaché à la population
- M Alexis NIOMBELA, Directeur des Infrastructures
- M Fred IKIA NGAKIENI, Directeur des technologies de l'information et de la communication au MSP
- M Eliot MANIMA-MOUKONO, Chef de service de l'information sanitaire
- M Austère Lemaxi MAKASSELA, Attaché à la documentation
- M Vinny Yves Joseph MOLLITAN, Attaché chargé de la communication
- M Rodrigue MOUNTOU MAVOUNGOU, Collaborateur à la DISER
- M Adonis Maurille GOUALA, agent au projet KOBIKISA
- M Martin INANA, DDSSSa Niari
- M Phillipe SAMBA, Personne ressource
- M Georges BATALA MPONDO, Personne ressource
- M Bernard TOUKOULOU, Personne ressource

**Appui  
logistique**

- Mme Christelle Natacha OKOMBI OUMBA
- Mme Tatiana EPENDI MILINGOU
- Mme Naomi Saingride OSTER
- Mme Arhouete Solange MOUKOKO
- Mme Lysette Catrylhe ONIENGUIA
- M Raoul Albert MOUNDZENDZE MBEMBA
- Mme Turedia Slevig Laura MOUNDOUANGA
- Mme Cynthia Magalli YAMBA

## LISTE DES ABREVIATIONS

|                |                                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>ARV</b>     | : Anti Rétro Viraux                                                |
| <b>AVC</b>     | : Accident Vasculaire Cérébral                                     |
| <b>AVP</b>     | : Accident de la Voie Publique                                     |
| <b>BCG</b>     | : Bacille de Calmette et Guérin                                    |
| <b>CAMEPS</b>  | : Centrale d'Achat des Médicaments Essentiels et Produits de Santé |
| <b>CAMU</b>    | : Caisse d'Assurance Maladie Universelle                           |
| <b>CAT</b>     | : Centre Anti-Tuberculeux                                          |
| <b>CDMT</b>    | : Cadre de Dépenses à Moyen Terme                                  |
| <b>CDAV</b>    | : Centre de Dépistage Anonyme Volontaire                           |
| <b>CENAMES</b> | : Centrale Nationale d'Achat des Médicaments                       |
| <b>CFCO</b>    | : Chemin de Fer Congo Océan                                        |
| <b>CHU</b>     | : Centre Hospitalier et Universitaire                              |
| <b>CIDTS</b>   | : Centre Inter Départemental de Transfusion Sanguine               |
| <b>CMS</b>     | : Centre Médico-Social                                             |
| <b>CNTS</b>    | : Centre National de Transfusion Sanguine                          |
| <b>CTA</b>     | : Centre de Traitement Ambulatoire                                 |
| <b>CTS</b>     | : Comité Technique de Suivi                                        |
| <b>CODIR</b>   | : Comité de Direction                                              |
| <b>COGES</b>   | : Comité de Gestion                                                |
| <b>COMEG</b>   | : Congolaise des Médicaments Essentiels et Génériques              |
| <b>COSA</b>    | : Comité de Santé                                                  |
| <b>COFIL</b>   | : Comité de Pilotage                                               |
| <b>CSI</b>     | : Centre de Santé Intégré                                          |
| <b>DS</b>      | : District Sanitaire                                               |
| <b>DC</b>      | : Direction Centrale                                               |
| <b>DDS</b>     | : Direction Départementale de la Santé                             |
| <b>DDPOP</b>   | : Direction Départementale de la Population                        |
| <b>DEP</b>     | : Direction des Études et de la Planification                      |
| <b>DELM</b>    | : Direction de l'Epidémiologie et de la Lutte contre la Maladie    |
| <b>DGPOP</b>   | : Direction Générale de la Population                              |
| <b>DI</b>      | : Direction des Infrastructures                                    |
| <b>DEM</b>     | : Direction de l'Équipement et de la Maintenance                   |
| <b>DGSSSa</b>  | : Direction Générale des Soins et Services de Santé                |
| <b>DOTS</b>    | : Traitement sous Observance Directe de la Tuberculose             |
| <b>DSRP</b>    | : Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté                |

|                    |                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DSISR</b>       | : Direction des Systèmes d'Informations Sanitaires et de la Recherche            |
| <b>DSRP</b>        | : Document Stratégique pour la Réduction de la Pauvreté                          |
| <b>DTC3</b>        | : Vaccin contre la Diphtérie, le Tétanos et la Coqueluche, 3 <sup>ème</sup> dose |
| <b>ECOM2</b>       | : Enquête Congolaise auprès des Ménages 2 <sup>ème</sup> génération              |
| <b>EDSC II</b>     | : Enquête Démographique et de Santé n°2                                          |
| <b>EG-DS/EC-DS</b> | : Equipe de Gestion du DS ou Equipe Cadre du District Sanitaire                  |
| <b>ENCV</b>        | : Enquête Nationale sur la Couverture Vaccinale                                  |
| <b>FAC</b>         | : Forces Armées Congolaises                                                      |
| <b>FHVE</b>        | : Fièvre Hémorragique à Virus Ebola                                              |
| <b>FRPC</b>        | : Facilité pour la Réduction de la Pauvreté et la Croissance                     |
| <b>GDBM</b>        | : Gestion des Déchets Biomédicaux                                                |
| <b>GTCV</b>        | : Groupe Technique Consultatif pour la vaccination                               |
| <b>HG</b>          | : Hôpital Général                                                                |
| <b>HHFA</b>        | : Harmonized Health Facility Assessment                                          |
| <b>HTA</b>         | : Hypertension Artérielle                                                        |
| <b>IB</b>          | : Initiative de Bamako                                                           |
| <b>IDE</b>         | : Infirmier Diplômé d'État                                                       |
| <b>IEC</b>         | : Information Education Communication                                            |
| <b>IO</b>          | : Infections Opportunistes                                                       |
| <b>IRA</b>         | : Infection Respiratoire Aiguë                                                   |
| <b>IST</b>         | : Infection Sexuellement Transmissible                                           |
| <b>JNV</b>         | : Journées Nationales de Vaccination                                             |
| <b>LNSP</b>        | : Laboratoire National de Transfusion Sanguine                                   |
| <b>MEG</b>         | : Médicaments Essentiels Génériques                                              |
| <b>MSASF</b>       | : Ministère de la Santé, des Affaires sociales et de la Famille                  |
| <b>NTIC</b>        | : Nouvelles Technologies de l'Information et la Communication                    |
| <b>ODD</b>         | : Objectifs de Développement Durable                                             |
| <b>OMD</b>         | : Objectifs du Millénaire pour le Développement                                  |
| <b>OMS</b>         | : Organisation Mondiale de la Santé                                              |
| <b>ONG</b>         | : Organisation Non Gouvernementale                                               |
| <b>PAM</b>         | : Programme Alimentaire Mondial                                                  |
| <b>PASCOB</b>      | : Projet d'Appui au Système de santé du Congo-Brazzaville                        |
| <b>PCA</b>         | : Paquet Complémentaire d'Activités                                              |
| <b>PCIME</b>       | : Prise en Charge Intégrée des Maladies de l'Enfant                              |
| <b>PDSS</b>        | : Programme de Développement des Services de Santé                               |
| <b>PEC</b>         | : Prise En Charge                                                                |

|               |                                                                              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PEV</b>    | : Programme Élargi de Vaccination                                            |
| <b>PFA</b>    | : Paralysie Flasque Aiguë (poliomyélite)                                     |
| <b>PIB</b>    | : Produit Intérieur Brut                                                     |
| <b>PIP</b>    | : Programme d'Investissement Public                                          |
| <b>PIPC</b>   | : Programme Intérimaire Post Conflit                                         |
| <b>PMA</b>    | : Paquet Minimum d'Activités                                                 |
| <b>PMAE</b>   | : Paquet Minimum d'Activités Élargi                                          |
| <b>PMAS</b>   | : Paquet Minimum d'Activités Standards                                       |
| <b>PNDS</b>   | : Plan National de Développement Sanitaire                                   |
| <b>PNLP</b>   | : Programme National de Lutte contre le Paludisme                            |
| <b>PNLS</b>   | : Programme National de Lutte contre le Sida                                 |
| <b>PNS</b>    | : Politique Nationale de Santé                                               |
| <b>Ppte</b>   | : Pays Pauvre Très Endetté                                                   |
| <b>PVVIH</b>  | : Personne vivant avec le VIH                                                |
| <b>PSE</b>    | : Paquets de Services Essentiels                                             |
| <b>PTF</b>    | : Partenaires Techniques et Financiers                                       |
| <b>RAMU</b>   | Regime d'Assurance Maladie Univeverselle                                     |
| <b>RGPH</b>   | Recensement Général de la Population et de l'Habitat                         |
| <b>SCO</b>    | : Service de la Coordination                                                 |
| <b>SIMR</b>   | : Surveillance Intégrée de la Maladie et la Riposte                          |
| <b>SRMNIA</b> | : Santé de la Reproduction Maternelle, Néonatale, Infantile, des Adolescents |
| <b>SNIS</b>   | : Système National d'Information Sanitaire                                   |
| <b>SPT</b>    | : Stratégie Plaintes Traitement                                              |
| <b>SSP</b>    | : Soins de Santé Primaires                                                   |
| <b>SSR</b>    | : Santé Sexuelle et Reproductive                                             |
| <b>STS</b>    | : Schémas Thérapeutiques Standardisés                                        |
| <b>TAR</b>    | : Traitement Anti Rétroviraux                                                |
| <b>TMN</b>    | : Tétanos Maternel Néonatal                                                  |
| <b>UNFPA</b>  | : Fonds des Nations Unies pour la Population                                 |
| <b>UNICEF</b> | : Fonds des Nations Unies pour l'Enfance                                     |



## GLOSSAIRE DES TERMES TECHNIQUES UTILISES

| Termes techniques                           | Définitions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Communauté</b>                           | Groupe d'individus qui vivent ensemble dans des conditions spécifiques d'organisation et de cohésion sociales. Ses membres sont liés, à des degrés variables, par des caractéristiques politiques, économiques, sociales et culturelles communes ainsi que par des intérêts et des aspirations communes, y compris en matière de santé ( <b>OMS ,1978</b> )                                                                                                                                                                             |
| <b>Déterminants de la santé</b>             | Selon la définition de l'OMS, les déterminants de la santé sont les « facteurs personnels, sociaux, économiques et environnementaux qui déterminent l'état de santé des individus ou des populations <sup>1</sup> ». Facteurs influant sur l'état de santé.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>District sanitaire</b>                   | Entité administrative et opérationnelle du système de santé intégré de district (SSID) dont les limites géographiques et la population de responsabilité sont bien connues. Le DS est constitué de toutes les institutions publiques ou privées offrant des soins et services de santé aux deux échelons et qui sont interdépendants. Le premier constitué d'un réseau de centres de santé et le deuxième représenté par l'hôpital de référence. Les paquets d'activités de ces échelons sont complémentaires et ne se chevauchent pas. |
| <b>Education pour la santé</b>              | Transmission et construction de savoirs et compétences d'une population, concernant la <b>santé</b> de cette population, avec intention d'éducation, inscrit dans la durée <sup>2</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Endémie</b>                              | Présence habituelle d'une maladie dans une zone géographique donnée [9]. Epidémie qui perdure et devenant permanent dans le temps dans une entité donnée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Epidémie</b>                             | L'épidémie désigne l'augmentation rapide et inhabituelle du nombre de cas d'une maladie donnée dans une entité donnée à un moment donné.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Espérance de vie</b>                     | Estimation du nombre moyen d'années qu'une personne, à un certain âge, peut s'attendre à vivre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Evaluation</b>                           | C'est un examen périodique de l'état d'une politique, d'un programme, ou d'un projet portant sur la performance, l'efficacité, et l'efficience. Elle comprend les quatre (4) principales étapes suivantes : (i) Mesure (performance réalisée, résultats), (ii) Comparaison avec les indicateurs, (iii) Analyse : jugement de valeur basé sur le seuil de satisfaction et (iv) Décision.                                                                                                                                                 |
| <b>Gestion axée sur les résultats (GAR)</b> | Système de gestion qui s'appuie sur le cycle de vie d'un programme ou d'un projet. Elle intègre les stratégies, les personnes. Approche de gestion mettant l'emphasis sur les résultats à court, moyen et long terme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

<sup>1</sup> Alla, François. « 3. Les déterminants de la santé », François Bourdillon éd., Traité de santé publique. Lavoisier, 2016, pp. 15-18.

<sup>2</sup> A. Deccache Quelles pratiques et compétences en éducation du patient ? Recommandations de l'O.M.S. La Santé de l'homme, n° 341, mai-juin 1999, pp 12-14).

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gouvernance</b>                   | Ensemble de décisions, de règles et de pratiques visant à assurer le fonctionnement optimal d'une organisation, ainsi que les organes structurels chargés de formuler ces décisions, de les mettre en œuvre et d'en assurer le contrôle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Gouvernance en santé publique</b> | Processus collectif de prise de décisions visant à garantir la vitalité et la performance des organismes ou des systèmes de santé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Indicateur</b>                    | Variable qui sert à mesurer les changements. Un indicateur est donc une grandeur spécifique observable et mesurable qui peut servir à montrer les changements obtenus ou les progrès accomplis par une politique, un plan, un programme, un projet ou une intervention en vue de la réalisation d'un effet spécifique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Indicateurs en santé</b>          | Ce sont des outils qui permettent d'évaluer un état de santé (mesure de l'état de santé d'un individu ou d'une population), une pratique, une organisation ou la survenue d'un événement, ainsi que son évolution dans le temps. Ils peuvent être de différents types : de structure, de processus, ou de résultats. Ils peuvent être quantitatives ou qualitatives.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Indicateurs d'exposition</b>      | Aussi appelés déterminants de santé, ce sont les facteurs ou événements modifiant l'état de santé. Parmi eux, on peut citer les facteurs de risque ou facteurs explicatifs de la survenue de problèmes de santé dont les facteurs intrinsèques représentent des facteurs de risque sur lesquels les actions de prévention n'ont peu ou pas d'efficacité car non modifiables (sexe, âge, gène). Dans ce registre, on retrouve aussi les comportements individuels, les habitudes de vie (habitudes alimentaires, sexuelles, usage de drogues ...), l'environnement et ses composantes physiques (radiations, bruit, ...), chimiques (air, eau, ...), et biologiques. Les indicateurs d'exposition peuvent être influencés par l'organisation des soins : offre, qualité, réactivité, accessibilité, efficacité, coût, équité, etc. |
| <b>Leadership</b>                    | Capacité d'un individu ou d'un groupe d'individus à mener ou conduire d'autres individus ou organisations dans le but d'atteindre certains objectifs. On dit alors qu'un leader est quelqu'un qui est capable de guider, influencer et d'inspirer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Morbidité</b>                     | Paramètre de mesure de la fréquence des maladies ou des états de mauvaise santé d'une population                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Mortalité</b>                     | Paramètre de mesure des décès dans une population                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Pandémie</b>                      | C'est lorsqu'une maladie transmissible ou infectieuse s'étend rapidement et touche une part importante de la planète.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Partenariat</b>                   | Il se définit comme une association active de différents intervenants qui, tout en maintenant leur autonomie, acceptent de mettre en commun leurs efforts en vue de réaliser un objectif (Wikipédia). Association d'au moins deux organismes pour mener une opération commune ou un ensemble d'opérations communes en vue d'objectifs communs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Participation communautaire</b>   | Processus par lequel des individus et des familles prennent en charge leur propre santé et leur propre bien-être comme ceux de la communauté en développant leur capacité de concourir à leur propre développement comme à celui de la communauté. Ils en viennent ainsi à mieux appréhender leur propre situation et être animés de la volonté de résoudre leurs problèmes communs, ce qui les mettra en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | mesure d'être des agents de leur propre développement au lieu de se cantonner dans le rôle de bénéficiaires passifs de l'aide au développement » (UNICEF et OMS, 1978,).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Planification en santé</b>                  | Processus continu de prévision de ressources et de services requis pour atteindre des objectifs déterminés selon un ordre de priorité établi dans le secteur de la santé. Elle permet de choisir les solutions optimales parmi plusieurs alternatives. Le choix de ces solutions tient compte les plusieurs facteurs, parmi lesquels on peut citer : (i) le contexte épidémiologique, les facteurs socio-économiques et culturel du pays, (ii) l'environnement interne et externe, etc...                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Planification stratégique</b>               | C'est une planification, qui partant de l'analyse de situation, représente la phase prospective de l'exercice, où les pays fixent les objectifs du secteur santé pour les cinq à dix futures années, en spécifiant les domaines d'intervention et les axes stratégiques les plus pertinents.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Planification opérationnelle</b>            | Action qui consiste à élaborer un plan opérationnel à court terme (une année de préférence) de mise en œuvre d'un plan stratégique couvrant plusieurs années. Ce plan fixe : (i) les objectifs, (ii) les résultats attendus, (iii) les activités, (iv) les indicateurs de suivi, (v) le budget, (vi) le calendrier, etc.... pour l'année et est élaboré après une évaluation du précédent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Planification tactique</b>                  | Encore appelée planification structurelle, c'est une démarche qui concerne les objectifs généraux et spécifiques. C'est le planning tactique ou structurel pour programmer les activités et les ressources nécessaires pour atteindre les objectifs fixés. Le produit de cette étape est le programme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Planification d'urgence</b>                 | <p>C'est une démarche qui consiste à anticiper les mesures, les procédures, les outils et les mécanismes de coordination à mettre en place pour une mobilisation rapide des moyens nécessaires afin de faire face à une situation de crise et d'assurer la protection des personnes et des biens. Elle doit être comprise comme une démarche globale qui repose sur un processus d'apprentissage continu, pour améliorer la résilience d'un système donné (résilience) [6].</p> <p>Ce processus peut être décrit comme un ensemble d'étapes, à savoir : (1) l'identification des risques, (2) la prévention, (3) la préparation (la planification), (4) la gestion de crise, (5) le rétablissement, (6) l'évaluation et (7) l'intégration des enseignements.</p> |
| <b>Promotion de la santé</b>                   | C'est le processus qui confère aux populations les moyens d'assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé, et d'améliorer celle-ci (Charte d'Ottawa 1986).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Règlement sanitaire international (RSI)</b> | Le RSI a été adopté par la 58 <sup>ème</sup> Assemblée Mondiale de la santé en 2005 grâce à la résolution WHA58.3.1. Il constitue le cadre juridique qui définit notamment les principales capacités nationales, dont les capacités aux points d'entrée, relatives à la prise en charge des urgences de santé publique de portée nationale et internationale, potentielle ou réelle, ainsi que les procédures administratives connexes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Résilience</b>                              | Phénomène psychologique qui consiste, pour un individu affecté par un traumatisme, à prendre acte de l'évènement de manière à ne pas, ou plus, vivre dans le malheur et à se reconstruire d'une façon socialement acceptable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Résilience d'une entreprise</b>             | Les organisations résilientes sont celles qui rebondissent et prospèrent après une perturbation des activités, car elles résistent aux impacts de la perturbation (grâce à                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | une bonne gestion des risques) et sont adaptables, flexibles et durables face à la situation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Revue</b>                 | C'est une activité de mise au point de l'état d'avancement d'une intervention, d'un projet, d'un programme ou d'une politique ». Elle a pour objectif de « redresser les écarts au protocole ou d'améliorer les points faibles » identifiés afin d'atteindre de manière optimale les objectifs prévus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Santé</b>                 | Etat de complet bien-être physique, mental et social, ne consiste pas seulement en l'absence de maladie ou d'infirmité (OMS, 1946).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Santé communautaire</b>   | Processus par lequel les individus et les familles prennent en charge leur propre santé et leur bien-être comme ceux de la communauté et développent leur capacité de concourir à leur propre développement comme celui de la communauté (OMS UNICEF, Alma Ata 1978).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Santé publique :</b>      | Concept social et politique qui vise une amélioration de la santé, une plus grande longévité et un accroissement de la qualité de la vie de toutes les populations par le biais de la promotion de la santé, de la prévention des maladies ainsi que par d'autres interventions afférentes à la santé (OMS, 1988).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Suivi ou monitoring</b>   | <p>Processus séquentiel et systématique de collecte et d'examen ou analyse des données, procédures et pratiques. Nécessite la détermination d'indicateurs pour chaque activité pendant le processus de planification. Il permet de répondre aux questions essentielles suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Est-ce que les activités prévues progressent conformément au plan établi ?</li> <li>✓ La manière dont les activités sont mises en œuvre permet-elle d'atteindre les objectifs ?</li> <li>✓ Les ressources prévues sont-elles utilisées selon le plan ?</li> </ul>                                                                            |
| <b>Supervision</b>           | Processus périodique qui vise à aider le personnel à améliorer sa prestation après, soit une évaluation par un superviseur externe, ou par les pairs, soit par l'auto-évaluation. Elle consiste en une détection des déficiences de performances éventuelles, en un feedback (rétro-information), en une remédiation et des encouragements du personnel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Supervision formative</b> | <p>Processus qui permet d'aider le personnel à améliorer sa prestation en impliquant un transfert de compétences, de connaissances, d'attitudes entre le superviseur et l'agent supervisé. Elle garantit des prestations de qualité. La supervision formative crée des compétences :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Elle met l'accent sur l'amélioration des compétences du personnel afin de s'assurer qu'il fournit des services de qualité ;</li> <li>✓ Elle nécessite une évaluation de la performance du programme et du personnel qui y est assigné, et la rétro-information.</li> <li>✓ Elle inclut habituellement la formation sur le site.</li> </ul> |

## PREFACE

Depuis 1992, le plan national de développement sanitaire (PNDS) est devenu le cadre de référence unique pour la mise en œuvre de la politique de santé par le Gouvernement. C'est ainsi qu'ont été mis en œuvre successivement les PNDS couvrant les périodes 1992-1996, 2007-2011 et 2018-2022. La période des années 1998 à 2006 a été consacrée essentiellement à des programmes d'urgences et de réhabilitation post-conflit.

Le présent PNDS 2023-2026, élaboré selon un processus participatif et inclusif impliquant l'ensemble des acteurs du système sanitaire national, est aligné sur la Politique Nationale de Santé (PNS) 2018-2030, au PND 2022-2026 et aux engagements internationaux. Ainsi, ces engagements convergent vers un objectif ultime qui est celui de l'atteinte de la couverture sanitaire universelle (CSU) : l'accès de tous sans exclusion, aux soins de santé de qualité, sans barrières financières pouvant priver aux populations la satisfaction d'autres besoins essentiels.

Le programme du Président de la République, **« Ensemble, poursuivons la marche »**, a inscrit dans ses priorités l'amélioration de l'état de santé des populations, notamment offrir des soins de santé de qualité pour tous. Dans cet élan, lors de son discours à la Nation du 28 novembre 2022 devant la représentation nationale réunie en congrès, le Chef de l'Etat a enjoint le Gouvernement de la République d'accélérer l'entrée en exploitation effective de l'assurance maladie universelle dès 2023 pour permettre l'accès à tous aux soins de santé de qualité, et cela, sans barrières financières.

La santé étant un droit inaliénable pour tout individu, la Couverture Sanitaire Universelle (CSU) constitue dès lors une exigence sociale et économique et un impératif de justice et d'équité. Ainsi, divers instruments ont déjà été mis en place dans la perspective de la CSU, notamment la mise en place du processus d'assurance maladie comme dispositif de financement de la santé. Ce dispositif contribuera grandement à la réalisation du PNDS, en synergie avec les autres secteurs de développement du Congo. En harmonie avec l'option prise dans le cadre des Objectifs de Développement Durable (ODD), la prise en compte de l'environnement, de l'éducation et de la promotion des droits humains favorisera sûrement la réalisation des objectifs de santé publique.

Dans ce travail, tous les segments du secteur de la santé ont été profondément examinés. Les résultats de cette analyse ont permis d'identifier des défis majeurs pour les quatre prochaines années, qui sont certes nombreux et de taille, mais la volonté de les relever est grande. La vision politique qui sous-tend les actions du secteur, la mission, les principes directeurs et les valeurs ont été présentés. Des orientations stratégiques ont été définies avec des résultats attendus formulés, conformément aux principes de Gestion Axée sur les Résultats.

Comme lors de son élaboration, la mise en œuvre de ce PNDS requiert aussi l'implication et l'engagement de toutes les parties prenantes : autorités administratives et territoriales, partenaires techniques et financiers, acteurs de la santé, partenaires sociaux, secteur privé, société civile, communautés, etc. Qu'il nous soit permis de remercier, au nom du Président de la République, Son Excellence Monsieur **Denis SASSOU N'GUESSO**, Chef de l'Etat et de son gouvernement, tous ceux qui ont pris part aux réflexions et concertations qui ont jalonné la maturation de ce présent PNDS.

Je pense, entre autres, à nos Partenaires Techniques et Financiers (PTF), pour leur précieux concours sans cesse renouvelé. Enfin, j'adresse mes encouragements aux personnels du secteur de la santé, dévoués et engagés, à l'accomplissement des objectifs qui leur sont assignés.

le Ministre de la Santé et de la Population



Gilbert MOKOKI

## LISTE DES TABLEAUX

|                                                                                             |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tableau 1: Répartition de la population par département et par sexe, 2023 .....             | 29  |
| Tableau 2 : Repartition des FOSA de 1 <sup>er</sup> échelon par département .....           | 35  |
| Tableau 3 : Dépenses courantes de santé par facteurs de prestation.....                     | 45  |
| Tableau 4: Assurés et taux de contribution financière à la CAMU.....                        | 47  |
| Tableau 5: Espérance de vie à l'âge x des personnes âgées.....                              | 63  |
| Tableau 6 : Principaux indicateurs du VIH en 2021 .....                                     | 71  |
| Tableau 7: Evolution des principaux indicateurs du paludisme au Congo, 2018 à 2020 .....    | 76  |
| Tableau 8 : Statistiques des cancers en 2020. ....                                          | 79  |
| Tableau 9 : Surveillance de la poliomyélite .....                                           | 82  |
| Tableau 10 : Evolution des cas atteints du virus dérivés du poliovirus sauvage .....        | 82  |
| Tableau 11: Cas et décès de Monkey-pox par départements et districts sanitaires, 2022 ..... | 85  |
| Tableau 12 : Répartition du Budget par programme du PNDS (en millions de FCFA) .....        | 177 |
| Tableau 13 : Répartition du budget par sous-programme PNDS (en millions de FCFA).....       | 178 |

## LISTE DES FIGURES

|                                                                                             |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Figure 1 : Carte géographique du Congo .....                                                | 28  |
| Figure 2 : Schéma de l'organisation du Système de santé du Congo .....                      | 33  |
| Figure 3 : Evolution du budget alloué et du taux de décaissement effectif .....             | 43  |
| Figure 4 : Evolution des taux d'allocation budgétaire et de décaissement, 2012 - 2020 ..... | 44  |
| Figure 5: Estimation de l'espérance de vie au Congo .....                                   | 62  |
| Figure 6: Evolution de la mortalité maternelle (pour 100000 NV) de 2021 à 2023.....         | 64  |
| Figure 7 : Causes des décès maternels au Congo, 2021. ....                                  | 65  |
| Figure 8 : Mortalité néonatale (pour 1000 NV) .....                                         | 66  |
| Figure 9 : Mortalité infantile (pour 1000 NV).....                                          | 66  |
| Figure 10 : Mortalité infanto-juvénile (pour 1000 NV) .....                                 | 67  |
| Figure 11 : Distribution des personnes âgées par groupe d'âge .....                         | 68  |
| Figure 12 : Evolution de la prévalence selon le sexe.....                                   | 72  |
| Figure 13 : Formes cliniques des nouveaux cas et rechutes de TB, Congo, 2017-2021 .....     | 74  |
| Figure 14 : Nombre de cas d'hépatites b et c dans 5 départements du Congo.....              | 77  |
| Figure 15 : Evolution du budget du PNDS 2023-2026.....                                      | 176 |
| Figure 16 : Répartition du budget en fonction des programmes du PNDS 2023 - 2026 .....      | 178 |
| Figure 17 : Scenarii de financement du PNDS 2023-2026.....                                  | 179 |

## RÉSUMÉ

Le Plan National de Développement Sanitaire (PNDS) 2023-2026 constitue le document de référence du secteur santé pour toute intervention en République du Congo. Il rassemble les interventions à haut impact susceptibles de contribuer efficacement et de façon efficiente et équitable à l'amélioration de l'état de santé de la population.

Il vise ainsi à réduire la charge de morbidité et la mortalité qui touchent particulièrement : (i) le couple mère-enfant, (ii) l'adolescent et le jeune, (iii) l'adulte, (iv) la personne de 3<sup>e</sup> âge avec la persistance des maladies transmissibles comme le paludisme, la tuberculose, le VIH/SIDA, l'augmentation des prévalences des maladies non transmissibles telles que les cardiopathies avec sa principale complication l'accident vasculaire cérébrale, les cancers, le diabète, les maladies mentales ou la drépanocytose.

Le PNDS 2023-2026 se fonde sur les orientations stratégiques de la santé retenues dans le PND 2022- 2026 et vise à améliorer l'état de santé de la population en ciblant le capital humain.

L'épidémie à covid-19 qui constituait un frein à la mise en œuvre du PNDS 2018-2022 étant surmontée, il apparaît urgent et indispensable de redoubler les efforts afin que le pays se donne les chances d'atteindre les principales cibles du troisième objectif de développement durable en lien avec la couverture sanitaire universelle et le bien-être.

À cet effet, les interventions à mettre en œuvre ont été regroupées en quatre (4) programmes d'intervention ciblant l'ensemble des actions prioritaires pour les quatre (4) prochaines années. Il s'agit de : (i) renforcement de la gouvernance et du pilotage du secteur santé, (ii) la promotion de la santé, (iii) l'amélioration de l'accès équitable des populations aux paquets de services essentiels de qualité, (iv) et la sécurité sanitaire et gestion des situations d'urgence selon l'approche englobant l'ensemble des menaces.

La mise en œuvre de ce plan se fera à tous les niveaux du système de santé avec la place centrale des collectivités locales dans le cadre de l'accélération de la politique de décentralisation. Aussi, les secteurs public et privé, la société civile avec l'appui des partenaires techniques et financiers seront davantage mis à contribution.

Pour garantir le suivi de la mise en œuvre et l'atteinte des objectifs fixés par ce plan, une place importante est accordée à la promotion de la santé, afin d'impulser la dynamique de toutes les parties, y compris les secteurs hors santé. Pour garantir cela, des indicateurs ont été définis, y compris la détermination des différents responsables de chacune des interventions prévues.

Le coût global estimatif de mise en œuvre du PNDS 2023-2026 s'élève à **817,644 milliards** de Francs CFA. La répartition du budget du PNDS 2023-2026 par programme pour les quatre prochaines années se décline comme suit : le programme n°1 : **renforcement de la gouvernance et du financement du secteur de la santé** est estimé à 138,545 milliards de FCFA, soit 17% du budget ; le programme n°2 : **promotion d'un meilleur état de santé et du bien-être de la population**, 468,864 milliards de FCFA, soit 57% ; le programme n°3 : **amélioration de l'accès équitable des populations aux paquets de services essentiels de qualité** est évalué à 113,273 milliards, soit 14% et le programme n°4 : **renforcement de la sécurité sanitaire, gestion des épidémies et autres situations d'urgence** est estimé à 96,962 milliards, soit 12%.

L'exécution de ce PNDS, avec l'implication de toutes les parties prenantes, permettra à la fois de recréer les conditions d'un système de santé inclusif et efficace et de satisfaire les demandes de santé de la population.

Au-delà des ressources financières qui constituent le premier défi de ce plan, le succès de sa mise en œuvre dépend aussi et surtout de la résolution de la problématique des ressources humaines en santé, de la réforme hospitalière, de l'accessibilité aux médicaments essentiels, aux produits



sanguins sécurisés, aux réactifs et vaccins et d'une mobilisation de tous les secteurs de la société en faveur des problématiques sanitaires.

Tenant compte des contraintes financières et de l'accroissement des dépenses catastrophiques, ce plan préconise l'accélération de la mise en exploitation effective de l'assurance maladie universelle et le renforcement de la décentralisation qui constituent des réponses adaptées et efficaces au secteur de la santé du Congo.

Le Gouvernement de la République du Congo, conscient de l'importance de la santé dans le processus général de développement du pays, a reconnu le droit à la santé du citoyen congolais à travers sa constitution et s'emploie à faire de la promotion de la santé un des domaines prioritaires de l'action gouvernementale.

Le plan national de développement sanitaire (PNDS) est le cadre programmatique de référence qui renseigne sur la stratégie sectorielle ainsi que sur les différentes interventions du secteur de la santé suivant un cycle de planification tous les 5 ans.

Le présent plan a pour enjeu fondamental l'avancée du pays vers la Couverture Sanitaire Universelle (CSU) pour la réalisation de l'Objectif de Développement Durable (ODD) numéro 3. À ce titre, sa conception est arrimée aux engagements du Président de la République, le 28 novembre 2022, devant l'Assemblée nationale réunie en congrès, qui a déclaré l'entrée en exploitation effective de l'Assurance maladie universelle (AMU) en 2023.

Le dernier PNDS 2018-2022 reposait sur quatre (4) programmes d'intervention qui englobent l'ensemble des actions prioritaires à savoir : (i) le renforcement de la gouvernance, du leadership et du pilotage du secteur santé, (ii) l'amélioration de l'accès équitable des populations aux paquets de services essentiels de qualité, (iii) la sécurité sanitaire et la gestion des situations d'urgence selon l'approche englobant l'ensemble des menaces et (iv) la promotion de la santé. Au-delà de ces programmes et en conformité avec les objectifs de développement durables (ODD), la santé a été classée parmi les urgences dans le programme d'action du Gouvernement, tiré du projet de société de son Excellence **Dénis SASSOU N'GUESSO**, Président de la République, Chef de l'Etat, **la marche vers le développement, allons plus loin ensemble**.

Tenant compte de ce qui précède, la mise en œuvre du PNDS 2023-2026, se fonde sur une approche pragmatique et réaliste qui reprend les objectifs non atteints de l'ancien plan qui visaient la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile. Aussi, il était question de baisser les incidences et les prévalences du VIH/SIDA, du paludisme et de la tuberculose ; de même que celles des autres maladies transmissibles, des maladies non transmissibles, des maladies tropicales négligées et des maladies évitables par la vaccination.



## INTRODUCTION

---

Le plan national de développement sanitaire (PNDS), institué par loi n°14-92 du 29 avril 1992, est le cadre programmatique des interventions du secteur de la santé. Il renseigne sur les différentes stratégies ainsi que sur les différentes interventions du secteur de la santé à mettre en œuvre pour contribuer à l'amélioration de la santé de la population congolaise. Suivant un cycle de planification quinquennal, le secteur de la santé s'est doté de ce plan pour faire face aux multiples défis de morbidité et de mortalité dans le pays.

Le Gouvernement, conscient de l'importance de la santé dans le processus général de développement du pays, a toujours accordé une place de choix dans la mise en œuvre des interventions de santé. Pour s'en convaincre, le Gouvernement MAKOSSO a placé, en première position, la bataille de la santé parmi les douze de son action, en conformité avec les prescriptions de Son Excellence Monsieur **Denis SASSOU-N'GUESSO**, Président de la République, Chef de l'Etat qui tient à l'amélioration de la santé de la population vivant au Congo.

Si le précédent PNDS 2018-2022 qui était constitué de quatre (4) programmes d'intervention n'a pu être mise en œuvre de façon adéquate, le présent PNDS 2023-2026 a, pour enjeu fondamental, celui d'atteindre les cibles du troisième ODD en lien avec la Couverture Sanitaire Universelle (CSU). A ce titre, sa conception est arrimée aux engagements de son Excellence Monsieur **Denis SASSOU N'GUESSO**, Président de la République, Chef de l'Etat qui a déclaré, le 28 novembre 2022, lors de son intervention au Parlement réuni en congrès, que l'Assurance Maladie Universelle (AMU) devrait être effective en 2023.

Prenant en compte ce qui précède, la mise en œuvre de ce nouveau PNDS 2023-2026, se fonde sur une approche pragmatique et réaliste en reprenant les objectifs non atteints de l'ancien plan. Ce nouveau PNDS vise la réduction de :

- (i) la mortalité maternelle de 304 à moins de 70 décès pour 100 000 naissances vivantes ;
- (ii) la mortalité néonatale de 20,2 à moins de 7,2 décès pour 1000 naissances vivantes ;
- (iii) la mortalité infanto-juvénile, de 40,4 à 24,59 décès pour 1000 naissances vivantes ;
- (iv) les incidences et prévalences du VIH/SIDA, du paludisme et de la tuberculose, des autres maladies transmissibles et des maladies non transmissibles ;
- (v) la prévalence des maladies tropicales négligées et des maladies évitables par la vaccination.

Le présent PNDS 2023-2026, inspiré du Plan National de Développement (PND) 2022-2026, a été élaboré selon une approche participative et inclusive impliquant les différentes parties prenantes du secteur de la santé. Il s'agit : i) des cadres de plusieurs ministères (plan, finances, fonction publique et sécurité sociale, affaires sociales, agriculture, élevage et de la pêche, environnement, développement durable, enseignement supérieur et recherche scientifique), (ii) des Partenaires Techniques et Financiers et (iii) des acteurs de la société civile. Le processus d'élaboration du PNDS 2023-2026 s'est déroulé en deux phases, à savoir :

### I.1. Phase préparatoire

L'élaboration du présent PNDS 2023-2026 a été précédée par la mise en place de deux organes à savoir : (i) le Comité de Pilotage (COPIL) et (ii) le Groupe de Travail Technique (GTT). Ces deux organes ont conduit le processus d'élaboration de ce document stratégique après une évaluation du précédent PNDS 2018-2022.

#### ▪ Le Comité de pilotage (COPIL)

Le COPIL est placé sous le patronage du Ministre de la santé et de la population. Cet organe a coordonné l'ensemble des travaux de l'évaluation du PNDS 2018-2022 et de l'élaboration du nouveau PNDS 2023-2026.

#### ▪ Le Groupe de Travail Technique (GTT)

Le GTT est coordonné par le Conseiller Technique du Ministre de la santé et de la population. Il est composé à la fois des cadres de la Direction des études et de la planification du MSP, des Responsables des différents programmes de santé et des structures sous tutelle, de l'équipe des consultants (internationaux et nationaux), et enfin des Représentants des différents Partenaires techniques et financiers du secteur de la santé au Congo.

Le GTT dispose d'un Secrétariat Technique, placé sous la direction du Directeur des Etudes de la Planification. Le secrétariat est chargé de l'opérationnalisation de tout le processus d'évaluation du PNDS 2018 - 2022. A ce titre, il était chargé de :

- ✓ préparer les réunions du Comité de Pilotage et du Groupe de Travail Technique ;
- ✓ sélectionner les outils usuels requis pour l'analyse approfondie de la situation sanitaire du pays ;
- ✓ identifier les besoins en données et informations complémentaires à l'analyse sommaire de la situation sanitaire du pays faite au cours des assises d'Ewo ;
- ✓ produire les protocoles et supports de collecte des données complémentaires pour approfondir l'analyse de la situation sanitaire nationale et,
- ✓ organiser la collecte, le traitement, l'analyse des données complémentaires ainsi que la rédaction de l'analyse de la situation sanitaire nationale, du PNDS 2023-2026.

### I.2. Phase d'élaboration proprement dite

Le démarrage effectif de l'élaboration du PNDS 2023-2026 a été marqué par la tenue de la première réunion du Comité de Pilotage et de la mise à disposition de tous les groupes de la méthodologie des travaux afin de standardiser les livrables de tous les participants.

Le processus d'élaboration du PNDS 2023-2026 a été guidé par les principes de la Gestion Axée sur les Résultats (GAR) faisant intervenir des outils de planification stratégique notamment l'analyse des Forces-Faiblesses et Opportunités-Menaces (FFOM), l'analyse causale, et l'analyse des parties prenantes. Ce processus a été organisé autour de plusieurs étapes majeures, sous forme d'entretiens, de visites aux structures et d'ateliers. Ces étapes sont :

## ▪ Préparation et élaboration du document

Cette étape a consisté à :

- ✓ l'élaboration de la note méthodologique qui a permis l'identification de l'ensemble des activités nécessaires à l'évaluation du PNDS 2018-2022 ;
- ✓ la collecte et l'analyse des données, qui se sont déroulées en quatre (4) moments à savoir : (i) la revue documentaire qui a permis de faire le point sur l'ensemble des informations disponibles concernant la situation sanitaire nationale ; (ii) les entretiens et les séances de travail avec les groupes thématiques mis en place en vue de disposer des informations reflétant l'état actuel de la situation sanitaire ; (iii) les visites de terrain pour collecter les informations supplémentaires ; (iv) le traitement et (v) l'analyse des données collectées.
- ✓ l'évaluation finale du PNDS 2018-2022 qui a permis d'apprécier le niveau d'atteinte des objectifs fixés ;
- ✓ l'analyse à travers laquelle les problèmes majeurs ainsi que leurs causes ont été identifiés. Cet exercice a abouti à l'identification des principaux défis majeurs auxquels le Congo devra faire face au cours des quatre prochaines années et à la définition des priorités nationales, en lien avec les ODD et divers autres engagements pris par le pays.
- ✓ le développement du cadre stratégique du PNDS 2023-2026 ayant permis de : i) rappeler la vision de la PNS 2018-2030 et de formuler (ii) les orientations stratégiques et les interventions ; (iii) les différents niveaux de résultat (impact, effets et produits) assortis d'indicateurs pertinents et (iv) les différentes actions prioritaires.

## ▪ Budgétisation du PNDS

La budgétisation du PNDS 2023-2026 a été faite à l'aide de l'outil « **One Health Tools** » (OHT). Elle a consisté à la formation d'un pool d'experts nationaux à l'utilisation de cet outil, puis à la collecte des données auprès des structures du ministère de la Santé et des autres ministères techniques (notamment le Plan et le Budget) et enfin à l'intégration des données dans l'outil.

## ▪ Elaboration du plan de suivi et évaluation

Pour suivre les activités des principaux programmes retenus dans le PNDS et évaluer leur succès, un plan de suivi et évaluation a été élaboré de façon participative.

## ▪ Validation et diffusion

Dans le cadre d'une appropriation collective en vue d'une synergie intersectorielle, la validation du PNDS 2023-2026 a été faite de façon consensuelle au cours d'un atelier réunissant les principaux cadres issus de toutes les parties prenantes. Après cette étape de validation, le plan a été diffusé aux acteurs, tant du niveau central que du niveau intermédiaire et périphérique pour les besoins d'appropriation.

## ▪ Limites de l'étude et difficultés rencontrées

L'élaboration du PNDS 2023-2026 a été confrontée essentiellement à une difficulté d'avoir des données factuelles à cause, d'une part, à une évaluation approximative du PNDS 2018-2022 et de l'éclosion de la pandémie COVID-19, d'autre part, à la réalisation des enquêtes comme l'EDS et l'ECOM. Par conséquent, les « base line » qui doivent servir de projections sont choisis à partir des données de routine et dans les rapports de l'OMS qui utilisent les modèles mathématiques pour l'ensemble des pays de la région africaine.

Les acteurs de l'élaboration du PNDS 2023-2026 ont rencontrés quelques difficultés en lien avec :

- ✓ la faible qualité des données ;
- ✓ le mauvais archivage des rapports dans les structures du ministère ;
- ✓ l'indisponibilité de plusieurs responsables des structures du ministère de la santé et de la population dans les échanges avec les consultants.

### II.1. Contexte géographique et démographique

#### II.1.1. Contexte géographique

Située en Afrique centrale, à cheval sur l'équateur, la République du Congo s'étend sur une superficie de 342.000 km<sup>2</sup>. Le pays dispose d'une façade maritime de 170 km sur l'Atlantique et partage ses frontières avec 5 pays, à savoir : le Gabon à l'Ouest sur 1.903 km, le Cameroun au Nord-Ouest sur 523 km ; la République Centrafricaine au Nord sur 467 km ; la République Démocratique du Congo à l'Est sur 2.410 km le long du fleuve Congo et enfin l'Angola par l'enclave du Cabinda au Sud sur 201 km.

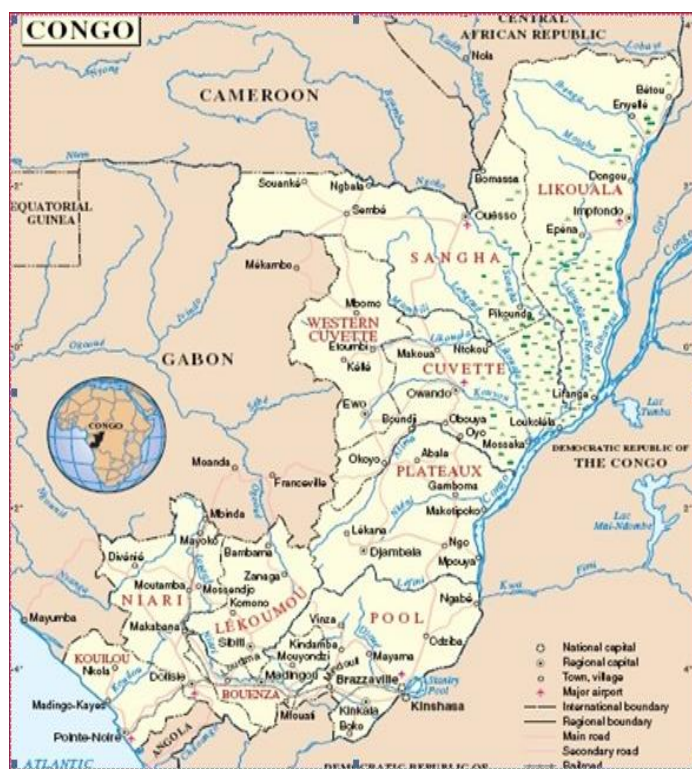


Figure 1 : Carte géographique du Congo

De par sa position géographique, le Congo a un climat du type équatorial marqué par deux saisons : la saison des pluies qui va d'octobre à avril avec des températures chaudes et humides et la saison sèche de mai à septembre. La température moyenne annuelle est de 25.50 C et la pluviométrie annuelle est en moyenne de 1376 mm<sup>3</sup> par an. Sur l'année, le Congo jouit de trois types de climats : un climat équatorial au nord ; un climat subéquatorial au centre, et un climat tropical humide au sud.

Le réseau hydrographique du Congo est composé de deux principaux bassins fluviaux : i) le bassin du Congo, situé sur le territoire congolais ; le principal collecteur est le fleuve Congo ; ii) le bassin du Kouilou-Niari dont le collecteur le plus important est le fleuve Kouilou. Il porte le nom de Niari dans son cours moyen et celui de N'Douo dans son cours supérieur.

Ces deux bassins constituent d'importants axes de circulation et une réserve riche en ressources halieutiques. Des crues occasionnent des inondations cycliques dans les départements de la Likouala, de la Cuvette et de la Sangha. Ce profil climatologique et géomorphologique a incontestablement une forte influence sur le profil épidémiologique du pays.

## II.1.2. Contexte démographique <sup>3</sup>

Le dernier recensement général de la population et de l'habitat (RGPH5) date de 2023 avec une population résidente de 6.142.180 habitants, dont 3.092.238 de femmes et 3.049.942 d'hommes et un rythme de croissance annuel intercensitaire de 3,2%. En d'autres termes, la population féminine représente 50,3% tandis que celle des hommes représente 49,7% de la population totale. Cette population est concentrée dans les départements qui abritent les deux grandes agglomérations (58,2%), Brazzaville avec 2.145.783 d'habitants et Pointe-Noire avec 1.420.612 d'habitants<sup>4</sup>. Pour le reste des départements, la population se répartit comme indiqué dans le tableau1.

**Tableau 1: Répartition de la population par département et par sexe, 2023**

| Département     | Année 2023       |                  |                  |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|
|                 | Homme            | Femme            | Ensemble         |
| Kouilou         | 52 111           | 45 251           | 97 362           |
| Niari           | 160 761          | 174 102          | 334 863          |
| Lékoumou        | 50 313           | 50 246           | 100 559          |
| Bouenza         | 180 914          | 182 936          | 363 850          |
| Pool            | 197 707          | 196 825          | 394 532          |
| Plateaux        | 137 918          | 145 503          | 283 421          |
| Cuvette         | 153 648          | 162 951          | 316 599          |
| Cuvette – Ouest | 58 280           | 61 048           | 119 328          |
| Sangha          | 113 359          | 96 342           | 209 701          |
| Likouala        | 174 270          | 181 300          | 355 570          |
| Brazzaville     | 1 061 708        | 1 084 075        | 2 145 783        |
| Pointe-Noire    | 708 953          | 711 659          | 1 420 612        |
| Total           | <b>3 049 942</b> | <b>3 092 238</b> | <b>6 142 180</b> |
|                 | <b>49,65%</b>    | <b>50,34%</b>    | <b>100%</b>      |

Le territoire congolais est parmi les moins densément peuplés d'Afrique avec 15,5 habitants au kilomètre carré. La population est inégalement répartie sur le territoire national. En 2023, les deux plus grandes villes (Brazzaville et Pointe-Noire) concentraient 3 566 395 habitants (58,06 %) dont 2 145 783 à Brazzaville (RGPH, 2023). L'exode des populations rurales vers ces localités est justifié par les opportunités de formation et d'emplois qu'elles offrent.

<sup>3</sup> Source : RGPH-5 2023

<sup>4</sup> RGPH-5 Congo : 2023

La population active (15 ans et plus) est, selon le RGPH-5, estimée à 3 445 973 personnes, composée à parts presque égales des femmes (1 739 666) et des hommes (1 706 307) en 2023.

## II.2. Contexte politique et administratif

Indépendante depuis le 15 Août 1960, la République du Congo est, comme le stipule la dernière constitution du 25 Octobre 2015, un État de droit, souverain, unitaire et indivisible, décentralisé, laïc et démocratique.

### II.2.1. Situation politique

Au plan politique, le Congo a opté, au début des années 90, pour le multipartisme. Le Congo a élaboré la dernière constitution dite constitution du 25 Octobre 2015. Cette dernière a instauré le régime semi présidentiel. Les institutions issues de cette nouvelle Constitution ont été progressivement mises en place.

### II.2.2. Situation administrative

**La loi n°3-2003 du 17 janvier 2003**, fixant l'organisation administrative territoriale, subdivise le pays en douze (12) Départements, seize (16) Communes, vingt-trois (23) Arrondissements, quatre-vingt-huit (88) Districts, cinquante-deux (52) Communautés urbaines, six (6) Communautés rurales, sept cent vingt (720) Quartiers et trois milles deux cent quatre-vingt-seize (3296) villages.

**La loi n°10 du 06 février 2003** transfère trois domaines de compétences aux collectivités locales : (i) la gestion de la santé, (ii) l'activité sociale et (iii) la protection civile. Les Départements sont placés sous l'autorité des Préfets, les Districts, les Communes et les Arrondissements sont administrés, respectivement par les Sous-Préfets, les Maires et les Administrateurs Maires Délégués.

La décentralisation a été amorcée avec la mise en place de conseils départementaux et municipaux. Le transfert de compétences et des ressources associées est en cours d'étude pour une mise en place effective. En parallèle, le statut de la Fonction publique territoriale a été prévu par **la loi n°5-2005 du 25 mai 2005 portant statut de la Fonction publique territoriale**. Cette dernière a fait l'objet de dix-huit décrets d'application adoptés en conseil des ministres le 29 décembre 2011.

Il sied aussi de noter que dans les faits, le fonctionnement de l'Etat demeure encore assez centralisé. Le processus de décentralisation tarde à produire tous ses effets.

## II.3. Contexte socio-économique

Le Congo, pays à revenu intermédiaire inférieur, est classé au 153<sup>ème</sup> rang mondial sur 189 pays avec un indicateur du développement humain (IDH) de 0,571 selon le rapport du développement humain 2020-2021<sup>5</sup>. Selon la Banque Mondiale, avec un revenu national brut (RNB) par habitant relativement élevé estimé à 1705 US\$ en 2019 et 1732 US\$ en 2020, 35 % de sa population vivait en-dessous du seuil de pauvreté en 2016 contre 39,6% en 2011. Le taux brut de scolarisation (TBS) primaire est de 107,6 pour les filles et 100,6% pour les garçons en 2019, tandis que le taux d'alphabétisation des personnes âgées de 15 ans et plus est de 79,3% (86,4% pour les hommes et 72,9% pour les femmes).

Selon le BIT, en 2020 le chômage a concerné 10,3% de la population active totale contre 9,6% en 2019. Le chômage touche de plus en plus les jeunes de 15 à 24 ans qui sont en général les primo-demandeurs d'emploi. Le taux de chômage dans cette tranche d'âge était estimé à 21,6% contre 6,7% pour les plus de 25 ans en 2019. Le taux de pauvreté au Congo selon la Banque Mondiale était de 52,5% en 2020.

---

<sup>5</sup> PNUD, Rapport sur le Développement Humain, 2019

<sup>5</sup> RGPH-5 Congo : 2023

<sup>5</sup> Revue de la performance du portefeuille des projets financés par la Banque mondiale au Congo, CPPR 2023.



Le système éducatif du Congo se caractérise par des taux bruts de scolarisation (TBS) qui dépassent les 100% (106,1% au primaire en 2019-2020). Cependant, l'enseignement primaire présente des faibles performances en termes d'acquis scolaires, 66,6% des élèves n'atteignent pas le seuil « suffisant » en mathématiques et 21% ne l'atteignent pas en français.

L'accès aux services sociaux de base reste préoccupant. En 2019, seulement 48,3% de la population a eu accès à l'électricité et 68% à l'eau potable. Un quart de la population dispose de toilettes modernes privées. Les autres utilisent des installations sanitaires précaires.

### **II.3.1. Situation économique et financière<sup>6</sup>**

Entre 2015 et 2023, la croissance annuelle du PIB réel du Congo a été de -1,9% en moyenne, tandis que son PIB par habitant s'est contracté de 32%, principalement en raison de la forte dépendance du Congo au pétrole.

L'activité économique reprend, mais la croissance du PIB reste modeste : elle est estimée à +1,9% en 2023 (un taux pas assez fort, la croissance du PIB réel par habitant étant estimée à -0,5% en 2023).

Le Congo a besoin d'une croissance économique plus forte et plus inclusive pour diminuer le taux de pauvreté de la population qui a augmenté à 46,8% en 2023.

La reprise en 2023 a été tirée par le secteur non pétrolier (+2,8%) en revanche, le secteur pétrolier a sous-performé (-0,5%) pour la quatrième année consécutive.

La discipline budgétaire et des réformes fortes telles que l'augmentation de 30% des prix des carburants à la pompe contribuent à maintenir l'excédent budgétaire (estimé à 3,6% du PIB en 2023).

L'ajustement des prix des carburants et l'augmentation de la demande intérieure contribuent à une hausse temporaire de l'inflation qui s'établit à 4,3%.

La dette publique reste élevée (96% du PIB en 2023) et, bien que la dette du Congo soit jugée « viable », le Congo est toujours considéré en « surendettement » en raison de la restructuration et de l'audit en cours des arriérés intérieurs, ainsi que de l'accumulation récurrente d'arriérés temporaires.

L'économie congolaise devrait poursuivre sa reprise progressive, avec un PIB qui devrait croître de 3,5% en 2024 et de 3,4% en moyenne en 2025-2026. La croissance sera principalement tirée par l'augmentation des investissements dans le secteur pétrolier, le développement du secteur gazier et par l'apurement continu des arriérés de l'Etat envers les entreprises nationales, l'augmentation progressive des dépenses sociales et des investissements publics et la mise en œuvre des réformes de la gouvernance et de l'environnement des affaires qui soutiendront la croissance de l'économie non pétrolière.

La reprise économique reste fragile : les risques pouvant impacter négativement les perspectives comprennent la volatilité des prix du pétrole et l'instabilité de la production pétrolière, une demande mondiale plus faible que prévu, un nouveau resserrement des conditions financières, des conditions météorologiques défavorables et des retards dans la mise en œuvre des réformes.

### **II.4. Contexte international**

Le contexte international est marqué par l'adoption par les Nations Unies, en septembre 2015, de la résolution relative au Programme de Développement Durable. Ce programme a défini les Objectifs

---

de Développement durable (ODD) qui incluent une dimension économique, sociale et environnementale et s'inscrit également dans la poursuite du travail non achevé relatif aux OMD.

Il comprend dix-sept (17) ODD dont le troisième ODD qui stipule « **Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge** ». Le troisième ODD comprend treize (13) cibles dont la cible 3.8, relative à la couverture sanitaire universelle. Le principe de base de l'ODD3 repris au point 26 de ladite résolution stipule « ne laisser personne pour compte ».

| Généralités et santé des populations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Le contexte géographique est favorable à la persistance des maladies tropicales d'intensité variable selon les territoires ; cela devrait inciter à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques départementales de santé publique contre ces maladies.</li><li>➤ La forte tendance de la concentration démographique en zones urbaines devrait orienter les politiques publiques vers l'intégration des problématiques de santé urbaine. Il paraît aussi nécessaire au regard de la jeunesse de la population congolaise (56 % des moins de 20 ans), de valoriser les politiques de prévention des risques en direction des jeunes (lutte contre les violences, sécurité routière, le VIH/IST, la consommation des drogues, ...).</li><li>➤ Le contexte politico-administratif pourrait favoriser le rapprochement des collectivités territoriales avec le système de santé en vue de renforcer la participation et l'investissement de la composante locale dans les prises de décision et la gestion des districts sanitaires.</li><li>➤ Le contexte économique et financier demeure préoccupant malgré l'amélioration de la situation macro-économique liée à l'envolée des prix des matières premières du fait de la guerre en Ukraine. L'accélération de l'entrée en exploitation de la Caisse d'assurance maladie universelle apparaît comme une solution incontournable pour réduire les contraintes financières d'accès aux soins de santé des populations et corrobore les préconisations internationales inscrites dans l'ODD 3 relatif à la couverture universelle en santé.</li></ul> |



### III.1. Organisation du système de santé

Le système de santé congolais est de type pyramidal à trois (3) niveaux et deux versants : un versant organisation administrative et un versant offre des prestations de soins et services de santé. La figure 2 ci-après schématise l'organisation du système de santé congolais.

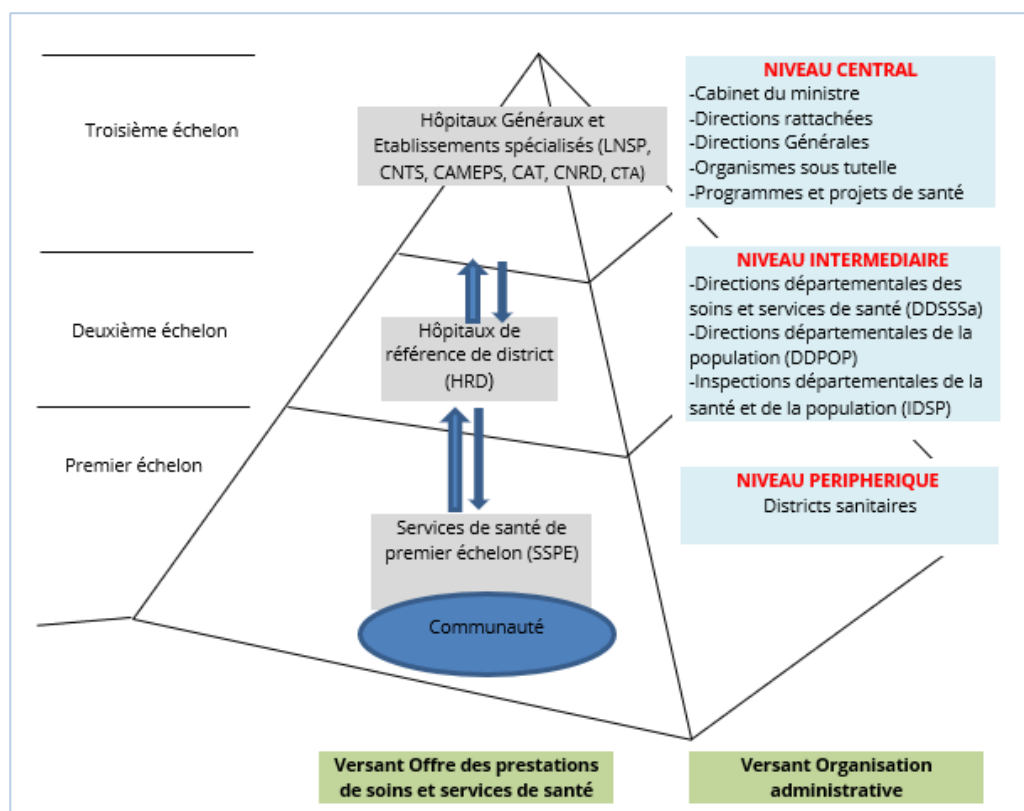


Figure 2 : Schéma de l'organisation du Système de santé du Congo

#### III.1.1. Organisation administrative

Le socle juridique et réglementaire de l'organisation du Ministère en charge de la santé et de la population du Congo est constitué par le **décret n° 2018 - 268 du 2 juillet 2018** portant organisation du Ministère de la santé et de la population. Au plan administratif, le système de santé compte trois niveaux hiérarchiques : niveau central, intermédiaire et périphérique ou opérationnel.

##### 1. Niveau central

Le rôle du niveau central est stratégique, normatif et régulateur. Il a également la responsabilité de la coordination de l'ensemble du secteur et de la mobilisation et l'allocation des ressources. Il est représenté par le cabinet du ministre de la santé et de la population, les directions rattachées au cabinet (direction des études et de la planification, direction de l'information sanitaire, de l'évaluation et de la recherche, la direction de la coopération, la direction des technologies de l'information et de la communication), l'Unité de coordination des programmes et projets, la cellule de gestion des marchés publics, l'Inspection générale de la santé, les structures sous tutelle (le Centre Hospitalier et Universitaire de Brazzaville, le Laboratoire national de santé Publique, le Centre National de Transfusion sanguine, les hôpitaux généraux et spécialisés, le Centre de traitement de l'insuffisance rénale, le Centre National de référence de la drépanocytose **Antoinette SASSOU N'GUESSO**, la Centrale d'Achat des Médicaments essentiels et Produits de Santé) et trois (3) directions générales : la direction générale de la population (DGPOP), la direction générale de

l'administration et des ressources humaines (DGAR) et la direction générale des soins et services de santé (DGSSSa).

Les centres de traitement ambulatoires spécialisés assurent la prise en charge (PEC) des pathologies spécifiques : le Centre National de Référence de la Drépanocytose (CNRD) **Antoinette SASSOU N'GUESSO** de Brazzaville, 2 centres de traitement ambulatoire (CTA) pour l'infection à virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et 2 centres antituberculeux (CAT) à Brazzaville et à Pointe-Noire.

## **2. Niveau intermédiaire**

Ce niveau est constitué des structures qui jouent un rôle d'appui technique aux districts sanitaires (DS) dans la transmission des informations, l'adaptation des normes nationales aux conditions locales et la supervision des DS. Il est représenté par les directions départementales en charge de la santé que dispose le Congo. Les territoires des départements sanitaires obéissent au découpage administratif du pays. Le nouvel organigramme du MSP a doté les départements de trois directions départementales : i) directions départementales des soins et services de santé (DDSSSa) ; ii) directions départementales de la population (DDPOP) ; iii) inspections départementales de la santé et de la population (IDSP).

## **3. Niveau périphérique**

Il est représenté par le district sanitaire. Le Congo avait opté pour le Système de santé intégré de district (SSID) depuis les années 1990, suite à l'expérimentation de la 1ère circonscription socio-sanitaire (actuellement district sanitaire) de Dolisie. De nos jours, le pays est découpé en 52 DS selon l'Arrêté n°5369 du 02 août 2017.

Chaque district sanitaire est subdivisé en aires de santé. Il comprend, pour son fonctionnement, selon le **Décret-n°2020-551-du-15-octobre-2020** portant attributions et fonctionnement des organes de gestion du DS, un Comité de gestion (organe délibérant), une Equipe Cadre du District (organe de prise de décision) et une équipe de gestion (organe de gestion).

### **III.1.2. Organisation de l'offre des prestations de soins et services de santé**

Le système de dispensation des soins et services de santé congolais est assurée par deux secteurs (public et privé). Ce système est structuré en trois échelons parmi lesquels les deux premiers constituent le district sanitaire et le 3ème échelon représente le deuxième niveau de recours.

#### **III.1.2.1. Premier échelon**

Le premier échelon est constitué des formations sanitaires du 1<sup>er</sup> échelon. C'est le niveau de premier contact entre la population et le système de santé. Les formations sanitaires du 1<sup>er</sup> échelon offrent un ensemble d'activités appelées « paquet minimum d'activités (PMA) fondés sur les soins de santé primaires (SSP). Ces soins et services doivent être accessibles (géographiquement, socialement, financièrement, culturellement) et acceptables aux populations de leur responsabilité.

#### **1. Centre de santé intégré (CSI) et le paquet minimum d'activités (PMA)**

Le CSI est une structure de soins de 1<sup>er</sup> échelon au niveau du district sanitaire. Placé sous le contrôle technique de l'équipe cadre du district sanitaire, le centre de santé intégré est responsable de toutes les prestations de soins et des services dans l'aire de santé où il est implanté. Les CSI offrent un paquet minimum d'activités standards (PMAS) couvrant les activités promotionnelles, préventives, curatives, palliatives et ré adaptifs.

Il existe 3 catégories de CSI : i) le CSI à paquet minimum d'activités standards (CSI/PMAS) ; ii) le CSI à paquet minimum d'activités élargi aux accouchements (CSI/PMAE type I) ; iii) le CSI à paquet minimum d'activités élargi aux actes chirurgicaux de base (CSI/PMAE type II).

Le pays compte à ce jour 344 CSI publics dont 211 CSI à PMAE I, 25 CSI à PMAE II, 108 CSI à PMAS et 319 postes de santé. Selon le Décret 2020-553 du 15 octobre 2020 portant attributions, organisation et fonctionnement des organes de gestion des CSI et des postes de santé, il ressort que les ratios

CSI/population sont loin de s'approcher de la norme (1 CSI pour 2500-5000 habitants en milieu rural) et 1 CSI pour 5000 à 10000 habitants en milieu urbain).

**Tableau 2 : Repartition des FOSA de 1<sup>er</sup> échelon par département**

| Départements         | CSI PMAS   | CSI PMAE 1 | CSI PMAE 2 | PS         | Total      |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Likouala</b>      | 2          | 7          | 2          | 13         | 24         |
| <b>Sangha</b>        | 4          | 3          | 2          | 12         | 21         |
| <b>Cuvette-Ouest</b> | 13         | 1          | 3          | 30         | 47         |
| <b>Cuvette</b>       | 17         | 7          | 2          | 44         | 70         |
| <b>Plateaux</b>      | 6          | 27         | 1          | 87         | 121        |
| <b>Pool</b>          | 10         | 45         | 1          | 39         | 95         |
| <b>Bouenza</b>       | 4          | 16         | 1          | 34         | 55         |
| <b>Lékoumou</b>      | 10         | 9          | 2          | 9          | 30         |
| <b>Niari</b>         | 12         | 35         | 6          | 21         | 74         |
| <b>Kouilou</b>       | 0          | 26         | 0          | 21         | 47         |
| <b>Pointe-Noire</b>  | 11         | 19         | 2          | 7          | 39         |
| <b>Brazzaville</b>   | 19         | 16         | 3          | 2          | 40         |
| <b>Total</b>         | <b>108</b> | <b>211</b> | <b>25</b>  | <b>319</b> | <b>663</b> |

Source : Rapport DGSSSa, 2022

## 2. Participation communautaire

La population bénéficiaire participe à la gestion du système de santé de district (SSD) à travers les comités de gestion (COGES) et des comités de santé (COSA). Ce sont des organes de participation communautaire qui soutiennent le fonctionnement du système de santé au niveau périphérique, conformément au Décret 2020-553 du 15 octobre 2020 susmentionné.

En 1992, le Congo a fait le choix d'un système de santé décentralisé (loi n° 014/92 du 29 avril 1992 instituant le Plan national de développement sanitaire) qui fait de la participation communautaire l'une des stratégies clés pour améliorer l'état de santé de la population avec sa pleine participation à la gestion du système de santé.

La mobilisation et la participation des communautés sont envisagées dans la déclaration d'Alma-Ata sur les soins de santé primaires en 1978 et dans la charte d'Ottawa pour la promotion de la santé en 1986 (SCHEEN, B.)<sup>7</sup>. En effet, la participation communautaire est reconnue comme une composante essentielle des soins de santé primaires (OMS, 1978 p.55)<sup>8</sup> et une des stratégies de promotion de la santé (OMS, 1986)<sup>9</sup>. Elle s'est largement imposée aux grands choix politiques comme à la planification, à l'exécution et au contrôle des programmes de développement (OMS,

<sup>7</sup> SCHEEN Bénédicte, Promotion de la santé et démarches participatives : Décryptage et points d'attention, Woluwe-Saint-Lambert : RESO, 2018, p.3

<sup>8</sup> OMS, Déclaration d'Alma-Ata sur les soins de santé primaires, 1978

<sup>9</sup> OMS, Charte d'Ottawa pour la promotion de la santé, 1986

1978 p.56). Aussi, la promotion de la participation communautaire est l'un de quatre principes de l'Initiative de Bamako.

Depuis lors, la réponse communautaire aux divers défis auxquels le pays est confronté dans le domaine de la santé s'est exprimée à travers l'implication de trois entités distinctes que sont (i) les organes de participation communautaire : les Comités de santé (COSA) et Comité de gestion (COGES), (ii) les agents de santé de village (AVS), les relais communautaires et (iii) les Organisations non gouvernementales (ONG).

Les comités de direction (CODIR), les comités de gestion (COGES), les comités de santé (COSA) sont mis en place et sont opérationnels. Au 31 décembre 2020, 179 CSI sur 344 disposent des COSA, soit 52,03%. Les CDS ne sont pas encore mis en place. Les outils pour la mise en œuvre de la politique de santé à base communautaire ont été validés. Dès lors, il serait nécessaire d'accélérer la mise en œuvre des différentes étapes prévues au titre de la mise en place de la politique nationale de santé communautaire.

Dans le cadre de cette politique, il est essentiel que la stratégie de motivation des relais communautaires soit définie et inscrite dans la durabilité. En outre, au-delà de l'élaboration des différents documents en lien avec la santé communautaire, il sera également important de développer un modèle de gestion du paquet d'activités de santé communautaire dans les districts sanitaires ayant les prérequis souhaités.

La prise en compte de ces deux dispositions devrait améliorer la qualité de la politique nationale de santé communautaire et faciliter son opérationnalisation. Au regard du niveau actuel, il importe de souligner que l'effectivité de la mise en œuvre de la santé communautaire dans les aires de santé telle que prévue par le PNDS 2018-2022, dépendait (i) de la mise en œuvre du plan stratégique national de la santé communautaire 2021-2024 validé en mars 2021 ; celui-ci n'est ni vulgarisé, ni opérationnalisé (ii) de la définition d'une stratégie claire de motivation des relais communautaires et (iii) des capacités des équipes des CSI et des COSA à accompagner les relais communautaires dans leurs travail au quotidien.

### **3. Structures opérationnelles de la santé de reproduction maternelle, néonatale, infantile, des adolescents et la nutrition (SRMNIA) et paquet de service**

À la suite du plan stratégique de la santé de reproduction maternelle, néonatale, infantile, des adolescents et la nutrition (PSI-SRMNIA 2018-2022), le pays s'est doté d'un autre plan couvrant la période 2022-2026.

L'offre des soins prénatals (SPN) et préscolaires pour les enfants de moins de 5 ans est disponible en ambulatoire dans le public dans les CSI et dans le privé dans les centres médicaux sociaux (CMS) et certains cabinets médicaux. L'hospitalisation des enfants est assurée dans les services de pédiatrie des hôpitaux et les cliniques. Les accouchements sont réalisés dans les maternités des hôpitaux, les CSI à PMAE, les cliniques et quelques CSI à PMA standard en milieu rural. Pour la santé des adolescents et des jeunes, le pays dispose d'un centre de santé universitaire à Brazzaville et de quelques centres de santé scolaire implantés dans les établissements scolaires.

#### **III.1.2.2. Deuxième échelon**

Le deuxième échelon du système des soins et services de santé congolais est constitué de 31 hôpitaux de district, appelés communément au Congo, « Hôpitaux de Base » ou « Hôpitaux de Référence ». Cet échelon constitue le premier niveau de référence des malades venant des FOSA du 1<sup>er</sup> échelon.

##### **1. Hôpitaux de Référence de District (HRD)**

Selon le Décret n°2020-552 du 15 octobre 2020 portant attributions, organisation et fonctionnement des organes de gestion de l'hôpital de référence du district sanitaire, les missions de ces derniers sont les suivantes : (i) dispenser les soins promotionnels, préventifs, curatifs, palliatifs et ré adaptatifs de qualité ; (ii) dispenser aux femmes enceintes des soins et services de qualité à la mère

et à l'enfant ; (iii) assurer la permanence et la continuité des soins aux patients y compris la référence et contre référence ; (iv) participer aux actions de santé publique du district sanitaire, notamment celles relatives à la santé communautaire ; (v) participer à la formation du personnel médical, para médical et d'appui dans leur domaine de compétence ; (vi) assurer la gestion de l'information sanitaire et la surveillance épidémiologique ; (vii) réaliser la recherche opérationnelle.

L'analyse situationnelle réalisée dans 19 HRD du Congo par la DGSSSa, dans le cadre de la réforme hospitalière de 2022, montre que le partogramme n'est pas systématiquement utilisé dans les maternités des hôpitaux visités. On note une absence des protocoles Thérapeutiques Standards (PTS) et la faible intégration des activités liées aux programmes spécifiques dans les HRD enquêtés.

Exceptées Brazzaville et de Pointe-Noire, toutes les FOSA du deuxième échelon sont généralement situées dans les chefs-lieux de départements ou des sous-préfectures. Ces FOSA ayant des statuts d'hôpitaux, sont administrées par une équipe de direction, sous tutelle administrative et technique des directions départementales. Elles ont pour mission d'améliorer l'accès aux soins en offrant un ensemble d'activités appelées « paquet complémentaires d'activités (PCA) » constitué des services d'hospitalisation, urgences médico-chirurgicales, urgences gynéco-obstétricales, urgences pédiatriques, explorations et examens paramédicaux (imagerie médicale et examens de laboratoire). Les dispositions légales précisent qu'un Hôpital Général situé dans un district sanitaire sans HRD joue le rôle de l'échelon de 1<sup>er</sup> recours pour cette entité.

## 2. Hôpitaux militaires

Le Congo dispose d'un réseau des FOSA des Forces Armées Congolaises (FAC) qui comprend l'Hôpital Central des Armées Pierre Mobengo à Brazzaville, les deux hôpitaux régionaux de Pointe-Noire et de Dolisie, la Clinique médico-chirurgicale Océan de Pointe-Noire et 10 infirmeries.

### III.1.2.3. Troisième échelon

Le troisième échelon est le second niveau de référence du système de soins et services de santé. Il est représenté par les 10 hôpitaux généraux (HG) dont la fonction principale est d'offrir des soins et services de santé du niveau tertiaire. Il s'agit de : le CHU, l'hôpital Central des armées Pierre Mobengo, l'HG Mère-Enfant Blanche GOMES et l'HG de Djiri à Brazzaville, l'HG Adolphe Sicé, l'HG de Loandjili et l'HG de Patra (Ngoyo) à Pointe Noire, l'HG de Dolisie dans le Niari, l'HG 31 juillet d'Owando et l'HG Edith Lucie Bongo Odimba d'Oyo dans le Département de la Cuvette.

Dans le souci d'améliorer l'accès aux soins et services de santé spécialisés, le pays entreprend la construction de deux (02) nouveaux HG ou départementaux tous les ans jusqu'à atteindre les 12 prévus par le Gouvernement, dans le cadre du Projet Santé pour tous du projet de société du Chef de l'Etat.

En plus des HG, le troisième échelon est aussi constitué des établissements spécialisés d'appui au traitement et au diagnostic ; il s'agit, pour le traitement, i) du Centre National de Référence de la Drépanocytose (CNRD) **Antoinette SASSOU N'GUESSO**, ii) des deux Centres de Traitement Ambulatoire (CTA) contre le VIH/Sida et, iii) de deux Centres antituberculeux (CAT). On compte également (iv) le Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS), (v) la Centrale d'Achat des Médicaments Essentiels et des Produits de Santé (CAMEPS), (vi) le Laboratoire National de Santé Publique (LNSP).

Le secteur privé constitue un partenaire important pour la couverture sanitaire universelle (CSU), situation dans laquelle toutes les personnes et toutes les communautés ont accès aux services de santé essentiels de qualité dont elles ont besoin sans se heurter à des difficultés financières.

En février 2019, a eu lieu à Addis-Abeba, une réunion de l'Union Africaine (African Leadership Meeting, ALM) à l'occasion de laquelle un engagement important a été pris à travers une déclaration. Cette Déclaration de l'Union africaine intitulée « *Engagement d'Addis-Abeba en vue d'une responsabilité partagée et d'une solidarité universelle pour un financement accru de la santé* », également connue sous le nom de Déclaration ALM, vise à renforcer la coopération entre les secteurs public et privé pour

un système de santé durable, efficace, efficient et équitable pour tous, et à préserver la sécurité sanitaire en Afrique<sup>10</sup>. Un élément essentiel à la mise en œuvre de la Déclaration ALM est de comprendre la contribution du secteur privé aux soins de santé dans les différents pays.

Au Congo, le secteur privé de la santé est en plein essor. Il est régi par le **Décret n°88/430 du 6 juin 1988 fixant les conditions d'exercice libéral de la médecine et des professions paramédicales et pharmaceutiques au Congo**. Il se subdivise en deux sous-secteurs : le privé à but non lucratif et le privé à but lucratif. Il est composé de structures pharmaceutiques, de soins, de laboratoire et d'imagerie médicale.

Le secteur privé à but non lucratif est constitué des FOSA des confessions religieuses, des ONG, des Associations et de certaines entreprises (SARIS, CIB, BRALICO, ...). Par contre, le secteur privé à but lucratif, par contre, est constitué des structures sanitaires non publiques, fondées sur la recherche du profit. Elles appartiennent à des particuliers ou à des groupes d'actionnaires. *Nombreuses d'entre-elles ne disposent pas d'autorisation d'exercice et ne respectent pas les plans de découpage des DS, donc de la carte sanitaire, causant ainsi d'énormes problèmes de contrôle et de régulation.*

Dans le registre de FOSA de 1<sup>er</sup> échelon, on compte les structures privées d'offre de soins constituées en secteur privé conventionnel et secteur privé confessionnel. En 2017, le pays comptait pour le secteur privé conventionnel de 1<sup>er</sup> échelon, 71 centres médico-sociaux (8,1%), 167 cabinets médicaux (19,2%), 19 cabinets dentaires (2,2%), 11 cabinets de kinésithérapie (1,3%) et 499 cabinets de soins infirmiers (57,2%). Le secteur privé confessionnel participe également à l'offre de soins au niveau primaire.

Près de 70 % de ces FOSA privées sont concentrées en zones urbaines (Brazzaville et Pointe-Noire), et parfois, géographiquement proches des FOSA publiques, créant ainsi de la concurrence déloyale, au lieu de combler le déficit d'offre de soins en fonction des besoins du MSP dont souffre le milieu rural.

Le secteur pharmaceutique privé occupe une place prépondérante dans le système de santé national. Le pays comptait 192 officines et 155 dépôts pharmaceutiques en 2015.

#### III.1.2.4. Programmes et projets de santé

En dehors des directions générales et des directions centrales, le Ministère de la santé et de la population dispose des programmes spécifiques concernant divers domaines de santé prioritaires. A ce jour, on dénombre 14 programmes rattachés à l'Unité de Coordination des Programmes et Projets (UCPP) qui dépendent directement du Cabinet du Ministre. Il s'agit de :

- Programme Elargi de vaccination ;
- Programme national de lutte contre le paludisme ;
- Programme national de lutte contre la tuberculose ;
- Programme national de lutte contre l'onchocercose,
- Programme national de lutte contre le VIH/SIDA et les infections sexuellement transmissibles ;
- Programme national de lutte contre la Trypanosomiase ;
- Programme national de lutte contre la Schistosomiase ;
- Programme national de lutte contre la Lèpre, le Pian et l'Ulcère de Buruli ;
- Programme national de lutte contre le Cancer ;
- Programme national de lutte contre les Infections nosocomiales ;
- Programme national de lutte contre les hépatites virales ;
- Programme national de santé mentale ;
- Programme national de lutte contre l'Insuffisance rénale ;
- Programme national des césariennes

---

<sup>10</sup> ALM Declaration. AIDS Watch Africa, 2020



Les projets en cours de mise en œuvre sont les suivants :

- ✓ Projet de Renforcement du Système de Santé « Kobikisa » ;
- ✓ Projet Régional d'Amélioration des Systèmes de Surveillance des Maladies (REDISSE IV) ;
- ✓ Projet de Riposte d'Urgence au COVID-19 (PRUC-19) ;
- ✓ Projet de lutte anti vectorielle (PLAV).

La majorité de ces projets et programmes demeurent très dépendants des financements et d'appuis techniques extérieurs. Toutefois, la mobilisation des ressources financières n'a pas été à la hauteur des attentes, ce qui n'a pas permis i) de mettre en œuvre les interventions essentielles requises, ii) d'assurer la disponibilité des intrants, réactifs et produits de santé notamment. Ces difficultés, observées depuis le cycle stratégique précédent, n'ont pas permis entre autres l'atteinte des objectifs attendus.

### **III.1.2.5. Médecine traditionnelle**

Les gouvernements africains, par l'intermédiaire de leurs Ministres de la santé, ont adopté au cours de la cinquantième session du Comité régional de l'OMS pour l'Afrique tenue en 2000, une résolution sur la médecine traditionnelle dans laquelle les États Membres étaient invités à générer des données factuelles sur la sécurité, l'efficacité et la qualité de la médecine traditionnelle. Depuis plusieurs décennies, la médecine traditionnelle est surtout utilisée dans le secteur informel au Congo alors que l'intégration de cette médecine dans le système de santé suit son cours. Le pays regorge d'une flore abondante et riche capable de prendre en charge plusieurs pathologies.

Avec l'arrivée de la pandémie à Covid-19, l'OMS œuvre, de concert avec les instituts de recherche, pour sélectionner les produits issus de la pharmacopée traditionnelle sur lesquels des investigations peuvent être menées afin de déterminer leur efficacité clinique et leur innocuité dans le traitement de cette pandémie.

La percée de cette médecine au Congo se fait de manière croissante en pointant souvent l'inaccessibilité financière et l'incapacité de la médecine moderne à soigner les maladies graves et chroniques. Le Congo compte environ 51 centres de médecine traditionnelle. Elle permet de compléter l'offre de soins et d'en améliorer les performances dans l'optique de réduire le taux de morbi-mortalité au Congo.

## **III.2. Performances du système de santé**

### **III.2.1. Gouvernance, leadership et pilotage du système de santé**

#### **III.2.1.1. Cadre juridique du secteur de la santé**

La Constitution du 25 octobre 2015 en son article 36 consacre et garantit le droit à la santé aux citoyens. Cette dernière stipule en effet que : « l'État est garant de la santé publique ». Sur le plan institutionnel, il convient de noter que de nouveaux textes législatifs et réglementaires ont été pris ou révisés au cours des cinq (5) dernières années par le gouvernement, en vue de réguler de manière plus efficace les différentes activités du secteur de la santé. Il s'agit notamment de : (i) la promulgation de cinq nouveaux décrets, portant respectivement organisation du Ministère de la Santé et de la Population ( décret n°2018/268 du 2 juillet 2018), Inspection générale ( décret n° 2018/269 du 2 juillet 2018) et directions générales ( décret n° 2018/270 du 2 juillet 2018, décret 2018/271 du 2 juillet 2018 et décret n° 2018/272 du 2 juillet 2018), (ii) l'adoption de quinze lois portant création de tous les hôpitaux généraux et autres structures sous-tutelle et ; (iii) l'adoption d'un arrêté interministériel (Arrêté n° 5369 du 2 août 2017) portant découpage du pays en 52 districts sanitaires.

Malgré ces avancées, le volet juridique présente encore des faiblesses, notamment : (i) l'insuffisance des textes d'application du PNDS depuis sa promulgation en avril 1992 et (ii) le retard dans la production des textes d'application du nouveau décret (2018/268 du 2 juillet 2018), portant organisation du MSP.

### III.2.1.2. Politique Nationale de Santé et planifications stratégiques

Le Congo a élaboré sa deuxième Politique Nationale de Santé en 2018. Elle couvre la période de 2018-2030. Cette dernière tire ses fondements sur les engagements nationaux et internationaux pris par le pays. Les politiques de population et de santé ont été réorientées dans le monde suite à certaines recommandations mondiales auxquelles la République du Congo avait souscrit.

La loi n° 014-92 du 29 avril 1992 institue le plan national de développement sanitaire, seul cadre de référence pour la mise en œuvre de la politique de santé par le Gouvernement. A ce jour, ont été mis en œuvre successivement les PNDS couvrant les périodes 1992-1996, 2007-2011 et 2018-2022 ; la période des années 1998 à 2006 a été consacré essentiellement à des programmes d'urgences et de réhabilitation post-conflit.

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan National de Développement (PND) 2012-2016, le Programme biennal de développement sanitaire 2015-2016 était la déclinaison sectorielle de ce dernier. Renouant avec les exigences de la planification comme outil de référence et dans le souci de se conformer résolument au cycle de planification défini par le Gouvernement, le PNDS 2018-2022 a été élaboré et mis en œuvre dans le cadre du PND 2018-2022. Depuis l'adoption du PNDS, les interventions de l'ensemble des partenaires se sont progressivement alignées sur ses orientations stratégiques.

### III.2.1.3. Engagements nationaux et internationaux

La Politique Nationale de Santé (PNS 2018-2030) tire ses fondements sur les engagements nationaux et internationaux pris par le pays.

#### 1. Engagements nationaux

La Politique Nationale de Santé est fondée sur le cadre politico-juridique national, notamment :

- ✓ la Constitution du 25 octobre 2015 en son article 36 ;
- ✓ l'ensemble des textes législatifs et réglementaires en vigueur ;
- ✓ le projet de société 2021-2026 de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef de l'Etat « **Ensemble, poursuivons la Marche vers le développement** » ;
- ✓ le Plan National de Développement (PND) pour la période 2022-2026.

#### 2. Engagements internationaux

La République du Congo a souscrit à divers engagements internationaux qui sont pris en compte dans la Politique Nationale de Santé. Il s'agit entre autres de :

- ✓ la Charte des Nations Unies (1945) ;
- ✓ la Constitution de l'OMS (1946) ;
- ✓ la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (1981) ;
- ✓ les Objectifs du Développement Durable ;
- ✓ la Déclaration d'Alma Ata sur les Soins de santé primaires (1978), réaffirmée par la Déclaration de Ouagadougou (2008) et d'Astana (2018) ;
- ✓ la Déclaration des Chefs d'État et de gouvernement d'Abuja (2001) ;
- ✓ le Protocole de Kyoto ratifié le 12 février 2007 : accord international visant la réduction des émissions des six gaz à effet de serre. Il vient s'ajouter à la Convention cadre des nations Unies sur les changements climatiques ;
- ✓ la résolution AFR/R62/9 sur la promotion de la santé ;
- ✓ la Déclaration de Brazzaville 2012 sur les maladies non transmissibles
- ✓ le Cadre d'action de KYOTO 2005-2015 pour des Nations et des collectivités résilientes face aux catastrophes ;
- ✓ la Déclaration d'Addis Abeba sur l'immunisation (2015) ;
- ✓ les plans stratégiques globaux (2006-2015 ; 2011-2020 ; 2021-2030) et régionaux (2006-2009 ; 2014-2020) sur la vaccination et la surveillance des maladies évitables par la vaccination ;



- ✓ la Charte d'Ottawa pour la promotion de la santé (1986) ;
- ✓ le Programme d'action de la Conférence Internationale sur la Population et le Développement (Caire, 1994) ;
- ✓ la Déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide au développement (2005), l'appropriation, l'harmonisation, l'alignement, les résultats et la responsabilité ;
- ✓ le Règlement Sanitaire International (RSI) de 2005 ;
- ✓ l'Agenda 2063 de l'Union Africaine (UA) : cadre stratégique pour la transformation socio-économique du continent au cours des 50 prochaines années ;
- ✓ la Déclaration de Ouagadougou sur les SSP et les systèmes de santé en Afrique ;
- ✓ la Déclaration de Libreville sur la santé et l'environnement en Afrique (2008) ;
- ✓ la Déclaration d'Alger sur la recherche en santé (2008) ;
- ✓ la Déclaration de Tunis sur le financement de la santé (2012) ;
- ✓ la Stratégie globale en santé de la reproduction, maternelle, néonatale, infantile et des adolescents 2016-2030 ;
- ✓ l'engagement des pays de l'Afrique de l'Ouest et du centre pour des adolescents et jeunes éduqués, en bonne santé et épanouis à Brazzaville, le 6 Avril 2023 ;
- ✓ le 13<sup>ème</sup> Programme de travail de l'OMS 2019-2022 (2018) ;
- ✓ la Convention de Bamako (interdiction importation en Afrique des déchets dangereux, adoptée le 30 janvier 1991 ;
- ✓ la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux et de leur élimination, adoptée le 22 mars 1988 et entrée en vigueur le 5 mai 1992 ;
- ✓ la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants ;
- ✓ la Convention de Rotterdam (procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux) ;
- ✓ la Convention de Vienne (protection de la couche d'ozone) ratifiée le 16/11/1994 ;
- ✓ la Convention Cadres des Nations Unies sur les changements climatiques, ratifiée le 25 juin 1996 ;
- ✓ la Convention sur la Diversité Biologique (Loi n°29/96 du 25 juin 1996) ;
- ✓ le Code international de conduite pour la distribution et l'utilisation des pesticides ;
- ✓ les Directives de Londres sur le commerce international des substances chimiques potentiellement nocives.

Les politiques de population et de santé ont été réorientées dans le monde suite à certaines recommandations mondiales auxquelles la République du Congo avait souscrit. Il s'agit notamment de celles de (i) la Conférence Internationale sur la Population et le Développement (CIPD 1994) du Caire avec l'adoption du concept de Santé de la Reproduction (SR), (ii) du sommet du Millénaire à New York en 2000 avec les objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), et (iii) de la stratégie mondiale de la santé de la femme et de l'enfant 2030 en lien avec les objectifs de développement durable (ODD). Cette stratégie vise la réduction de 10% des risques sanitaires pesant sur les adolescents et les jeunes notamment les infections sexuellement transmissibles (IST) et à virus de l'immunodéficience humaine (VIH), les grossesses précoces et non désirées, l'alcoolisme, la toxicomanie, ainsi que la morbidité de la femme dues aux cancers gynécologiques et autres violences basées sur le genre.

#### III.2.1.4. Coordination du système de santé

Le système de santé congolais prévoit des organes de coordination à trois niveaux :

**Niveau national** : la coordination du système de santé est réalisée à travers le Conseil National de Santé, les comités de pilotages dont celui du PNDS, le comité de coordination inter-agence (CCIA) et le Comité de Coordination National (CCN), des projets financés par le Fonds Mondial. Ces instances sont souvent placées sous le pilotage, soit de la présidence de la République, soit sous la tutelle du Ministre en charge de la santé.

En dehors du CCIA et du CCN, les autres organes n'ont pas été fonctionnels pendant la mise en œuvre du PNDS 2018-2022. On note également que la multiplicité des organes ne favorise pas une bonne coordination du secteur, puisqu'il n'existe pas de liens entre ces différentes instances, ce qui entretient le caractère fragmenté du dialogue.

**Niveau départemental** : l'instance habilitée à coordonner les interventions sanitaires est le Conseil départemental de santé. Sous l'égide des Préfets, une expérience heureuse a débuté dans sept (7) directions départementales de santé sous PBF, avec la tenue régulière de comités départementaux de coordination de la santé (CDCS). Cette expérience devrait servir d'exemple dans la dynamisation des conseils départementaux de santé dans les 12 départements du pays.

**Niveau périphérique** : le cadre légal de fonctionnement d'un district sanitaire prévoit plusieurs organes de coordination et de participation communautaire dont les Comités de Gestion (COGES), les fédérations de comité de santé (FECOSA) et les Comités de santé (COSA). Tout comme au niveau départemental, leur fonctionnalité a été peu observée.

**Au plan interne**, le Ministère en charge de la santé a signé le 7 février 2017 un protocole d'accord avec l'Alliance du Secteur Privé de la Santé (ASPS). Le Ministère de la Santé et de la Population promeut également le dialogue public-privé en matière de santé, bien que le processus soit encore au stade d'expérimentation.

En ce qui concerne l'aide au développement, le ministère en charge de la santé bénéficie d'un appui conséquent de la part des agences du système des Nations Unies (OMS, Unicef, UNFPA, PAM, etc.), la Banque mondiale, le Fonds mondial, Gavi ainsi que celle de plusieurs associations, fondations et ONG nationales et internationales.

### III.2.1.5. Décentralisation des services

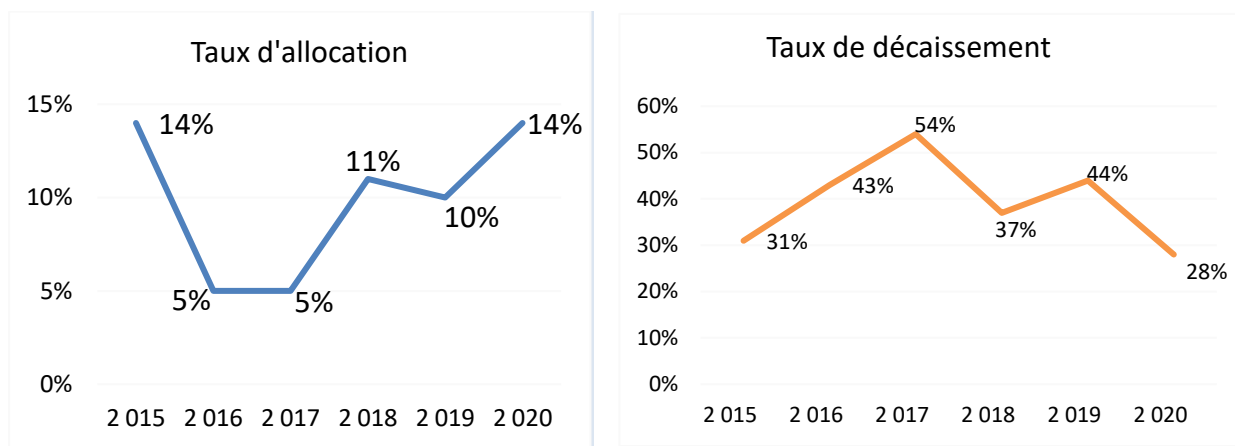
Dans le cadre de la décentralisation, le Congo a opté pour une gestion de certaines structures de santé du niveau périphérique par les collectivités locales. La décentralisation a été amorcée par la mise en place de conseils départementaux et municipaux. Le transfert de compétence et des ressources associées est en cours d'étude pour une mise en place effective.

En parallèle, le statut de la fonction publique territoriale a été prévu par la loi n°5-2005 du 25 mai 2005. La loi sur la fonction publique territoriale a fait l'objet de dix-huit décrets d'application adoptés en conseil des Ministres le 29 décembre 2011. Mais dans les faits, le fonctionnement de l'État demeure encore centralisé.

Le processus de décentralisation tarde encore à produire tous ses effets. Les obstacles identifiés dans la mise en œuvre de cette décentralisation sont de nature juridique. En effet, le projet de loi fixant la répartition des compétences entre l'État et les collectivités locales en matière de santé de base, le projet de décret fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Conseil départemental de santé et le décret portant attributions, organisation et fonctionnement des organes de gestion du district sanitaire sont déjà adoptés.

### III.2.2. Financement du Secteur

L'évolution du budget de l'État consacré à la santé affiche une tendance globalement à la hausse entre 2015 et 2020, même si on a noté une certaine stagnation entre 2016 et 2017 à 5% et une baisse en 2019 (10%). Ce budget est passé à 14% en 2020 tandis que le taux d'exécution de ce budget a évolué en dents de scie. Celui-ci a varié comme suit : 43% en 2016, 54% en 2017, 37% (2018), 44% (2019) et 28% en 2020 comme le montrent les graphiques suivants.



**Figure 3 : Evolution du budget alloué et du taux de décaissement effectif**

Source : Rapport d'activités MSPPFIFD, 2020.

### III.2.2.1. Dépense totale de santé (DTS)

La DTS est passée de 149 milliards en 2018, soit 2 % du PIB à 195 milliards en 2019, soit 2,59 % du PIB et à 246 milliards de Francs CFA en 2020, soit 4,09% du PIB. On note une augmentation de la DTS de 65% entre 2018 et 2019.

La DTS par habitant au cours de la période 2018 - 2020 est passée de 36 156 à 44 307 FCFA, comparé à l'année 2018 (31146) ; cette dépense a connu un accroissement de 42%. Les acquisitions en équipements santé pour riposter à la Covid-19 ont représenté une part importante de cet accroissement.

Les dépenses courantes de santé sont passées de 144 milliards à 192 milliards de Francs CFA entre 2018 à 2019 et à 229 milliards entre 2019 et 2020, tandis que les dépenses de santé en investissement sont passées de 5 à 3 milliards de Francs CFA entre 2018 et 2019, et à 16 milliards entre 2019 à 2020, avec une moyenne de 96% pour la Dépense Courante de Santé (DCS) et 4% pour les dépenses en investissement.

Le taux d'allocation budgétaire en faveur du ministère en charge de la santé pour la période 2019-2020 n'a aucunement augmenté pour atteindre les 15% conformément à la déclaration d'Abuja<sup>11</sup>. Un constat assez controversant, car, même pendant la période pandémique, la part consacrée à la santé est passée de 11 à 8% entre 2018 et 2019 ensuite à 9% en 2020 en dépit de nombreux défis sanitaires du pays.

Le taux moyen d'exécution budgétaire en faveur de la santé est de 68% courant 2016 à 2020, avec un pic de 124% en 2020. Ce faible taux d'exécution s'accommode avec une allocation inefficace car, la dépense est plus orientée vers les administrations sanitaires au détriment des soins aux populations.

### III.2.2.2. La mobilisation des ressources

La mobilisation des ressources du secteur de la santé consiste à collecter des fonds à travers les différents mécanismes qui peuvent provenir de différentes sources qui sont : l'Administration publique (à travers le budget de la santé), les bailleurs (bi et multi latéraux, ONGs et Fondations internationales), les ménages, les entreprises, les ONGs nationales et les fondations nationales.

D'une manière générale, le financement du système de santé congolais est essentiellement assuré par l'Administration publique et les Ménages. Les DCS sont passées de 144 086 989 622 à 192 255 746 692 entre 2018 à 2019 et à 229 915 654 569 entre 2019 et 2020. En effet, 84 % de ces

<sup>11</sup> Déclaration d'Abuja/ membre de l'UA

dépenses ont été assurées par les fonds publics et la contribution des ménages congolais. Toutefois, il est à souligner que le volume des dépenses de santé du Gouvernement a connu une augmentation entre 2018 et 2020. De manière spécifique, l'on note une diminution de 8% entre 2019 et 2020. Par contre, les fonds du reste du monde ont connu une augmentation de 123%.

Le Gouvernement est la principale source de financement de la santé avec une contribution de 43,84% et 51,37% de la DCS entre 2019 et 2020. Sa DCS a enregistré une augmentation d'environ 40,12%. Entre 2018 et 2019, il a financé 58% et 64% pour les soins curatifs, 13% et 15% de la DCS pour les soins préventifs, et enfin 29% et 19% de la DCS pour la gouvernance, Administrations.

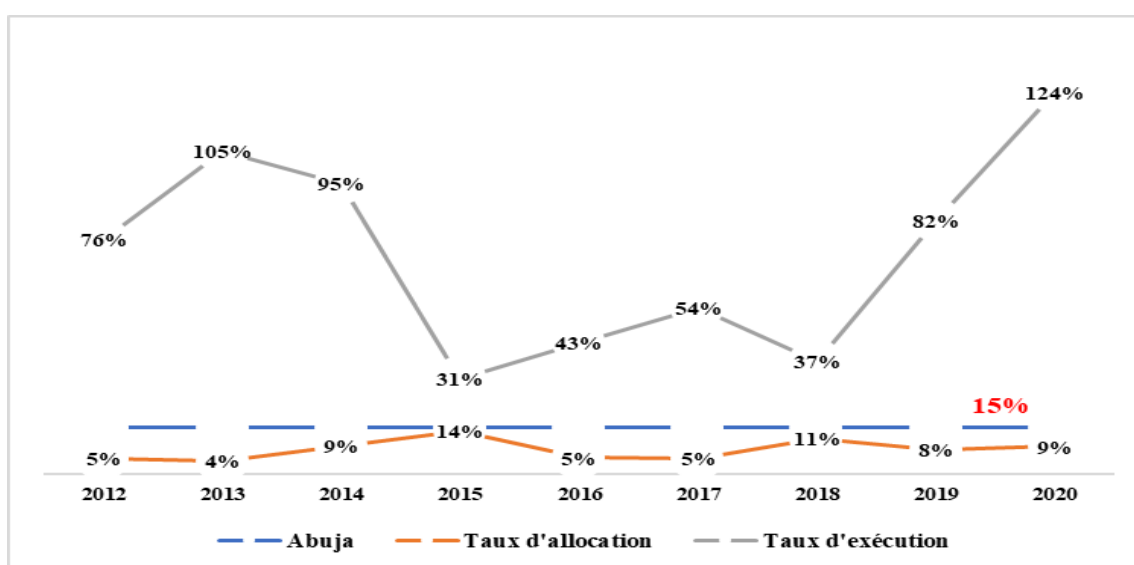
Les ménages constituent la deuxième source de financement du système de santé congolais. L'essentiel de sa dépense est réalisé par paiement direct des soins, avec une contribution d'environ 42,17% et 29,06 % de la DCS entre 2019 et 2020. L'essentiel des DCS des ménages ont servi à financer les biens médicaux (44 %), les soins curatifs hospitaliers (29%) et les soins curatifs ambulatoires (15%).

Les partenaires multi et bilatéraux constituent la troisième source de financement dans le système de santé congolais. Avec une contribution d'environ 5,48% en 2018, 7,25% en 2019 et 13,54% en 2020 de la DCS.

Les entreprises et ONG fondations nationales occupent la dernière position après les bailleurs. Leur financement est passé respectivement de 8,9% à 6,10% de la DCS entre 2018 et 2020.

Plus de la moitié des DCS ont été mobilisées par le régime de l'administration publique qui occupe la première position (52% en moyenne). Le régime des paiements directs est le deuxième régime de financement de la santé en République du Congo. Il est entièrement financé par les ménages avec une moyenne de 40% de la DCS. Ce niveau de paiement direct de santé montre l'insuffisance de mécanismes de partage des risques au Congo. Le régime volontaire de paiement privé des soins de santé vient en troisième position avec une moyenne de 8% de DCS.

70% des DCS ont été utilisées pour maladies infectieuses et parasitaires, traumatismes 7%, maladies non transmissibles 6%, santé de la reproduction 5%, carences nutritionnelles 2% et les autres maladies/affections et affections non spécifiques 10%. Avec une forte incidence sur la part du paludisme (44% de la DCS en moyenne), il constitue le premier poste des dépenses de santé, suivi des infections des voies respiratoires 12% en moyenne et du VIH/SIDA et autres maladies sexuellement transmissibles (MST) avec 7% en moyenne. La part du financement de la riposte contre Covid-19 par rapport à la DCS représente 16% en 2020.



**Figure 4 : Evolution des taux d'allocation budgétaire et de décaissement, 2012 - 2020**

Source : Rapport comptes de la santé 2019-2020

La lecture de ce graphique révèle que le taux moyen d'exécution en faveur de la santé est de 68% courant 2016 à 2020. Cette augmentation tendancielle a enregistré une baisse en 2018 après un rebond sans précédent atteignant les 124% en 2020. Cet effort du Gouvernement est salubre et encourageant et pourrait s'expliquer par les efforts consentis pour faire face à la pandémie de la Covid-19.

**Tableau 3 : Dépenses courantes de santé par facteurs de prestation**

|                            | 2018            | %   | 2019            | %   | 2020            | %   |
|----------------------------|-----------------|-----|-----------------|-----|-----------------|-----|
| Rémunération des employés  | 57 368 274 798  | 40  | 84 743 942 042  | 44  | 94 580 244 597  | 41  |
| Services de soins de santé | 6 949 689 237   | 5   | 11 274 011 580  | 6   | 20 584 733 878  | 9   |
| Produits pharmaceutiques   | 46 814 201 590  | 32  | 43 215 468 215  | 22  | 39 276 973 574  | 17  |
| Autres produits de santé   | 2 062 971 847   | 1   | 2 883 235 965   | 1   | 23 368 252 081  | 10  |
| Services non sanitaires    | 6 046 709 225   | 4   | 10 662 886 920  | 6   | 12 749 319 406  | 6   |
| Biens non sanitaire        | 5 728 034 921   | 4   | 32 805 958 735  | 17  | 34 222 815 074  | 15  |
| Autres facteurs            | 19 117 108 044  | 13  | 6 670 243 235   | 3   | 5 133 315 959   | 2   |
| DCS                        | 144 086 989 662 | 100 | 192 255 746 692 | 100 | 229 915 654 569 | 100 |

Source : Rapport comptes de la santé 2019-2020

Il ressort de ce tableau que dans l'ensemble des DCS, la rémunération des employés (en moyenne 42%) et les produits pharmaceutiques (en moyenne 32%) constituent les principaux postes des consommations des biens et services de santé.

### III.2.2.3. Financement basé sur la performance (PBF)

Le financement basé sur la performance est une source supplémentaire de financement de la santé, qui vise une efficacité allocative en privilégiant directement la production de soins (équipement et motivation du personnel) et réduit la part contributive des ménages par les gratuités et les baisses des prix. De 2015 à 2019, le financement a été de près de 46 milliards FCFA (80 millions Dollars US) par le gouvernement et 20% par prêt de la Banque Mondiale. Depuis 2020, le Gouvernement a décidé de la poursuite du programme de financement basé sur la performance d'un montant de 29 milliards FCFA (50millions dollars US).

Une composante de ce nouveau volet est l'appui à la gestion des Finances publiques qui vise à renforcer la transparence, la redevabilité et les capacités de mobilisation des budgets au niveau du secteur santé pour un montant de 3 millions de dollars US. Il y'a aussi une expansion du projet de filets sociaux LISUNGI dans le département de la Likouala pour une valeur de 1millions dollars US.

### III.2.2.4. Accessibilité financière et géographique aux soins et services de santé

Le coût élevé des consultations, des médicaments et des examens complémentaires, constitue le principal motif des retards et des non-recours aux soins et services de santé en République du

Congo<sup>12</sup>. A cela s'ajoute le paiement direct, comme principal mode d'accès aux services de santé, dont les conséquences sont dramatiques surtout pour les populations vulnérables.

Cette situation se développe dans un contexte où la part des ménages dans les dépenses de santé dépassait celle de l'Etat depuis 2012,<sup>13</sup> avant de passer à la deuxième place derrière en 2019<sup>14</sup>. Toutefois, cela est à considérer avec prudence car cette baisse de la part des ménages pouvant être un effet-Covid-19, c'est-à-dire, le fait de la sous-demande des soins liée à la pandémie. En effet, le seul facteur de la baisse des dépenses des ménages dans les pays en développement, est l'assurance maladie universelle ou encore le respect de l'application des mécanismes de gratuité touchant les problèmes prioritaires de santé publique.

Le choix fait par l'Etat congolais, de recourir à l'assurance maladie universelle et obligatoire, marque la volonté politique de stopper les barrières financières aux soins.

A côté des problèmes d'accessibilité financière, la demande et l'utilisation des services de santé sont aussi limitées par des facteurs géographiques, touchant particulièrement les populations des zones rurales.

### **III.2.2.5. Assurance maladie universelle en République du Congo**

Afin d'assurer la promotion, la restauration ou l'entretien de la santé des populations par le système congolais de santé déjà fragile<sup>15</sup>, l'Etat congolais s'est engagé à mettre en place des réformes ambitieuses du financement de la santé. Ainsi, plusieurs textes de loi ont été promulgués :

- loi de réforme de la sécurité sociale (n° 31-2011 du 15 juillet 2011 et les textes subséquents notamment la loi n° 14-2023 du 27 mai 2023 modifiant et complétant certaines dispositions antérieures instituant le système de sécurité sociale) ;
- la loi n°37-2014 du 27 juin 2014, instituant le régime d'assurance maladie universelle modifiée par la loi n° 12-2023 du 10 mai 2023 complétant certaines dispositions antérieures ;
- loi 37-2014 du 27 juin 2014 substituée par la loi n° 19-2023 du 27 mai 2023 dorénavant dénommée loi portant création de la caisse d'assurance maladie universelle (CAMU).

Pour renforcer le système de santé et optimiser le financement de santé en République du Congo, la CAMU s'est fixée trois objectifs majeurs : i) améliorer l'accessibilité aux soins à tous à travers la réduction des barrières financières ; ii) développer l'offre de soins de qualité ; iii) garantir l'équilibre financier du RAMU afin de pérenniser la protection de la santé des populations.

Pour atteindre ces objectifs, la CAMU a mis en place un modèle de financement basé sur la solidarité contributive pour financer un panier socle couvrant les problèmes de santé les plus importants du paysage épidémiologique du Congo avec des perspectives d'élargissement tridimensionnel (augmentation du périmètre du panier de soins, augmentation de la couverture de la population et augmentation des taux de cotisation financière).

Le RAMU est un régime obligatoire pour toute personne résidant au Congo afin de couvrir le maximum de population par le mécanisme de la mutualisation des risques sanitaires et des contributions financières. A ce jour, l'assiette des cotisations pour les catégories visées couvre déjà les 3/4 de la population 4.606.635). Le mécanisme assurantiel choisi par le Gouvernement est « le tiers payant » (vs remboursement des frais).

---

<sup>12</sup> MSP. Elaboration et estimation du coût du panier de soins de l'assurance maladie universelle au Congo, 2017.

<sup>13</sup> Rapport des comptes nationaux de la santé de la période 2012-2015 et 2016-2018

<sup>14</sup> Rapport des comptes nationaux de la santé de la période 2019-2020

<sup>15</sup> Rapport Revue secteur de la Santé 2018 - 2022

**Tableau 4: Assurés et taux de contribution financière à la CAMU**

| N° | Assurés                                            | Taux de contribution financière |
|----|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1  | Travailleurs du secteur public                     | 2,27 %                          |
| 2  | Travailleurs du secteur privé                      | 2,27%                           |
| 3  | Travailleurs indépendants et professions libérales | 3,79 %                          |
| 4  | Etudiants                                          | 11 764 FCFA/an                  |
| 5  | Retraités                                          | 2,27%                           |
| 6  | Personnes vulnérables                              | 3529 FCFA/an                    |
| 7  | Employeurs                                         | 4,55%                           |

Source : Projet Caisse d'assurance maladie universelle, République du Congo, 2020.

Actuellement, les fonds de démarrage de la CAMU sont représentés par une contribution de 0,5% par mois, applicable sur la fraction de salaire supérieur à 500 000 depuis l'année 2021, représentant actuellement près de trois (03) milliards de FCFA sans compter la patente annuelle des entreprises à hauteur de 0,5 %. D'autres marges de manœuvres spécifiques étaient dédiées dans la Loi de Finances 2019 à travers la création de 2 taxes comme suit : i) une taxe sur les boissons et les tabacs pour 1 milliard FCFA/ an ; ii) une taxe sur les pylônes des sociétés privées de télécommunication pour 2 milliards FCFA/an.

Pour faciliter et préparer l'entrée en exploitation de l'assurance maladie universelle, le gouvernement congolais a opté pour :

- ✓ l'accroissement de l'accessibilité géographique en continuant le projet de construction des 12 hôpitaux généraux (Santé pour tous). A titre d'illustration, deux de ces nouveaux hôpitaux ont été mis en service (1 à Brazzaville et 1 à Pointe Noire) ;
- ✓ l'amélioration de la résilience du système de santé éprouvé par la crise du Covid-19 et en prévention des chocs sanitaires potentiels qui impactent plus les populations économiquement faibles et creusent les inégalités socio-sanitaires (Projet de Riposte Urgente au Covid-PRUC-19, REDISSE IV) ;
- ✓ le maintien des programmes de santé visant les gratuités ciblées pour les couches vulnérables (Projet de filets sociaux LISUNGI, gratuité de la césarienne, gratuité du traitement anti paludique, gratuité des soins pour les PVVIH) ;
- ✓ disponibilité de l'offre de soins par la *loi sur le partenariat public-privé dans la santé* et le maintien des programmes d'incitations à l'accroissement de l'offre de prestation aux coûts négociés et les incitations financières aux prestataires, la réduction du taux de renoncement aux soins par la gratuité des soins pour les socialement faibles (KOBKISA, LISUNGI), avec l'appui de la Banque Mondiale ;
- ✓ mise en place des réformes dans le financement de la santé pour une meilleure allocation efficiente (le cheminement des flux financiers vers la production de soins, relation entre quantités de soins produits et allocation budgétaire).

### III.2.3. Coopération et partenariat

Les partenaires nationaux et internationaux jouent un rôle important en matière de coopération et de partenariat avec le MSP.



**Les partenaires techniques et financiers** : les partenaires techniques et financiers soutiennent la mise en œuvre du PNDS en assurant l'appui technique et financier. Ils s'alignent sur la PNS et le PNDS.

**Le secteur privé, la société civile, les associations et ONG** : le secteur privé, la société civile, les associations et ONGs contribuent de façon réglementaire à l'offre de soins, services de santé de qualité et recherche.

**Les ordres professionnels (Médecins, Pharmaciens et ceux à venir...)** : les Ordres sont mis à contribution pour veiller à leur participation active au développement du secteur de la santé en prenant une part active aux commissions techniques et groupes de travail de l'organe de coordination du secteur.

**Le syndicat** : les différents syndicats des professionnels et personnels de santé sont mis à contribution pour s'assurer du respect des obligations contractuelles. Leur rôle est prépondérant dans la vulgarisation du code de conduite du fonctionnaire de l'administration publique. Ils participeront également aux différentes revues et évaluations de la performance du secteur.

### III.2.4. Système national d'information sanitaire (SNIS)

Le système national d'information sanitaire (SNIS) comprend tous les mécanismes de génération, de validation, d'analyse et de diffusion de données. La production des statistiques complètes et en temps réel sur les cibles choisies, l'analyse des progrès et des performances de chaque secteur du cadre choisi et enfin la prise de décision fondée sur des données factuelles.

#### III.2.4.1. Gestion de l'information de routine

Le Congo, en novembre 2019, a élaboré un plan stratégique national du SNIS et de la Cyber-santé 2020-2024. Il intègre les domaines des infrastructures Technologies de l'Information et Communication (TIC), des services, des applications, des normes et interopérabilités, de la législation, du renforcement des capacités des professionnels de la santé et de la gouvernance.

##### ▪ Collecte des données

Les outils de collecte standardisés existent au niveau des structures de santé privées, des CSI et HRD, mais pas au niveau des hôpitaux généraux. Les HRD utilisent les outils de collecte des CSI ne couvrant pas l'ensemble de leur paquet d'activités ou leur plateau médico-technique.

Le processus conduisant à l'élaboration des outils de collecte standardisés des HRD et des HG est en cours de mise en œuvre. Les outils de collecte et de traitement de données en version papier sont encore beaucoup utilisés à différents niveaux du SNIS. Cependant, un certain nombre d'outils informatiques de saisie et d'analyse des données sont mis à disposition à différents niveaux du système même s'ils ne sont pas souvent utilisés. Il s'agit de :

- ✓ **DHIS2**. Une plate-forme logicielle gratuite et open source pour la collecte, l'analyse, la visualisation et le partage de données pour tous les programmes de santé, des événements et enquêtes de santé. Le modèle de données DHIS2 prend en charge les données agrégées et individuelles - y compris les fonctionnalités de surveillance et de suivi des personnes ou entités individuelles au fil du temps - et la saisie de données en ligne et hors ligne via le portail Web DHIS2, l'application mobile Android, les SMS ou l'importation directe. Cette plateforme a été élaborée avec l'appui du Fonds Mondial et Gavi pour la gestion totale du système national de l'information sanitaire. Les données sont produites dans presque toutes les FOSA publiques, privées et confessionnelles du pays sous format papier en rapports compilés puis transmis au niveau des districts sanitaires pour la saisie. Les 12 Départements et les 52 districts sanitaires ont été formés à l'utilisation du DHIS2 et ont été dotés en modem/router avec forfait internet de 3 ans pour la transmission des données via internet ; il est aussi utilisé pour la gestion des données de vaccination de routine.
- ✓ **EWARS** pour la surveillance épidémiologique hebdomadaire ;



- ✓ **SIRCOV** pour la gestion des données de la pandémie à Covid-19 ;
- ✓ **SAGE** pour la gestion des stocks de médicaments et produits de santé de la reproduction à la CAMEPS.

#### ▪ **Circuit de transmission des données.**

En matière de SNIS, le Congo dispose d'un système d'information organisé autour des trois niveaux de la pyramide sanitaire. Le circuit de transmission des données est clair en ce qui concerne les données provenant des CSI, des HB et des ECD. En effet, les DS disposent d'outils standards qu'ils renseignent régulièrement et qu'ils transmettent à la Direction en charge de l'information sanitaire. En ce qui concerne les hôpitaux généraux et les autres structures sous tutelle, des rapports non standardisés sont envoyés au Cabinet du Ministre.

Il existe des circuits parallèles mis en place par les programmes de santé avec, dans la plupart des cas, l'appui technique et financier des partenaires techniques et financiers (PTFs). Par conséquent, on note l'existence de plusieurs supports de collecte dans les FOSA, pour les mêmes objectifs, dans les mêmes structures et remplis par les mêmes agents. Cette fragmentation du système d'information pourrait s'expliquer en partie par la méconnaissance des décideurs du large éventail de fonctionnalités du DHIS2, par le refus délibéré des décideurs d'adopter une plateforme unique de collecte, de stockage, d'analyse et de diffusion de données. Alors qu'à fortiori, la mutualisation des ressources des programmes transversaux avec celles du SNIS contribuerait à améliorer l'efficacité du SNIS.

#### ▪ **Qualité des données.**

La qualité des données s'est nettement améliorée par rapport aux années précédentes grâce aux formations, aux supervisions formatives et aux séances de validation mensuelles des données avant saisie dans les DS, mais, elle reste néanmoins une préoccupation majeure au Congo. Dans la plupart des cas, les écarts entre les données des enquêtes et les données administratives se sont réduits. Les taux de complétude des FOSA est supérieur à 87%.

Les HRD utilisent encore les mêmes formulaires que les CSI à PMAE en attendant l'élaboration des formulaires standardisés de collecte de données des HRD et ceux des Hôpitaux généraux. Ainsi, tous les paquets d'activités des HRD ne sont pas couverts par ces formulaires de collecte. Le formulaire de rapport des HG a été standardisé. De ce rapport, tous les formulaires de collecte de données des HG, à une exception près, ont été élaborés et paramétrés dans l'entrepôt nationale de données sanitaires DHIS-2. Les gestionnaires de données sont formés ; il ne reste qu'à produire ces rapports et les mettre à disposition des hôpitaux pour que commence la remontée mensuelle des données dans les hôpitaux.

En ce qui concerne la promptitude, le taux est à 48,94%. Aucun Département sanitaire, ni Hôpital général ne transmet ses rapports dans les délais à la DGSSSa et à la DISER. Cette faible promptitude limite la capacité de riposte du système de santé face aux problèmes de santé. Toutefois, les maladies à potentiel épidémique sont sous surveillance spécifique. Un rapport hebdomadaire est régulièrement produit.

#### ▪ **Utilisation de l'information pour la prise des décisions.**

Le processus décisionnel basé sur les données factuelles générées par le SNIS doit encore être renforcé au Congo, bien qu'avec les données déjà collectées, les décideurs orientent leurs interventions de façon précise et suivent l'impact de leurs actions au quotidien et réajustent leur politique au besoin.

### **III.2.4.2. Carte sanitaire**

Le Ministère de la santé et de la population dispose de trois productions de la carte sanitaire. Il existe l'édition de 2005, celle de 2015 illustrée à partir des données des annuaires statistiques 2014. La seconde édition renseigne aussi bien sur le découpage administratif (départements et districts

sanitaires) que sur l'implantation des structures de santé au sein des districts sanitaires. Elle documente également sur la population et plusieurs autres indicateurs de santé, et celle de 2022.

### III.2.4.3. Enquêtes et études sectorielles

Plusieurs enquêtes et études sont réalisées dans le secteur de la santé. Il s'agit de l'enquête à indicateurs multiple (MICS, 2015), de l'enquête de pauvreté (en 2005, 2009 et 2011), de l'enquête de séroprévalence du SIDA en 2009 et de l'enquête démographique et de santé (EDS en 2005 et 2011-2012). Cependant, leur planification ne cadre pas avec celui de la planification stratégique pour laquelle ces enquêtes devraient fournir les données, soit pour élaborer le PNDS et d'autres plans stratégiques, soit leurs évaluations. A titre d'exemple, pour l'élaboration du PNDS 2018-2022, les données de l'EDS 2011-2012 sont utilisées et l'EDS 2017 en cours de préparation ne seront disponibles qu'à partir de 2019 et ne pourront servir ni à l'élaboration du PNDS en cours (parce que le rapport sera publié après l'élaboration du PNDS) ni à son évaluation à mi-parcours (parce que son rapport sortira avant ladite évaluation). Des études telles que celles des comptes nationaux de la santé et l'enquête SARA ne sont toujours pas institutionnalisées.

### III.2.4.4. Fonctionnalité des bulletins

Depuis 2021, deux bulletins sont diffusés périodiquement par la DISER et par la DELM ; il s'agit du bulletin national de l'information sanitaire (BNIS) et du bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH).

#### ▪ Bulletin national de l'information sanitaire (BNIS)

Le BNIS est édité par la DISER. Les directions départementales des soins et services de santé transmettent régulièrement les données. Les complétudes et les promptitudes n'atteignent pas encore les 100%.

Les informations concernent les consultations curatives, les soins prénataux, la fréquentation des services, la santé de la reproduction, les violences basées sur le genre (VGB), la nutrition, la malnutrition, l'hypertension artérielle, l'insuffisance rénale, le paludisme, la tuberculose/co-infections.

#### ▪ Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH/SMIR)

Les FOSA transmettent en temps réel les données par la plateforme EWARS. Les complétudes et les promptitudes n'atteignent pas encore les 100%. Dix-huit (18) maladies sont sous surveillance.

Les informations les plus régulières concernent les cas et décès de maladies à potentiel épidémique, notamment la rougeole, la shigellose, les paralysies flasques aiguës (poliomyélite), le paludisme, la fièvre jaune et la grippe. Les accidents de la voie publique (AVP) sont également traités.

Ce BEH, édité par la DELM, tient lieu de support de retro-information aux formations sanitaires sources de données, aux décideurs et aux utilisateurs des données pour la prise des décisions.

### III.2.4.5. Recherche en santé

La recherche dans le domaine de la santé n'est pas encore bien établie au Congo. Le pays, eu égard aux leçons apprises pendant la pandémie de Covid-19, a lancé la dynamisation de la recherche au niveau national. Dans ce contexte, le Laboratoire National de Santé Publique (LNSP) a renforcé son département de la recherche afin de parvenir à répondre aux questions scientifiques pertinentes dans le pays.

La recherche étant encore assez faiblement menée dans le secteur public, le ministre en charge de la Santé a appelé de ses vœux et accompagne vigoureusement les partenariats entre institutions publiques et privées.

Une convention de collaboration a, dans ce sens, été signée entre le LNSP et la Fondation Congolaise pour la Recherche Médicale (FCRM), institution de référence dans la conduite de la recherche

biomédicale dans le pays. Cette collaboration a, entre autres, permis de meilleures synergies entre ces deux institutions pendant la pandémie suscitée.

La DISER travaille sur la formalisation de la collaboration entre le MSP et les établissements de formation en recherche et santé publique telle que la Faculté des sciences de la santé (FSSA) notamment, le parcours santé publique et le Centre Inter-états d'Enseignement Supérieur en Santé Publique d'Afrique Centrale (CIESPAC). Cette collaboration permet de mieux orienter et soutenir la recherche sur le système national de santé.

Quelques axes d'amélioration doivent néanmoins être soulignés, à l'instar de l'absence de mécanisme de capitalisation des données de la recherche (exemple : une unité de veille sanitaire). Cette unité devrait assurer la veille des publications scientifiques, des rapports d'études et d'évaluation et produire de façon périodique une synthèse sur l'état de la recherche sur des thématiques de santé publique majeure.

Sur le plan financier, le MSP ne dispose pas, dans son budget, d'une ligne dédiée à la recherche en santé. L'enjeu majeur en matière de digitalisation demeure la révision de ladite stratégie pour l'aligner aux objectifs du PNDS 2023-2026 et la mise en œuvre de son plan d'action.

#### **III.2.4.6. Surveillance épidémiologique**

Il existe au niveau national, la DELM en charge d'organiser la surveillance épidémiologique sur toute l'étendue du territoire national ; au niveau intermédiaire, les points focaux de surveillance représentés par les Secteurs Opérationnels et au niveau périphérique, les points focaux de surveillance des DS et des FOSA.

S'agissant de la surveillance épidémiologique, la république du Congo a adapté et validé, selon l'approche « Une Seule Santé », la 3<sup>ème</sup> édition du Guide OMS de surveillance intégrée de la maladie et riposte (SIMR) pour renforcer les capacités du pays en matière de prévention, de préparation et de riposte aux urgences de santé publique, avec la liste de maladies et événements prioritaires dont cinq (5) zoonoses prioritaires. Les définitions de cas pour les maladies prioritaires et les outils de surveillance ont été vulgarisés à tous les niveaux.

Parmi les problèmes relatifs à la surveillance épidémiologique, on peut citer : (i) la coexistence de plusieurs sous unités de surveillance épidémiologique et peu coordonnées : PEV, DISER et autres programmes nationaux, la faible intégration des FOSA privées dans la surveillance épidémiologique, la faible intégration de la communauté dans le système national de surveillance, la faible complétude et promptitude des données dans certains départements, l'insuffisance des équipements matériels et logistiques à tous les niveaux du système et surtout la quasi absence de financement domestique pour la mise en œuvre de la SIMR.

#### **III.2.4.7. Processus de digitalisation**

En 2020, dans la décision WHA73(28), l'assemblée mondiale de la santé a adopté la Stratégie mondiale pour la santé numérique 2020-2025. En République du Congo, le secteur des Technologies de l'Information et de la Communication constitue l'un des secteurs prioritaires et de croissance pour le développement socio-économique du Congo avec un impact particulier sur le secteur de la santé.

La République du Congo, à l'instar de tous les pays de la région dispose d'un cadre juridique réglementant le secteur des télécommunications ainsi qu'une autorité de régulation sectorielle. Une loi portant protection des données à caractère personnelles a été aussi adoptée. Le cadre juridique relatif à la Cybersécurité a été adopté par le parlement en 2019. Le pays dispose d'une bonne couverture en réseaux TIC et une bonne connectivité au niveau national et international permettant le développement des services TIC pour la santé de qualité.

Le Congo a élaboré en 2018 une Stratégie Nationale de Développement de l'Economie Numérique 2018-2022. Cependant, le contexte d'apparition de la maladie à coronavirus 2019 ou Covid-19 en

2019 et sa déclaration par la 77<sup>ème</sup> session de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) comme urgence sanitaire mondiale en 2020 a conduit à l'arrêt du processus d'exécution de la feuille de route du gouvernement conduite par le ministère de la santé et de la population qui visait la mise en œuvre du plan d'action 2020–2024 adossé à la stratégie au début de l'année 2020. Cet arrêt se justifie par la réorientation des priorités à cause de la nécessité de la riposte à la pandémie.

Toutefois, les mesures prises par le Gouvernement dans le cadre de la riposte à la pandémie ont favorisé la réalisation du Système Intégré de Riposte à la Covid-19 (SIRCOV). Cette intervention de la cyber-santé a permis de poser les bases d'une infrastructure nationale garantissant la connectivité sur l'ensemble du territoire au niveau des départements sanitaires, des districts sanitaires et de la plupart des formations sanitaires (hôpitaux généraux, hôpitaux de bases et centres de santé intégrés).

Outre le SIRCOV, le District Health Information System version 2 (DHIS2) mis en service dans l'ensemble des départements sanitaires et districts sanitaires en 2000 a été adopté comme principale plateforme pour la collecte et le traitement de l'information sanitaire. Par ailleurs, le taux d'utilisation des TIC dans le secteur de la santé reste très marginal, plusieurs interventions en cyber-santé se sont soldées par des échecs. L'enjeu majeur en matière de digitalisation demeure la révision de ladite stratégie pour l'aligner aux objectifs du nouveau PNDS 2023-2026 et la mise en œuvre de son plan d'action.

Parmi les forces du SNIS, on peut citer : (i) l'existence d'une direction de l'information sanitaire, de l'évaluation et de la recherche au sein du MSP, (ii) l'élaboration et la mise en œuvre du plan stratégique de suivi et évaluation du secteur de la santé 2011-2015, (iii) l'existence des gestionnaires de base de données au sein de chaque DS et (iv) la disponibilité des outils de collecte des données standardisés dans tous les CSI et hôpitaux de district.

Parmi les faiblesses, on peut citer : (i) non standardisation des outils de collecte, de compilation et d'analyse dans les hôpitaux généraux, les directions centrales, les institutions d'appui au diagnostic et la centrale d'achat, (ii) l'insuffisance des ressources matérielles, humaines, financières et de moyens dédiés à la gestion des données, (iii) la faible complétude et promptitude des rapports (iv) l'irrégularité des enquêtes, (v) l'existence des systèmes parallèles mis en place par certains programmes de santé et/ou certains partenaires au développement (vi) l'absence de mécanisme de capitalisation des données de la recherche en matière de santé, (vii) l'absence de l'institutionnalisation des études telles que les comptes nationaux de la santé, l'enquête SARA, etc., (viii) la qualité insuffisante des données est une préoccupation majeure, (ix) les décisions prises dans le secteur ne sont pas toujours fondées sur les bases factuelles générées par le SNIS

### III.2.5. Ressources humaines en santé (RHS)

Le Ministère de la santé et de la population ne dispose pas d'un plan de développement des ressources humaines en santé. Cette situation pourrait, dans une large mesure, expliquer les problèmes que l'on observe dans ce domaine.

#### III.2.5.1. Gestion des ressources humaines en santé (RHS)

Les ressources humaines constituent le pilier de l'offre des soins et de services de santé. En 2021, le MSP a réalisé une collecte de données des ressources humaines à tous les niveaux de la pyramide sanitaire afin d'avoir une cartographie du personnel du secteur public pour définir un plan national de développement des ressources humaines de la santé.

En termes de résultats, 8 577 agents de santé ont été répertoriés dans les structures sanitaires étatiques avec une inégale répartition de ces derniers entre les départements ; Brazzaville (48,9%) et Pointe-Noire (13,8%) regroupent plus de la moitié du personnel de santé (62,7%).

Les femmes représentent près de 74% des agents. Près de 38% de ce personnel évoluent dans les hôpitaux généraux avec une grande majorité au CHU-B (61,2%). Plus de la moitié (61,8%) de ces

agents de santé sont des fonctionnaires et environ le quart (26,3%) sont des contractuels. Cette même tendance est aussi observée dans certains départements.

Une particularité est observée dans le département de la Sangha et de la Cuvette où les agents de santé communautaires et les bénévoles représentent respectivement 51,4% et 47% de l'ensemble du personnel. A Brazzaville, les contractuels représentent 47% du personnel. Les corps les plus nombreux sont les corps infirmier (54,9%), administratif (15,5%) et médical (15,0%). Selon les grades, les infirmiers diplômés d'Etat (18,9%), les agents techniques (16,4%), les sage-femmes (8,8%), les monitrices sociales (7,9%), %, les assistants sanitaires (7,3%) et les médecins (6,0%) sont les grades les plus prédominants.

### III.2.5.2. Densité du personnel de santé

En ce qui concerne la mise en œuvre de l'ODD n°3, l'OMS estime que la densité du personnel de santé doit être d'au moins 4,45 pour 1000 habitants pour que le pays dispose d'assez de ressources humaines pour offrir l'ensemble des paquets de services de santé requis. Avec une densité moyenne de 1,0 personnel de santé pour 1.000 habitants, le Congo ne dispose pas d'un effectif suffisant pour améliorer ses chances d'atteindre l'ODD n°3 d'ici à 2030. A ce déficit, il faut ajouter l'inégale répartition de ce personnel de santé sur le territoire national. Trois départements (25%) ont moins d'un médecin, infirmier, sage-femme pour 1 000 habitants ; environ 58% (7/12) des départements ont environ 1 médecin, infirmier et sage-femme pour 1 000 habitants. Un seul département a plus de 2 médecins, infirmiers et sage-femmes pour 1 000 habitants.

La répartition par département laisse percevoir que plus de trois quart (77,7%) des médecins sont concentrés à Brazzaville (61,8%) et Pointe Noire (15,9%). Près de 47% de ces médecins sont des spécialistes et avec comme spécialités prédominantes la Gynécologie-obstétrique (11,6%), la Cardiologie (8,3%), la Pédiatrie (5,8%) et l'ORL (4,6%). Pour ce qui est des sage-femmes, l'on note également une inégale répartition par département avec une forte concentration à Brazzaville (47,3%) et à Pointe-Noire (17,5%). Le constat est le même pour la répartition des infirmiers par département avec 39,5% à Brazzaville et 13,9% à Pointe Noire. Plus de deux tiers (69,4%) des infirmiers sont des fonctionnaires.

Dans l'ensemble du pays, il existe 511 médecins pour une population de 5.731.855<sup>16</sup> habitants avec un ratio de 0,9 médecin pour 10 000 habitants. Ces résultats traduisent l'insuffisance du nombre de médecins sur l'étendue du territoire national. Seuls les départements de Brazzaville et de la Cuvette-Ouest sont au-delà de la norme de l'OMS avec chacun 1,5 médecins pour 10 000 habitants, correspondant à une charge de travail respectivement de 6 737 et 6 657 habitants par médecin. Les départements de la Bouenza et des Plateaux ont le ratio le plus faible (0,2 médecins pour 10000 habitants).

Sur l'ensemble du territoire national, il existe 754 sage-femmes pour un effectif de 1 501 123 femmes en âge de procréer (15-49 ans) ; ce qui correspond à un ratio de 2,5 sage-femmes pour 5 000 femmes en âge de procréer. Ce résultat montre que le Congo dispose suffisamment des sage-femmes pour la prise en charge des femmes en âge de procréer.

En termes de ratio, le pays compte 7,8 infirmiers pour 10 000 habitants soit une charge de travail de 1 276 habitants pour un infirmier. Ces résultats sont au-delà de la norme de l'OMS qui recommande un infirmier pour 10 000 habitants.

Pour la mise en œuvre de l'objectif de développement durable n°3, l'OMS estime que la densité du personnel de santé doit être d'au moins 4,45 médecins, sage-femmes, infirmiers pour 1 000 habitants pour que le pays dispose d'assez de ressources humaines pour offrir l'ensemble des paquets de service de santé requis.

---

<sup>16</sup> Rapport sur la situation des ressources humaines de la sante, 2023

Le Gouvernement a mis en place une série des mesures incitatives qui visent à favoriser une répartition géographique plus équitable du personnel. En plus, depuis 2013, le personnel de santé bénéficie d'un statut particulier avec une amélioration substantielle des salaires. Ces mesures ne semblent pas suffisantes pour stabiliser le personnel de santé en milieu rural. En effet, le maintien en zone rurale du personnel de santé reste un grand défi. Cette situation est aggravée par la migration des personnels médicaux et autres cadres supérieurs vers l'extérieur. On estime à plus de 150 médecins congolais exerçant à l'étranger.

### **III.2.5.3. Cadre organique et de gestion prévisionnelle des RHS**

Au moins cinq (5) ministères sont impliqués dans la gestion des RHS, à savoir, le Ministère de la Fonction Publique en charge de la gestion des carrières des fonctionnaires, le Ministère de la santé qui gère les effectifs, les Ministères en charge des finances et du budget qui assurent la paie des fonctionnaires et, enfin, le Ministère en charge de la décentralisation, qui a la responsabilité de la gestion des ressources humaines affectées dans les entités territoriales décentralisées.

Le cadre organique de gestion prévisionnelle des emplois et des carrières a connu des difficultés de fonctionnement. L'affectation du personnel est assurée par le Ministère de la fonction publique sur proposition du Ministère de la santé. Cependant, les quotas attribués par le gouvernement au Ministère de la santé ne sont pas souvent en adéquation avec les besoins exprimés par celui-ci.

### **III.2.5.4. Projection des besoins en personnels de santé**

L'absence d'un plan stratégique des ressources humaines, établi pour répondre aux besoins de la mise en œuvre de la politique nationale de santé, notamment du PNDS demeure un handicap majeur pour définir les projections des besoins en personnels de santé pour les années à venir.

Il convient de noter que depuis 1998, les Ministères en charge de la formation professionnelle des personnels de santé organisent et traitent seuls les concours d'entrée dans ces écoles sans tenir compte des textes en vigueur. De même, ces ministères ne tiennent pas toujours compte des besoins du ministère de la santé lors de la fixation des quotas.

### **III.2.5.5. Production des ressources humaines de santé**

Le Congo compte une Faculté des sciences de la santé, établissement de l'université Marien NGOUABI de Brazzaville, placé sous la tutelle du ministère en charge de l'enseignement supérieur et cinq (5) écoles paramédicales, basées respectivement à Brazzaville, Pointe Noire, Dolisie, Kinkala et Owando relevant du ministère en charge de l'enseignement technique et professionnel.

#### **▪ Conditions de recrutement et d'admission**

En général, l'accès à la formation dans les écoles paramédicales se fait par voie de concours. Deux types de concours sont effectués :

- ✓ Le concours d'accès à la formation dans les filières (agent technique de santé, technicien auxiliaire de laboratoire, secrétaire d'administration sanitaire). Il est réservé aux élevés titulaires du brevet d'étude de premier cycle (BEPC).
- ✓ Le concours d'accès à la formation dans les filières (infirmiers d'Etat, Sage femmes d'Etat, Technicien Qualifié de laboratoire, secrétaire principal d'administration sanitaire,) réservé aux élevés titulaires de Baccalauréat.
- ✓ Le concours professionnel est réservé aux agents de santé en poste qui désirent passer à l'échelle ou à la catégorie supérieure après un minimum de trois (3) ans d'exercice.

Une autorisation préalable de concourir est délivré par le ministère en charge de la fonction publique à la demande de l'agent. Le ministère de la santé n'étant pas impliqué dans cette démarche.

La Faculté des sciences de la santé (FSSA) est chargée de la formation des médecins et autres cadres supérieurs de santé. Elle comporte cinq (05) filières de formation à savoir : la médecine générale, les sciences biomédicales, les sciences infirmières, la formation en sage-femme et la santé publique. La



FSSA forme également les médecins spécialistes dans plusieurs disciplines (cardiologie, hépato-gastro-entérologie, pédiatrie, chirurgie générale, oncologie médicale, gynécologie et obstétrique, urologie, oto-rhino-laryngologie...).

Cette faculté forme, en moyenne par année, 40 médecins, 16 diplômés de master en santé publique, 18 diplômés de master en sciences biomédicales, 15 sage-femmes et 15 licenciés en sciences infirmières.

De façon générale, le nombre moyen des médecins produits chaque année et celui des autres professionnels de santé sont très faibles pour prétendre satisfaire les besoins en ressources humaines nécessaires pour réaliser les engagements nationaux et internationaux en matière de santé.

L'analyse de situation réalisée en décembre 2014 dans le cadre du Projet d'Appui au Développement des RHS (PADHRS)-Formation initiale a fait ressortir un certain nombre d'obstacles qui doivent être levés pour renforcer la gouvernance de la formation paramédicale, optimiser les ressources allouées et produire des diplômés qui répondent aux standards et aux besoins du pays. Ces obstacles sont :

- ✓ l'absence d'un cadre de concertation entre les différents ministères impliqués dans la problématique de gestion inefficace des RHS (ministère de la fonction publique, ministères des finances et du budget, ministères des enseignements et le ministère de la décentralisation). Actuellement, la mise en œuvre de la formation paramédicale implique plusieurs ministères (MES, METPFQE, MSP), un réseau de quatre écoles paramédicales relevant de l'enseignement technique, plusieurs départements de la FSSA relevant de l'enseignement supérieur. Cependant, des décisions clés concernant la mobilisation et l'allocation des ressources, la détermination des effectifs, et la conception des programmes se font sans une réelle concertation entre ces institutions ;
- ✓ le déficit en normes devant guider la gestion efficace des RHS. A titre illustratif la production et la gestion des RHS souffre de : (i) l'absence d'un plan national de développement des RHS, (ii) l'inadéquation besoin/ formation, (iii) l'opacité dans le recrutement dans la fonction publique, (iv) l'amateurisme dans les affectations des ressources humaines ne tenant pas compte des besoins ressentis ;
- ✓ une mobilisation de ressources peu alignée sur les besoins de formation. L'ensemble du budget de l'éducation (incluant les ministères en charge de l'enseignement supérieur et de l'enseignement Technique et Professionnel) représente 8% du budget global de l'État pour l'exercice 2013. Les dépenses en éducation sont inférieures à la moyenne internationale avec un peu moins de 4% du PIB qui y est consacré. En ce qui concerne la formation paramédicale, malgré une certaine progression des investissements, ceux-ci restent insuffisants comme le reflètent les budgets de fonctionnement limités des établissements et la précarité des conditions matérielles de fonctionnement ;
- ✓ le constat est aussi celui d'un déploiement inefficace des ressources allouées à ce secteur. Les EPM comptent par exemple 165 employés administratifs alors qu'on compte seulement quelques enseignants permanents (3 par exemple à l'école de Brazzaville). Au METPFQE, les sommes disponibles pour l'investissement sont, en 2014, 11 fois supérieures à celles disponibles en fonctionnement. Les programmes de la FSSA mobilisent un réseau relativement large d'enseignants (professeurs et assistants professeurs de divers départements, praticiens, etc.), mais la quasi-totalité de ces enseignants ont un statut de vacataires. Ils assurent ainsi des charges de cours sans réel ancrage dans les programmes, ce qui crée un contexte peu favorable à la collaboration, au travail d'équipe et au renouvellement pédagogique.

Au terme de cette analyse, il apparaît que le système de formation initiale du personnel paramédical est encore peu développé et accuse des dysfonctionnements importants qui constituent des sérieux obstacles au développement du système de santé.

### III.2.5.6. Formation continue des RHS

Le Ministère de la Santé et de la Population ne dispose pas à ce jour d'un plan de formation continue du personnel de santé. Néanmoins, quelques expériences d'appui à la formation continue du personnel ont été réalisées grâce aux PTFs. Il s'agit du projet PARAMED et le projet d'appui au développement des ressources humaines (PADRHS), réalisés en partenariat avec l'Agence Française de Développement (AFD).

### III.2.6. Médicaments, vaccins, produits sanguins et technologies

Afin de garantir un accès équitable aux médicaments et examens de laboratoire, le Gouvernement s'est doté de la Politique Pharmaceutique Nationale en 2004. Pour sa mise en œuvre, un premier plan directeur pharmaceutique 2006-2010 a été mis en place, le deuxième plan 2013-2018 n'a pas pu être mis en œuvre. Cependant, le troisième plan directeur 2018-2023 est en cours de mise en œuvre.

Dans le but de réglementer l'approvisionnement en médicaments des formations sanitaires publiques, la lettre circulaire no 001/MSASF/CAB du 16 mars 2007 interdit tout approvisionnement en dehors du circuit national d'approvisionnement.

#### III.2.6.1. Approvisionnement, stockage et distribution des médicaments et autres produits de santé

Il existe deux réseaux d'approvisionnement et de distribution des médicaments dans le pays : le réseau public et le réseau privé.

##### 1. Le réseau public d'approvisionnement

Le réseau public d'approvisionnement est confié à la **Centrale d'achats des Médicaments Essentiels et des Produits de Santé (CAMEPS)**. Elle est chargée d'acquérir les médicaments essentiels et les produits de santé de qualité, approvisionner les formations sanitaires publiques et privées, rendre les médicaments essentiels et produits de santé disponibles et accessibles à moindre coût sur l'ensemble du territoire national et accompagner le Gouvernement dans la mise en œuvre des politiques de gratuité (programmes de santé prioritaires: VIH/Sida, Tuberculose, Paludisme, Onchocercose, Cancer, Santé de la Reproduction, gestion de la pandémie à covid-19, etc...).

La CAMEPS dispose actuellement de deux agences, une à Brazzaville et l'autre à Pointe-Noire, avec le projet de construire un dépôt supplémentaire dans la zone septentrionale du pays. Le système d'approvisionnement en médicaments essentiels s'organise en 3 niveaux :

- **Niveau central**, la centrale d'achats assure l'approvisionnement, le stockage et la distribution de l'ensemble des médicaments essentiels et produits de santé ;
- **Niveau intermédiaire**, les districts sanitaires jouent le rôle de dépôt de district et distribuent les médicaments aux centres de santé et Hôpitaux de Districts. La majorité des districts sanitaires ne disposent pas de dépôts pharmaceutiques, ainsi que le personnel qualifié. Le plan de distribution est normalement d'un (1) approvisionnement trimestriel, mais il se fait actuellement en fonction des commandes reçues ;
- **Niveau périphérique**, les CSI et les HRD, ainsi que les HG disposent en leur sein de points de dispensation de médicaments qui approvisionnent les différents services et dispensent les médicaments aux patients. Mais ce modèle de fonctionnement type « pharmacie à usage interne » est encore timide, l'essentiel des structures hospitalières fonctionnent encore selon le type « pharmacie officinale ». Toutefois, le circuit d'approvisionnement en médicaments n'est pas respecté, certaines FOSA continuent à s'approvisionner auprès des grossistes privés, des officines et même à travers les circuits illicites. La principale raison en est la faible disponibilité des médicaments dans le circuit public.

Par ailleurs, de par leur statut, les HG peuvent s'approvisionner directement auprès des fournisseurs de médicaments essentiels pour leur propre usage.



Le réseau public d'approvisionnement et de distribution des vaccins se fait à travers le Programme Elargi de Vaccination (PEV) assisté par l'Unicef dont la division logistique basée à Copenhague est chargée des achats sur la base des besoins exprimés par le programme.

Le circuit officiel de distribution se présente comme suit : les départements (niveau intermédiaire) sont approvisionnés par le dépôt central une (1) fois par trimestre, soit 4 fois par an ; les départements à leur tour approvisionnent les districts sanitaires (DS) mensuellement, soit 12 fois par an et les districts sanitaires approvisionnent mensuellement les centres fixes de vaccination ou Centres de Santé Intégrés (CSI).

## **2. Le réseau privé d'approvisionnement**

Le réseau privé de distribution des médicaments se compose comme suit :

- les grossistes répartiteurs ;
- les officines pharmaceutiques ;
- les dépôts pharmaceutiques.

Cinq (5) grossistes répartiteurs se chargent de l'approvisionnement en médicaments. Il s'agit de SEP, LABOREX, UBIPHARM-CONGO, PHARMACREDIT, ZENUFA. Ils s'approvisionnent auprès de leurs centrales de distribution, basées à l'étranger ; ceux-ci se chargent de collecter les médicaments auprès des industries pharmaceutiques. Les approvisionnements du secteur privé sont plus centrés sur les spécialités et très peu sur les médicaments génériques.

La commercialisation d'un médicament en République du Congo n'est possible qu'après obtention d'une autorisation de mise sur le marché du ministère en charge de la santé.

Aucune procédure de contrôle qualité n'est mise en œuvre sur place mais, la Direction de la pharmacie et du médicament (DPM) procède au contrôle de la qualité auprès d'un laboratoire basé à Kinshasa. Cependant, les dépôts pharmaceutiques s'approvisionnent suivant une liste limitative publiée par la DPM qui exclut les médicaments du tableau A, les psychotropes et les stupéfiants.

Le réseau privé d'approvisionnement et de distribution des vaccins se fait à travers les différentes officines qui s'approvisionnent auprès des grossistes agréés. Les vaccins achetés auprès des grossistes sont stockés au niveau des différentes officines qui en assurent la dispensation auprès du public. Les ménages se procurent les vaccins au niveau des officines sur prescription des formations sanitaires publiques et privées qui assurent le service de vaccination.

### **III.2.6.2. Disponibilité des médicaments essentiels et génériques (MEG) dans les formations sanitaires (FOSA)**

La disponibilité (basée sur les médicaments traceurs) est de 48,4% dans les HRD et de 45,7% dans les CSI. Cette faible disponibilité est due au fait que la CAMPES qui a débuté ses activités en Août 2017 n'a jamais reçu à ce jour sa dotation initiale en médicaments et encore moins son budget de fonctionnement ; elle se ravitaille sur fonds propres générés par des achats de médicaments à crédit à l'international.

### **III.2.6.3. Production locale des médicaments**

En 1974, le Gouvernement a créé le Laboratoire Pharmaceutique du Congo (LAPCO), entreprise d'Etat chargée de la production locale d'un certain nombre de molécules. Suite à des difficultés de fonctionnement, LAPCO a été privatisé et transformé en LAPHARCO, qui malheureusement a cessé

ses activités. L'une des raisons de sa fermeture est la rigidité du régime fiscal-douanier qui taxe de 60% l'importation des matières premières<sup>17</sup>.

Actuellement, la production locale en produits de santé est quasi nulle et se limite, d'une part aux fluides et gaz médicaux produits par deux sociétés privées et d'autre part, les produits sanguins labiles par le Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS).

#### **III.2.6.4. Vente illicite des médicaments et médicaments contrefaits**

A l'exemple d'autres pays d'Afrique, le Congo est confronté à des réseaux illicites de vente des médicaments. Loin d'être un phénomène marginal, ce commerce semble se structurer, autour de filières d'approvisionnement et de distribution remarquablement organisées. Mais, l'organisation de ce trafic des médicaments n'est pas documentée par le Ministère de la Santé. Ce phénomène pourrait être favorisé par les dysfonctionnements observés dans le circuit officiel d'approvisionnement et de distribution des médicaments.

Bien que le Congo ait signé l'Appel de Cotonou du 12 octobre 2009 portant sur les médicaments falsifiés et de qualité inférieure, malheureusement la convention Médicrime de 2016, qui est un dispositif international de lutte contre la criminalité pharmaceutique, n'a pas encore été signée.

Avec les autres pays de la CEMAC le Congo a adopté un plan sous régional de lutte contre les médicaments falsifiés et de qualité inférieure. Un référentiel de sanctions et infractions liées à l'exercice illégal de la pharmacie est en cours d'adoption par les pays de la CEMAC.

#### **III.2.6.5. Assurance qualité des médicaments**

Il n'existe pas de laboratoire pour le contrôle de la qualité des médicaments. Pour assurer la qualité des médicaments utilisés, un projet de création d'un laboratoire de contrôle qualité est en cours. Le laboratoire national de santé publique a, depuis quelques temps, pris des contacts avec un consortium de banques et laboratoires de contrôle qualité d'Espagne, le Congo se propose de construire un laboratoire de contrôle qualité à Brazzaville et une antenne à Pointe-Noire, les études de faisabilités étant vers la fin.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique pharmaceutique commune des pays membres de la CEMAC, un référentiel d'homologation des médicaments a été adopté. Le pays devra le traduire en procédures nationales. Ces procédures serviront de base au travail de la commission nationale d'homologation des médicaments créée en 2017.

#### **III.2.6.7. Approvisionnement en produits sanguins sécurisés**

Le centre national de Transfusion sanguine (CNTS) assure une mission de santé publique, au service des malades, grâce à la générosité des donateurs. Acteur indispensable dans le système de santé et l'offre de soins, il collecte le sang, réalise sa qualification biologique, prépare les produits sanguins, les stocke et les distribue aux formations sanitaires.

Le CNTS est structuré en trois niveaux, à savoir : (i) le niveau central représenté par la direction générale, (ii) le niveau intermédiaire constitué des Centres interdépartementaux de transfusion sanguine (CIDTS) de Brazzaville - le Pool, de Pointe-Noire - Kouilou, du réseau Nord ( Likouala, Sangha, Cuvette, Cuvette-Ouest, les plateaux) et du réseau Sud-Ouest (Lékoumou, Niari, Bouenza), et (iii) le niveau périphérique qui est le réseau de distribution des produits sanguins, fait de 48 Postes de transfusion sanguine (PTS) et des dépôts de sang installés dans les formations sanitaires publiques et privées à PMAE.

S'agissant de la collecte, le nombre de dons de sang collectés est passé de 56111 en 2017 à 86 129 en 2021 et une projection de 100.000 poches en 2022, soit une augmentation de 44,9%. Malgré ces progrès significatifs, le sang continue de manquer, surtout dans les territoires où l'activité

---

<sup>17</sup>Ministère de la Santé et de la Population-Congo : Plan directeur pharmaceutique national 2014-2018

transfusionnelle n'est pas présente. Les besoins nationaux annuels en termes de collectes sont estimés à 160.000, soit un manque de près de 60.000 poches.

Le CNTS réalise toutes les analyses biologiques obligatoires édictées par l'OMS sur l'ensemble des produits sanguins labiles mis à disposition des FOSA, c'est dans ce sens qu'ils sont dits sécurisés.

Les problèmes prioritaires (faiblesses) du CNTS qui minent l'atteinte de l'autosuffisance en produits sanguins sont les suivants :

- ✓ le sous financement de la transfusion sanguine au Congo : le budget de l'Etat alloué à l'établissement est de deux milliards deux cent quatre-vingt millions (2.280.000.000) de FCFA. Ce budget a été établi sans avoir réalisé une analyse préalable des coûts des activités de la chaîne transfusionnelle et sans tenir compte des exigences de sécurité biologique de plus en plus contraignantes garantissant l'innocuité du sang. En effet, ce budget même dans l'hypothèse où il est totalement décaissé, il ne peut soutenir la production de près de 160.000 unités de sang sécurisés dont les FOSA ont besoin chaque année pour assurer les actes transfusionnels. De surcroît, ces quatre (4) dernières années, le taux de décaissement du budget n'excède pas les 30% ;
- ✓ la part encore importante des dons familiaux de remplacement sur l'ensemble des dons collectés chaque année ;
- ✓ le niveau encore faible de mobilisation de la population en faveur du don de sang volontaire et bénévole : la stratégie de communication sur le don de sang volontaire et bénévole manque de financement pour sa mise en œuvre ;
- ✓ le manque récurrent des réactifs et des consommables ;
- ✓ le faible taux de couverture nationale : l'implantation des FOSA se fait sans la prise en compte de la problématique du sang. Le CNTS n'est pas associé en amont des projets, si bien que nombreuses formations sanitaires n'ont pas de local approprié pour organiser le service transfusionnel. Dans ces conditions, l'établissement déjà sous-financé, ne peut ni construire un local, ni acquérir les équipements, ni disposer du personnel nécessaire pour assurer le service ;
- ✓ la vétusté des infrastructures et du plateau technique : l'état actuel des infrastructures et des plateaux techniques ne peut soutenir un niveau production permettant de satisfaire la demande actuelle en produits sanguins, ne peut en outre permettre d'anticiper et d'absorber l'accroissement sans cesse des besoins en produits sanguins. Par ailleurs, le plateau technique actuel ne permet pas à l'établissement de produire les produits sanguins adaptés à chaque situation clinique, notamment le nouveau-né, la femme en âge de procréer, le sujet drépanocytaire et de bien d'autres pathologies ;
- ✓ l'insuffisance de la chaîne de froid : l'établissement ne dispose pas de banques de sang à énergie solaire lui permettant d'organiser le service dans les zones non connectées au réseau électrique national ;
- ✓ l'absence des moyens logistiques : l'établissement ne dispose pas d'une logistique suffisante lui permettant de se déployer à différents endroits pour collecter davantage de sang et d'accueillir les donneurs dans de meilleures conditions ;
- ✓ l'insuffisance en personnel : les effectifs actuels sont insuffisants au regard des standards en vigueur en nombre d'équivalent temps plein par poste de travail.

### **III.2.7. Promotion de la santé**

La promotion de la santé constitue un levier important pour l'adoption de comportements et modes de vie favorables à la santé et l'autonomisation des communautés dans les activités de santé. Le Congo dispose d'une politique nationale de promotion de la santé (2020-2024) ; celle-ci vise, d'ici 2025, une société dans laquelle les individus, les ménages et les communautés disposent des

moyens nécessaires pour la maîtrise de leur santé et du bien-être intégral des populations. Par contre, la stratégie de mise en œuvre n'existe pas.

En vue de réduire la charge croissante des maladies de santé publique évitables en Afrique, l'OMS a élaboré une stratégie de promotion de la santé visant « à améliorer les interventions de promotion de la santé afin de contribuer à la réduction des principales causes des décès évitables, des incapacités et des maladies transmissibles et non transmissibles, des violences et des traumatismes, des affections maternelles et infantiles, et des menaces nouvelles et récurrentes à la santé dans la Région africaine ».

Les orientations de l'OMS corroborent avec la situation en République du Congo dont les 56% de la population sont âgées de moins de 20 ans. Vu la jeunesse de la population, la lutte contre les comportements à risques est l'une des principales composantes.

L'avènement de la pandémie de Covid-19 a prouvé, dans tous les Etats du monde, que la communication constitue une composante à part entière du processus d'amélioration de l'état de santé de la population, du fait notamment des difficultés rencontrées dans la riposte telles que : le déni de la maladie, la peur et le refus de se faire vacciner, les fake news, etc.), en témoigne, l'appel du Chef de l'Etat de décembre 2021 relatif à l'intensification des activités de communication dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19.

L'organisation des activités d'information et de sensibilisation, de grande envergure et sur toute l'étendue du territoire national, figure parmi les priorités nationales en matière de santé de ces cinq prochaines années telles que définies récemment par le Ministre de la Santé et de la Population dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations du Gouvernement.

L'amélioration du système de santé congolais passe également par le renforcement de la promotion de la santé afin de prévenir les problèmes de santé évitables par des actions de communication. En effet, à l'exception du plan de riposte national à la pandémie, il n'y a pas eu des stratégies et plans de communication alignés sur le PNDS 2018-2022. Le système national de santé a ainsi été privé d'une stratégie de communication pouvant lui permettre d'agir sur les déterminants de la santé.

Etant donné que la santé « ne se résume pas à l'offre de soins », il est plus qu'urgent qu'une stratégie de communication soit déclinée et parfaitement alignée au PNDS 2023-2026 soit mise en œuvre pour agir plus efficacement sur les déterminants de santé en vue d'une meilleure gouvernance de la santé.

Dans ce contexte, l'amélioration de l'état de santé des populations visée par le PNDS 2018-2022 s'est avérée peu satisfaisante car plusieurs problèmes de santé n'ont pas trouvé de réponses appropriées. Entre autres causes de cette faible performance figure l'absence d'une stratégie de communication pour promouvoir l'adoption d'attitudes et de comportements des acteurs du système de santé et des populations favorables à la bonne santé de la population. En effet, le changement social et comportemental, la faible appropriation des problèmes de santé par les acteurs du système de santé y compris les acteurs communautaires, la faible implication de la communauté et des formations sanitaires du secteur privé dans la surveillance intégrée des maladies et riposte (SIMR) et le manque de régularité dans la production du bulletin hebdomadaire sont tant de facteurs non pris en compte qui sont étroitement liés à la stratégie de communication.

Le renforcement des capacités et l'élaboration d'une stratégie de communication du MSP contribueront à accompagner le processus de changement de comportement par la sensibilisation, l'éducation des populations sur les risques sanitaires et la promotion de l'information des populations sur les bonnes habitudes et l'hygiène de vie.

## Profil du système de santé

- Le Ministère de la santé et de la population a fait le choix de trois directions générales sans secrétariat général à la place d'une seule direction générale de la santé pour son management et sa coordination.
- Le système de santé est très dépendant du niveau central par faible niveau de décentralisation. En outre, il se caractérise par une part non négligeable des programmes verticaux et d'une faible capacité en promotion de la santé.
- Le profil du système de santé de la République du Congo est de type district sanitaire, c'est-à-dire conçu pour offrir les soins de santé primaires à la plus grande partie de la population. Mais paradoxalement, les priorités politiques et les ressources sont tournées essentiellement vers les hôpitaux généraux qui reçoivent moins de malades, arrivant souvent à des stades critiques généralement à cause des retards à la consultation.
- L'offre de soins au Congo est essentiellement concentrée dans les zones urbaines, de même que le personnel qualifié de santé.
- L'offre de soins n'est pas adaptée aux personnes âgées, surtout dépendantes faisant généralement l'objet des comorbidités.
- Le développement des soins du secteur privée en plein essor, demeure moins régulé et contrôlé, mais tend à dépasser l'offre publique de santé (près de 52 %) <sup>18</sup>.

### Problèmes prioritaires retenus pour les RHS

- Inexistence d'un plan de développement des RHS ;
- Insuffisance des effectifs au niveau du secteur de la santé ;
- Répartition inéquitable des RHS sur le territoire national entre les milieux urbain et rural
- Inadéquation entre les besoins et la production des RHS ;
- Absence d'un cadre de concertation entre les différents ministères de la santé, de la fonction publique, des finances, les ministères des enseignements et les collectivités locales ;
- Absence d'un cadre organique pour la gestion prévisionnelle des RHS.

---

<sup>18</sup> Banque Mondiale. Offre de soins en République du Congo, 2017.

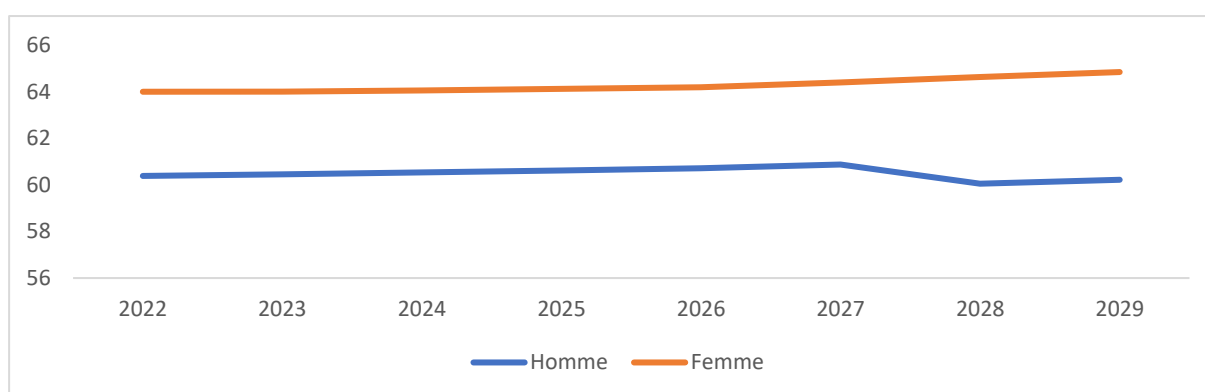
### IV.1. Principaux indicateurs de santé

#### IV.1.1. Espérance de vie

L'espérance de vie<sup>19</sup> mesure le nombre moyen d'années pendant lesquelles un individu peut espérer vivre en l'absence de changement des taux actuels de mortalité. C'est l'un des indicateurs permettant de mesurer la longévité humaine pour une société donnée et représente, par conséquent, le reflet du progrès ou de la dégradation dans les domaines sanitaire, socioéconomique et environnemental.

Selon les dernières données du Plan national de développement (PND), l'espérance de vie à la naissance était de 65 ans en 2019, soit 7 ans en dessous de la moyenne mondiale qui est de 72 ans et un plus que la moyenne en Afrique subsaharienne (60 ans). La progression de l'espérance de vie s'expliquerait par les efforts accomplis ces dernières années par le Gouvernement de la République en matière de santé et d'amélioration des conditions de vie des populations. Ces chiffres sont à considérer en parallèle avec la réduction globale du nombre de décès aussi bien chez les adultes que chez les enfants (OIT, 2021).

Les données de l'OMS publiées en 2020 donnent pour le masculin 63.8ans, le féminin 65.6ans et l'espérance de vie moyenne est de 64.7 ans. A la lumière du graphique ci-dessous, l'espérance de vie à la naissance en République du Congo est en constante augmentation depuis 2022, passant de 62 ans à 64,7 ans en 2029.



**Figure 5: Estimation de l'espérance de vie au Congo**

Les personnes âgées peuvent encore espérer vivre des années supplémentaires. En effet, les personnes qui atteignent l'âge de 60 ans peuvent encore espérer vivre 14,4 années supplémentaires ; cette durée de vie moyenne est de 5,1 années supplémentaires de vie pour celles qui arrivent à 80 ans.

<sup>19</sup>. L'espérance de vie calculée ne prend pas en compte les indicateurs de santé, donc c'est n'est pas l'espérance de vie de bonne santé.

**Tableau 5: Espérance de vie à l'âge x des personnes âgées**

| Âge X | Espérance de vie à l'âge X (nombre d'années) |
|-------|----------------------------------------------|
| 60    | 14,4                                         |
| 65    | 11,5                                         |
| 70    | 8,9                                          |
| 75    | 6,8                                          |
| 80    | 5,1                                          |

Source : INS, RGPH-07

#### IV.1.2. Fécondité

Le taux de fécondité du Congo est progressivement en baisse. Son ISF est passé de 4,8 enfants par femme en 2005 à 4,4 selon le MICS 2014-2015 et à 4,32 en 2020.

La fécondité des adolescentes, marquée par un taux variant de 129‰ (EDSC-I) à 147‰ (EDSC-II) et 110‰ (MICS5/Congo 2014-2015), présente des défis énormes liés entre autres à leur entrée précoce dans la vie féconde. La part des filles entrant dans la vie féconde est passée de 27,2% (EDSC 2005) à 32,9% (EDSC 2011), et celle ayant déjà un enfant a augmenté de 7,9% à 15 ans et 54,8% à 19 ans. Selon le MICS 2014-2015, la proportion des jeunes de 15-24 ans ayant déjà des rapports sexuels précoces (avant 15 ans) est de 13,7% chez les femmes et de 16,8% chez les hommes.

Les taux des grossesses précoces dont la proportion à 15 ans est plus importante en 2011 avec 12,9% contre 7% en 2005, augmentent avec l'âge, passant à 19,8% à 16 ans, et doublant à 17 ans (25,9%). Cette fécondité croissante chez les jeunes filles a des origines multifactorielles notamment l'urbanisation, la dépravation des mœurs, les faiblesses de l'éducation en matière de santé sexuelle et reproductive, les violences sexuelles sans contraception, ainsi que la paupérisation.

Cette fécondité pourrait s'expliquer par le faible recours à la contraception alors que le planning familial fait partie du paquet d'activités des formations sanitaires à tous les niveaux du système du Congo. L'utilisation de la contraception moderne est passée de 22,0% en 2012 à 30,1% en 2014 (MICS 2014-2015). En 2021, le taux d'utilisation contraceptive a gravement baissé à 2,2 % (INS, 2021).

#### IV.1.3. Mortalité générale

Depuis plusieurs décennies, le Congo enregistre une baisse significative du nombre de décès annuels pour 1000 personnes toutes les causes confondues. Selon Perspective Monde<sup>20</sup> pour l'ensemble de la période de 1960 -2015, on enregistre une diminution de la mortalité globale de 56% en 55 ans, et une moyenne annuelle de 12,78. Le taux de mortalité générale était de 11,25 pour mille en 2012. Cette mortalité était légèrement plus élevée chez les femmes comparées à celle des hommes : 4,4 pour mille chez les hommes et 5,4 pour mille chez les femmes âgées de 15-49 ans. C'est en 1960 qu'on enregistre la valeur la plus élevée (17,09) et en 2015 la valeur la plus basse (7,56). En considérant les tendances actuelles, les estimations font état d'un chiffre d'environ 5,76 en 2020. La pandémie à Covid-19 serait responsable d'une surmortalité élevée.

<sup>20</sup>Perspectives monde, date de consultation : 26/1/2018. Source : Banque Mondiale

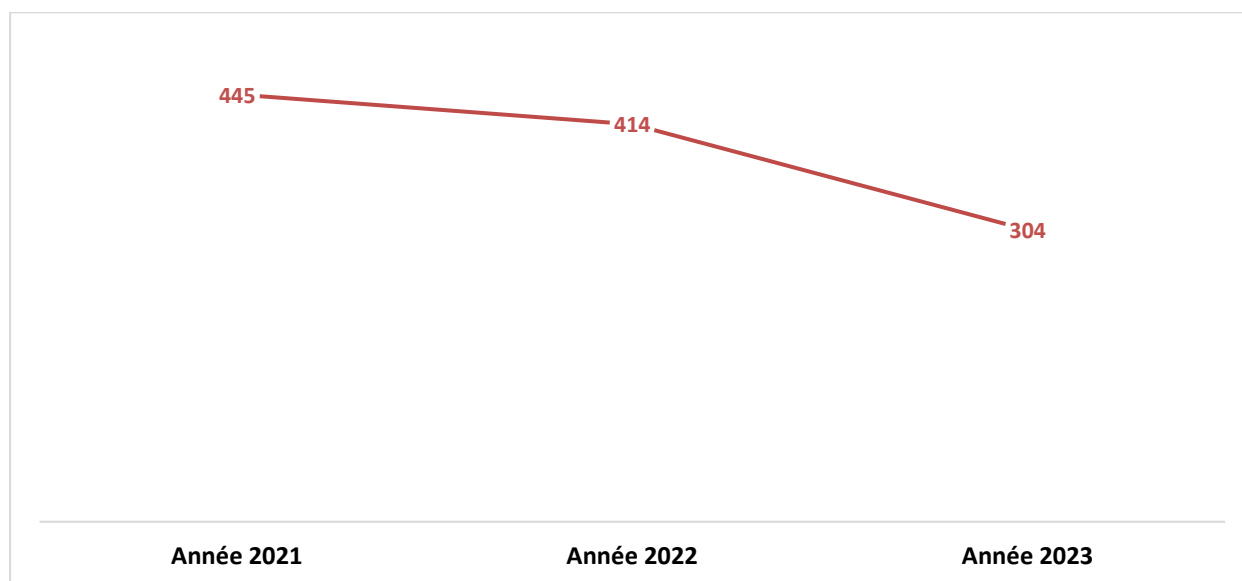


## IV.2. Santé maternelle

### IV.2.1. Mortalité maternelle et facteurs de risque

La mortalité maternelle demeure préoccupante en dépit des efforts consentis. La proportion des femmes en âge de procréer est de 20% pour un ratio de la mortalité maternelle de 445 décès et de 414 décès maternels pour 100.000 NV respectivement pour 2021 et 2022. Parmi ces décès, 97,1% sont évitables. L'allure des décès maternels était décroissante entre 2015 et 2018 avec des taux respectifs de 346 pour 100 000 naissances vivantes et de 426 pour 100 000 naissances vivantes avant de repartir à la hausse en 2021<sup>21</sup>. Cette situation reste préoccupante au regard de la cible 1 de l'ODD 3, formulée comme suit « D'ici à 2030, faire passer le taux mondial de mortalité maternelle au-dessous de 70 pour 100 000 naissances vivantes ; et aucun pays ne devrait dépasser 140 décès pour 100 000 naissances vivantes ».

Avec la survenue de la COVID 19, le taux de mortalité en 2022 est remonté à 414 décès maternels pour 100 000 selon le rapport de l'observatoire des décès maternels et infantiles, avant de baisser significativement à 304 décès maternels en 2023<sup>22</sup>.



**Figure 6: Evolution de la mortalité maternelle (pour 100000 NV) de 2021 à 2023**

Source : MSP, Observatoire nationale des décès néonatal et infantiles, 2023.

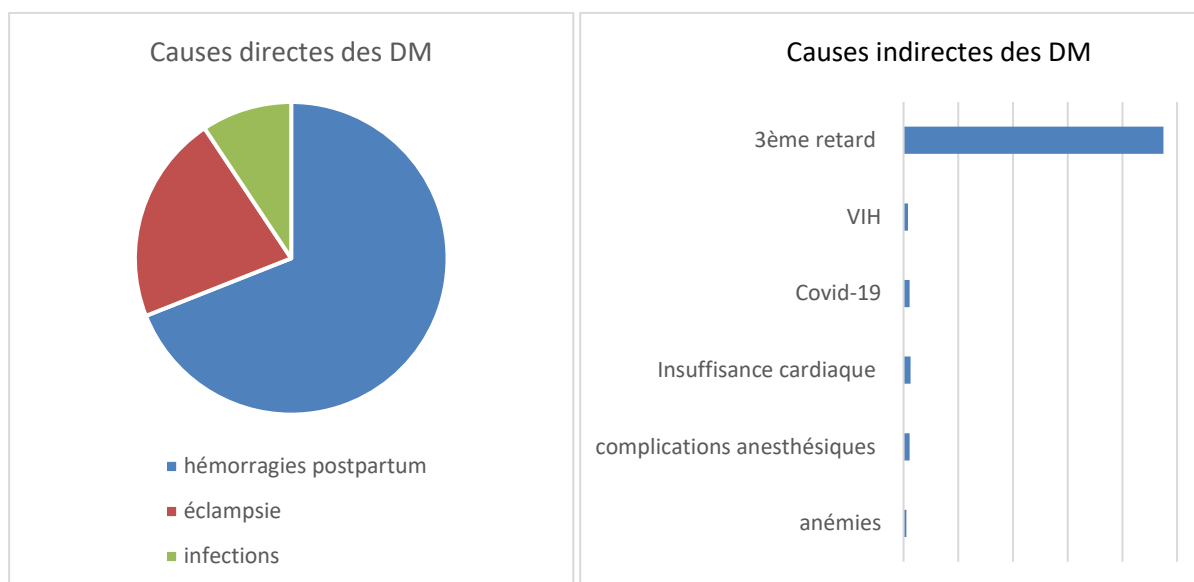
La tranche d'âge la plus affectée en 2021 est celle de 30 à 34 ans avec (56,4%), correspondant à la période la plus active sur le plan sexuel. Les paucipares étaient les plus représentatives avec 42,9%. Ces décès maternels sont survenus essentiellement dans le post-partum immédiat, moins de 24 heures dans 68,9 %, faisant de cette période, la plus critique.

Cette mortalité maternelle est attribuable à des causes directes et indirectes. Les causes directes sont constituées des hémorragies postpartum avec 61,2 %, de l'éclampsie avec 19, 2 % et des infections du post-partum et du post-abortion avec 8,3 %. Par contre les causes indirectes représentant 10,3 % des décès, sont constituées des anémies (1%), des complications anesthésiques (2,2 %) et de l'insuffisance cardiaque (2,6%), la COVID-19 dans 2,2 % et le VIH dans 1,6 % des cas.

L'analyse de la mortalité maternelle montre une tendance à la baisse entre 2021 et 2023 selon les données du MSP, montrant aussi des inégalités entre les départements. Presque toutes les causes de ces décès sont évitables par une offre des soins curatifs, préventifs et promotionnels de qualité.

<sup>21</sup> MSP, Observatoire nationale des décès néonatal et infantiles, résultat de la surveillance des décès maternels, néonataux et infantiles en République du Congo, 2021

<sup>22</sup> MSP, Observatoire nationale des décès néonatal et infantiles, résultat de la surveillance des décès maternels, néonataux et infantiles en République du Congo, 2023.



**Figure 7 : Causes des décès maternels au Congo, 2021.**

Source : MSP, Observatoire nationale des décès néonatal et infantiles, résultat de la surveillance des décès maternels, néonataux et infantiles en République du Congo, 2023.

Pour contribuer à la réduction du taux de mortalité maternelle, l'OMS recommande que le taux de couverture en TPIg-SP soit  $\geq 80\%$ . Mais, malgré la gratuité de la prise en charge du paludisme chez la femme enceinte et les recommandations de l'OMS sur la prévention du paludisme par la Sulfadoxine Pyriméthamine, la couverture en TPI demeure faible depuis plusieurs années. En 2021, elle était de 30,95 % (63,33 % dans le département de la Bouenza et 9,79 % dans le département de la Cuvette-Ouest), de 7,5 % en 2018 et de 12,5 % en 2015. Les tendances évolutives s'améliorent mais restent faibles paradoxalement aux taux de couverture en CPN (83,7% en 2018 et 93 % en 2021)<sup>23</sup>.

### IV.3. Santé de l'enfant

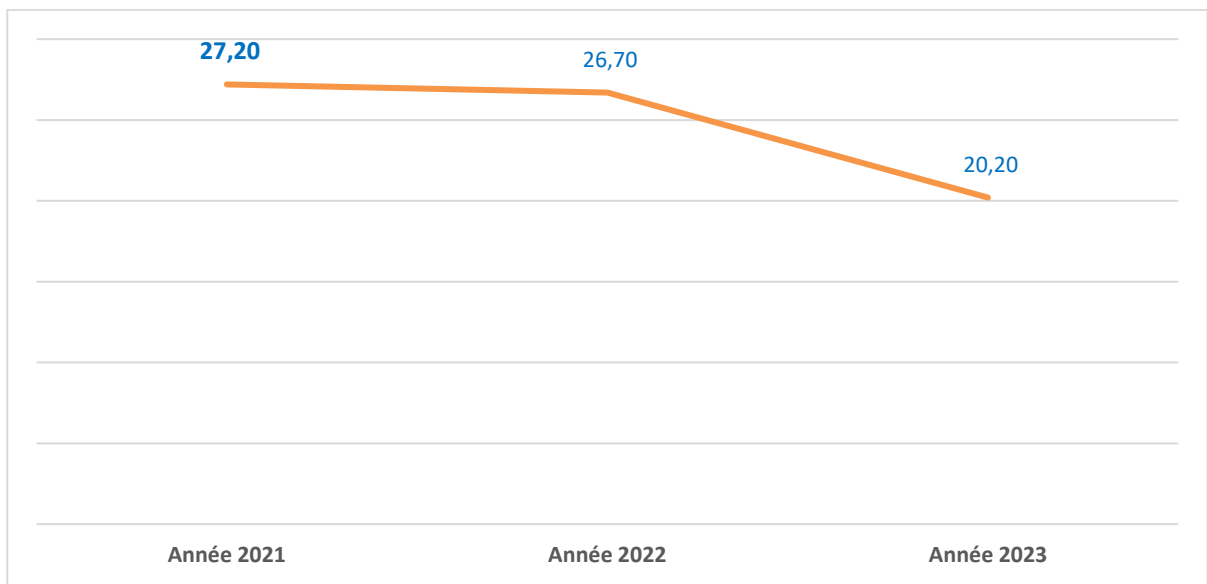
La cible 3.2 de l'ODD n° 3, stipule que d'ici à 2030, il faut éliminer les décès évitables de nouveau-nés et d'enfants de moins de 5 ans, tous les pays devant chercher à ramener la mortalité néonatale à 12 pour 1 000 naissances vivantes au plus et la mortalité des enfants de moins de 5 ans à 25 pour 1 000 naissances vivantes au plus.

En République du Congo, la santé de l'enfant se caractérise par une amélioration globale des taux de mortalité, bien que les cibles des années antérieures n'aient pas été atteintes. Cette amélioration serait attribuable aux efforts consentis en matière de prévention et de prise en charge des enfants.

#### IV.3.1. Mortalité néonatale

Cette mortalité connaît une baisse progressive depuis l'EDS 2005, où elle était de 33 pour 1000 naissances vivantes avant de baisser à 27,20 pour 1000 NV en 2021 et à 20,20 en 2023. Le rythme des efforts consentis pour réduire cette mortalité plaide en faveur de l'atteinte de la cible de 12 pour 1 000 naissances vivantes d'ici à 2030 comme le recommande les ODD.

<sup>23</sup> MSP (2021). Facteurs associés à la faible couverture en traitement préventif intermittent du paludisme chez les femmes enceintes en République du Congo.



**Figure 8 : Mortalité néonatale (pour 1000 NV)**

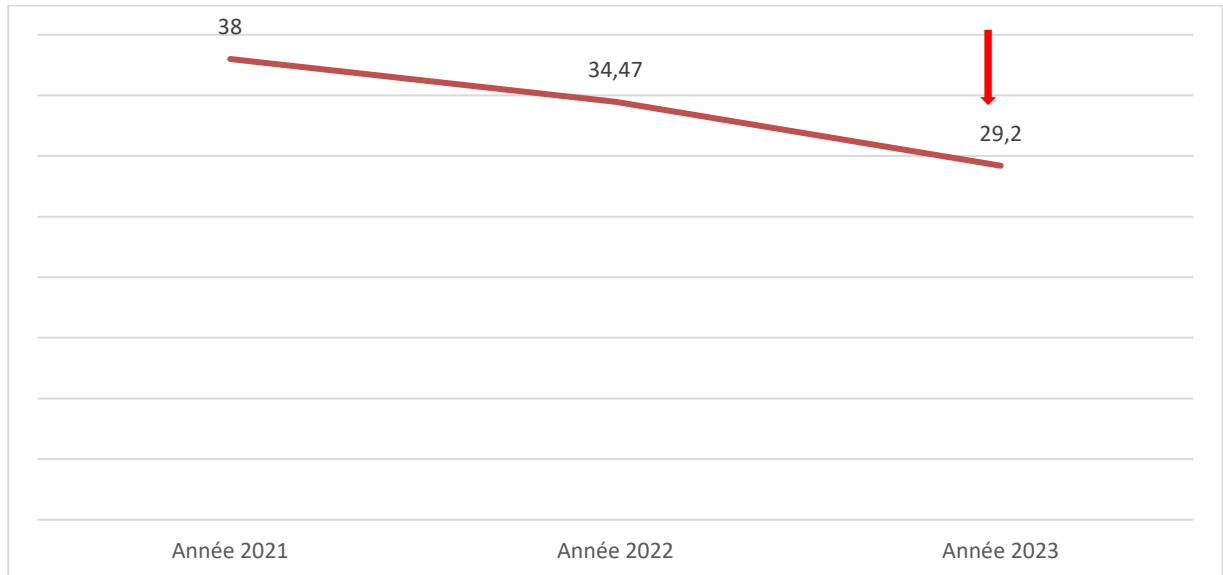
Source : MSP, Observatoire nationale des décès néonatal et infantiles, 2023.

#### IV.3.2. Mortalité infantile

Les décès infantiles sont repartis en décès néonataux et en décès post-néonataux. Globalement, la vulnérabilité du nouveau-né par rapport à l'enfant de plus de 28 jours demeure préoccupante.

Les données du Ministère en charge de la santé montre amélioration des tendances globales de la mortalité infantile passant de 38 à 29,2 pour 1000 entre 2021 et 2023.

Les principales causes de décès sont : le paludisme (32,7%), le sepsis sévère (32,5%) et l'infection respiratoire aiguë (11,2%).

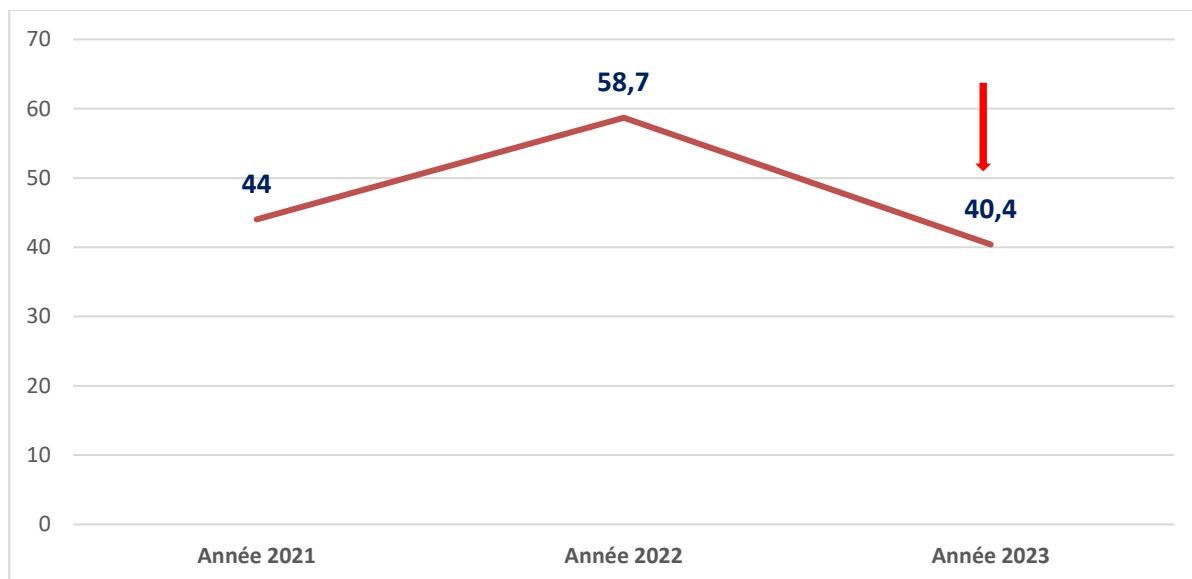


**Figure 9 : Mortalité infantile (pour 1000 NV)**

Source : MSP, Observatoire nationale des décès néonatal et infantiles, 2023.

### IV.3.3. Mortalité infanto-juvénile

L'objectif du dernier PNDS était de « Réduire la mortalité infanto juvénile, de 68 à 52 décès pour 1000 naissances vivantes ». En 2022, le taux de mortalité infanto-juvénile était de 58,7 décès pour 1000 NV, avant de décroître à 40,4 décès pour 1000 NV en 2023. Ce résultat est très encourageant et les efforts doivent être maintenus pour atteindre au plus un taux de 25 pour 1000 naissances vivantes recommandé pour satisfaire aux ODD 3.2 d'ici 2030.



**Figure 10 : Mortalité infanto-juvénile (pour 1000 NV)**

Source : MSP, Observatoire nationale des décès néonatal et infantiles, 2023.

### IV.4. Santé des adolescents et jeunes

Les jeunes et les adolescents sont à la fois victimes des maladies chroniques qui étaient l'apanage des plus âgés et des maladies transmissibles telles que le VIH, la tuberculose, les hépatites et autres. Si les tendances actuelles ne sont pas rapidement inversées, les ODD d'ici 2030 ne seront pas atteints.

Il n'existe pas de données récentes sur cette question. Selon les données du MICS 2014-2015, le Congo a une population très jeune avec 47% de personnes de moins de 18 ans. Cette population fait face à d'énormes défis, en matière de santé et facteurs y associés (eau, hygiène et assainissement, éducation et protection).

Selon le Plan Stratégique National de prévention du VIH chez les adolescents et jeunes 2020-2024, près de 30% des nouvelles infections au VIH se retrouvent chez les jeunes d'âge compris entre 15 et 24 ans. Certaines études montraient déjà une prévalence globale d'HTA de 32,5 % à Brazzaville dont 19,3% concernait essentiellement les jeunes de 24-35 ans. Cette HTA n'était pas traitée car ces personnes ignoraient qu'elles avaient cette pathologie chronique et grave. En plus, 53,2 % d'entre ces jeunes consommait le tabac et 62,3 % consommait l'alcool<sup>24</sup>.

En 2017, on notait déjà le phénomène de banalisation de l'alcoolisme juvénile au Congo-Brazzaville avec précocité de l'initiation à l'alcool avec risque de dépendance. Durant cette année, 61 % des jeunes adultes et un peu plus de 25 % d'adolescents étaient touchés par la consommation d'alcool, définie selon eux comme critère d'affirmation et de maturité<sup>25</sup>. Cependant, les conséquences de l'alcoolisme sont visibles sur plusieurs plans dont celui des accidents de la voie publique favorisés

<sup>24</sup> Enquête sur l'HTA et les autres facteurs de risque à Brazzaville, mai 2004.

<sup>25</sup> Congo – Jeunesse : L'alcoolisme juvénile se banalise de plus en plus (lesechos-congobrazza.com) cité le 28 décembre 2022.

par le recours massif aux cyclomoteurs « Jakarta » comme moyen de transport en commun. Déjà en 2011, un total de 3126 accidents avait été comptabilisé dans les deux grandes villes dont 2003 à Brazzaville et 1123 à Pointe-Noire, causant 137 décès<sup>26</sup>.

La permanence des multiples facteurs de risque croissants dans le temps se traduit par des incidences précoces des maladies non transmissibles dont les AVC à des âges très jeunes (autour de 20 ans) en République du Congo<sup>27</sup>. Toutefois, il sied de noter aussi que chez les adolescents et jeunes, la précocité des rapports sexuels surtout non protégés, la fréquence des grossesses précoces, la fréquence élevée des avortements (23%), les agressions sexuelles, la prévalence élevée de l'infection à VIH (22% de nouvelles infections concernent la tranche d'âge de 15 à 24 ans)<sup>28</sup> constituent des facteurs menaçant la santé des adolescents et des jeunes.

Un autre facteur aggravant est que les jeunes fréquentent trop peu les services de santé appropriés, que ce soit pour le VIH, la tuberculose, ou encore toute autre maladie infectieuse, et ne maîtrisent pas grand-chose sur ces maladies. Cela se traduit par le fait que depuis plusieurs années, le taux de séropositivité au VIH et à la tuberculose est en nette augmentation chez les jeunes qui en paient le lourd tribut. Les données du ministère de la santé et de la population montrent que les nouvelles infections au VIH/Sida sont dominantes en milieu juvénile avec une augmentation considérable depuis 2012. Il est donc nécessaire de promouvoir les services de santé chez les jeunes, en leur apportant directement les informations en matière de santé.

#### IV.5. Santé des personnes âgées

On estime entre 177508 personnes âgées de 60 ans et plus au Congo (Projections et perspectives démographiques du Congo 2007-2025, INS 2015), soit environ 4,8% de la population totale, dont 76816 hommes (43,3%) et 100692 femmes (56,7%). Le sexe ratio femme-homme est de 1,31. Le groupe le plus représenté est celui des personnes de 60 à 69 ans (104768 soit 59%).

Il existe une diminution progressive des personnes âgées et les tranches d'âges les plus touchées sont : 70-79 ans (55719 soit 31,4%) ; 80-89 ans (14845 soit 8,4%) et 90 ans et plus (2176 soit 1,2%).

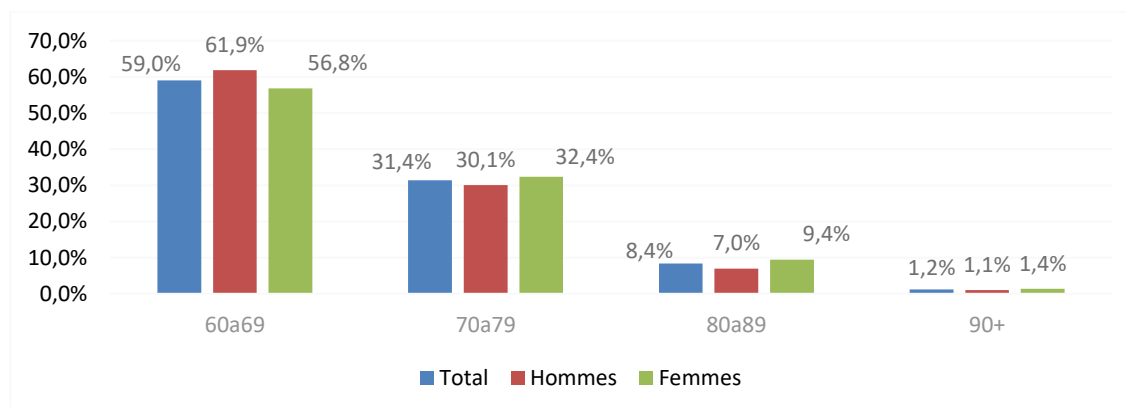


Figure 11 : Distribution des personnes âgées par groupe d'âge

Source : Stratégie des personnes âgées 2016-2021.

##### IV.5.1. Morbidité et mortalité chez les personnes âgées

Actuellement, il n'existe pas de données sur la santé des personnes âgées en République du Congo. Les seules informations sont hospitalières et très peu spécifiques de ces personnes dont même la

<sup>26</sup> Batala Mpondo, Georges, et al. « Étude exploratoire de la sécurité routière à Brazzaville et à Pointe-Noire en République du Congo », *Santé Publique*, vol. 1, no. HS, 2014, pp. 71-79

<sup>27</sup> Données d'observations hospitalières au CHU de Brazzaville. Septembre 2022

<sup>28</sup> MSP 2018.

définition opérationnelle est confrontée aux écueils méthodologiques (par exemple en France, la personne âgée est celle qui a au moins 75 ans). Toutefois, il paraît évident que devant l'absence significative des professionnels de la santé spécialisés en gériatrie, aggravée par le manque des structures dédiées à la prévention et à la prise en charge exclusive des personnes âgées, on peut conclure à un risque de morbi-mortalité très préoccupant pour ces populations fragiles.

En effet, l'âge avancé étant lié à plusieurs comorbidités du fait du vieillissement des organes, de la baisse de l'immunité, du faible niveau d'activité physique et professionnelle, du réseau social souvent réduit et à la vulnérabilité économique, les systèmes de santé doivent se mettre à niveau pour ne pas être source d'aggravation des inégalités sociales de santé des personnes âgées.

Les données d'expérience hospitalière provenant des professionnels de santé du CHU de Brazzaville, indiquent que les personnes âgées souffrent de plusieurs types de maladies dont principalement<sup>29</sup> :

- ✓ les maladies de la transition épidémiologique qui sont liées au mode de vie (les cancers, le diabète, l'HTA, les maladies cardiaques, les AVC, l'obésité, ...) ;
- ✓ les maladies telles que les maladies oculaires, les problèmes dentaires, les rhumatismes, les arthropathies, la maladie de Parkinson, les démences séniles (Alzheimer, corps de lewy, ...).

Il est important de noter que l'absence de spécialistes et de sensibilisation sur les démences chez la personne âgée par exemple, entretient l'ignorance des populations sur les problématiques de santé des personnes âgées. Dans les sociétés congolaises, la maladie d'Alzheimer est souvent interprétée comme de la "sorcellerie" et expose les personnes âgées à l'exclusion sociale ou à l'abandon par leurs proches.<sup>30</sup>

La réponse à la prise en charge des personnes âgées passe par une réorganisation du système de santé qui doit être inclusif. Les personnes âgées étant souvent polypathologiques, leur prise en charge nécessite des soins de plusieurs spécialistes ; et donc, il faut des pôles de santé ou des fusions des centres de santé (spécialisés) accessibles (géographiquement, financièrement et socialement), avec des soins efficaces, continus et adaptés.

Au regard de la fragilité de l'état de santé des personnes âgées, comme largement démontré par la Covid-19 à travers le monde et au Congo<sup>31-32</sup>, l'inclusion des soins gériatriques de surveillance des risques et de prise en charge classique dans les FOSA de premier échelon dans la pyramide sanitaire réduirait la charge de morbidité et de mortalité des personnes d'âge avancé. Aussi, il paraît important, dans le cadre de la surveillance, d'actualiser en permanence les outils de collecte d'informations pour mieux suivre les maladies des personnes âgées afin d'organiser et d'adapter le système de santé.

Dans les années à venir, la santé des vieux pèsera sur le système de santé car ils seront de plus en plus nombreux comme le prédisent les prévisions. Actuellement, le faible nombre de personnes âgées en République du Congo, traduit une hausse de mortalité évitable par des mesures de santé publique citées plus haut.

## IV.6. Santé sexuelle et reproductive

La problématique de la santé sexuelle et reproductive au Congo est sous documentée alors qu'elle est centrale pour la santé des femmes en âge de procréer au regard des tendances de la mortalité materno-infantile et des IST qui lui sont associées.

---

<sup>29</sup> Données issues des échanges avec les médecins du CHU de Brazzaville dans le cadre de cette évaluation.

<sup>30</sup> Entretiens avec la gériatre du CHU de Brazzaville.

<sup>31</sup> NODJADOUM Eric. Mémoire Master Santé Publique sur l'analyse de la morbi-mortalité des patients suivis pour Covid-19 en République du Congo ; année académique : 2020-2021.

<sup>32</sup> GONGAULT BANI Constant. Evaluation de la prise en charge des patients hospitalisés pour Covid-19 au Congo/Brazzaville ; année académique : 2020-2021.

Le phénomène de précocité des rapports sexuels mis en évidence au Congo montre que l'âge moyen d'entrée dans la vie sexuelle est de 15 ans (52 % Kindamba dans le pool et 76 % à Mossendjo dans le Niari)<sup>33</sup>. L'âge très jeune des premiers rapports sexuels non protégés est un facteur de risque de grossesses précoces et des IST. Sans compter les phénomènes de rapports sexuels forcés ou viols, le MICS-5 2014-2015, montrait déjà que la proportion des jeunes de 15-24 ans ayant des rapports avant l'âge de 15 ans était de 13,7% chez les femmes et de 16,8% chez les hommes (l'âge des premiers rapports sexuels étant de 15,6 ans en zone rurale contre 16,6 ans en zone urbaine).

Les seules données disponibles montrent que le taux d'utilisation de la contraception demeure faible en République du Congo. En effet, le MICS 2014-2015, montrait que 30,1% des femmes de 15-49 ans utilisaient une méthode contraceptive contre 22,0% en 2012. Sur les 1466738 des femmes en âge de procréer (15-49 ans) en 2021 au Congo, 32506, soit 2,2 % ont utilisé une méthode contraceptive, comme suit : i) Pilule : orale 4701 ; ii) les méthodes injectables : 24343 ; iii) le dispositif intra utérin (DIU) : 317 ; iv) les implants : 2961 ; v) les spermicides : 184 femmes.

Ces faibles performances paraissent paradoxales d'autant que le planning familial fait partie du paquet d'activités des formations sanitaires à tous les niveaux du système du Congo. Cela a comme conséquences le VIH, les IST et les grossesses non désirées qui souvent conduisent aux avortements et donc aussi à leurs complications. En effet, les avortements qui concernent dans la plupart des cas des jeunes femmes, constituent la troisième cause de décès maternels du pré partum (18%) au Congo<sup>34</sup>.

## **IV.4. Profil épidémiologique**

### **IV.4.1. Maladies transmissibles**

#### **IV.4.1.1. Le VIH/SIDA**

En République du Congo, la gravité de la situation du VIH particulièrement chez les femmes enceintes, chez les nourrissons et chez les jeunes et adolescents doit être rapidement corrigée afin d'inverser la tendance de propagation massive et silencieuse de cette épidémie dans toutes les couches de la population.

L'infection à VIH demeure préoccupante au Congo, avec une prévalence dans la population générale adulte (15-49 ans) estimée à 4,1% en 2022, montrant une épidémie de type généralisé, et correspondant à la deuxième prévalence la plus élevée de la région Afrique de l'Ouest et du Centre (après la Guinée Equatoriale, à 6,7%).

Les estimations du Spectrum montrent une augmentation de 10% du nombre d'adultes vivant avec le VIH au cours des 05 dernières années. Le nombre de personnes vivant avec le VIH est passé de 110.000 patients en 2017 à 140. 000 patients en fin 2022 dont 91.000 femmes adultes et 12 000 enfants), 16.000 nouvelles infections (dont 9.200 femmes adultes et 2.500 enfants) et 7.700 décès (dont 3.800 femmes adultes et 1.800 enfants). Les nouvelles infections chez les jeunes (15-24 ans) représentaient plus du quart (soit 4960) de toutes les nouvelles infections, survenant 4 fois plus chez les jeunes filles. Les principales données obtenues en fin 2021 sont contenues dans le tableau 6 ci-dessous.

---

<sup>33</sup> MSP. Rapport de la revue de la stratégie intégrée de la sante de la reproduction maternelle, néonatale, infantile, des adolescents et la nutrition du Congo 2018 - 2022.

<sup>34</sup> Anki Yambare, Analyse des déterminants de la mortalité maternelle pré partum en République du Congo 2013- 2015

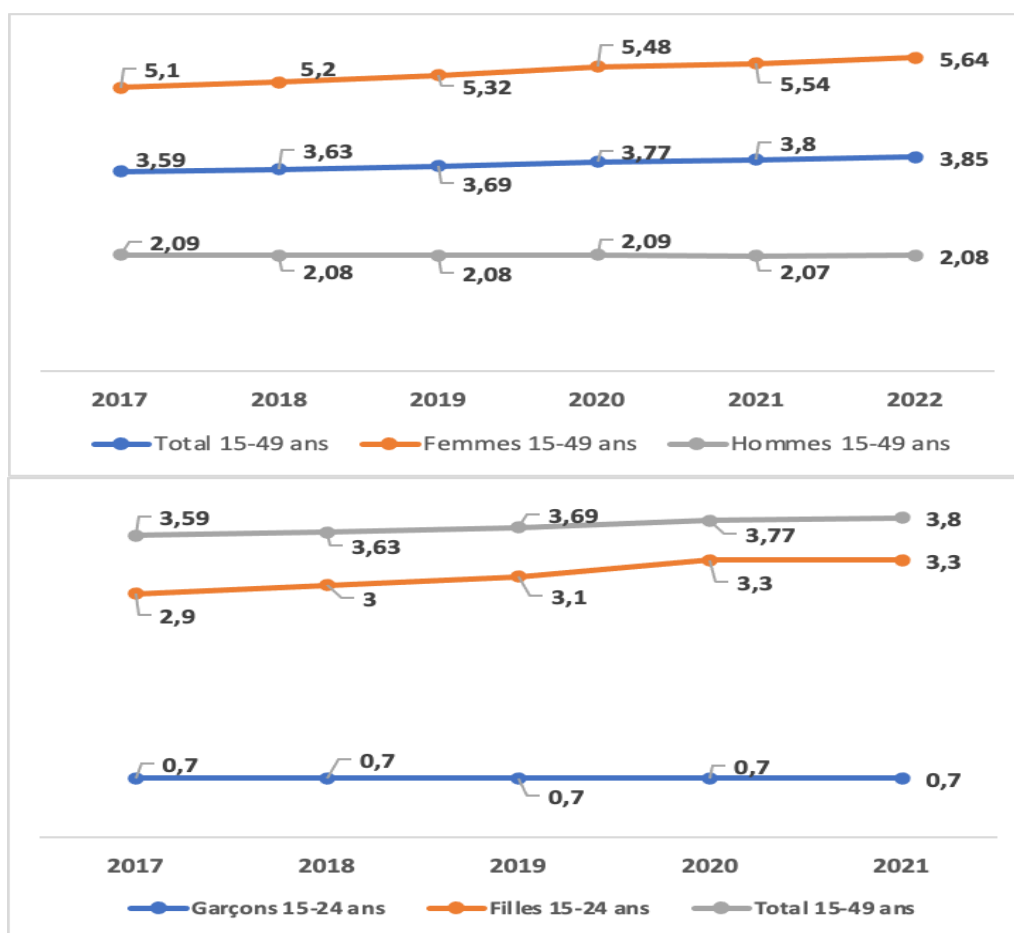


**Tableau 6 : Principaux indicateurs du VIH en 2021**

| Indicateurs                                                 | Données                    |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Prévalence du VIH chez les adultes de 15 à 49 ans           | <b>3.8 [2.7 - 5.9]</b>     |
| Prévalence du VIH Femmes âgées de 15 à 49 ans               | 5.6 [4.0 - 8.7]            |
| Prévalence du VIH Hommes de 15 à 49 ans                     | 2.1 [1.4 - 3.3]            |
| Prévalence du VIH chez les 15-24 ans                        | 2.0 [0.9 - 3.9]            |
| Prévalence du VIH chez les jeunes femmes (15-24 ans)        | 3.3 [1.3 - 6.8]            |
| Prévalence du VIH chez les jeunes hommes (15-24 ans)        | 0.7 [0.3 - 1.2]            |
| Nombre total de PVVIH                                       | 130 000 [95 000 - 200 000] |
| Nombre total de PVVIH (femmes)                              | 90 000 [65 000 - 140 000]  |
| Nombre total de PVVIH (hommes)                              | 41 000 [30 000 - 61 000]   |
| Nombre d'adultes de 15 ans et plus vivant avec le VIH       | 120 000 [86 000 - 180 000] |
| Nombre de femmes âgées de 15 ans et plus vivant avec le VIH | 84 000 [60 000 - 130 000]  |
| Nombre d'hommes de 15 ans et plus vivant avec le VIH        | 35 000 [25 000 - 53 000]   |
| Nombre d'enfants de 0 à 14 ans vivant avec le VIH           | 12 000 [8500 - 17 000]     |

Source : ONUSIDA, 2021

Sur le plan évolutif, on note que le nombre de PVVIH chez les hommes et les femmes connaît une augmentation régulière. Quelle que soit l'année, on note que le nombre de femmes vivant avec le VIH demeure presque le double de celui des hommes. La figure 11 ci-après montre l'évolution de la prévalence du VIH selon le sexe.



**Figure 12 : Evolution de la prévalence selon le sexe**

Ces tendances reflètent différentes faiblesses des programmes au niveau de : la prévention primaire (préservatifs) chez les adolescentes et les jeunes femmes, d'accessibilité au dépistage et reflétées en parallèle dans l'augmentation des nouvelles infections, gap dans le traitement et la suppression virale dans ces groupes de population, mais également l'existence d'un certain nombre de facteurs de vulnérabilité (précarité économique, violences sexuelles, l'accès aux moyens SSR...)

La prévalence des adultes sous ARV est de 30 %, tandis que le nombre estimé de nouvelles infections est de 7 300 et celui des décès liés au VIH/SIDA est de 5 600 (UNAIDS Data 2021). Les tendances épidémiologiques du VIH ressortent que la part d'augmentation des nouvelles infections était de 8% entre 2015 et 2021.

La situation du VIH chez les femmes enceintes est préoccupante ; 17 % seulement bénéficient du dépistage lors des soins prénatals (SPN) alors que 93% d'entre-elles réalisent au moins une SPN. En outre, 98% des nourrissons exposés au VIH ne bénéficient pas du diagnostic précoce et 94% ne sont pas sous prophylaxie antirétrovirale. Les données de traitement ont montré que 1.526 mères VIH recevaient une PTME sur 7.800 dans le besoin, soit 19,6%. Par ailleurs, la cascade 95-95-95 indique que 24% des PVIH connaissaient leurs statuts VIH (soit 35.062 personnes), 97% de ces dernières recevaient un traitement antirétroviral, et 77% des personnes sous traitement ont observé une suppression de la charge virale. Ce qui montre un réel problème au niveau du dépistage.

En dépit des faiblesses constatées, de nombreux progrès ont été enregistrés dont nous pouvons citer :

- 1) baisse de la prévalence du VIH chez les femmes enceintes, de 3,6% en 2012 à 1,5% en 2023, selon les résultats des enquêtes de séro- surveillance sentinelles des femmes enceintes ;
- 2) augmentation de la couverture en ARV chez les femmes enceintes, de 10% en 2019 à 43% en 2023 ;

3) mise sous traitement antirétroviral de 38 000 personnes en 2023, contre 26 000 en 2019.

Pour atteindre les ODD d'ici 2030, le volet relatif au SIDA vise à mettre fin à cette épidémie afin que ce ne soit plus une menace de santé publique. Pour assurer la continuité de la riposte au Sida et poursuivre la marche du pays vers l'élimination de l'épidémie du VIH à l'horizon 2030, la Direction exécutive du Conseil National de Lutte contre le VIH/Sida, les IST et les épidémies (Dex/CNLSE) vient d'élaborer et valider un nouveau Cadre stratégique national de riposte pour la période 2023-2027 (CSN 2023-2027).

Le but de ce nouveau cadre stratégique est d'accélérer la réponse nationale et renforcer l'efficacité et la performance des programmes en vue de mettre fin à l'épidémie du VIH en tant que menace de santé publique d'ici à fin 2030, en s'appuyant sur les orientations de la politique nationale de santé, les orientations de développement sanitaire, la Nouvelle stratégie mondiale de l'ONUSIDA relative aux 95-95-95, « c'est-à-dire que 95 % de toutes les personnes vivant avec le VIH devraient être au courant de leur statut VIH, 95 % de ces personnes devraient recevoir un traitement antirétroviral continu (TAR) et 95 % de toutes les personnes sous TAR devraient enfin avoir une charge virale indétectable ». L'objectif mondial zéro stigmatisation et discrimination pour la période 2021-2026 ainsi que la stratégie mondiale 2030 de l'OMS (VIH, hépatites, IST).

#### **IV.4.1.2. La tuberculose (TB) et co-infection TB/VIH**

La République du Congo est classée parmi les 30 pays à charge élevée de la TB et de la TB/VIH dans le monde alors que l'élimination de la tuberculose d'ici 2030 est l'une des priorités de la santé mondiale, comme le prévoient les ODD ainsi que la stratégie « End TB » de l'OMS entérinée en 2018.

La tuberculose (TB) demeure un problème majeur de santé publique pour le pays. En 2021, l'OMS estimait le taux d'incidence à 370 cas pour 100 000 habitants, au-dessus de la moyenne africaine (237 cas pour 100 000 habitants) et mondiale (133 cas pour 100 000 habitants). Au cours de cette même année, 11 980 nouveaux cas et rechutes de tuberculose (toutes formes) ont été déclarés par le Programme National de Lutte contre la Tuberculose (PNLT). La mortalité, toutes formes confondues, est également élevée, soit 54 pour 100 000 habitants pour les patients TB-HIV négatifs et 45 pour 100 000 habitants pour les patients TB-HIV positifs. Sur les 4 dernières années, l'évolution de la mortalité se traduit par une baisse entre 2017 et 2019, suivie d'une hausse en 2020 à cause de la pandémie de Covid-19 puis enfin d'une régression du nombre de décès à 54 cas (30-85) pour 100 000 habitants en 2021<sup>35</sup>.

Chez les coinfectés TB/VIH, le taux de mortalité est resté stable entre 2013 et 2017 avant de baisser régulièrement jusqu'en 2019. Tout comme chez les tuberculeux indemnes de VIH, le taux de mortalité chez les TB/VIH a connu une hausse en 2020 avant d'amorcer une tendance à la baisse en 2021 pour s'établir à 45 (22-75) cas de décès pour 100.000 habitants<sup>36</sup>.

Le Congo fait partie des 30 pays qui présentent la plus forte charge de la maladie TB et de la TB/VIH. Il est dépourvu de système de surveillance remplissant les conditions de mesure directe de l'incidence à partir des données du pays. De ce fait, l'incidence de la TB dans ce pays est généralement estimée par l'OMS par des méthodes combinant l'utilisation des données de notification et l'opinion d'experts sur le sous-diagnostic et la sous-déclaration dans le pays.

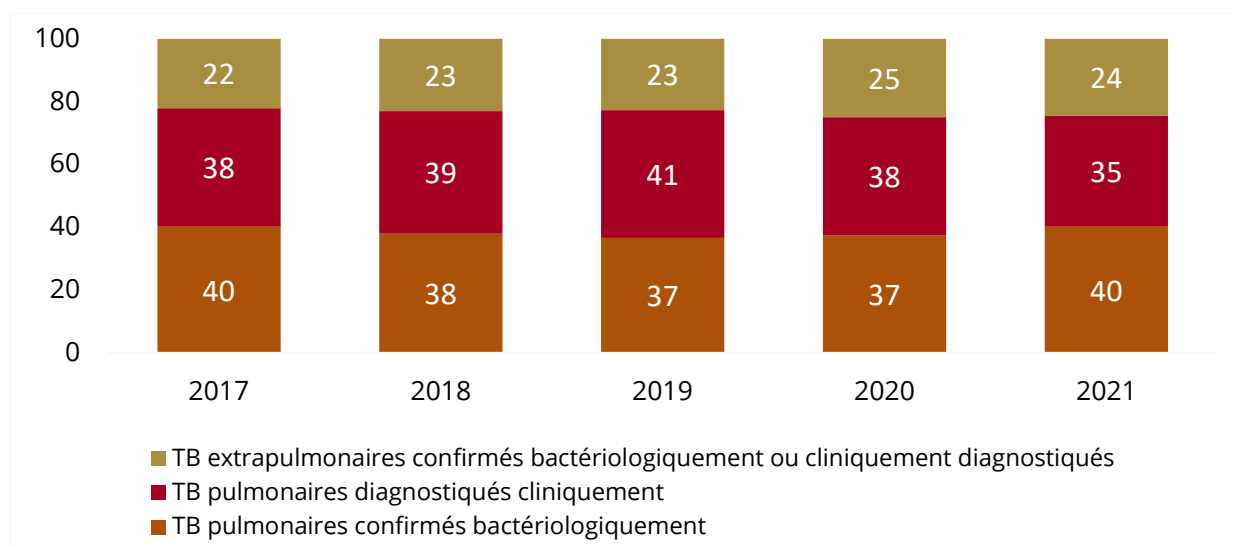
En 2021, le taux d'incidence de la TB au Congo est estimé par l'OMS à 370 (231-542) cas pour 100 000 habitants<sup>37</sup>, et n'a pas connu grande variation depuis l'année 2000. Ce taux a augmenté de 4% en 2021 par rapport à son niveau de 2000. Le système de surveillance du Congo a notifié 11980 nouveaux cas et rechutes de TB en 2021 tandis que l'incidence estimée était de 22000 cas soit un gap de 45%.

---

<sup>35</sup> [www.who.int/tb/data](http://www.who.int/tb/data)

<sup>36</sup> [www.who.int/tb/data](http://www.who.int/tb/data)

<sup>37</sup> [www.who.int/tb/data](http://www.who.int/tb/data)



**Figure 13 : Formes cliniques des nouveaux cas et rechutes de TB, Congo, 2017-2021**

La détection des cas de tuberculose n'est pas optimale car, 45% cas incidents ne sont pas diagnostiqués et mis sous traitement. L'insuffisance du dépistage de la tuberculose est liée au diagnostic hypercentralisé, à l'absence d'intégration des activités de dépistage dans les établissements de soins du secteur public (77,6%), et à la faiblesse des stratégies spécifiques de screening chez les populations clés et vulnérables, notamment les enfants, les personnes vivant avec le VIH, les détenus, les migrants et réfugiés, les groupes autochtones

La couverture en unité de bacciloscopie de 1, le nombre limité de Gene experts, le système de transport des échantillons à l'état de projet pilote, la fonctionnalité non optimale du LNR, les besoins non satisfaits en personnels font du réseau de laboratoire un dispositif pas pleinement opérationnel.

Le taux de succès du traitement a certes progressé atteignant 75,2% en 2021, mais la prise en charge reste confrontée à des pesanteurs socio-sanitaires qui engendrent des dépenses pour le patient, un important nombre de perdus de vue (12,6%), des non évalués (10%).

Concernant la TBPR, même si l'offre diagnostique n'est pas encore décentralisée, le taux de succès du traitement est assez satisfaisant (81%) et le soutien économique et nutritionnel aux patients est quasi permanent.

Des efforts ont été faits pour instaurer des guichets uniques TB/VIH. Cependant, les activités de collaboration TB-VIH sont encore suboptimales. En effet, la couverture du dépistage du VIH chez les patients TB au Congo reste faible depuis 5 ans et inférieure à 45% et seulement 40% des coinfectés sont mis sous ARV.

La proportion des enfants parmi les nouveaux cas et rechutes de TB est restée dans l'intervalle 5 à 15% (norme OMS). La prise en charge thérapeutique des enfants et des adolescents se fait surtout dans des services intégrés à tous les niveaux de la pyramide sanitaire sur la base des directives nationales. Cependant, elle est confrontée à de nombreux défis de type organisationnel et technique.

La communauté contribue à la mise en œuvre des stratégies de lutte contre la tuberculose à travers les ONGs mais sa participation est encore peu développée pour agir sur les déterminants et favoriser l'atteinte des indicateurs. Il importe de noter que les activités de communication, de collaboration multisectorielle et du secteur privé (6,1%) ne sont pas très solides pour impulser une dynamique poussée de performance.

Il est à noter qu'en République du Congo, le dépistage, les médicaments de première et de deuxième ligne sont gratuits. L'application des nouvelles directives du traitement de la pharmacorésistance

avec suppression totale des injectables est effective. Le programme bénéficie de l'appui des partenaires tels que le Fonds Mondial (FM), IDA et OMS.

Un nouveau plan stratégique vient d'être élaboré et adopté. Ce plan, qui couvre la période 2023-2027, s'inscrit dans les grandes orientations de la stratégie mondiale « END TB ». La vision à long terme de ce plan stratégique national (PSN) s'aligne à celle de la stratégie « END TB » qui est de faire du Congo, un pays avec « Zéro décès et aucune maladie ni souffrances dus à la tuberculose ». L'année 2025, comprise dans la période couverte par le PSN, pose des jalons importants d'objectifs de réduction de 50% de l'incidence et de 75% de la mortalité par rapport à 2015.

#### IV.4.1.3. Le Paludisme

Le paludisme demeure une préoccupation majeure de santé publique et l'une des premières causes de morbi-mortalité en République du Congo. Le vecteur le plus fréquemment observé est *Anophele gambiae* (90%). La principale espèce plasmodiale rencontrée sur l'ensemble du territoire est *Plasmodium falciparum*.

Comme dans plusieurs autres pays où sévit cette maladie, toutes les couches de la population sont exposées, notamment les enfants de moins de cinq ans et les femmes enceintes considérées comme les plus vulnérables.

Selon le Rapport du Programme national de lutte contre le paludisme de 2021, le paludisme demeure la première cause des consultations avec une fréquence de 71 % contre 63% en 2016. Il est responsable de 56 % d'hospitalisations versus 20 % en 2016 et de 42 % de mortalité (stable par rapport à 2016)<sup>38</sup>.

Ces fréquences témoignent de la multiplicité importante des facteurs de risque (faible utilisation de la MILDA, insalubrité, administration non supervisée de la Sulfadoxine/pyriméthamine chez les femmes enceintes, ...) et de la prévention.

Globalement depuis 2017, on observe une tendance à la baisse des décès liés au paludisme passant de 49% à 14% entre 2017 et 2021. Dans le cadre de la lutte contre le paludisme, le Congo est en phase de contrôle de la maladie selon la classification OMS avec un taux d'incidence globale de 228 cas pour 1000 personnes exposées en 2021.

Dans la riposte contre ce fléau, en dépit des efforts fournis, le Congo est encore à la phase de contrôle de la maladie, suivant la classification de l'OMS. En effet, malgré l'observation d'une diminution progressive de plus de 37% du taux d'incidence globale 39 entre en 2019 (238 cas pour 1000 personnes exposées) et 2021 (219 cas pour 1000 personnes exposées), le Congo n'a pas encore atteint la norme relative au contrôle de la maladie.

La charge épidémiologique du paludisme est très importante pour le système de soins au Congo. Le paludisme constitue la première cause des consultations (71%), d'hospitalisation (56%) et de mortalité (42%)<sup>40</sup> en 2021. Le taux d'hospitalisation du au paludisme a connu une augmentation, il est passé de 5 à 10 pour 10 000 habitants tandis que le taux de mortalité due au paludisme a diminué de 39 à 15 pour 100 000 habitants<sup>41</sup>, pour la même période.

Globalement, la tendance des principaux indicateurs, notamment l'incidence et la mortalité liées au paludisme chez les enfants de moins de 5 ans est à la hausse entre 2018 et 2022. Néanmoins, il a été observé une diminution de la mortalité de 12% (passant de 31% à 19%) entre 2019 et 2020, après la campagne de distribution de masse des MILDA de 2019. Cette tendance a été inversée par une

---

<sup>38</sup> Rapport du Programme national de lutte contre le paludisme, 2021

<sup>39</sup> Rapport OMS

<sup>40</sup> DHIS2

augmentation de 6% de cet indicateur qui est passé de 23% à 29% entre 2021 et 2022. De même, l'incidence du paludisme a connu une augmentation de 10% (passant de 58% à 66%) entre 2019 et 2021. En 2022, cette incidence a été de 50%.

Toute la population est exposée au risque de contracter cette maladie. Cependant les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans constituent les groupes les plus vulnérables. Chez les moins de 5 ans, le paludisme représente 66% des causes de consultation externe, 58% des causes d'hospitalisations et 23% des causes de décès au niveau des hôpitaux<sup>42</sup>.

**Tableau 7: Evolution des principaux indicateurs du paludisme au Congo, 2018 à 2020**

| Indicateurs                                                                                      | 2018                                                   | 2019                                                    | 2020                                                    | 2021                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Incidence du paludisme chez les moins de 5 ans pour 1000 personnes                               | 243.<br>(Rapport OMS 2017)                             | 237.7<br>(Rapport OMS 2018)                             | 228.0<br>(Rapport OMS, 2019)                            | 218.7<br>(Rapport OMS 2020)                                                  |
| Couverture des enfants de moins de 5 ans qui dorment sous moustiquaires imprégnées d'insecticide | 60%<br>(MICS 2014-2015)                                | 60%<br>(MICS 2014-2015)                                 | 60%<br>(MICS 2014-2015)                                 | 60%<br>(Rapport de l'enquête post campagne réalisée en 2020)                 |
| Femmes enceintes qui dorment sous moustiquaires imprégnées d'insecticides                        | 60%<br>(MICS 2014-2015)                                | 60%<br>(MICS 2014-2015)                                 | 60%<br>(MICS 2014-2015)                                 | 68,3% (Rapport de l'enquête post campagne réalisée en 2020)                  |
| Couverture en TPI 3                                                                              | 12%<br>(MICS 2014-2015)                                | 12%<br>(MICS 2014-2015)                                 | 12%<br>(MICS 2014-2015)                                 | 34% (Rapport annuel du PNLP 2021) et 30,95 % (Rapport de l'enquête TPI-2021) |
| Hospitalisation liée au paludisme pour 10000 personnes                                           | 68,9<br>(Rapport revue à mi-parcours du PSN 2014-2018) | 126,2<br>(Rapport revue à mi-parcours du PSN 2014-2018) | 115,4<br>(Rapport revue à mi-parcours du PSN 2014-2018) | 5 pour 10000 personnes (Rapport PNLP 2021)                                   |
| Mortalité liée au paludisme chez les enfants de moins de 5 ans pour 100000                       | 21,5<br>(Rapport revue à mi-parcours du PSN 2014-2018) | 19,1<br>(Rapport revue à mi-parcours du PSN 2014-2018)  | 44,8<br>(Rapport revue à mi-parcours du PSN 2014-2018)  | 4 pour 100000<br>(Rapport PLNP 2021)                                         |

<sup>42</sup> Rapport PNLP, 2021

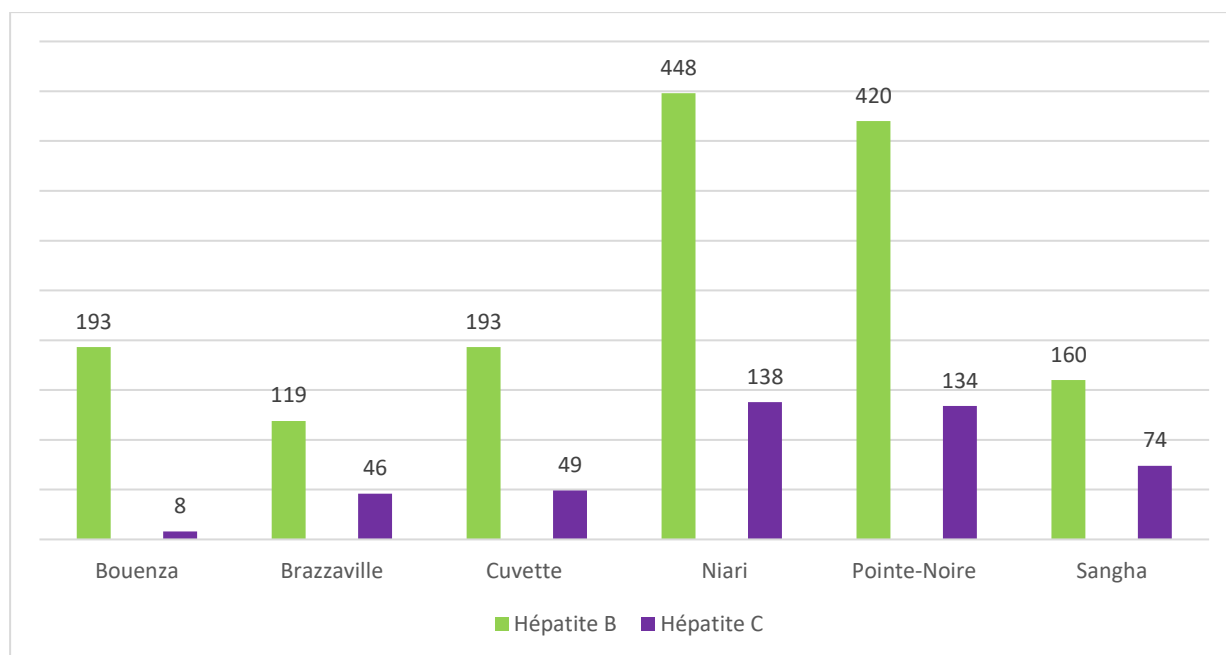
Un nouveau plan stratégique vient d'être élaboré et adopté. Il couvre la période 2023-2027. Le but de ce plan est de contribuer à l'amélioration du niveau de santé de la population congolaise par la réduction du fardeau humain et socio-économique dû au paludisme.

L'Objectif général est de réduire la morbidité proportionnelle et la mortalité liées au paludisme. Il s'agira spécifiquement, d'ici fin 2027, de : i) réduire de 78% (de 54% à 10,5%) la morbidité liée au paludisme de la population générale par rapport aux données de 2015 ; ii) réduire de 78% (de 41% à 9,02%) la mortalité liée au paludisme par rapport aux données de 2015 ; iii) renforcer la surveillance épidémiologique et entomologique ; iv) renforcer les capacités managériales du PNLP.

#### IV.4.1.4. Les hépatites virales

**La stratégie mondiale de l'OMS concernant l'hépatite virale prévoit l'élimination de l'hépatite d'ici 2030 (définie comme une réduction de 90 % des nouveaux cas et de 65 % des décès).**

En République du Congo, près de 4.000 personnes souffrent de l'hépatite<sup>43</sup>. En 2016, le MSP estime que plus de 75 % des personnes atteintes d'hépatite virale l'ignorent. Les données récentes du MSP révèlent des prévalences de l'hépatite B et C respectivement de 8,27% et de 2,33%.



**Figure 14 : Nombre de cas d'hépatites b et c dans 5 départements du Congo**

Source : MSP/Programme national Hépatites, 2022

Les données sur les hépatites sont très sous-estimées en République du Congo. En effet, peu de structures sanitaires font les tests de diagnostic pour la prise en charge des hépatites B et C.

Les données du MSP concernant la sécurité des injections et des produits sanguins, obtenues sur 2635 tests biologiques effectués chez les donneurs de sang par marqueurs viraux montrent 198 cas (7,51%) et 52 cas (1,97%) respectivement d'hépatite B et d'hépatite C.

#### IV.4.2. Maladies non transmissibles

**La cible 3.4** de l'ODD n°3, stipule que d'ici 2030, il faut réduire d'un tiers, par la prévention et le traitement, le taux de mortalité prématurée due à des maladies non transmissibles et promouvoir la santé mentale et le bien-être.

<sup>43</sup> Olufunmilayo Lesi, expert du groupe des maladies transmissibles au bureau régional Afrique de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS)

La montée des maladies chroniques se fait à un rythme inquiétant en République du Congo, du fait de la prolifération des facteurs de risque tels que les émissions des particules fines de monoxyde de carbone par les vieux véhicules, le stress, la consommation d'alcool, de tabac, des aliments sucrés et salés, ... tout ceci dans un contexte d'insuffisance des stratégies et structures de prévention primaire et d'offre de soins adaptés à ces maladies de prise en charge au long cours<sup>44</sup>. Si les tendances actuelles ne sont pas rapidement corrigées, les ODD d'ici 2030 ne seront pas atteints.

Les maladies non transmissibles (MNT) sont des affections chroniques qui, en l'absence de diagnostic rapide et de prise en charge précoce, provoquent une hausse des taux de morbidité et de mortalité dans les populations humaines. En Afrique, la mortalité liée aux maladies non transmissibles augmente au fil des ans à tel point que la part de ces maladies dans l'ensemble des décès est passée de 24,2 % en 2000 à 37,1 % en 2019. La principale cause étant la faible capacité de diagnostic précoce et de prise en charge de manière équitable.

Au Congo, le bureau pays de l'OMS souligne que 80% des MNT, comme les maladies cardiovasculaires, l'insuffisance rénale, l'hypertension artérielle, les cancers, l'asthme et autres ne sont pas diagnostiquées. Au niveau des centres de santé intégrés, leur prise en charge est presque inexistante alors que plus de 30% de la population adulte est hypertendue et 3 à 4% diabétique.

#### **IV.4.2.1. Maladies cardiovasculaires**

Bien que peu de données actualisées existent sur la thématique, on note que l'enquête STEPS de 2004 menée à Brazzaville avait mis en évidence une prévalence globale de l'hypertension artérielle ignorée par la population de 32,5%. Autrement dit, une HTA non traitée. En plus, une survenue très précoce était observée car, près de 19% des jeunes d'âge compris entre 25 et 34 ans ignoraient être victimes de cette maladie chronique. Environ 68,2 % des sujets de 54 à 65 ans étaient touchés par l'HTA. Toutefois, en 2017, les données hospitalières ont mis en évidence une fréquence d'HTA de 55,8% chez les 37 à 73 ans.

Les statistiques sanitaires du Congo ont rapporté 1663 cas d'HTA en 2015 et 2164 cas d'HTA en 2016. Les données du CHU de Brazzaville révèlent que la plupart des cas d'insuffisance cardiaque reçus en 2017, avaient comme cause principale l'HTA. Dans ce même registre, on note des taux élevés d'AVC qui constituent la première cause d'hospitalisation dans les services de neurologie, de réanimation, de cardiologie et de médecine interne au Congo Brazzaville avec une fréquence de 40% entre 2014 et 2017 au CHU de Brazzaville et à l'hôpital de Loandjili de Pointe-Noire. La fréquence d'hospitalisation pour AVC était de 56% chez les hommes et 44% chez les femmes.

Le phénomène de précocité d'AVC est très préoccupant en République du Congo car près de 70 % des cas étaient des sujets d'âge compris entre 25 et 59 ans avec une létalité de 27,7%.

#### **IV.4.2.2. Le diabète**

Selon le MSP, les données hospitalières relèvent une prévalence de 7% de l'ensemble de la population congolaise, dans un contexte où les médicaments et autres produits nécessaires à la prise en charge ne sont pas toujours disponibles. Il y a une décennie, le diabète de type 2 était considéré comme une maladie des adultes. Mais, au fil des années et au regard de l'absence de mise en œuvre des stratégies de prévention et de promotion de la santé en faveur des jeunes, apparaît une inversion des profils des sujets diabétiques en République du Congo avec des cas très jeunes de diabète de type 2. En effet, les données du CHU de Brazzaville, montrent une prévalence de 4,3% des jeunes d'âge moyen de 19 ans suivis pour un diabète de type 2<sup>45</sup>.

Le diabète constitue la première cause d'insuffisance rénale au Congo. Les données hospitalières montrent que 45% des cas d'insuffisance rénale concernent les sujets diabétiques. En 2015, 946 cas avec un taux de létalité de 3,4% et 591 cas pour une létalité de 1,35% en 2016 ont été

---

<sup>44</sup> Données hospitalières du CHU de Brazzaville, 2023

<sup>45</sup> Mayanda Ohouana, R., Andzouana Mbamognoua, N., Okoumou-Moko, A., Elenga-Bongo, C., Bouenizabila, E., & Monabeka, H. (2021). Diabète de Type 2 de l'Enfant et de l'Adolescent au CHU de Brazzaville. *HEALTH SCIENCES AND DISEASE*, 22(6).



observés au CHU de Brazzaville. Les complications du diabète notifiées dans le rapport du CHUB sont essentiellement : l'acidocétose (58,20%), le pied diabétique (18,03%), l'hypoglycémie (9,56%), les abcès/infections cutanées (9,56%) et la gangrène gazeuse (4,64%).

#### IV.4.2.3. Les cancers

L'absence des statistiques nationales sur le cancer au Congo ne facilite pas l'organisation de la lutte contre cette maladie. Cependant, à Brazzaville, le registre des cancers qui existe depuis 1996 rapporte, pour la période 2010-2013 sur l'ensemble des patients diagnostiqués, 43,6% sont des hommes, 52,6% des femmes et 4,3% des enfants. En moyenne, 600 cas de cancer sont diagnostiqués chaque année à Brazzaville.

Les cancers les plus fréquents chez l'homme sont : le cancer de la prostate, du foie, du sang, de la peau, des poumons et celui du colon. Chez la femme, les cancers les plus retrouvés sont : le cancer du sein, du col utérin, du sang et des ovaires. Le cancer de la rétine, du rein, du sang, des os et des ganglions sont les plus fréquents chez les enfants<sup>46</sup>. En 2020, selon le Globocan, on note 2478 nouveaux cas des cancers en République du Congo avec un risque cumulé de 9,7% de développer un cancer avant l'âge de 75 ans.

**Tableau 8 : Statistiques des cancers en 2020.**

| Variables                                                                                                        | Hommes                                                | Femmes                                                   | Total                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Nombre de nouveaux cas de cancer                                                                                 | 1 105                                                 | 1 373                                                    | 2 478                                                     |
| Taux d'incidence normalisé selon l'âge                                                                           | 92.8                                                  | 81.7                                                     | 84.4                                                      |
| Risque de développer un cancer avant l'âge de 75 ans (%)                                                         | 11.0                                                  | 8.9                                                      | 9.7                                                       |
| Prévision des cas des cancers sur 5 ans                                                                          | 2 060                                                 | 3 078                                                    | 5 138                                                     |
| Top 5 des cancers les plus fréquents, à l'exclusion du cancer de la peau autre que le mélanome (classés par cas) | Prostate<br>Foie<br>Colorectum<br>Estomac<br>Leucémie | Sein<br>Col de l'utérus<br>Colorectum<br>Foie<br>Estomac | Sein<br>Prostate<br>Col de l'utérus<br>Foie<br>Colorectum |

Source : Globocan, 2020

#### IV.4.2.4. La drépanocytose

La drépanocytose est une maladie génétique de l'hémoglobine qui touche la plupart des pays de la région africaine de l'OMS. Elle cause une déformation des globules rouges en leur donnant la forme d'une faucille, ce qui perturbe le transport d'oxygène dans le sang et augmente la susceptibilité à la formation de caillots. La majorité des enfants atteints de la forme la plus grave de la maladie meurent avant l'âge de 5 ans, généralement d'une infection ou d'une perte de sang grave.

<sup>46</sup> [http://www.santetropicale.com/sites\\_pays/actus.asp](http://www.santetropicale.com/sites_pays/actus.asp) cité le 29 décembre 2022.

En République du Congo, plus de 25 % de la population, soit 1,4 million de personnes, présente un trait drépanocytaire<sup>47</sup>. La maladie reste encore peu connue, ignorée ou sous-estimée par la population et même par certains professionnels de santé. Bien que non chiffrée au CHU de Brazzaville comme dans la plupart des établissements de santé du pays, la mortalité demeure élevée.

#### IV.4.2.5. Maladie mentale

D'après l'OMS, environ 450 millions de personnes souffrent actuellement d'un désordre mental, de l'addiction à des substances toxiques, et de la démence au niveau mondial. Plusieurs facteurs peuvent avoir un effet sur le développement de la maladie mentale. À titre d'exemple, au niveau biologique, on peut penser à des dommages prénatals, des traumatismes physiques, des infections et des déséquilibres chimiques dans le cerveau. Pour ce qui est des facteurs psychologiques et sociaux, des éléments tels que l'absence de soutien social, les mauvais traitements durant l'enfance, la violence familiale, le chômage et les changements importants au cours de la vie peuvent influencer le déclenchement de ces maladies.

Le service de psychiatrie du CHU de Brazzaville, le seul dont dispose la République du Congo, enregistre en moyenne 1.200 admissions chaque année dues aux maladies mentales. Au Congo, comme dans la plupart des sociétés africaines, la déficience mentale, étant peu connue est souvent associée à la sorcellerie et le recours aux soins médicaux n'est pas toujours la première option. La situation de ces maladies est accentuée par la consommation de substances psychotropes qui connaît un effet de mode auprès des populations jeunes. Selon le rapport d'activités de 2016 du CHU de Brazzaville, les principales pathologies en hospitalisation étaient les psychoses délirantes aiguës représentant 43,5% des cas, les schizophrénies (22,3%), les troubles bipolaires en phase maniaque (16,1%) et les psychoses hallucinatoires chroniques (8,8%).

Selon le rapport d'activités de 2021 du CHU, les principales pathologies enregistrées en hospitalisation étaient : les psychoses délirantes aiguës (29,41%), les schizophrénies (26,47%), les troubles bipolaires essentiellement en phase maniaque (26,47%), les psychoses hallucinatoires chroniques (11,76%) et les psychoses toxiques (5,88%). A l'hôpital Général Adolphe SICE de Pointe-Noire et à l'Hôpital Central des Armées de Brazzaville, on enregistre respectivement une moyenne annuelle de 700 et 433 consultations. Le pic d'apparition des maladies mentales était retrouvé chez les 15 à 25 ans, ceci étant accentué par le confinement lié à la pandémie de la COVID-19.

En termes de ressources humaines, on dénombre quatre (04) médecins psychiatres, cinq (05) médecins généralistes, trois (03) infirmiers spécialisés en santé mentale, seize (16) infirmiers diplômé d'Etat, et dix-sept (17) psychologues cliniciens, exerçant tous dans les structures publiques. Le dispositif d'offre de soins de santé mentale reste caractérisé par une insuffisance quantitative et qualitative en personnel avec une inégale répartition sur le territoire national (trois médecins psychiatres sont à Brazzaville et à un à Pointe-Noire). Cette situation a pour conséquences : i) une insuffisance de certains profils d'agents (psychiatres, psychologues, infirmiers spécialisés en santé mentale...) ; ii) une absence d'autres profils d'agents (Educateurs Spécialisés, Orthophonistes, Psychomotriciens ; Ergothérapeutes,) ; iii) une insuffisance de formation des professionnels en santé mentale ; iv) une répartition inégale des ressources humaines en santé mentale.

L'ampleur des MNT a conduit à l'élaboration d'une stratégie régionale africaine dénommée PEN-PLUS, visant à alléger le fardeau que ces maladies font peser sur les populations rurales et non desservies moyennant la mise en place de services de consultation externe décentralisés et intégrés dans les centres de santé de premier niveau.

La République du Congo a adopté cette stratégie régionale à Lomé (2022) en acceptant d'assurer l'offre de services essentiels de lutte contre les MNT à travers des services décentralisés de consultation externe complétées par une prise en charge intégrée des cas.

---

<sup>47</sup><https://www.afro.who.int/fr/news/au-congo-le-centre-de-reference-de-la-drepanocytose> cité le 29 décembre 2022.

#### IV.4.2.6. Les maladies bucco-dentaires

Les maladies et affections bucco-dentaires sont à l'origine d'une importante charge de morbidité dans de nombreux pays et font ressentir leurs effets tout au long de la vie, en provoquant une gêne, des douleurs, des lésions défigurantes.

Au Congo, les données permettant de documenter le poids des maladies et affections buccodentaires ne sont pas disponibles. Néanmoins, avec l'évolution des conditions de vie, en particulier du fait de la consommation croissante de sucres et d'une exposition insuffisante aux fluorures est un signal important qui laisse présager un accroissement de la prévalence de ces maladies.

#### IV.4.3. Maladies évitables par la vaccination

La vaccination joue un rôle important dans la réalisation de 14 des 17 objectifs de développement durable. De 2017 à 2022, deux (2) nouveaux vaccins ont été introduits dans le calendrier national de routine : le vaccin anti poliomyélite injectable (VPI) et le vaccin combiné contre la rougeole et la rubéole (RR). Le vaccin antitétanique (VAT) a été remplacé par le vaccin combiné contre la diphtérie et le tétanos (Td) et le vaccin anti rotavirus (Rotarix) a été remplacé en 2020 par le Rotavac qui se prend actuellement en trois (3) doses.

##### IV.4.3. 1. Surveillance des maladies évitables par la vaccination

La poliomyélite, la rougeole, la fièvre jaune et le tétanos maternel et néonatal sont les principales maladies évitables par la vaccination qui font l'objet d'une surveillance au cas par cas au niveau du programme. Cette surveillance est organisée selon les niveaux de la pyramide sanitaire. Les objectifs fixés dans le PPAC 2018-2022 en matière de surveillance épidémiologique étaient les suivants :

- ❖ D'ici fin 2022, au moins 95% des DS ont atteint/maintenu les indicateurs de performance requis pour la certification :
- ❖ D'ici fin 2022, au moins 80% des DS ont maintenu les indicateurs de performance requis pour l'élimination de la rougeole :
- ❖ D'ici fin 2022, maintenir les indicateurs de performance de la fièvre jaune :
- ❖ -D'ici fin 2022, maintenir à moins d'1 cas suspect de TMN pour 1000 Naissances Vivantes dans 100% des DS.

##### a) Surveillance de la poliomyélite/paralysies flasques aiguës

Tous les pays d'Afrique centrale ont été déclarés libres de poliovirus sauvage le 25/08/2020. La situation des principaux indicateurs de la surveillance de la poliomyélite au Congo se présente comme suit entre 2018 et 2022.

Dans le cadre de la surveillance épidémiologique, un rapport de situation est produit hebdomadairement et prend en compte les principaux indicateurs de surveillance des maladies ciblées. Ce suivi a permis de prendre des actions pour une amélioration des activités de surveillance.

Le Congo a maintenu et amélioré les indicateurs majeurs de la surveillance des PFA. En effet,

- ❖ Le taux de PFA non Polio annualisé (objectif  $\geq 3$ ) est resté supérieur à 3 ces cinq dernières années. Il est passé de 7,5 en 2019 à 7,76 en 2023, avec une légère baisse en 2020.
- ❖ En ce qui concerne le pourcentage des selles prélevées dans les 14 jours (objectif  $\geq 80\%$ ), il est passé de 90,5% en 2019 à 98% en 2023. Une chute à 82,4% a été observée en 2021 suite aux difficultés du système sanitaire dues à la lutte contre la pandémie de Covid-19. Cette situation épidémique de Covid-19 a été également l'une des causes de non atteinte des deux principaux indicateurs des années 2019 et 2020 respectivement 25% et 75%.
- ❖ S'agissant des résultats de laboratoire, aucun poliovirus sauvage (PVS) n'a été isolé. Par contre, six (6) cas de poliovirus dérivés de la souche vaccinale (PVDV) vaccinale ont été notifiés de 2020 à 2023 dont un (1) de type 1 et 5 de type 2. Parmi les derniers, deux (2) ont

été rapporté par la surveillance environnementale. La qualité des selles à travers la détection des entérovirus (Taux NPENT $\geq$ 10%) s'est améliorée et oscille autour de 12% ces dernières années.

- ❖ Le point faible dans le cadre de la surveillance des PFA est la promptitude de l'acheminement des échantillons de selles au laboratoire qui reste en deçà de 50% selon le Rapport de situation (SitRep) de la 52ème semaine de l'année 2023.

**Tableau 9 : Surveillance de la poliomyélite**

| Indicateurs                                            | 2018        | 2019         | 2020       | 2021         | 2022        |
|--------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------|--------------|-------------|
| Total cas PFA notifiés                                 | 166         | 200          | 100        | 176          | 165         |
| Nombre CS ayant notifié au moins 1 cas                 | 140(16.17%) | 175 (20.21%) | 97(11.20%) | 110 (17.02%) | 148 (17.1%) |
| Taux de PFA Non Polio annualisé / 100000               | 6.51        | 7.57         | 3.7        | 6            | 6.5         |
| % de cas de PFA adéquats                               | 90.1        | 80           | 78.8       | 81.2         | 93.9        |
| % districts ayant atteint les 2 principaux indicateurs | 81.4        | 73.07%       | 32.7%      | 63.4         | 76.9        |
| Taux Entérovirus Non Polio                             | 11.9        | 13.9%        | 10.1%      | 13.6         | 8.4         |

En somme,

92% des districts ont atteint un taux de PFA non Polio  $\geq$ 3

90% des districts ont un taux d'adéquation des selles  $\geq$  80%

83 % des districts ont atteint les 2 principaux indicateurs sus cités sur les 12 derniers mois.

La situation des cas atteints du virus dérivé du poliovirus sauvage (VDPV) est présentée dans le tableau 10 ci-après.

**Tableau 10 : Evolution des cas atteints du virus dérivés du poliovirus sauvage**

| Situation des cas de VDPV sur les trois dernières années |               |                     |  |                          |  |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------------|--|--------------------------|--|
| Années                                                   | Nombre de cas | Localisation par DS |  | Statut                   |  |
| 2020                                                     | 01            | • Mvouti-Kakamoeka  |  | • cVDPV2                 |  |
|                                                          | 01            | • Poto-Poto         |  | • cVDPV2 (Environnement) |  |
| 2021                                                     | 01            | • Bacongo           |  | • cVDPV2                 |  |
|                                                          | 01            | • Mossendjo         |  | • cVDPV2                 |  |
| 2022                                                     | 00            | • N/A               |  | • N/A                    |  |

| Début paralysie des cas de cVDPV2 par année, département, district et statut de l'épidémie |    |             |                              |                          |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Année                                                                                      | N° | Département | Date du dernier cas de VDPV2 | Districts                | Statut de l'épidémie |
| 2020                                                                                       | 1  | Kouilou     | 08/09/2020                   | Mvouti-Kakamoeka         | Clôturée             |
|                                                                                            | 2  | Brazzaville | Décembre 2020 (S51)          | Poto-Poto(environnement) | Clôturée             |
| 2021                                                                                       | 4  | Brazzaville | 21/01/2021                   | Bacongo                  | Clôturée             |
|                                                                                            | 5  | Niari       | 31/01/2021                   | Mossendjo                | Clôturée             |

La surveillance de la poliomyélite se fait également par le biais de la surveillance environnementale. De l'analyse des performances de cette surveillance, il ressort ce qui suit :

- ❖ Plus de 95% des échantillons sont prélevés dans les délais (semaines) ;
- ❖ Faible taux de détection des entérovirus dans la majorité des sites de prélèvement ;
- ❖ Amélioration progressive du taux de détection des entérovirus : 9,0% en 2022 à 30% en 2023.

Ce suivi a permis de mener en 2022 une évaluation des sites de surveillance et conduit à la fermeture de deux sites. Les recommandations formulées ont permis d'améliorer les performances au cours des semaines suivantes.

## **b) Surveillance de la rougeole**

Au niveau national, les principaux indicateurs ont été améliorés comme suit :

- ❖ Le taux d'éruption fébrile non rougeoleux TEFNR (objectif >2) est resté supérieur à 2 ces cinq dernières années, sauf en 2019 où il était estimé à 1,75.
- ❖ Le pourcentage de DS ayant investigué au moins 1 cas suspect de rougeole est passé de 98% en 2019 à 100% en 2023, avec une chute en 2020 (70%).
- ❖ Le taux d'incidence (objectif < 1 cas pour 1000 000 habitants) est toujours supérieur à la norme requise.
- ❖ Le pays est confronté ces dernières années à une recrudescence des flambées épidémiques de rougeole.

### **IV.4.3. 3. La fièvre jaune**

Les indicateurs de performance de la fièvre jaune, tout comme ceux de la rougeole ont été maintenus et améliorés. Il s'agit :

- ❖ du taux d'investigation annualisé pour 100.000 habitants inférieur ou égal à 2 ;
- ❖ du pourcentage des DS avec au moins 1 cas suspect de fièvre jaune prélevé supérieur à 80% des DS sauf en 2020.

### **IV.4.3. 4. Le Tétanos maternel et néonatal**

Depuis 2009, le Congo a réalisé des gros efforts et a atteint le stade de pré-élimination du tétanos néonatal et maternel. Les données de la surveillance du TMN ne sont plus saisies dans la base de données depuis plus de cinq ans par manque de notification des cas à travers les fiches d'investigation.

Ce bon niveau de performance a permis la détection des épidémies de rougeole, de fièvre jaune et de poliomyélite qui ont fait l'objet de riposte. En effet, une campagne de vaccination réactive contre la fièvre jaune a été menée en 2022 et trois passages de campagnes contre la poliomyélite utilisant le bivalent et le nOPV2 ont été menés en 2023. Ces actions de riposte réalisées avec l'appui des partenaires a permis de renforcer les couvertures vaccinales des enfants ciblés.

### **IV.4.4. Maladies à potentiel épidémique (MPE)**

Les maladies à potentiel épidémique (MPE) constituent des menaces importantes pour la santé publique. Elles sont responsables de morbidité et de mortalité élevées et engendrent souvent de perturbations socio-économiques importantes.

#### **IV.4.4.1. La rage**

Au Congo, une épidémie silencieuse de rage a sévi dans les départements de la Bouenza, de la Lékoumou, du Niari, du Kouilou et de Pointe Noire depuis 2012. En effet, entre 2012 et 2013, les services de santé humaine et animale du Niari ont enregistré 157 cas d'animaux mordeurs ou griffeurs, dont 97% sont des chiens.

Il sied de noter que le virus de la rage a été isolé sur un chien le 29 octobre 2013 au Laboratoire de Diagnostic Vétérinaire de Brazzaville (LDVB) et confirmé le 10 décembre 2013 par le laboratoire de référence de l'OIE (ARC-Onderstepoort Veterinary Institute) de l'Afrique du Sud. Face à cette situation de suspicion, il est à craindre qu'une épidémie de rage se déclenche dans les départements sus mentionnés. Dans les pays voisins, la RDC et l'Angola, des cas de rage humaine sont régulièrement notifiés.

#### **IV.4.4.2. La Covid-19**

Débutée le 16 novembre 2019 à Wuhan, dans la province de Hubei (en Chine centrale), cette maladie infectieuse émergente, appelée la maladie à coronavirus 2019 ou Covid-19 est, provoquée par un nouveau coronavirus appelé SARS-CoV-2. En moins de 6 mois, depuis son éclosion, cette maladie avait atteint tous les continents. D'où la pandémie à corona virus 2019 qui n'a épargné aucun pays. Le premier cas en Afrique a été enregistré le 14 février 2020 et pour le Congo, le premier cas été enregistré le 14 mars 2020. Les départements de Brazzaville et de Pointe-Noire demeurent les plus touchés sur les 12 que compte le pays. Jusqu'au 24 juillet 2022 (29e semaine épidémiologique), 24 775 cas ont été confirmés parmi lesquels 386 décès soit un taux de létalité de 1,6%.

#### **IV.4.4.3. Les gripes**

En 2009, la grippe H1N1 a atteint le Congo avec 4146 cas notifiés. Sur 88 cas testés, 59 soit 67% se sont révélés positifs. Entre janvier et juin 2017, 6253 cas de gripes ont été notifiés dans le pays dont la grande partie à Brazzaville (4453). La situation en 2018 n'a pas été documentée cependant de janvier 2019 à août 2022 le pays a enregistré 211 447 cas de grippe saisonnière (données EWARS) dont les tendances se présentent comme illustré par les figures ci-dessous. Plus de la moitié de cas (soit 147 421 cas) est enregistrée dans les départements de Brazzaville et Pointe-Noire représentant les 2 plus grandes villes du pays.

#### **IV.4.4.4. Le chikungunya**

En 2011, une épidémie de chikungunya a sévi dans les départements de Brazzaville et du Pool. Elle a touché 11 320 personnes sans occasionner de décès. Une deuxième épidémie a été observée en 2017 dans les mêmes départements avec 117 cas. En 2019, le pays a connu une grande épidémie de chikungunya ayant touché 10 départements du pays (en dehors de la Likouala et de la Cuvette Ouest). Un total de 11 554 cas suspects a été répertorié sans aucun décès.

#### **IV.4.4.5. Le Monkey pox**

En République du Congo (RC), les premiers cas de cette maladie furent déclarés en 2003, plus précisément dans le département de la Likouala. En réponse à ce fléau, des formations du personnel de santé et des membres de la communauté ont été organisées avec l'appui du CDC américain pour sa reconnaissance et sa surveillance.

Depuis le début de l'année 2022, le pays a enregistré 29 cas parmi lesquels, 19 cas suspects, 5 cas probables (avec lien épidémiologique), 5 cas confirmés et 3 décès soit un taux de létalité de 30,00%, Toutes les populations (autochtones et bantous) sont touchées.

**Tableau 11:** Cas et décès de Monkey-pox par départements et districts sanitaires, 2022

| Département et district sanitaire | Cas suspects | Cas probables | Cas confirmés | Nombre de décès | Nombre de prélèvements réalisés |
|-----------------------------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|---------------------------------|
| Likouala                          | <b>3</b>     | <b>5</b>      | <b>2</b>      | <b>3</b>        | <b>2</b>                        |
| Impfondo                          | 3            | 5             | 2             | 3               | 2                               |
| Enyellé-Bétou                     | 0            | 0             | 0             | 0               | 0                               |
| Sangha                            | <b>3</b>     | <b>0</b>      | <b>2</b>      | <b>0</b>        | <b>3</b>                        |
| Ouessou (Pokola)                  | 3            | 0             | 2*            | 0               | 3                               |
| Brazzaville                       | <b>4</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>4</b>                        |
| Madibou                           | 2            | 0             | 0             | 0               | 2                               |
| Talangaï                          | 1            | 0             | 0             | 0               | 1                               |
| Ouenze                            | 1            | 0             | 0             | 0               | 1                               |
| Pointe- Noire                     | <b>9</b>     | <b>0</b>      | <b>1</b>      | <b>0</b>        | <b>9</b>                        |
| Ngoyo                             | 6            | 0             | 1             | 0               | 6                               |
| Tié tié                           | 2            | 0             | 0             | 0               | 2                               |
| Lumumba                           | 1            | 0             | 0             | 0               | 1                               |
| Total                             | <b>19</b>    | <b>5</b>      | <b>5</b>      | <b>3</b>        | <b>18</b>                       |

Les 2 cas confirmés de Ouesso ont été importés de Enyellé- Betou (Likouala). Il s'agit des données de septembre 2022.

#### IV.4.4.6. La maladie à virus Ebola (MVE)

De 2001 à 2005, le Congo a connu quatre épidémies de MVE dans le département de la Cuvette-Ouest. Bien que le Congo n'ait plus été confronté à une épidémie de MVE depuis 2005, la résurgence de cette maladie en République Démocratique du Congo (RDC) fait toujours peser les menaces d'une éventuelle importation des cas compte tenu de la récurrence des épidémies depuis 2018. La province de l'Equateur faisant frontières avec trois Départements du Congo a connu trois épidémies depuis 2018. La RDC est déjà à sa 15<sup>ème</sup> épidémie de la MVE. Le risque d'une résurgence endogène pour le Congo n'est pas non plus à écarter.

#### IV.4.4.7. Shigellose, choléra et fièvre typhoïde

Entre juin et septembre 2023, les départements du Niari, Pointe Noire et Brazzaville étaient en épidémie de choléra, shigellose et fièvre typhoïde, selon l'analyse des données par la DELM.

Au 24/08/2023, la situation épidémiologique se présente comme suit : i) 21 cas de choléra diagnostiqués au Laboratoire National de Santé Publique (17 dans le Niari et 4 à PointeNoire), dont 11 co-infections de choléra et shigellose et 1 cas co-infection fièvre typhoïde ; ii) 83 cas confirmés de



shigellose dont 60 dans le Niari, 6 à Pointe-Noire, 8 à Brazzaville, 5 dans le Pool, 2 cas dans la Bouenza et 2 cas dans la Cuvette-Ouest ; iii) 22 cas confirmés de fièvre typhoïde dont 14 à Dolisie, 1 à Pointe-Noire, 1 dans la Bouenza, 2 à Brazzaville, 1 dans la Lékoumou, 1 dans la Likouala, 1 dans le Kouilou et 1 dans le Pool ; iv) 52 décès dont 33 dans le département de Dolisie, 12 à Pointe-Noire, 4 dans la Bouenza, 1 dans le Kouilou, 1 à Brazzaville et 1 dans la Lékoumou.

Le risque de choléra pour le Congo est toujours élevé compte tenu de la dégradation des conditions d'hygiène et d'approvisionnement en eau potable aussi bien dans les zones urbaines que rurales. Le partage de longues frontières avec la République Démocratique du Congo, pays endémique de choléra, augmente cette vulnérabilité.

#### **IV.4.5. Maladies tropicales négligées (MTN)**

Inscrites à l'agenda des Objectifs de développement durable (ODD), les MTN qui sont au nombre de 17 selon l'OMS, touchent surtout les populations pauvres. Ici nous présentons les plus fréquentes en République du Congo. Le recours à l'approche One Health dans la lutte contre ces maladies représente un atout majeur.

##### **IV.4.5.1. L'onchocercose**

L'onchocercose, maladie cécitante est présente dans la partie sud du Congo, plus précisément dans deux grands foyers : le foyer du bassin du fleuve Congo et son affluent le Djoué (Brazzaville et du Pool) et le foyer du bassin du fleuve Kouilou-Niari (Pool, Bouenza, Lékoumou, Niari et Kouilou). Au total, environ 800.000 personnes sont exposées à la nuisance simuliennienne favorisant la transmission de l'onchocercose. En 2015, 135 cas d'onchocercose ont été enregistrés dans les formations sanitaires par dépistage passif. Brazzaville a enregistré le plus de cas (64 cas) suivi du Pool (38 cas) et de la Lékoumou (14 cas). Les autres départements qui ont rapporté des cas d'onchocercose ont enregistré 8 cas tout au plus.

##### **IV.4.5.2. La filariose lymphatique**

Concernant la filariose lymphatique, les résultats des cartographies menées en 2008 et 2015 montrent que la maladie est présente au Congo dans les départements du Niari, de la Bouenza, du Pool, de la Cuvette, de la Cuvette Ouest, de la Sangha et de la Likouala. En 2015, on estimait la prévalence de la filariose lymphatique à environ 4,7% au Congo. Au cours de cette même année, 485 cas de filariose lymphatique ont été détectés dans les formations sanitaires dont 1 cas dans le Kouilou, 57 dans la Bouenza, 93 dans le Pool, 2 dans les Plateaux, 1 dans la Cuvette et 332 à Brazzaville.

##### **IV.4.5.3. La schistosomiase**

La schistosomiase affecte les départements du Kouilou, du Niari, de la Bouenza, de la Lékoumou, du Pool, de Brazzaville et de la Sangha. Les résultats de la cartographie nationale réalisée en 2011, montrent que les départements du Kouilou et de la Bouenza sont les plus touchés avec respectivement 23,0% et 11,6% de cas chez les enfants en âge scolaire (5 à 14 ans). Dans la Lékoumou, la prévalence est de 4,4%. En 2015, 627 cas ont été relevés au niveau des départements dont 1 cas dans le Niari, 8 dans la Bouenza, 1 cas dans le Pool, 28 cas dans la Cuvette ouest, 28 cas dans la Likouala, 148 cas à Brazzaville et 413 cas à Pointe-Noire.

##### **IV.4.5.4. Les géo-helminthiases**

Concernant les géo-helminthiases, elles sont présentes au Congo dans tous les départements avec des taux de prévalence allant de 20 à 80% d'après une cartographie complète réalisée en 2011 de manière intégrée avec celle de la schistosomiase. Les populations les plus touchées sont les enfants en âge préscolaire et scolaire. Les données de l'annuaire statistiques 2015 montrent que les départements les plus touchés sont ceux de Brazzaville (11.661 cas), Sangha (2.877 cas) et Pool (2.398 cas). 5. Le trachome Le trachome n'avait jamais été mentionné dans la littérature scientifique au Congo. Pourtant, le pays est limitrophe d'un foyer actif de trachome en République Centrafricaine. La cartographie réalisée en 2015 sur cette maladie dans les départements de la Likouala et de la



Sangha a mis en évidence des cas de trachome dans ces deux départements avec un taux de prévalence de 2,9% chez les enfants de 1 à 9 ans, parmi lesquels environ ¾ des enfants des peuples autochtones.

#### **IV.4.5.5. La trypanosomiase**

La trypanosomiase humaine africaine (THA) ou maladie du sommeil affecte les communautés rurales. Elle attaque non seulement la santé des personnes mais également leurs moyens de vie (le bétail). Les évaluations réalisées entre 2014 et 2017 montrent que la prévalence globale de la maladie dans le pays est passée de 0,31 et 0,21%.

#### **IV.4.5.6. La lèpre**

En ce qui concerne la lèpre, le Congo dispose encore de poches endémiques dans six départements (Sangha, Likouala, Cuvette, Niari Kouilou et Pool). En 2016, 151 cas ont été enregistrés soit un taux de prévalence de 0,36 pour 1.0000 habitants. Parmi eux, 73 cas nouveaux ont été détectés, soit un taux de détection de 0,17 pour 1.0000 habitants, dont des 93% cas multi bacillaires et 15% de cas présentant des invalidités ou séquelles motrices, témoignant ainsi de détection tardive des cas. Les femmes ont été les plus touchées avec 55% des cas. Cette situation conduit à une perte de l'autonomie financière à des difficultés à la réinsertion, à de la stigmatisation au rejet social.

#### **IV.4.5.7. Le pian**

Le Congo est l'un des pays les plus touchés en Afrique sub-saharienne, à l'instar des pays frontaliers. Les populations les plus touchées sont les minorités ethniques, notamment les peuples autochtones. A partir de 2012, l'arrêt progressif des activités de lutte a conduit à la perte de la maîtrise de l'épidémiologie réelle de la maladie. En 2016, le dénombrement passif des cas a permis de relever 58 cas entre 2014 et 2016, principalement dans les départements de la Likouala, la Sangha et la Lékoumou.

#### **IV.4.5.8. L'ulcère de Buruli**

La lutte effective contre l'Ulcer de Buruli au Congo avait permis de réduire l'incidence annuelle de 400 à 100 cas par an, entre 2006 et 2011. Les départements les plus touchés sont ceux de Pointe-Noire, du Kouilou, du Niari, de la Bouenza, du Pool, de Brazzaville et de la Cuvette. Entre 2013 et 2016, 71 cas ont été détectés passivement dont 33% au stade ulcéreux avec respectivement, 57,14% dans la catégorie 2 et 28,57 % dans la catégorie.

### **IV. 5. Déterminants sociaux de la santé**

Les déterminants sociaux de la santé sont les facteurs qui déterminent l'état de santé d'un individu. Selon l'OMS, les déterminants sociaux de la santé se définissent comme les facteurs structurels et les conditions de vie quotidiennes qui sont à l'origine d'une grande partie des inégalités en santé entre pays et dans les pays. Ils englobent la répartition du pouvoir, des revenus, des biens et des services, les conditions de vie des individus (accès aux soins, scolarisation et éducation, conditions de travail, loisirs, habitat et environnement).

Le terme de « déterminants sociaux » regroupe donc les facteurs sociaux, politiques, économiques, environnementaux et culturels qui ont une forte influence sur l'état de santé.<sup>48</sup> Ils constituent le principal facteur de l'atteinte des ODD d'ici 2030.

#### **IV. 5.1. Pauvreté et revenus des ménages**

La pauvreté a augmenté en milieu rural (71 pour cent) si elle a diminué en milieu urbain (20 pour cent). Les femmes, les jeunes et les populations autochtones restent plus marginalisés économiquement. Par ailleurs, les ménages qui ont réussi à échapper à la pauvreté vivent proches

---

<sup>48</sup> OMS-SOIXANTE-DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE-Commission des Déterminants sociaux de la Santé. Rapport du Secrétariat. 16 mars 2009

du seuil de pauvreté et sont donc vulnérables aux chocs et au sous-investissement dans le capital humain. Malgré une croissance soutenue entre 2000 et 2014, l'inégalité de revenus est forte et est restée pratiquement inchangée avec un coefficient de Gini de 0,46.

L'inégalité persiste entre les milieux urbain, périurbain et rural en termes de pauvreté et d'accès aux services publics. Bien que 65 pour cent de la population se concentre en milieu urbain, une grande partie de cette population reste pauvre et 47 pour cent vivent dans des bidonvilles périurbains.<sup>49</sup>

D'après les données des enquêtes congolaises auprès des ménages, entre 2005 et 2011, l'incidence de la pauvreté a connu un recul au niveau des ménages et de la population générale. Au niveau des ménages, elle est passée de 42,3% à 37,5% soit un recul de 4,8 points. Au niveau de la population générale, elle est passée de 50,1% à 46,5%, enregistrant ainsi une baisse de 3,6 points. Ce taux serait plus élevé en milieu rural (74,8%) qu'en milieu semi-urbain (57,8%) et urbain (Brazzaville : 29,4% ; Pointe-Noire : 25,5% ; autres communes : 55%).

Le Rapport National de Développement Humain (RNDH) de 2021 renseigne également sur l'Indice de Pauvreté Multidimensionnel qui est un indicateur synthétique comportant trois dimensions : la santé (indicateurs de mortalité infantile et nutrition), l'éducation (indicateurs sur les effectifs d'enfants inscrits et le nombre d'années d'études) et le niveau de vie (indicateurs sur les biens possédés par les ménages, la nature du sol de leurs habitations, l'accès à l'électricité, à l'eau, la nature des toilettes et le type de combustible de cuisine utilisé).

Au Congo, cet indicateur était de 0,192 et il traduisait une incidence de la pauvreté multidimensionnelle de 43% et un degré de privation de 44,7% en 2011-2012 (contre 51,2% en 2009). Concrètement, cela signifie qu'une personne pauvre au Congo ne satisfait pas 44,7% des besoins de base en matière de santé, d'éducation et d'accès aux biens et services nécessaires pour mener une vie décente. Selon les données présentées dans le rapport, dans le seul domaine de la santé, un ménage pauvre ne satisferait pas 32,8% des besoins sanitaires de base en 2011-2012.

Le taux de chômage en milieu urbain est de 16,1% en 2011. Il est d'environ 5 points plus élevé chez les femmes que chez les hommes (respectivement 18,8% contre 13,9%) et affecte plus Brazzaville (17,6%) que Pointe-Noire (13,4%). Les générations actuelles sont plus affectées par le chômage que les anciennes.

Dans l'ensemble, plus d'un chômeur sur deux est une femme (51,9% de femmes contre 48,1 d'hommes). L'enquête MICS-2014-2015 a renseignée sur l'indice de bien-être économique. En effet, 16% des femmes vivent dans un ménage classé dans le quintile le plus pauvre alors que 22% vivent dans un ménage du quintile le plus riche. Ces proportions sont les mêmes pour les hommes. Pour limiter l'impact économique du Covid sur les revenus des ménages les plus précaires, le gouvernement a élargi le Programme de filets sociaux LISUNGI à 50.000 ménages dits pauvres.

Sur le plan sanitaire, les populations pauvres, autochtones et réfugiées de la Likouala bénéficient, en outre des Voucher (transferts du cash) des exonérations des frais de soins de qualité, grâce à l'approche LISUNGI-FBP.

## IV. 5.2. Éducation

Selon le diagnostic fait dans le PND (2018-2022), le cycle d'enseignement du préscolaire est en pleine émergence, mais, se caractérisait en 2015 par un faible taux de couverture nationale de 20%, en deçà de la cible de 30% fixé à l'horizon 2024. Concernant le cycle primaire, le taux brut de scolarisation est supérieur à 100%, avec un taux net de scolarisation de l'ordre de 80%. Mais, seuls 30 % des élèves du primaire maîtrisent les compétences attendues en mathématiques, et 40 % en français<sup>50</sup>.

---

<sup>49</sup> En 2015, 47 pour cent de la population urbaine vivait dans des bidonvilles, situés pour la plupart dans les zones urbaines et périurbaines (Banque mondiale).

<sup>50</sup> <https://www.banquemondiale.org/fr/country/congo/overview> cité le 9 janvier 2023.

Les défis majeurs du système éducatif du Congo se définissent en termes de qualité d'apprentissage, d'accès des enfants défavorisés à une éducation de base de qualité et d'abandon des filles au 1er cycle du secondaire. En effet, Seuls 18% des élèves qui achèvent le cycle primaire ont une maîtrise suffisante des apprentissages en lecture et en calcul, Moins de 40% d'enfants autochtones sont inscrits au cycle d'enseignement primaire et il existe une forte déperdition des filles au secondaire dont les principales causes sont les violences scolaires (37% des violences physiques et 33 % des violences sexuelles)<sup>51</sup>.

L'accès au collège s'est élargi avec un taux brut de scolarisation (TBS) qui est passé de 68,4% en 2012 à 94,71% en 2015. Au lycée, le taux de couverture s'est également accru de 2012 à 2015 en passant de 30% à 41,18%. Selon les résultats du RGPH 2007, 81,8% de la population résidente congolaise âgée de 50 ans et plus était instruite. Le niveau d'études atteint par la majorité des résidents était celui du primaire (33,6%) tandis que 4,2% seulement de la population avait accédé aux études universitaires.

L'analphabétisme était encore très répandu au sein de la population congolaise en 2007. Les résultats du RGPH évaluaient le taux d'analphabétisme, respectivement à 18,5% pour le français et à 11,8% pour toutes langues confondues. Le taux brut de scolarisation baisse avec le cycle d'études. En 2007, il variait de 115,3% au cycle primaire à 9,2% au cycle supérieur. Le taux net de scolarisation au primaire (81,3%) était largement en deçà des efforts exigés par la communauté internationale (100%).

D'après les données de l'enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS) de 2014-2015, le taux d'alphabétisation des jeunes de 15 à 24 ans était de 83,9% chez les femmes contre 88,8% chez les hommes. La proportion d'enfants atteignant la dernière classe du primaire était de 96,3%, renforçant ainsi la place du Congo dans l'atteinte de l'ODD 4 stipule « d'ici à 2030, faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons aient accès à des activités de développement et de soins de la petite enfance et à une éducation préscolaire de qualité qui les préparent à suivre un enseignement primaire ».

Le niveau d'éducation est facteur important de l'état de santé car, il influence le niveau des connaissances et pratiques en lien notamment avec la prévention en santé et le recours aux soins. Selon les résultats de l'EDSC-2011-2012, 60,2% des femmes n'ayant aucun niveau d'instruction avaient une connaissance parfaite des complications liées à la grossesse contre 72,4% pour celles qui avaient le niveau secondaire 2<sup>ème</sup> cycle ou plus.

#### **IV. 5.3. Accès à l'électricité**

La République du Congo, regorge d'importantes ressources énergétiques dont la mise en valeur est indispensable à son développement économique. Il dispose d'un important réseau hydrographique dont les ressources en eau sont estimées à 842 milliards de m<sup>3</sup>, et la capacité des sites identifiés en 2010 pour la production d'électricité, à 14 000 MW <sup>52</sup>. Il offre également des opportunités d'exploitation d'autres types d'énergie pour la production d'électricité : l'énergie solaire grâce à un ensoleillement de 12h par jour ou encore la biomasse grâce à un domaine forestier couvrant plus de 20 millions d'hectares, soit plus de 60% du territoire national.

L'offre potentielle d'énergie électrique est supérieure à la demande nationale estimée fin 2010 à 355 MW. Cependant, la capacité totale disponible demeure faible à cause notamment de la vétusté des installations de transport et de distribution<sup>53</sup>.

La République du Congo envisage d'atteindre un taux d'accès en matière d'électricité de 50% dans les communautés urbaines et rurales d'ici 2030. L'objectif du gouvernement est d'améliorer le

---

<sup>51</sup> <https://www.unicef.org/congo/education> cité le 9 janvier 2023.

<sup>52</sup> Décret n° 2010-822 du 31 décembre 2010 portant approbation de la stratégie de développement des secteurs de l'énergie électrique, de l'eau et assainissement, Journal Officiel du 27 janvier 2011, n° 4

<sup>53</sup> Rapport pays de la Banque mondiale. « Infrastructures de la République du Congo : une perspective continentale », mars 2010.

niveau de couverture qui se situe en 2022 à 45% pour les deux grandes villes (Brazzaville et Pointe-Noire), à peine 15% dans les villes secondaires, et à 5% dans les autres localités du pays<sup>54</sup>.

Dans l'ensemble, moins d'un ménage congolais sur deux (42 %) disposent de l'électricité. Cependant, par rapport à 2005, on constate une amélioration puisque à cette date, 34 % seulement des ménages en disposaient. Malgré ces progrès, des disparités demeurent et, en milieu rural, la quasi-totalité des ménages n'ont toujours pas l'électricité (88 % contre 41 % en milieu urbain). Les résultats concernant le mode d'éclairage montrent que dans l'ensemble, 55 % des ménages s'éclairent à l'aide de lampes à pétrole. Cette proportion varie de 80 % en milieu rural à 40 % en milieu urbain où plus d'un ménage sur deux (54 %) s'éclaire à l'électricité. Globalement, 38 % des ménages utilisent l'électricité pour s'éclairer.

#### **IV. 5.4. Accès à l'eau, hygiène, assainissement**

Les défis restent à relever pour garantir un accès équitable et durable à l'eau saine et à l'assainissement. Le profil épidémiologique du pays est caractérisé par des niveaux encore élevés des taux de morbidité et de mortalité des maladies liées à la dégradation de l'environnement, à l'insuffisance prononcée de la maîtrise de la gestion de l'assainissement et de l'accès à l'eau saine (paludisme, maladies diarrhéiques, dermatoses, choléra, poliomyélite, etc.).

En milieu urbain, en l'absence de l'application des dispositions des plans directeurs d'aménagement urbain et des plans d'occupation des sols, les populations s'installent dans les quartiers spontanés et précaires où le manque de services de base tels que l'eau et l'assainissement est une problématique très complexe liant la santé et l'environnement.

Le sixième objectif du développement durable vise un accès universel et équitable à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement d'ici 2030, en particulier pour les populations vulnérables. Il appelle également à une gestion durable de cette ressource, et mentionne la réduction du nombre de personnes souffrant de la rareté de l'eau. Dans le contexte actuel, il sied de relever que le pays ne dispose pas de politique ni de stratégie sectorielle encore moins d'arrangement institutionnel clairement établi notamment en matière d'assainissement.

En République du Congo, le taux d'accès en eau potable est de 66% en milieu Urbain, et 47 % en zone rurale : soit 56% de couverture nationale. Le taux d'accroissement annuel du service d'approvisionnement de 2015 à 2020 est de 0.83. Si ce taux est maintenu à ce niveau, il pourra compromettre l'atteinte en 2030 de l'accès universel à l'eau potable par le pays, selon les dernières données de 2019 du programme de surveillance de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène (JMP) publiées en 2021.

S'agissant de l'assainissement collectif, les progrès dans l'assainissement des deux grandes villes sont enregistrés avec l'appui des partenaires au développement. Cependant, du fait de l'urbanisation galopante et mal maîtrisée des villes, les réseaux d'évacuation des eaux pluviales sont largement insuffisants. Les canalisations d'évacuation des eaux pluviales ne couvrent pas l'ensemble des quartiers des villes. Elles sont souvent engorgées de déchets solides de toutes sortes et sont débordées à la moindre averse. Il en est de même pour les grands collecteurs naturels qui sont aussi obstrués par le sable dû à l'érosion et les déchets solides. Cette situation a pour conséquence majeure la survenue des inondations, des érosions, des glissements de terrain et des ensablements. Avec le manque de services de base, la persistance de telles pratiques risque d'accroître les problèmes environnementaux et sanitaires.

L'insuffisance des structures et des équipements appropriés de traitement des déchets solides et liquides est très préoccupante au Congo. En l'absence de réseaux d'évacuation des eaux usées conventionnels, les eaux usées domestiques sont le plus souvent jetées dans les cours, les rues et le réseau d'eaux pluviales. Les eaux résiduaires industrielles, les effluents des établissements de santé ainsi que les eaux usées des établissements de tourisme et d'accueil sont jetés dans les

---

<sup>54</sup> Propos recueillis du Ministre congolais de l'Energie et de l'Hydraulique

exutoires sans traitement préalable ou après un traitement aléatoire. Ces pratiques ont pour conséquences majeures l'eutrophisation et le comblement des plans d'eau.

Le pays ne dispose pas toujours d'un plan de gestion des déchets biomédicaux. Cependant, dans le cadre du Projet de Riposte Urgente à la Covid-19 financé par la Banque Mondiale, 04 incinérateurs modernes ont été fournis pour les deux grandes villes (Brazzaville et Pointe-Noire).

Dans le domaine de l'assainissement autonome, selon les données du JMP de 2021, au niveau national, encore 8% de la population défèque à l'air libre, seulement 20% utilisent des installations sanitaires hygiéniques. La défécation à l'air libre en milieu rural est pratiquée par 23% de la population et le taux d'assainissement basique en milieu urbain est seulement 27%. Avec les efforts des dernières années, le taux d'utilisation de latrines améliorée en République du Congo est estimé à plus de 76%. Cependant, le nombre de latrines non couvertes reste encore important : 34%. En outre, moins de 11% des ménages utilisent un système approprié d'évacuation des eaux usées, dont 15% en milieu urbain et moins de 2% en espace rural.

En matière d'hygiène, au niveau national, le lavage des mains reste un défi majeur encore. Dix-huit pourcent (18%) de ménages n'ont, ni installation, ni savon et eau pour l'hygiène des mains. En effet, seulement 33,4% des ménages dans les milieux ruraux ont un endroit spécifique pour se laver les mains, 40% des centres de santé n'ont pas un dispositif de lavage des mains et 95% des écoles primaires n'ont pas d'installations de lavage des mains.

Selon l'UNICEF Congo, ces problèmes sont des conséquences des faiblesses constatées au niveau des ressources humaines, de la capacité de gestion, d'exploitation et de maintenance des ouvrages, mais aussi du manque de stratégie de gestion et de suivi technique des ouvrages<sup>55</sup>.

L'accès à l'eau dans les milieux de soins reste très critique, ce qui constitue un facteur de risque de la propagation des micro-organismes et les épidémies manu portées dont les infections nosocomiales. Le Congo a prévu, dans le cadre du Projet de Riposte à la Covid-19 et de Renforcement du Système de Santé (RSS), une évaluation WASH en 2023 et la construction d'une dizaine de forages avec fontaines d'eau dans les communautés riveraines.

Dans le cadre de la Prévention contre les infections, outre le PNLS, le Congo dispose maintenant d'un programme de lutte contre les infections nosocomiales. Les efforts conjugués des deux programmes permettront de disposer d'un cadre réglementaire et juridique de lutte contre les infections.

#### **IV. 5.5. Facteurs climatiques**

Selon le PNUDi, les effets du changement climatique s'observent au Congo, entre autres, à travers la modification du calendrier cultural, la vulnérabilité de la zone côtière, la dégradation des sols, les érosions pluviales et les inondations consécutives aux crues.

Les inondations occasionnent l'augmentation des maladies diarrhéiques et vectorielles. En plus des districts de Makotimpoko dans les Plateaux, de Mossaka et de Loukolela dans la Cuvette, même certains quartiers de Brazzaville et de Pointe-Noire sont souvent victimes d'inondations pluviales.

#### **IV. 5.6. Consommation de drogue, d'alcool et du tabac**

Les données manquent sur l'usage régulier de drogues en population générale. Néanmoins, selon la cartographie établie par le CNLS<sup>56</sup>, 432 consommateurs de drogues injectables ont été recensés en 2017 dans cinq villes notamment Brazzaville, Pointe Noire, Dolisie, Pokola et Ouessou. Ces pratiques sont souvent présentes au sein des populations présentant des risques élevés de contamination au VIH/SIDA (professionnelles du sexe et hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes).

---

<sup>55</sup> <https://www.unicef.org/congo/eau-hygiene-et-assainissement> cité le 9 janvier 2023.

<sup>56</sup> Cartographie CNLS, 2017

Les données récoltées dans le cadre du MICS 2015 ont mis en avant une consommation d'alcool<sup>57</sup> de 61,7% chez les hommes contre 47,0% chez les femmes. Pour les moins de 15 ans, ce sont 7,7% des femmes et 14,3% des hommes qui ont bu au moins un breuvage alcoolisé. Cependant, l'usage à risque n'est pas évalué.

Selon le MICS 2014-2015, le taux de prévalence du tabagisme dans la population était de 8%. La consommation de tabac chez les 15-49 ans était de 2,7% chez les femmes et de 18,7% chez les hommes. Chez les moins de 15 ans, ce sont 4,5% des hommes et 0,7% des femmes<sup>58</sup>. Cependant, l'usage à risque n'est pas évalué. L'OMS estime que la consommation de tabac va connaître une augmentation régulière jusqu'à atteindre 32,2% en 2020 et 49,2% en 2025 chez les personnes âgées de 15 ans et plus<sup>59</sup>.

| Profil épidémiologique du Congo |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ➤                               | Le paysage épidémiologique du Congo est caractérisé par l'inachèvement de la transition épidémiologique traduite par la persistance des maladies infectieuses en forte recrudescence et des hautes prévalences des maladies chroniques.                                                                                                                                                       |
| ➤                               | La part de la mortalité précoce et évitable est élevée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ➤                               | Avec le réchauffement climatique, les maladies infectieuses se propage facilement en touchant plusieurs personnes. La tuberculose en particulier connaît un regain au Congo, qui s'expliquerait entre autres par un lien probable entre le réchauffement climatique et la propagation des maladies infectieuses selon l'Organisation mondiale de la santé et le PNLT du Congo <sup>60</sup> . |
| ➤                               | Les maladies chroniques et non transmissibles touchent de plus en plus les plus jeunes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ➤                               | Les maladies tropicales négligées deviennent fréquentes dans les zones endémiques.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ➤                               | Les comportements sexuels à risque, les violences, la consommation d'alcool, de tabac, des stupéfiants et de drogues sont de nombreux facteurs de risque au Congo.                                                                                                                                                                                                                            |
| ➤                               | L'absence dans la presque totalité des formations sanitaires (FOSA) d'un service d'hygiène hospitalière ;                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ➤                               | aucun comité de lutte contre les IAS n'est mis en place, excepté le CHU.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

<sup>57</sup> Pourcentage de personnes de 15-49 ans qui ont bu au moins une boisson alcoolisée n'importe quand durant le mois dernier

<sup>58</sup> ECOM

<sup>59</sup> OMS. Estimations des tendances de la prévalence du tabagisme, 2000-2025

<sup>60</sup> <https://www.gavi.org/fr/vaccineswork/congo-rechauffement-climatique-favorise-circulation-tuberculose> cité le 9 janvier 2023.

## CHAPITRE V : PROBLEMES PRIORITAIRES

Les principaux problèmes prioritaires identifiés à l'issue de l'analyse de la situation réalisée à partir des résultats de la revue finale du PNDS 2018-2022 sont ci-dessous décrits par programme dudit PNDS :

| Programmes du PNDS 2018-2022                                                                         | Domaines/Sous domaines                                     | Problèmes                                                                                                                                                | Causes principales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Programme n°1</b> : renforcement de la gouvernance, du leadership et du pilotage du secteur santé | Cadre juridique                                            | P1. Le cadre juridique incomplet, les textes existants faiblement appliqués                                                                              | 1.Certaines lois et décrets n'ont pas de textes d'application<br>2.Absence de textes et lois d'encadrement dans certains domaines de la santé<br>3. Faible vulgarisation des textes, procédures, normes du secteur de la santé à tous les niveaux                                                                                                                                       |
|                                                                                                      | Planification                                              | P2. Les plans (PTAB ou POA, programmes et projets) sont faiblement alignés au PNDS, les résultats opérationnels sont non orientés vers le PNDS 2023-2026 | 1.Faibles capacités de planification, de suivi et d'évaluation à tous les niveaux du système                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                      |                                                            |                                                                                                                                                          | 2.Absence d'un référentiel de formation sur la gestion axée sur les résultats (GAR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                      |                                                            |                                                                                                                                                          | 3.Déficit dans la gestion de l'information sanitaire (nature de données, non définition des indicateurs de suivi/évaluation, collecte, compilation, analyse/traitement et diffusion)                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                      | Coordination, pilotage et redevabilité du système de santé | P3. Déficit fonctionnel des organes de coordination des parties prenantes à tous les niveaux                                                             | 4.Absence d'indicateurs d'appréciation du pilotage du PNDS par les directions départementales de la santé<br>1.Non fonctionnalité des organes de coordination prévus dans le système (Conseil national de santé, comité interministériel de pilotage, du comité technique de suivi du PNDS et du secrétariat technique permanent, Conseils départementaux, COGES du district, CD, COSA) |



| Programmes du PNDS<br>2018-2022 | Domaines/Sous<br>domaines    | Problèmes                                                                     | Causes principales                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                              |                                                                               | 2.Inadéquation des compétences répondant au profil attendu des animateurs des organes de pilotage et de coordination du système de santé à différents niveaux               |
|                                 |                              |                                                                               | 3.Insuffisance des mécanismes de redevabilité à tous les niveaux du système de santé                                                                                        |
|                                 | Ressources Humaines en Santé | P4. Les ressources humaines sont insuffisantes et inéquitablement réparties   | 1.Déficit quantitatif et qualitatif des RHS                                                                                                                                 |
|                                 |                              |                                                                               | 2.Retard dans la mise en œuvre du cadre stratégique national de développement des ressources humaines en santé (plan de formation, plan de recrutement, plan des carrières) |
|                                 |                              |                                                                               | 3.Non fonctionnalité du cadre de coordination entre les institutions de production et le ministère utilisateur (MSP)                                                        |
|                                 |                              |                                                                               | 4.Répartition inéquitable des RHS entre le milieu rural et le milieu urbain                                                                                                 |
|                                 |                              |                                                                               | 5.Retard dans la mise en œuvre de la fonction publique territoriale à travers la loi sur la décentralisation                                                                |
|                                 |                              |                                                                               | 6.Persistance des antivaleurs dans les structures de santé pour plusieurs raisons (non application intégrale du statut du personnel de santé, déficit déontologique)        |
|                                 | Financement de la santé      | P5.-Insuffisance des ressources financières consacrées au secteur de la santé | 1.Faible allocation budgétaire affectée au secteur de la santé à tous les niveaux                                                                                           |
|                                 |                              |                                                                               | 2.Retard dans la fonctionnalité des mécanismes de solidarités (assurance maladie universelle)                                                                               |



| Programmes du PNDS<br>2018-2022 | Domaines/Sous<br>domaines                          | Problèmes                                                                            | Causes principales                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                    |                                                                                      | 3.Complexité des procédures dans l'utilisation des fonds alloués dans les structures de santé                                                                           |
|                                 |                                                    |                                                                                      | 4.Faible capacité de mobilisation des fonds au niveau local                                                                                                             |
|                                 |                                                    |                                                                                      | 5.Gestion non orthodoxe des recettes issues des recouvrements des coûts (à insérer dans l'analyse)                                                                      |
|                                 |                                                    |                                                                                      | 6. Faible taux de décaissement à tous les niveaux                                                                                                                       |
|                                 | Système national de l'information sanitaire (SNIS) | P6. Insuffisance des données produites par le SNIS                                   | 1. Déficit quantitatif et qualitatif de l'information sanitaire à tous les niveaux du système de santé y compris le secteur privé                                       |
|                                 |                                                    |                                                                                      | 2.Non-respect du circuit de l'information sanitaire                                                                                                                     |
|                                 |                                                    |                                                                                      | 3.Retard dans l'implémentation du DHIS2 dans les HG et des programmes                                                                                                   |
|                                 |                                                    |                                                                                      | 4. Faible rapportage des données des HG dans le DHIS-2                                                                                                                  |
|                                 | Digitalisation                                     | P7. Faible taux d'informatisation des processus de gestion des structures sanitaires | 5. Non transmission des rapports d'activités des HG                                                                                                                     |
|                                 |                                                    |                                                                                      | 1.Manque de logiciels de gestion des sous composantes du système de santé (RH, Hôpitaux, médicament, laboratoire, urgence sanitaire...)                                 |
|                                 |                                                    |                                                                                      | 2.Absence d'infrastructures informatiques viables limitant les capacités à développer des services numériques tel que définis dans le programme e-gouv du PND 2022-2026 |
|                                 |                                                    |                                                                                      | 3.Faible capacité de mobilisation des ressources pour la mise en œuvre de la stratégie « e-santé » à tous les niveaux du système de santé                               |

| Programmes du PNDS<br>2018-2022                                                                                      | Domaines/Sous<br>domaines     | Problèmes                                                                 | Causes principales                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                      | Etude et enquête<br>recherche | P8. Insuffisances de<br>données stratégiques pour<br>la prise de décision | 1.Irrégularité dans la réalisation des études, enquêtes et recherches                                                               |
|                                                                                                                      |                               |                                                                           | 2.Absence de la stratégie de la recherche en santé au Congo                                                                         |
|                                                                                                                      |                               |                                                                           | 3.Absence de cartographie des secteurs prioritaires de la recherche adaptés au contexte épidémiologique du pays                     |
|                                                                                                                      |                               |                                                                           | 4.Faible niveau de financement direct de la recherche en santé                                                                      |
|                                                                                                                      |                               |                                                                           | 5.Absence de cadre de coordination intersectoriel                                                                                   |
|                                                                                                                      |                               |                                                                           | 6.Absence de financement sécurisé pour la réalisation des enquêtes d'envergure nationale (EDS, HHFA, MICS, ENCV, STEPS)             |
| <b>Programme n°2</b> : amélioration<br>de l'accès équitable des<br>populations aux paquets de<br>services de qualité | Couverture<br>sanitaire       | P1. Faible taux d'utilisation<br>des services                             | 1.Insuffisance des ressources financières                                                                                           |
|                                                                                                                      |                               |                                                                           | 2.Mauvaise planification                                                                                                            |
|                                                                                                                      |                               |                                                                           | 3.Non extension des supports normatifs dans les CSI autres que ceux des DS appuyés par l'OMS                                        |
|                                                                                                                      |                               |                                                                           | 4.Non-respect des normes et procédures de passation des marchés                                                                     |
|                                                                                                                      |                               |                                                                           | 5.Non actualisation des outils de rationalisation des soins à différents échelon (algorithmes/ordinogrammes)                        |
|                                                                                                                      |                               |                                                                           | 6.Irrégularité des formations des équipes de santé sur l'offre des paquets de soins essentiels (PSE)                                |
|                                                                                                                      |                               |                                                                           | 7.Non intégration/ décentralisation des techniques de base de la prise en charge de certaines maladies non transmissibles (HTA/AVC, |

| Programmes du PNDS<br>2018-2022 | Domaines/Sous<br>domaines                        | Problèmes                                                                                      | Causes principales                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                  |                                                                                                | diabète, lésions précancéreuses) et des maladies mentales dans le PMA de services de santé de premier échelon                                                                               |
|                                 |                                                  |                                                                                                | 8.Irrégularité des supervisions formatives dans quelques CSI de chaque DS sur la prise en charge de certaines maladies non transmissibles par des spécialistes venus des hôpitaux généraux. |
|                                 |                                                  |                                                                                                | 9. Absence du découpage des DS en aire de santé                                                                                                                                             |
|                                 |                                                  | P2. Faible couverture nationale en structures de dispensation des produits sanguins sécurisés. | 1.Non validation des normes ISO sur la transfusion sanguine                                                                                                                                 |
|                                 |                                                  |                                                                                                | 2.Insuffisance des postes de transfusion sanguine (seulement 44 PTS/64 PTS pour une couverture totale du territoire national)                                                               |
|                                 |                                                  | P3. Faible fonctionnalité des districts sanitaires (DS)                                        | 1.Insuffisance quantitative et qualitative des RHS dans les équipes cadres et des équipes de gestion des DS                                                                                 |
|                                 |                                                  |                                                                                                | 2.Insuffisance de formations des membres composant les équipes cadres et de gestion de DS                                                                                                   |
|                                 |                                                  |                                                                                                | 3.Insuffisance des capacités logistiques                                                                                                                                                    |
|                                 |                                                  |                                                                                                | 4.Insuffisance des ressources financières                                                                                                                                                   |
|                                 |                                                  |                                                                                                | 5.Faible fonctionnement des organes de gestion.                                                                                                                                             |
|                                 | Infrastructures et équipements médico-sanitaires | P4. Déficit du plateau technique dans les                                                      | 1.Absence d'une stratégie de développement des infrastructures sanitaires                                                                                                                   |
|                                 |                                                  |                                                                                                | 2.Non actualisation de la carte sanitaire                                                                                                                                                   |

| Programmes du PNDS<br>2018-2022 | Domaines/Sous<br>domaines            | Problèmes                                                     | Causes principales                                                                                                                                       |
|---------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                      | formations sanitaires (CSI, HRD et HG)                        | 3.Faible poursuite de la transformation de certains CSI (PMA standards) en PMAE 1, PMAE 1 en PMAE 2 et PMAE 2 en hôpitaux de référence de district (HRD) |
|                                 |                                      |                                                               | 5. Faible identification des besoins allant du niveau périphérique au niveau central.                                                                    |
|                                 |                                      |                                                               | 6. Faible financement pour l'acquisition du plateau technique                                                                                            |
|                                 |                                      |                                                               | 7. Absence de la stratégie nationale en matière de maintenance du plateau technique dans les FOSA                                                        |
|                                 |                                      |                                                               | 8. Non validation du document sur les normes en infrastructures et équipements                                                                           |
|                                 | MEG et produits médicaux et sanguins | P5. Faible accessibilité financière de la population aux MEG  | 1.Non mise en place des mécanismes assurantiels                                                                                                          |
|                                 |                                      | P6. Faible disponibilité des MEG dans les HRD et dans les CSI | 1.Inadéquation entre l'allocation budgétaire et les besoins en MEG                                                                                       |
|                                 |                                      |                                                               | 2.Insuffisance des ressources financières dédiées à l'approvisionnement, au stockage et à la distribution des MEG                                        |
|                                 |                                      |                                                               | 3.Absence de laboratoire de contrôle de qualité des médicaments                                                                                          |
|                                 |                                      |                                                               | 4. Non maitrise des consommations moyennes mensuelles                                                                                                    |
|                                 |                                      |                                                               | 5. faible niveau de compétence des agents de santé en charge de la gestion des MEG                                                                       |
|                                 |                                      |                                                               | 1.Absence de partenariat public-privé                                                                                                                    |

| Programmes du PNDS<br>2018-2022 | Domaines/Sous<br>domaines | Problèmes                                                              | Causes principales                                                                                                |
|---------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                           | P7. Insuffisance de production locale des médicaments                  | 2.Faible implication de la médecine traditionnelle                                                                |
|                                 |                           |                                                                        | 3. Absence d'unité de production locale                                                                           |
|                                 |                           | P8. Existence des circuits parallèles de vente des médicaments         | 1.Faible application des textes législatifs en la matière                                                         |
|                                 |                           |                                                                        | 2.Faible pouvoir d'achat des ménages                                                                              |
|                                 |                           |                                                                        | 3.Faible disponibilité des MEG dans les FOSA                                                                      |
|                                 |                           |                                                                        | 4.Faible utilisation des MEG dans les FOSA                                                                        |
|                                 |                           |                                                                        | 5.Faible sensibilisation des populations sur les dangers des médicaments de la rue                                |
|                                 | Technologie de la santé   | P9. Installation des équipements non conformes aux normes              | 1.Absence des normes et procédures d'installation des équipements et de maintenance                               |
|                                 |                           |                                                                        | 2.Insuffisance de contrôle technique                                                                              |
|                                 |                           | P10. Faiblesse de la gouvernance en matière de technologie de la santé | 1.Faible capacité opérationnelle de la direction de la technologie de la santé (DTS)                              |
|                                 |                           | P11. Insuffisance de l'offre en matière de technologie de la santé     | 1.Faibles capacités logistiques en matière de technologie de la santé                                             |
|                                 |                           |                                                                        | 2.Insuffisance des locaux de travail                                                                              |
|                                 |                           |                                                                        | 3.Insuffisance quantitative et qualitative des techniciens supérieurs et des techniciens qualifiés de laboratoire |
|                                 |                           |                                                                        | 4.Insuffisance de financement                                                                                     |

| Programmes du PNDS<br>2018-2022 | Domaines/Sous<br>domaines | Problèmes                                                            | Causes principales                                                                                                      |
|---------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | Utilisation des services  | P12. Faible capacité du système de référence et de contre-référence. | 1.Caducité du texte sur la référence et la contre-référence (décret 525).                                               |
|                                 |                           |                                                                      | 2.Non mise en place de la consultation de la première référence dans les HRD et dans la deuxième référence dans les HG. |
|                                 |                           |                                                                      | 3.Absence de formation des membres des équipes techniques sur la référence et la contre-référence au niveau des FOSA    |
|                                 |                           |                                                                      | 4.Absence des supports de gestion des malades référés et contre référés                                                 |
|                                 |                           |                                                                      | 5.Non application de la stratégie de référence-contre référence                                                         |
|                                 |                           |                                                                      | 6.Absence de mise à jour de la hiérarchisation des hôpitaux.                                                            |
|                                 |                           |                                                                      | 7.Non implication des HG dans la gestion des DS dans leur zone d'implantation                                           |
|                                 |                           | P13. Insuffisance de l'offre des soins en faveur des personnes âgées | 1.Absence des spécialistes en matière de gériatrie ;                                                                    |
|                                 |                           |                                                                      | 2.Manque d'infrastructures spécialisées pour la prise en charge des personnes âgées                                     |
|                                 |                           |                                                                      | 3.Non validation du plan stratégique d'actions en faveur des personnes âgées                                            |
|                                 |                           | 14. Insuffisance des activités de lutte contre les                   | 1.Absence de stratégie nationale de prévention et contrôle des infections dans les établissements de santé              |
|                                 |                           |                                                                      | 2. Insuffisance du matériel d'hygiène dans les FOSA                                                                     |

| Programmes du PNDS<br>2018-2022 | Domaines/Sous<br>domaines       | Problèmes                                                                                 | Causes principales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                 | infections associées aux soins (IAS) dans les FOSA                                        | 3.Faible taux de couverture en assainissement de l'environnement dans les FOSA ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                 |                                 | P15. Faible implication des communautés dans la prestation des soins et services de santé | 1.Faible capacité des équipes des CSI et des COSA à accompagner les relais communautaires dans leur travail au quotidien                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                 |                                 |                                                                                           | 2.Absence de sensibilisation de la communauté sur la gestion de leurs problèmes de santé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                 |                                 |                                                                                           | 3. Insuffisance de formation des membres des organes de participation communautaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                 |                                 | P16. Déficit de mécanismes d'assurance qualité des soins et services                      | 1.Manque de politique de qualité des soins et services                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                 |                                 |                                                                                           | 2.Manque d'évaluation de la satisfaction des utilisateurs des services de santé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                 |                                 |                                                                                           | 3.Faible disponibilité des protocoles de prise en charge à tous les niveaux de soins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                 | Santé de la mère et de l'enfant | P17.Persistance d'une mortalité maternelle, néonatale et infantile élevée                 | <p>1. Causes de la Mortalité maternelle</p> <p>Causes obstétricales directes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hémorragie et rupture utérine 62%</li> <li>• Eclampsie 19,5%</li> <li>• Infection du poste partum et post abortum 7%</li> </ul> <p>Causes obstétricales indirectes</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Insuffisance cardiaque 2,6%</li> <li>• Complications anesthésiques 2%</li> </ul> |



| Programmes du PNDS<br>2018-2022                                                                                                 | Domaines/Sous<br>domaines                                              | Problèmes                                                                                                                       | Causes principales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• VIH 1,7%</li> </ul> <p>Le 3ème retard est responsable de 94,4% des décès maternels<br/>Insuffisance du plateau technique, non disponibilité des produits sanguins et des médicaments, insuffisance de formation des prestataires de santé)</p> <p>2. Causes de la Mortalité néonatale</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Infections néonatales 44,9%</li> <li>• Prématurité 30%</li> <li>• Asphyxie 21%</li> </ul> <p>La mortalité néonatale est liée au mauvais suivi des grossesses et des accouchements, à l'insuffisance du plateau technique (Insuffisance des services de néonatalogie et des unités de soins kangourou)</p> <p>3. Causes de la Mortalité infantile</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Paludisme 41,1%</li> <li>• Sepsis sévère 27%</li> <li>• Bronchopneumonie 20,9%</li> </ul> <p>La mortalité infantile est due au premier retard (81,8% des enfants décédés proviennent du domicile dans un état grave)</p> |
| <b>Programme n°3</b> : sécurité sanitaire et gestion des situations d'urgence selon l'approche englobant l'ensemble des menaces | Gestion des épidémies selon le RSI 2005 et autres situations d'urgence | P1 : Faible capacité de prévention, de préparation et de réponse aux épidémies et autres situations d'urgence de santé publique | 1. Absence/Insuffisance des textes de coordination interministérielle et du partenariat avec les parties prenantes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                 | 2. Non ratification du RSI par le Parlement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                 | 3. Absence de formalisation du Point Focal national du RSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                 |                                                                        |                                                                                                                                 | 4. Non opérationnalisation du COUSP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Programmes du PNDS<br>2018-2022 | Domaines/Sous<br>domaines | Problèmes | Causes principales                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|---------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                           |           | 5.Faiblesse dans la mise en œuvre de la surveillance intégrée des maladies et riposte (SIMR) y compris et faible implication de la communauté et les formations sanitaires du secteur privé |
|                                 |                           |           | 6.Faible communication en vue de renforcer la confiance sociale dans les actions gouvernementales liées à la santé publique                                                                 |
|                                 |                           |           | 7.Faible niveau de décentralisation dans la gestion de la crise sanitaire                                                                                                                   |
|                                 |                           |           | 8.Absence d'évaluation et de redevabilité dans l'utilisation des ressources financières                                                                                                     |
|                                 |                           |           | 9.Absence de manuel de procédure de gestion des urgences de santé publique.                                                                                                                 |
|                                 |                           |           | 10.Non sécurisation des financements recommandés par l'OMS sur les urgences et catastrophes                                                                                                 |
|                                 |                           |           | 11.Absence de pré positionnement des médicaments et intrants pour la riposte aux crises sanitaires                                                                                          |
|                                 |                           |           | 12.Insuffisance des ressources humaines formées à la gestion des épidémies et catastrophes                                                                                                  |
|                                 | Détection des cas         |           | 1.Insuffisance dans la préparation du pays aux épidémies                                                                                                                                    |
|                                 |                           |           | 2.Inexistence des centres d'isolement dans les points d'entrée                                                                                                                              |
|                                 |                           |           | 3.Insuffisance des moyens diagnostics                                                                                                                                                       |
|                                 |                           |           | 4.Insuffisance des RH spécialisées                                                                                                                                                          |

| Programmes du PNDS<br>2018-2022              | Domaines/Sous<br>domaines | Problèmes                                                                     | Causes principales                                                                                                              |
|----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | Riposte                   |                                                                               | 5. Insuffisance dans la recherche et dans la maîtrise des agents pathogènes                                                     |
|                                              |                           |                                                                               | 1. Insuffisance de couverture en structures de diagnostics (laboratoires)                                                       |
|                                              |                           |                                                                               | 2. Insuffisance des moyens de transport des échantillons                                                                        |
|                                              |                           |                                                                               | 3. Insuffisance en médicaments et intrants de prise en charge                                                                   |
|                                              |                           |                                                                               | 4. Faible capacité de prise en charge des cas des maladies à potentiel épidémique connues                                       |
|                                              |                           |                                                                               | 5. Insuffisance quantitative et qualitative des ressources humaines<br>6. Faible appropriation de l'approche One Health         |
| <b>Programme n°4</b> : Promotion de la santé |                           | P1. Faible capacité de gouvernance et de pilotage de la promotion de la santé | 1. Absence des textes d'application sur l'organisation et le fonctionnement des organes de gestion sur la promotion de la santé |
|                                              |                           |                                                                               | 2. Absence de stratégie nationale sur la promotion de la santé                                                                  |
|                                              |                           |                                                                               | 3. Absence des normes et procédures en matière de promotion de la santé                                                         |
|                                              |                           |                                                                               | 4. Faible niveau de décentralisation de la promotion de la santé                                                                |
|                                              |                           |                                                                               | 5. Absence de suivi et évaluation des interventions de promotion de la santé                                                    |

| Programmes du PNDS<br>2018-2022 | Domaines/Sous<br>domaines | Problèmes                                                         | Causes principales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                           | P2. Faible qualité de l'offre en matière de promotion de la santé | <p>1.Faible maitrise du paquet des services en matière de promotion de la santé</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Paquet centré sur les maladies transmissibles prioritaires :</b><br/>Paludisme ; Maladies diarrhéiques ; IRA ; Parasitose intestinale ; VIH/Sida et IST ; Tuberculose ; Hépatites ; Malnutrition ; Maladies bucco-dentaires.</li> <li>▪ <b>Paquet centré sur les facteurs de risques des maladies non transmissibles prioritaires :</b><br/>Tabagisme ; Alcoolisme ; Inactivité physique ; Alimentation malsaine (sucre, graisse et sel) ; Pollution de l'air ; Traumatisme en rapport avec les accidents de voies publiques ; Consommation de drogue.</li> <li>▪ <b>Paquet centré sur les maladies évitables par la vaccination</b><br/>Rougeole ; Choléra ; Poliomyélite ; Fièvre jaune ; Covid-19 ; Monkey pox</li> <li>▪ <b>Paquet lié au marketing de l'offre des services publics (services agréments)</b></li> <li>▪ <b>Promotion de la médecine traditionnelle</b></li> </ul> <p>2.Insuffisance du personnel et des agents communautaires en quantité et en qualité à tous les niveaux</p> <p>3.Insuffisance des supports et outils pour la promotion de la santé</p> <p>4.Insuffisance de formation et de supervision des équipes chargées de la mise en œuvre de la promotion de la santé</p> <p>5.Faibles compétences des RH et des relais communautaires en matière de communication</p> <p>6.Faible auto responsabilité et auto détermination des communautés dans la gestion de leur santé</p> |

### VI.1. Rappel de la vision de la politique nationale de santé 2018-2030

La vision du secteur santé telle que formulée dans la politique nationale de santé s'intitule comme suit : « Un Congo doté d'un système de santé performant, résilient et à même de garantir l'accès universel à des services de santé de qualité et un état de santé optimal pour soutenir durablement la croissance et le développement du pays » est assuré pour toutes les couches sociales, avec la pleine participation des communautés à l'horizon 2030.

Autrement dit, le Congo projette d'offrir à tous, un accès universel aux services essentiels de santé de qualité, sans aucune forme d'exclusion ou de discrimination, et avec la pleine participation des populations. C'est dans cette perspective que s'inscrit résolument le PNDS 2023-2026 qui privilégie le renforcement du système de santé et la gouvernance pour la réalisation optimale des interventions à haut impact, à même de réduire significativement la mortalité et la morbidité chez toutes les cibles, avec un accent particulier pour les plus vulnérables (cible mère-enfant).

### VI.2. Alignement du PNDS 2023-2026 sur les engagements nationaux et internationaux

La République du Congo, a fait le choix d'inscrire l'action gouvernementale dans une approche programmatique qui oriente la stratégie de développement économique et social du pays dans un plan quinquennal dénommé « Plan National de Développement (PND 2022-2026) » qui contient les grandes orientations nationales. Ces orientations s'alignent sur les accords mondiaux du développement socio-économique. Ainsi, dans le secteur de la santé, les orientations stratégiques du présent PNDS 2023-2026, formulées à l'issue de l'analyse de la situation réalisée à partir des résultats de la revue finale du PNDS 2018-2022 sont en conformité avec la politique nationale de santé 2018-2030 et les cibles de l'ODD n°3.

Le tableau suivant fait le lien entre les orientations stratégiques du PNDS 2023-2026 et les cibles de l'ODD n° 3 auxquels ils contribuent.

| Orientations stratégiques du PNDS 2023-2026                                | Cibles de l'ODD n°3                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.Renforcement de la gouvernance et du financement du secteur santé        | <b>3.c.</b> Accroître considérablement le budget dédié au secteur de la santé, la formation, le recrutement et le maintien en poste des ressources humaines en santé                                                                             |
| 2.Promotion d'un meilleur état de santé et du bien-être de la population ; | <b>3.3.</b> D'ici à 2030 mettre fin à l'épidémie de SIDA, de la tuberculose et du paludisme et aux maladies tropicales négligées et combattre l'hépatite, les autres maladies transmises par l'eau, ainsi que les autres maladies transmissibles |
|                                                                            | <b>3.4.</b> D'ici à 2030 réduire d'un tiers, par la prévention et le traitement, le taux de mortalité prématurée due aux maladies non transmissibles et promouvoir la santé mentale et le bien-être                                              |
|                                                                            | <b>3.5.</b> Renforcer la prévention et le traitement de l'abus de substances psychoactives, notamment les stupéfiants et l'alcool                                                                                                                |

|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     | <b>3.6.</b> D'ici à 2030 diminuer de moitié à l'échelle mondiale le nombre de décès et de blessure dus à des accidents de la route                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                     | <b>3.9.</b> D'ici à 2030, réduire nettement le nombre de décès et des maladies dus à des substances chimiques dangereuses et à la pollution, ainsi qu'à la contamination de l'air, de l'eau et du sol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                     | <b>3.a.</b> Renforcer dans tous les pays, selon qu'il convient, l'application de la convention –cadre de l'OMS pour la santé antitabac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.Amélioration de l'accès équitable des populations à des paquets de services essentiels de qualité | <b>3.1.</b> D'ici à 2030, faire passer le taux mondial de mortalité maternelle au-dessous de 70 pour 100.000 Naissances Vivantes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                     | <b>3.2.</b> D'ici à 2030, éliminer les décès évitables des nouveau-nés et d'enfants de moins de 5 ans, tous les pays devant chercher à ramener la mortalité néonatale à 12 pour 1.000 Naissances Vivantes au plus et la mortalité des enfants de moins de 5 ans à 25 pour 1.000 Naissances Vivantes au plus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                     | <b>3.7.</b> D'ici à 2030, assurer l'accès de tous à des services de soins de santé sexuelle et procréative, y compris à des fins de planifications familiale, d'information et d'éducation et la prise en compte de la santé procréative dans les stratégies et programmes nationaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                     | <b>3.8.</b> Faire en sorte que chacun bénéficie d'une assurance –santé comprenant une protection contre les risques financiers et donnant accès à des services de santé essentiels de qualité et à des médicaments et vaccins essentiels sûrs, efficaces, de qualité et d'un cout abordable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                     | <b>3.b.</b> Appuyer la recherche et la mise au point de vaccins et des médicaments contre les maladies transmissibles ou non, qui touchent principalement les habitants des pays en développement, donner accès à des médicaments et vaccins essentiels à un cout abordable, conformément à la déclaration de DOHA sur l'accord sur les ADPIC et la santé publique, qui réaffirme le droit qu'ont les pays en développement pour protéger la santé publique et en particulier assurer l'accès universel aux médicaments , de recourir pleinement aux dispositions de l'accord sur les ADPIC qui managent une flexibilité à cet effet. |

4. Renforcement de la sécurité sanitaire, gestion des épidémies et autres situations d'urgence

**3.d.** Renforcer les moyens dont disposent tous les pays, en particulier les pays en développement en matière d'alerte rapide, de détection des risques et de gestion des risques sanitaires nationaux et mondiaux

### VI.3. Principes directeurs du PNDS 2023-2026

Les principes directeurs qui guident la mise en œuvre du PNDS sont :

- **Leadership fort :** L'élaboration du PNDS (2023-2026) qui s'harmonise avec la vision du Président de la République, a été conduite sous le leadership du Ministre de la Santé et de la Population. C'est lui qui a donné les orientations, tout en tenant compte des contributions de toutes les parties prenantes du secteur de la santé. La mise en œuvre de ce plan se fera également selon les priorités du MSP.
- **Processus inclusif et participatif :** Le PNDS, dans son élaboration, a réuni toutes les parties prenantes, que ce soit les structures du ministère en charge de la santé à tous les niveaux de la pyramide sanitaire, les autres secteurs ministériels, les Partenaires Techniques et Financiers, le secteur privé et la société civile. La mise en œuvre se fera également à travers des plans opérationnels élaborés de façon régulière à travers un processus participatif.
- **Droits humains :** Les actions envisagées dans le cadre du PNDS concourent à satisfaire les droits fondamentaux reconnus à la population. Il s'agit notamment, du droit à la vie, à l'éducation et la formation, à la santé, à un emploi décent, à un environnement sain, à l'information et à la liberté d'expression.
- **Genre :** Le PNDS, dans sa mise en œuvre, va promouvoir l'équité et l'égalité entre les sexes. De manière spécifique, cela va se traduire par l'opérationnalisation de solutions aux causes des écarts constatés entre les femmes et les hommes qui résultent des dynamiques du pouvoir entre les hommes et les femmes et la manière dont ces dynamiques façonnent les rôles de genre, l'accès et le contrôle des ressources, la prise de décisions au sein des familles et la participation des femmes.
- **Équité :** le PNDS s'aligne sur le principe de « ne laisser personne pour compte ». Ainsi, son opérationnalisation intégrera des interventions spécifiques qui favorisent la prise en compte des groupes spécifiques.

### VI.4. But et objectifs du PNDS 2023 - 2026

#### VI.4.1. But du PNDS

Permettre à toute la population congolaise de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous.

#### VI.4.2. Objectifs

##### VI.4.2. 1. Objectif Général

Contribuer à améliorer l'état de santé et le bien-être des populations, sans exclusion, par le renforcement du système de santé.

## VI.4.2. 2. Objectifs spécifiques

Pour atteindre cet objectif général, sept (7) objectifs spécifiques ont été définis. Il s'agit de :

1. Réduire la mortalité maternelle de 304 à moins de 70 décès maternels pour 100.000 naissances vivantes d'ici 2026 ;
2. Réduire la mortalité infanto-juvénile de 40,4 à 24,59 décès pour 1.000 naissances vivantes d'ici 2026 ;
3. Réduire de 31% le ratio de mortalité néonatale de 20,20 à moins de 7,2 décès d'ici 2026 ;
4. Réduire la mortalité liée aux maladies transmissibles de 10% d'ici 2026 ;
5. Réduire de 20% le niveau des facteurs de risque des maladies non transmissibles d'ici 2026 ;
6. Réduire de 20% la fréquence des comportements à risque chez les adolescents et chez les jeunes d'ici 2026 ;
7. Réduire de 20% le niveau de vulnérabilité des populations face aux épidémies, autres catastrophes et événements de santé d'ici 2026.

## VI.5. Orientations stratégiques du PNDS 2023 - 2026

La mise en œuvre du PNDS 2023-2026 repose sur quatre (4) orientations stratégiques traduites en programmes à savoir :

1. **Programme 1** : Renforcement de la gouvernance et du financement du secteur santé ;
2. **Programme 2** : Promotion d'un meilleur état de santé et du bien-être de la population ;
3. **Programme 3** : Amélioration de l'accès équitable des populations à des paquets de services essentiels de qualité ;
4. **Programme 4** : Renforcement de la sécurité sanitaire, gestion des épidémies et autres situations d'urgence.

Chacun de ces programmes se décline en sous-programmes, résultats attendus, lignes d'actions prioritaires et activités clés par ligne d'action (conf. cadre logique du PNDS).

## VI.6. Résultats sectoriels attendus

Les résultats sectoriels attendus sont :

1. **Résultat sectoriel 1** : La gouvernance et le financement du secteur sont renforcés ;
2. **Résultat sectoriel 2** : La promotion d'un meilleur état de santé et du bien-être de la population est assurée ;
3. **Résultat sectoriel 3** : L'offre de services de santé de base et de référence de qualité est universellement accessible aux populations ;
4. **Résultat sectoriel 4** : La sécurité sanitaire, la gestion des épidémies et autres situations d'urgences sont renforcées.

Les différents résultats sectoriels sont déclinés en résultats intermédiaires (RI) que sont :

### Pour le résultat sectoriel 1 portant sur la gouvernance et le financement du secteur santé

- ✓ RI 1 : La gouvernance des structures de santé est améliorée à tous les niveaux du système de santé ;
- ✓ RI 2 : Les organes de pilotage, de coordination et de partenariat à tous les niveaux sont fonctionnels ;
- ✓ RI 3 : Le processus de planification stratégique et opérationnelle est amélioré à tous les niveaux du système de santé ;
- ✓ RI 4 : Les effectifs des RHS en termes de quantité et qualité sont équilibrés ;
- ✓ RI 5 : Le système d'information sanitaire permettant la planification, le suivi et l'évaluation est performant ;
- ✓ RI 6 : Le financement de la santé en termes de quantité et qualité est efficace ;
- ✓ RI 7 : La coordination et le partenariat du secteur est renforcé.



## **Pour le résultat sectoriel 2 portant sur la promotion d'un meilleur état de santé et du bien-être de la population**

- ✓ RI 1 : La gouvernance et le pilotage de la promotion de la santé sont renforcés ;
- ✓ RI 2 : Le cadre juridique et institutionnel relatif à la gestion de la santé environnementale est renforcé et harmonisé ;
- ✓ RI 3 : Les services d'hygiène disposent d'un laboratoire de l'hygiène publique d'analyses de l'eau de boisson, des aliments, des eaux usées et des contrôles environnementaux,
- ✓ RI 4 : La qualité de l'offre en matière de promotion de la santé est améliorée ;
- ✓ RI 5 : L'implication de la communauté en matière de promotion de la santé est renforcée.

## **Pour le résultat sectoriel 3 portant sur l'accès équitable des populations aux paquets de services essentiels de qualité et utilisation des services**

- ✓ RI 1 : la couverture du pays en DS ayant une équipe cadre de district et une équipe de gestion fonctionnant dans les normes est améliorée ;
- ✓ RI 2 : la couverture sanitaire du pays en services de santé de premier échelon (SSPE) capables d'offrir les paquets des services essentiels est améliorée ;
- ✓ RI 3 : la couverture sanitaire du pays en hôpitaux de district capables d'offrir des soins d'urgences 24 h/24 est améliorée ;
- ✓ RI 4 : la couverture sanitaire du pays en établissements capables d'offrir les soins de spécialités essentiels de qualité et à moindre coût est améliorée ;
- ✓ RI 5 : l'accès aux médicaments, produits sanguins labiles, vaccins et technologies dans les structures de dispensation est garanti ;
- ✓ RI 6 : l'offre des analyses biomédicales est améliorée dans le pays ;
- ✓ RI 7 : la couverture de l'assurance maladie universelle est mise en exploitation ;
- ✓ RI 8 : la couverture du pays en FOSA offrant des soins et services de la reproduction de qualité est améliorée ;
- ✓ RI 9 : la couverture en FOSA offrant l'ensemble des éléments traceurs des soins et services de santé infantiles traceurs est augmentée ;
- ✓ RI10 : la couverture en FOSA offrant les soins et services de santé des adolescents et les jeunes est améliorée.

## **Pour le résultat sectoriel 4 portant sur la sécurité sanitaire, gestion des épidémies et autres situations d'urgence**

- ✓ RI 1 : les capacités du pays en matière d'alerte rapide des épidémies sont renforcées ;
- ✓ RI 2 : les capacités de gestion des catastrophes et autres risques sanitaires nationaux sont améliorées.

## **VI.7. Actions prioritaires par programme du PNDS 2023-2026**

L'impact de la pandémie à Covid-19 a profondément perturbé la réalisation des actions prévues dans le PNDS 2018-2022. C'est ainsi que dans ce registre, le choix est fait de reprendre l'intégralité des actions du dernier plan afin de veiller à leur mise en œuvre.

### **VI.7.1. Programme n°1 : Renforcement de la gouvernance et du financement du secteur santé**

Le programme de renforcement de la gouvernance et du financement du secteur santé comprend deux sous programmes qui sont : le sous-programme « renforcement du cadre juridique, administratif et financier » et le sous-programme « amélioration de la coordination et du partenariat du secteur santé »

#### **VI.7.1.1. Sous-programme 1.1 : « renforcement du cadre juridique, administratif et financier**

Le renforcement du cadre juridique, administratif et financier constitue un préalable pour l'atteinte des objectifs de couverture sanitaire universelle dans le contexte de la gestion axée sur les résultats.

Cette approche stratégique adressera, entre autres, les dimensions suivantes : le pilotage et la coordination, la planification, le suivi, l'évaluation, la recherche, la régulation, la mobilisation accrue des ressources et leur utilisation rationnelle.

Les onze (11) actions suivantes seront entreprises afin de renforcer la gouvernance et le financement du secteur santé : (i) l'amélioration du cadre juridique et réglementaire de mise en œuvre du PNDS, (ii) la mise en place des normes d'organisation et de fonctionnement des structures de santé à tous les niveaux du système de santé, (iii) le renforcement des capacités managériales des organes de pilotage, de coordination et de partenariat, (iv) le renforcement des capacités managériales (planification, suivi, supervision et évaluation) à tous les niveaux du système de santé, (v) le renforcement des mécanismes de suivi et d'évaluation des plans opérationnels annuels et du plan global, (vi) le renforcement de la gestion orthodoxe des RHS, (vii) les ressources financières consacrées au secteur de la santé, (viii) la mobilisation des fonds additionnels par la mise en place des financements innovants pour combler le gap de financement de l'Etat, (ix) le renforcement du Système National d'Information Sanitaire (SNIS), (x) la digitalisation du système de santé et (xi) les études et enquêtes dans le domaine de la recherche en santé.

### **1. Amélioration du cadre juridique et réglementaire de mise en œuvre du PNDS**

Il s'agit d'actualiser les textes devenus caduques notamment, ceux mettant en place le conseil national de santé, le comité de pilotage du PNDS, le comité technique du PNDS, l'organisation et le fonctionnement des DDSSa et des DDPOP, l'harmonisation des décrets du conseil départemental et du comité technique de suivi, les textes relatifs aux comités interministériels, la plateforme « Une seule Santé », le comité technique de suivi et le secrétariat technique permanent.

### **2. Mise en place des normes d'organisation et de fonctionnement des structures de santé à tous les niveaux du système de santé.**

Les normes d'organisation et de fonctionnement des structures de santé à tous les niveaux sont nécessaires pour garantir l'efficacité d'une politique de santé. Elles devront donc être élaborées et diffusées. Elles touchent aussi bien les niveaux central, intermédiaire et périphérique du système de santé.

En matière de gouvernance sanitaire, dans le domaine de la normalisation et de la régulation, un arsenal de textes normatifs sera élaboré et/ou révisé puis validé et diffusé en vue de disposer d'une assise réglementaire concernant les différentes normes et procédures de gestion des ressources, de prestations de services, de coordination et de suivi et évaluation.

Plusieurs mesures fortes sont requises pour accroître la contribution de tous les secteurs y compris du secteur privé, partenaire privilégié dans la définition et la mise en œuvre des politiques de santé, dans le relèvement des défis du secteur.

### **3. Renforcement des capacités managériales des organes de pilotage, de coordination et de partenariat**

Il s'agit d'organiser trois (3) sessions de formation des membres des organes de pilotage, de coordination et de partenariat pour la mise en œuvre du PNDS (Conseil national de santé, Comité interministériel de pilotage, Comité technique de suivi du PNDS et Secrétariat technique permanent, Conseils départementaux, COGES du district, CD, COSA) sur le management.

### **4. Renforcement des capacités managériales (planification, suivi, supervision et évaluation) à tous les niveaux du système de santé**

Il s'agit ici de renforcer la planification, le suivi et l'évaluation en vue d'améliorer la performance à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Il sera mis en place un mécanisme de validation et d'arbitrage budgétaire pour tous les plans annuels à tous les niveaux de la pyramide sur la base de critères objectifs de qualité bien définis. Des critères de qualité applicables à tout le processus de planification du MSP seront élaborés et intégrés à un système de normalisation interne.

Il s'agira également de renforcer les fonctions managériales : planification, coordination, suivi et monitoring, audit et contrôle, formation, gestion des médicaments, gestion financière. Des stratégies sous sectoriels seront élaborés ou actualisés afin de les aligner au PNDS. C'est le cas des stratégies de lutte contre le VIH/Sida, la Tuberculose, le paludisme, le tabagisme, l'alcoolisme, la santé mentale, etc. Chaque structure devra chaque année élaborer son plan d'action opérationnelle pour la mise en œuvre du PNDS. L'évaluation des plans opérationnels annuels se fera après une évaluation ou revue annuelle du secteur de la santé. Par ailleurs, une évaluation à mi-parcours se fera au dernier semestre 2024 et une évaluation finale en 2026.

#### **5. Renforcement des mécanismes de suivi et d'évaluation des plans opérationnels annuels et du plan global**

Il est question d'organiser mensuellement les réunions de monitoring des indicateurs de suivi.

#### **6. Renforcement de la gestion orthodoxe des RHS**

Il s'agit essentiellement de répartir équitablement les RHS entre le milieu rural et le milieu urbain selon la loi sur la décentralisation (fonction publique territoriale).

#### **7. Ressources financières consacrées au secteur de la santé**

Selon les données du dernier PNDS, le Congo a consacré en moyenne 70\$ US par habitant et par an à la santé, sans résultats comparativement supérieurs aux autres pays de la sous-région qui ont eu des dépenses de santé nettement inférieures. De ce fait, dans un contexte des ressources limitées, la priorité est de voir comment améliorer l'efficacité dans l'utilisation des fonds alloués dans le secteur de la santé. La logique est d'orienter environ 70 % des ressources dans les soins de santé primaires qui sont reconnus comme efficaces dans la réduction de la morbi-mortalité des populations. Pour ce faire, l'allocation directe des ressources financières sécurisées aux FOSA est déterminante. Cette option est inscrite dans la politique de financement de la santé par la Caisse d'assurance maladie universelle via le ministère en charge de la sécurité sociale.

#### **8. Mobilisation des fonds additionnels par la mise en place des financements innovants pour combler le gap de financement de l'Etat**

L'augmentation des ressources et leur utilisation équitable et efficace dans le secteur de la santé doit être une priorité pour atteindre les ODD. Pour cela, la cible d'au moins 86 dollars US de dépense de santé par habitant et par an sera nécessaire pour améliorer les progrès vers la couverture sanitaire universelle. La mise en exploitation de l'assurance maladie universelle basée sur la contribution financière solidaire permettra de disposer des fonds directs et accessibles pour la santé. En même temps, l'augmentation de la part du budget publique de la santé permettra d'accroître la dépense totale de santé par habitant et par an. En outre, le gouvernement fera des efforts pour diversifier les recettes fiscales pour améliorer la mobilisation des ressources domestiques en vue de financer durablement la santé. Les évaluations périodiques des taux de décaissement et des de financement des secteurs prioritaires seront également améliorés.

#### **9. Renforcement du Système National d'Information Sanitaire (SNIS)**

Dans cette rubrique, il s'agira de : (i) implémenter la stratégie de développement du système national d'informations sanitaire, (ii) standardiser les outils de collecte et de traitement des données au niveau des hôpitaux généraux ainsi que la définition du circuit de l'information et (iii) aligner les sous-systèmes d'information sanitaire (projets et programmes) sur le système national. L'informatisation des formations sanitaires prévue dans le cadre de la mise en œuvre de l'assurance maladie universelle devra être alignée aux objectifs du SNIS.

#### **10. Digitalisation du système de santé**

Il s'agit d'utiliser les solutions informatiques dans les processus de gestion intégrant les procédures métiers, le pilotage d'objet ou d'outils dans le but d'optimiser les performances du fonctionnement des organisations.

## **11. Etudes et enquêtes dans le domaine de la recherche en santé**

Cette ligne d'action se fera à travers : (i) la réalisation des deux (02) enquêtes SARA (1 en 2023 et 1 autre en 2025), (ii) l'élaboration des quatre (04) comptes de la santé, (iii) la réalisation d'une enquête ménage sur le « Baromètre-santé », (iv) la séro-surveillance, (v) l'élaboration d'un plan d'amélioration de la qualité des données, (vi) la promotion de l'utilisation des résultats des études et de la recherche issus de la FSSA, du CIESPAC et des sociétés savantes, et (vii) l'enquête démographique de santé (2024), le MICS (2025), les annuaires des statistiques (2023 à 2026), la revue externe du programme élargi couplée à l'enquête nationale de couverture (2024), la nutrition, ECOM (2024). Il sera nécessaire d'associer dans cette rubrique l'Institut National des Statistiques (INS).

### **VI.7.1.2. Sous-programme 1.2 : Amélioration de la coordination et du partenariat du secteur santé**

Le sous-programme « Amélioration de la coordination et du partenariat du secteur santé » comprend une seule action, à savoir : le renforcement de la coordination et du partenariat du système de santé.

### **VI.7.2. Programme n° 2 : Promotion d'un meilleur état de santé et du bien-être de la population**

Le programme de la promotion d'un meilleur état de santé et du bien-être de la population comprend deux sous programmes qui sont : le sous-programme « amélioration de la gouvernance et du pilotage en matière de la promotion de la santé et le sous-programme « amélioration du cadre et/ ou mode de vie des populations ».

La promotion de la santé étant le processus qui permet aux populations d'améliorer la maîtrise de leur santé et de ses déterminants. Ce programme vise à renforcer la prévention et la mise en œuvre des actions multisectorielles visant la promotion des comportements favorables à la santé y compris dans la communauté.

Il s'agit ici de renforcer la prévention et la promotion sur les facteurs de risques des maladies dans la communauté et en milieu de soins. La population congolaise sera sensibilisée sur les facteurs de risque (prévention primaire) et l'importance du dépistage précoce des maladies non transmissibles et transmissibles, les populations cibles du PEV seront vaccinées (y compris au papillomavirus humain et l'hépatite B à la naissance).

Les actions de prévention et de promotion de la santé seront menées dans tous les DS. La mise en œuvre de ses missions, mobilisera les ressources humaines qualifiées en quantité suffisante, des directives et/ou protocoles actualisés et intrants nécessaires pour améliorer le paysage épidémiologique du Congo.

#### **VI.7.2.1. Sous-programme 2.1 : Amélioration de la gouvernance et du pilotage en matière de la promotion de la santé**

Six (06) actions prioritaires sont inscrites dans le cadre de ce sous-programme : (i) le renforcement de la gouvernance en promotion de la santé, (ii) le renforcement et l'harmonisation du cadre juridique et institutionnel de la santé environnementale, (iii) la mise en place des directives, normes et procédures de gestion de la santé environnementale en rapport avec le contexte actuel, (iv) l'acquisition du matériel adéquat, des réactifs, des milieux de culture et d'autres fournitures nécessaires pour la surveillance et le contrôle de la qualité de l'eau, de l'air, du sol, de l'eau de boisson, des boissons, des aliments et des eaux usées, (v) le renforcement de la qualité de l'offre en matière de promotion de la santé, et (vi) l'acquisition des matériels et des équipements adéquats pour la gestion des déchets biomédicaux.

### **VI.7.2.2. Sous-programme 2.2 : Amélioration du cadre et/ ou mode de vie des populations**

Une seule action sera entreprise dans le cadre de ce sous-programme, à savoir : le renforcement de l'implication de la communauté en matière de promotion de la santé.

### **VI.7.3. Programme n°3 : Amélioration de l'accès équitable des populations aux paquets de services essentiels de qualité**

Le programme d'amélioration de l'accès équitable des populations aux paquets de services essentiels de qualité comprend trois sous programmes qui sont : le sous-programme « renforcement de l'offre de soins et services de santé », le sous-programme « amélioration de l'accès financier aux soins et services de santé des populations » et le sous-programme « renforcement des programmes de santé de la mère, de l'enfant, des jeunes et des adolescents »

Ce programme constitue le fondement sur lequel la couverture sanitaire universelle en santé sera développée en République du Congo. Il vise à donner accès à tous de manière inclusive aux soins de santé de qualité sans obstacles financiers. L'atteinte de cet objectif ne peut passer, selon l'OMS, qu'à travers un mécanisme d'assurance maladie universelle. C'est à ce titre que le Gouvernement de la République a fait le choix de mettre en place une caisse de mise en œuvre du régime d'assurance maladie universelle (RAMU) visant, à titre de rappel, trois objectifs pour atteindre les ODD pour la santé à savoir : (i) améliorer l'accès aux soins à tous, (ii) développer de l'offre de soins de qualité et (iii) garantir l'équilibre financier du RAMU pour rendre durable la protection de la santé des congolais.

#### **VI.7.3.1. Sous-programme 3.1 : Renforcement de l'offre de soins et services de santé**

Onze (11) actions sont inscrites dans le cadre de ce sous-programme : (i) la revitalisation des districts sanitaires afin de développer les soins de santé primaires , (ii) le développement des aires de santé conformément au plan de couverture des 52 DS (PSE conformément aux normes du système de santé intégré de district (SSID) , (iii) l'instauration de l'approche « pangouvernementale » dans certains DS à faible indicateurs de santé, notamment dans les départements de la Likouala, du Pool, la Cuvette-ouest et la Lékoumou, (iv) la mise en place de l'approche de la santé à base communautaire dans les aires de santé, (v) l'amélioration de l'offre du PCA des 31 FOSA de première référence (hôpitaux de district), (vi) la finalisation des travaux de construction de 8 HG départementaux (2 par an) y compris le maintien des HG préexistants (CHU de Brazzaville, Dolisie, 31 juillet Owando, Adolphe Sicé, Loandjili et Blanche Gomes) , (vii) l'amélioration de l'accès des populations aux médicaments, vaccins, autres produits de santé et technologie, (viii) l'amélioration de l'accès des patients aux produits sanguins sécurisés, (ix) l'approvisionnement en vaccins et intrants nécessaires aux activités d'immunisation des populations cibles, (x) le renforcement du plateau technique du LNSP pour être en conformité avec ses nouvelles missions de l'Institut National de Santé Publique et (xi) le renforcement de la qualité des laboratoires périphériques .

#### **VI.7.3.2. Sous-programme 3.2: amélioration de l'accès financier aux soins et services de santé des populations**

Ce sous-programme comporte deux (02) actions qui sont : (i) la mise en exploitation de l'assurance maladie universelle destinée à couvrir toutes les catégories de populations (Préparer les FOSA à assurer les soins aux bénéficiaires de l'AMU) et (ii) la mobilisation du financement de la vaccination, des urgences et catastrophes et des initiatives de gratuité ainsi que pour des médicaments essentiels génériques, réactifs, consommables et autres produits de santé de la CAMEPS

#### **VI.7.3.3. Sous-programme 3.3 : « renforcement des programmes de santé de la mère, de l'enfant, des jeunes et des adolescents.**

Le sous-programme « renforcement des programmes de santé de la mère, de l'enfant, de l'adolescent et du jeune » comporte sept (07) actions qui sont : (i) le renforcement du suivi anténatal de la femme, (ii) le renforcement de la qualité du suivi prénatal, (iii) la promotion de l'accouchement

propre et de qualité dans les FOSA offrant les accouchements , (iv) l'amélioration de la qualité des soins curatifs de l'enfant dans les FOSA de 1<sup>er</sup> et de 2<sup>ème</sup> échelon, (v) l'amélioration de l'offre des services de vaccination, de supplémentation à la vitamine A et du déparasitage systématique , (vi) l'amélioration de l'état nutritionnel et (vii) l'augmentation de la couverture du pays en centres de santé scolaire et universitaire .

#### **VI.7.4. Programme n° 4 : Renforcement de la sécurité sanitaire, gestion des épidémies et autres situations d'urgence**

Le programme de renforcement de la sécurité sanitaire, gestion des épidémies et autres situations d'urgence comprend deux sous-programmes qui sont : le sous-programme « gestion des épidémies selon le règlement sanitaire international » et le sous-programme « gestion des catastrophes et autres événements de santé en fonction des dispositions du RSI 2005 ».

La sécurité sanitaire est une priorité nationale et constitue un grand défi à relever du fait que les maladies d'origine alimentaire, zoonotique et environnementale sont une cause importante de morbidité et mortalité au Congo et constituent, de ce fait, des problèmes majeurs de santé publique.

Ces dernières années, l'émergence et la propagation d'agents infectieux avec un risque accru de pandémies (grippe aviaire H5N1, Monkey-pox, fièvres hémorragiques dont Ebola...) trouvent leur origine dans le monde animal. Aux phénomènes infectieux, s'ajoutent à notre ère industrielle, les risques non infectieux, climatiques, chimiques ou nucléaires qui perturbent l'écosystème. Pour faire face à ces enjeux, la coordination entre les différents secteurs de santé, humaine, animale et environnementale, doit donc être renforcée selon l'approche « **Une seule santé** ».

L'évaluation conjointe externe réalisée par le Congo en mars 2019 a permis de mesurer les risques, l'ampleur de l'impact des flambées épidémiques et les liens étroits qui existent entre la santé humaine, animale et environnementale. Un Plan d'Action National de Sécurité Sanitaire (PANSS) couvrant la période 2022-2024 est disponible. C'est un engagement du Gouvernement Congolais pour améliorer la situation de la sécurité sanitaire de notre population, mais aussi, une adhésion au pacte mondial pour la sécurité sanitaire dont l'OMS, la FAO, et l'OIE sont les porte-étendards.

Ce programme est axé sur l'amélioration de la gouvernance et du pilotage dans la gestion des urgences de santé publique, la préparation du pays aux épidémies (gestion des épidémies selon le RSI), la recherche et la maîtrise des agents pathogènes (détection des cas) et enfin l'amélioration des capacités de prise en charge des cas des maladies à potentiel épidémique connues (riposte).

##### **VI.7.4.1. Sous-programme 4.1 : gestion des épidémies selon le règlement sanitaire international (RSI).**

Une seule action sera entreprise dans le cadre de ce sous-programme, à savoir : la préparation aux épidémies.

##### **VI.7.4.1. Sous-programme 4.2 : gestion des catastrophes et autres événements de santé en fonction des dispositions du RSI.**

Cinq (5) actions prioritaires sont inscrites dans le cadre de ce sous-programme : (i) la prévention et ripostes contre les catastrophes et autres événements, (ii) le renforcement des services de santé de détection dans les points d'entrées (aéroports, Beach, ports secondaires, points d'accostage), (iii) l'élaboration de la cartographie des risques environnementaux au niveau national, (iv) la mise en place d'un Système d'Alerte et d'informations aux populations (SAIP) et (v) la mise en place des sites sentinelles de surveillance de la contamination des aliments dans les villes de Brazzaville, Pointe Noire, Dolisie, Nkayi, Mossendjo, Gamboma, Oyo, Pokola et Ouesso .

#### **VI.8. Théorie du changement général**

La théorie du changement du PNDS 2023-2026 prévoit que la République du Congo enregistrera des progrès réels d'ici 2026 en matière de santé, alignés sur les ODD avec l'appui des partenaires au développement.

Le résultat d'impact suivant a été formulé : « **D'ici 2026, les populations ont leur état de santé et de bien-être amélioré** ». La théorie du changement général du PNDS 2023-2026 traduit les changements à opérer et les facteurs contextuels à contrôler pour l'atteinte de ce résultat ultime attendu. Il s'énonce comme suit :

- ✓ Si, les acteurs au niveau central, déconcentré et décentralisé du système de santé, assurent un leadership, un management et un financement efficaces et inclusifs,
- ✓ Si, le système de planification, de suivi et d'évaluation assure une utilisation adéquate de l'information sanitaire pour la prise de décision,
- ✓ Si, le système de santé assure les investissements adéquats pour des services de santé de qualité et accessibles,
- ✓ Si, le système de santé assure une meilleure prise en charge des groupes spécifiques prioritaires,
- ✓ Si, le système de santé assure une prise en charge efficace contre les maladies,
- ✓ Si, le système de santé assure une réponse efficace aux urgences de santé publique,
- ✓ Si, les populations, en particulier les plus vulnérables, utilisent des services de santé de qualité et adoptent des comportements adéquats favorisant une meilleure santé,

Alors, la République du Congo jouira d'un développement sanitaire où les populations ont **leur état de santé et de bien-être amélioré**.

Parce que (i) la gouvernance et le financement du secteur sont renforcés à travers des mécanismes de pilotage, de régulation, de supervision, de contrôle, d'audit, de mobilisation et de rationalisation de l'utilisation des ressources, (ii) la promotion d'un meilleur état de santé et du bien-être de la population est assurée, (iii) l'accès équitable des populations aux paquets de services essentiels de qualité et utilisation des services est amélioré et iv) la sécurité sanitaire et la gestion des situations d'urgences sont renforcées

Dans un contexte où (i) la volonté politique du Gouvernement en faveur du secteur de la santé, et de la mise en œuvre des ODD et de la réduction des décès évitables de mères et d'enfants est renforcée, (ii) la volonté et l'engagement des partenaires à adhérer à la mise en place d'un panier commun dans le cadre d'une approche sectorielle sont effectifs, (iii) la République du Congo maintient une forte croissance économique nationale, (iv) la mobilisation de ressources additionnelles internes et les financements innovants pour la santé sont effectifs.

Des mesures sont prises pour faire face i) au mauvais environnement international et national de crise financière, à la situation sécuritaire, politique et sociale trouble (terrorisme, guerre, etc.), ii) aux catastrophes climatiques ou environnementales ou la recrudescence des maladies à potentiel épidémique (fièvres hémorragiques, maladies émergentes et ré-émergentes), iii) à l'insuffisance de fonds alloués au secteur de la santé et iv) aux pesanteurs socio-culturelles qui limitent l'utilisation des services et l'adoption de comportements favorables à la santé.

### **VI.8.1. Théorie du Changement adaptée à chaque programme**

La théorie du changement général s'appuie sur des théories du changement spécifique à chaque axe stratégique.

#### **VI.8.1.1. Théorie du Changement du programme n°1**

La théorie du changement liée à la gouvernance et au financement du secteur santé, s'énonce de la manière suivante :

- ✓ Si les acteurs du système de santé disposent du savoir-être et du savoir-faire pour la conception et la mise en œuvre des politiques, normes et règlements ;
- ✓ Si le ministère de la Santé et de la population est capable d'assurer la coordination, la régulation à chaque niveau de la pyramide sanitaire et la collaboration effective avec les autres secteurs (les différents ministères, le secteur privé, les collectivités territoriales, la société civile, etc.) et les partenaires techniques et financiers ;
- ✓ Si les acteurs de tous les niveaux du système de santé sont mieux outillés pour la mobilisation et la gestion efficiente des ressources financières ;



- ✓ Si les acteurs aux niveaux central et déconcentré (Etat, privé, ONG, autres institutions) sont mieux outillés pour la production, l'analyse et la transformation des données de qualité en information utilisable pour la prise de décision ;
- ✓ Si les acteurs aux niveaux central et opérationnel du système de santé disposent de capacités renforcées en matière de planification, de suivi et d'évaluation des interventions sanitaires ;
- ✓ Si le système de santé dispose d'une infrastructure informatique de communication supportant les principaux sous systèmes d'informations sanitaires digitalisés et interfacés les uns aux autres de sorte à consolider les données collectées et à alimenter le SNIS ;
- ✓ Si le système de santé dispose de capacités renforcées en matière de développement de la recherche et de l'innovation.

Alors, la gouvernance et le financement du secteur de la santé sont améliorés.

Parce que (i) les acteurs aux niveaux central, déconcentré et décentralisé du système de santé, assurent un management et un financement efficaces, et inclusifs, et (ii) le système de planification de suivi et d'évaluation assure une utilisation adéquate de l'information sanitaire pour la prise de décision en vue d'une mise en œuvre efficace des interventions sanitaires.

Dans un contexte où (i) l'application des textes législatifs et réglementaires, et des politiques et directives est effective, (ii) la régulation de l'exercice en clientèle privée est améliorée, (iii) le fonctionnement régulier et optimal des régions, districts sanitaires et des mécanismes de coordination intra et intersectorielle est assuré, (iv) le financement pour la formation des ressources humaines est suffisant, (v) les mécanismes de contrôles internes et un cadre de redevabilité sont fonctionnels, (vi) la disponibilité d'une information sanitaire exhaustive et de qualité est assurée. Des initiatives sont prises pour faire face aux effets secondaires de l'instabilité politique et à la corruption et détournement des deniers publics.

#### **VI.8.1.2. Théorie du Changement du programme n°2**

La théorie du changement relative liée à la promotion d'un meilleur état de santé et du bien-être de la population pose que :

- ✓ Si les populations, surtout les plus défavorisées et vulnérables s'approprient de bonnes capacités pour la demande de services de santé et la prévention des maladies ;
- ✓ Si les autorités administratives, politiques, communautaires, religieux et syndicaux, les responsables de groupements d'intérêts économiques, les parents et autres acteurs de la société civile disposent de capacités suffisantes pour favoriser la demande et l'utilisation des services de santé.

Alors, la promotion d'un meilleur état de santé et du bien-être de la population sera améliorée.

Parce que les populations en particulier, utilisent des services de santé de qualité et adoptent des comportements adéquats favorisant une meilleure santé.

Dans un contexte où i) la qualité des services de santé est améliorée, ii) l'accessibilité géographique et financière des services de santé est assurée.

Des mesures sont prises pour i) Améliorer le faible niveau d'instruction de la population, ii) améliorer le faible niveau économique de la population, iii) faire face aux rumeurs sur l'offre de service.

#### **VI.8.1.3. Théorie du Changement du programme n°3**

La théorie du changement relative à l'amélioration de l'accès équitable des populations à des paquets de services essentiels de qualité, s'énonce comme suit :

- ✓ Si le système de santé dispose de ressources humaines qualifiées, en quantité suffisante, équitablement réparties et motivées ;
- ✓ Si le système de santé dispose des infrastructures et équipements adéquats et maintenus en bon état à tous les niveaux de la pyramide sanitaire ;



- ✓ Si le système de santé dispose de capacités renforcées pour assurer un accès accru à des produits de santé de qualité et en quantité suffisante ;
- ✓ Si le système de santé est mieux outillé pour assurer une offre de services intégrés et adaptés aux besoins de la mère, du nouveau-né et de l'enfant ;
- ✓ Si le système de santé est mieux outillé pour assurer une offre de services intégrés et adaptés aux adolescents et jeunes ;
- ✓ Si le système de santé est mieux outillé pour lutter efficacement contre les maladies transmissibles y compris les maladies tropicales négligées et les maladies évitables par la vaccination au sein des établissements sanitaires ;
- ✓ Si le système de santé est mieux outillé pour lutter efficacement contre les Maladies non transmissibles (MNT) au sein des établissements sanitaires ;
- ✓ Si les structures de santé sont mieux outillées pour assurer la prévention et le contrôle des infections, l'accès aux services d'eau, d'hygiène et d'assainissement et la gestion des déchets sanitaires ;
- ✓ Si Les acteurs à tous les niveaux de la pyramide sanitaire sont mieux outillés pour la gestion et la fourniture de soins de qualité ;
- ✓ Si Le système de santé dispose de capacités renforcées en matière de préparation aux situations d'urgences et de prévention des événements de santé publique ;
- ✓ Si Le système de santé dispose de capacités renforcées pour la détection précoce des événements de santé publique, la riposte et la continuité des services essentiels de santé dans les situations d'urgence.

Alors, l'offre et l'accès équitable des populations à des paquets de services essentiels et de qualité seront assurées.

Parce que (i) le système de santé investit efficacement dans des services de santé accessibles et qualité, (ii) le système de santé développe une offre de prestations ciblant les soins de santé prioritaires et inclusifs, (iii) le système de santé assure une prise en charge rapide et efficace contre les maladies, (iv) le système de santé assure une réponse rapide et efficace aux urgences de santé publique.

Dans un contexte où (i) le parcours de soins à travers le système de référence et contre référence, le Système National d'Information Sanitaire (SNIS) et la digitalisation facilitant la télémédecine sont améliorés, (ii) les infrastructures, les équipements et leur maintenance sont renforcés, (iii) la disponibilité des produits de santé est assurée, (iv) le renforcement et la capitalisation de certaines initiatives positives (Kobikisa, l'assurance maladie universelle) est effective, (v) l'implication de la médecine et la pharmacopée traditionnelles dans la lutte contre les maladies est mise à contribution, (vi) la répartition équitable des RHS obéissant au principe de profil-poste aux différents postes tient compte du paysage épidémiologique et de la charge de travail des personnels de santé.

Des initiatives sont prises pour i) améliorer la faible collaboration intersectorielle entre le Ministère en charge de la Santé et les autres Ministères impliqués dans la gestion et la production des Ressources Humaines, ii) lutter contre l'immigration du personnel de santé, iii) améliorer la collaboration intersectorielle entre le Ministère en charge de la Santé et les collectivités territoriales dans le cadre de l'implantation et l'équipement des structures sanitaires et iv) faire face à la pénurie de produits de santé sur le marché international et améliorer leur production au niveau local.

#### **VI.8.1.4. Théorie du Changement du programme n°4**

La théorie du changement relative au Renforcement de la sécurité sanitaire, à la gestion des épidémies et autres situations d'urgence s'énonce de la manière suivante :

- ✓ Si les moyens systématiques de suivre la progression des épidémies ou des catastrophes d'un foyer à l'autre par l'approvisionnement des moyens diagnostics rapides et accessibles sont disponibles, de même que des spécialistes (nationaux et internationaux), ainsi que des ressources matérielles et logistiques de manière suffisante là où il faut mettre en œuvre les interventions ;
- ✓ S'il y a renforcement de la recherche dans la maîtrise des agents pathogènes respiratoires ;

- ✓ Si l'accès aux médicaments antiviraux et autres, aux vaccins est garanti à un rythme rapide en quantité suffisante, et de bonne qualité au coût accessible ;
- ✓ Si la communication en vue de renforcer la confiance dans les actions gouvernementales liées à la santé publique est améliorée ;
- ✓ Si la gouvernance participative et la gestion décentralisée des crises sanitaires est améliorée ;
- ✓ Si l'évaluation et la redevabilité dans l'utilisation des ressources financières dans le manuel de procédure de gestion des urgences de santé publique est intégrée.

Alors, le management des épidémies et des catastrophes sera efficace. Parce que la surveillance épidémiologique est renforcée, la préparation et planification des crises avec les PTFs est régulièrement menée, la prévention, le diagnostic, le dépistage et la prise en charge précoce sont adaptés et efficaces.

## CHAPITRE VII : CADRE LOGIQUE

---

Le cadre logique ci-après présente les quatre (4) programmes retenus dans le PNDS 2023-2026. Chacun de ces programmes est décliné en sous-programmes, résultats attendus, lignes d'actions prioritaires et activités clés par ligne d'action, auxquels les indicateurs de suivi sont associés.

| Programme n°1 : Renforcement de la gouvernance et du financement du secteur santé                                             |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |                                            |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| Sous-programme 1.1 : Renforcement du cadre juridique, administratif et financier                                              |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |                                            |                          |
| Résultats attendus                                                                                                            | Lignes d'actions prioritaires                                                                                                                                                      | Contenu des lignes d'actions                                                                                                                                                                        | Indicateurs de suivi                                                                                                                                                                | Source de vérification                     | Structures responsables  |
| <b>Résultat attendu n°1 :<br/>La gouvernance des structures de santé est améliorée à tous les niveaux du système de santé</b> | <b>Amélioration du cadre juridique et réglementaire de mise en œuvre du PNDS</b><br>(Applicabilité des textes juridiques et réglementaires à tous les niveaux du système de santé) | Actualiser les textes relatifs à la création et au fonctionnement des organes de mise en œuvre du PNDS 2023-2026 à tous les niveaux du système de santé (national, départemental et périphérique) ; | Existence des textes juridiques actualisés et promulgués portant création et fonctionnement des organes de mise en œuvre du PNDS 2023-2026 à tous les niveaux du système de santé ; | Journal officiel de la République du Congo | CABINET<br>DGSSSa<br>IGS |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    | Actualiser les textes relatifs à l'organisation et au fonctionnement des DDSSSa et des DDPOP ;                                                                                                      | Existence des textes juridiques actualisés et promulgués portant organisation et fonctionnement des DDSSSa et des DDPOP ;                                                           |                                            |                          |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    | Elaborer les textes juridiques de mise en place des comités interministériels de la plateforme « Une seule Santé »                                                                                  | Existence des textes juridiques mettant en place des comités interministériels de la plateforme « une seule santé »                                                                 |                                            |                          |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                    | Élaborer un texte juridique pour la création et le fonctionnement du                                                                                                                                | Existence du décret portant création et fonctionnement du                                                                                                                           | Journal officiel de la République du Congo | DGSSSa<br>IGS            |

|  |  |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |                        |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|
|  |  | Programme National de la Santé Bucco-dentaire                                                                                                                       | Programme National de la Santé Bucco-dentaire                                                                                                                                                                                                                                         |                                            | DGAR                   |
|  |  | Rendre fonctionnel les organes de mise en œuvre du PNDS 2023-2026 à tous les niveaux du système de santé (national, départemental et périphérique) ;                | <p>Nombre d'organes de mise en œuvre du PNDS rendus fonctionnels au niveau central ;</p> <p>Nombre d'organes de mise en œuvre du PNDS rendus fonctionnels au niveau départemental ;</p> <p>Nombre d'organes de mise en œuvre du PNDS rendus fonctionnels au niveau périphérique ;</p> | Journal officiel de la République du Congo | DGSSSa<br>IGS          |
|  |  | Rendre fonctionnels les comités interministériels de la plateforme « Une seule Santé »                                                                              | Nombre des comités interministériels de la plateforme « Une seule Santé » rendus fonctionnels                                                                                                                                                                                         |                                            |                        |
|  |  | Mettre en place un cadre de concertation incluant tous les institutions impliquées dans la recherche en santé (santé ; enseignement supérieur : FSSA, IRSSA et INS) | Existence d'un cadre de concertation incluant tous les institutions impliquées dans la recherche en santé                                                                                                                                                                             | Journal officiel de la république du Congo | DGSSSa<br>DISER<br>DEP |

|  |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                     |                     |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  |                                                                                                                                    | Elaborer le manuel de formation en Soins de Santé Primaire et en gestion des districts sanitaires                                                                                   | Disponibilité du manuel de formation en Soins de Santé Primaire et en gestion des DS                                | Manuel de formation en soins de santé primaire et en gestion des DS | DGSSSa              |
|  | <b>Mise en place des normes d'organisation et de fonctionnement des structures de santé à tous les niveaux du système de santé</b> | Elaborer les textes d'application sur l'organisation et le fonctionnement des organes de gestion sur la promotion de la santé                                                       | Existence des textes juridiques portant organisation et fonctionnement des directions rattachées à la DGSSSa        | Journal officiel de la République du Congo                          | DGSSSa<br>CTS-PNDS  |
|  |                                                                                                                                    | Finaliser l'élaboration du Code de santé publique (draft disponible)                                                                                                                | Existence du code de santé publique élaboré                                                                         | Document du code de santé publique                                  | DGSSSa              |
|  |                                                                                                                                    | Elaborer un manuel des normes d'organisation et de fonctionnement des formations sanitaires à tous les niveaux (indicateurs de performance pour CSI, HRD, HG, ECD, EGD, DDS inclus) | Disponibilité du manuel des normes d'organisation et de fonctionnement des formations sanitaires à tous les niveaux | Manuel des normes d'organisation et de fonctionnement.              | DGSSSa              |
|  |                                                                                                                                    | Élaborer un Plan Stratégique National de la santé buccodentaire                                                                                                                     | Existence d'un Plan Stratégique National de la santé buccodentaire                                                  | Plan Stratégique National de la santé buccodentaire validé          | UCPP<br>DEP         |
|  |                                                                                                                                    | Élaborer un Plan Stratégique National du Projet de Lutte Antivectorielle (PLAV)                                                                                                     | Existence d'un Plan Stratégique National du PLAV                                                                    | Plan Stratégique National du PLAV                                   | DEP<br>UCPP<br>PLAV |

|                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |                                                             |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                   |                                                                                                           | Elaborer et valider la stratégie de la coopération bi et multilatérale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Existence de la stratégie de coopération bi et multilatérale élaborée et validée | Document de la stratégie de coopération bi et multilatérale | Direction de la Coopération                  |
|                                                                                                                                   |                                                                                                           | Elaborer un Plan Stratégique National sur la Promotion de la Santé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Existence d'un Plan Stratégique National sur la Promotion de la Santé            | Plan stratégique national sur la Promotion de la Santé      | DGSSSa<br>DEP                                |
| <b>Résultat attendu n°2 :<br/>Les organes de pilotage, de coordination et de partenariat à tous les niveaux sont fonctionnels</b> | <b>Renforcement des capacités managériales des organes de pilotage, de coordination et de partenariat</b> | Organiser trois (3) sessions de formation en management pour les membres des organes de pilotage, de coordination et de partenariat.<br><br><i><b>NB :</b> 1 session pour les DDSSSa /DDPOP de la zone nord (Cuvette, Cuvette ouest, Likouala, Plateaux, Sangha) ; 1 session pour les DDSSSa/DDPOP de la zone centre (Brazzaville et Pool) ; 1 session pour les DDSSSa /DDPOP de la zone sud (Bouenza, Kouilou, Lékoumou, Niari, Pointe-Noire)</i> | Nombre de sessions de formation organisées en management                         | Rapports de formation                                       | DEP<br>Direction de la Coopération<br>DGSSSa |
|                                                                                                                                   |                                                                                                           | Redynamiser les sessions de dialogue politique en santé à tous les niveaux du système de santé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nombre de sessions de dialogue politique en santé redynamisées.                  | Rapport DEP                                                 | DEP<br>CTS-PNDS                              |

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                  |                                                 |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Résultat attendu n°3 :<br/>Le processus de planification stratégique et opérationnelle est amélioré à tous les niveaux du système de santé</b> | <b>Renforcement des capacités managériales (planification, suivi, supervision et évaluation) à tous les niveaux du système de santé</b> | Elaborer un référentiel de formation sur la gestion axée sur les résultats (GAR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Disponibilité du référentiel de formation sur la GAR                                                                             | Document du Référentiel de formation sur la GAR | DEP<br>CTS-PNDS<br>DGSSSa |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         | Organiser quatre (4) sessions de formation sur la planification, le suivi et l'évaluation à tous les niveaux du système de santé<br><br><i><b>NB :</b> 1 session pour le niveau central ; 1 session pour les DDSSSa /DDPOP de la zone nord (Cuvette, Cuvette ouest, Likouala, Plateaux, Sangha) ; 1 session pour les DDSSSa/DDPOP de la zone centre (Brazzaville et Pool) ; 1 session pour les DDSSSa /DDPOP de la zone sud (Bouenza, Kouilou, Lékoumou, Niari, Pointe-Noire).</i> | Nombre de sessions de formation organisées sur la planification, le suivi et l'évaluation à tous les niveaux du système de santé | Rapport de formation DEP/UCPP                   | CABINET<br>DEP<br>UCPP    |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         | Organiser les sessions d'élaboration ou de révision des plans des structures de santé pour les alignés au PNDS 2023-2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | % de structures de santé ayant des plans alignés au PNDS 2023-2026                                                               | Rapport DEP/UCPP                                | DEP<br>CTS-PNDS           |

|  |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                          |     |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|  | <b>Renforcement des mécanismes de suivi et d'évaluation des plans opérationnels annuels et du plan global</b> | Organiser chaque fin du mois une réunion de suivi des indicateurs ( <i>12 réunions/an x 4 pour la période de mise en œuvre du PNDS</i> )                                               | % de structures de santé ayant organisé chaque fin du mois une réunion de suivi des indicateurs                                               | Rapport de suivi des indicateurs de suivi                                                | DEP |
|  |                                                                                                               | Organiser la revue à mi-parcours de la mise en œuvre des PTAB pour chaque structure mettant en œuvre le PNDS (en fin juin de chaque année)                                             | % de structures de santé ayant organisé une revue à mi-parcours de la mise en œuvre de leur PTAB (en fin juin de chaque année)                | Rapport de l'évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre des PTAB des structures du MSP | DEP |
|  |                                                                                                               | Organiser la revue annuelle de la mise en œuvre des PTAB pour chaque structure mettant en œuvre le PNDS (1 fois par an en fin décembre de chaque année) et planification des priorités | Disponibilité du rapport d'évaluation annuelle de la mise en œuvre des PTAB des structures du Ministère de la santé et de la population (MSP) | Rapports d'évaluation annuelle de la mise en œuvre des PTAB des structures du MSP        | DEP |
|  |                                                                                                               | Produire les indicateurs d'appréciation de mise en œuvre du PNDS par les directions départementales de la santé                                                                        | Disponibilité des indicateurs d'appréciation de mise en œuvre du PNDS au niveau des DDSSSa                                                    | Document des normes et procédures                                                        | DEP |
|  |                                                                                                               | Organiser les évaluations à mi-parcours et finale de la mise en œuvre du PNDS 2023-2026 (septembre à décembre 2024)                                                                    | Rapport de la RAMP disponible ;                                                                                                               | Rapport RAMP du PNDS 2023-2026                                                           | DEP |



|                                                                                                           |                                                                 |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                           |                                                                 | pour la RAMP et juin à septembre 2026 pour l'évaluation finale)                                                                                                                 | Rapport de l'évaluation finale du PNDS 2023-2026 disponible                                                                                                                                                                                                               | Rapport évaluation finale du PNDS 2023-2026 |                |
| <b>Résultat attendu n°4 :<br/>Les effectifs des RHS en termes de quantité et qualité sont équilibrés</b>  | <b>Renforcement de la gestion orthodoxe des RHS</b>             | Répartir équitablement les RHS entre le milieu rural et le milieu urbain selon la loi sur la décentralisation (fonction publique territoriale)                                  | Ratio médecin, infirmier, sage-femme sur population                                                                                                                                                                                                                       | Rapport DGAR                                | DGAR<br>DGSSSa |
|                                                                                                           |                                                                 | Élaborer un plan de recrutement des RHS (2023-2026)                                                                                                                             | Existence d'un plan de recrutement des RHS                                                                                                                                                                                                                                | Plan de recrutement des RHS validé          | DGAR           |
|                                                                                                           |                                                                 | Élaborer un plan de formation continue des RHS                                                                                                                                  | Existence d'un plan de formation continue des RHS                                                                                                                                                                                                                         | Plan de formation continue validé           | DGAR           |
| <b>Résultat attendu n°5 :<br/>Le financement de la santé en termes de quantité et qualité est adéquat</b> | <b>Ressources financières consacrées au secteur de la santé</b> | Réviser les mécanismes d'attribution des budgets selon les besoins de chaque niveau de la pyramide sanitaire (plus de 30% du budget du MSP pour les structures opérationnelles) | Part du budget alloué au MSP par rapport au budget national ;<br><br>Taux de décaissement du budget de l'état pour l'ensemble des structures du MSP ;<br><br>% des FOSA ayant signé une convention avec la CAMU ;<br><br>Part des ménages dans le financement de la santé | Rapport financier                           | DEP            |

|                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                                                   |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                         | Intégrer le FBP dans toutes les formations sanitaires des 27 districts sanitaires restants                                                                 | % des formations sanitaires ayant intégrées le FBP comme mode de financement                          | Rapport des districts sanitaires                                  | DEP<br>UCPP          |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                         | Acquérir les médicaments des initiatives de gratuité (vaccins, ARV, réactifs des examens de laboratoire, kits césarienne, antituberculeux, antipaludiques) | Nombre de jours de rupture des médicaments                                                            | Rapports financiers ; Comptes de la santé                         | CAMEPS<br>DPM<br>DEP |
|                                                                                                                                           | <b>Mobilisation des fonds additionnels par la mise en place des financements innovants pour combler le gap de financement de l'Etat</b> | Renforcer la mobilisation des fonds issus des financements innovants (taxes sur le tabac, l'alcool, ...)                                                   | Nombre de textes d'application des taxes concernées élaborés                                          | Journal officiel                                                  | DEP                  |
| <b>Résultat attendu n°6 :<br/>Le système d'information sanitaire permettant la planification, le suivi et l'évaluation est performant</b> | <b>Renforcement du Système National d'Information Sanitaire (SNIS)</b>                                                                  | Evaluer l'applicabilité du plan stratégique de développement du SNIS                                                                                       | Disponibilité du rapport d'évaluation de l'applicabilité du plan stratégique de développement du SNIS | Rapport d'évaluation du plan stratégique de développement du SNIS | DISER<br>DTIC<br>DEP |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                         | Etendre le DHIS2 dans l'ensemble des structures de santé à tous les niveaux                                                                                | %des FOSA publiques utilisant le DHIS2 ;<br>% des FOSA privées utilisant le DHIS2                     | Rapports du SNIS                                                  | DTIC<br>DISER        |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                         | Déployer le Système d'Information de Gestion Logistique (SIGL) au niveau périphérique                                                                      | Pourcentage des structures de santé utilisant le SIGL                                                 | Rapport de la DTIC ;<br>Rapport des FOSA (HRD et HG)              | DTIC<br>DGSSSa       |

|                                                                                                                  |                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                  |                                           | Mettre en place le dossier médical type CMO électronique                                                                                                                  | Dossier médical électronique mis en place (préalable : informatisation de la gestion des données dans toutes les FOSA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rapport du SNIS, Rapports des FOSA (HRD, HG) | DTIC<br>DISER<br>DGSSSa |
|                                                                                                                  |                                           | Organiser 4 sessions de formations techniques et opérationnelles des agents impliqués dans la collecte, l'analyse des données et l'utilisation de l'information sanitaire | Nombre de sessions de formations organisées sur la collecte, l'analyse et l'utilisation de l'information sanitaire.<br><b>NB : 1 session pour le niveau central ; 1 session pour les DDSSSa /DDPOP de la zone nord (Cuvette, Cuvette ouest, Likouala, Plateaux, Sangha) ; 1 session pour les DDSSSa/DDPOP de la zone centre (Brazzaville et Pool) ; 1 session pour les DDSSSa /DDPOP de la zone sud (Bouenza, Kouilou, Lékoumou, Niari, Pointe-Noire).</b> | Rapport de formation                         | DEP<br>DISER<br>DTIC    |
| <b>Résultat attendu n°7 :<br/>Le système de santé dispose d'une infrastructure informatique de communication</b> | <b>Digitalisation du système de santé</b> | Élaborer la feuille de route de la stratégie « e-santé ».                                                                                                                 | Disponibilité de la feuille de route                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Feuille de route de la stratégie e-santé     | DTIC<br>DEP             |
|                                                                                                                  |                                           | Evaluer la mise en œuvre de la stratégie « e-santé » à tous les niveaux du système de santé                                                                               | Disponibilité du Rapport d'évaluation de la mise en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rapport d'évaluation de la stratégie e-santé | DTIC<br>DEP             |

|                                                                                                                       |  |                                                                                                                                        |                                                                                                                               |                                                                  |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>supportant les principaux sous systèmes d'informations sanitaires digitalisés et interfacés les uns aux autres</b> |  | (1 évaluation en 2024 et 1 en 2026)                                                                                                    | œuvre de la stratégie e-santé                                                                                                 |                                                                  |                |
|                                                                                                                       |  | Élaborer la stratégie de communication du MSP                                                                                          | Existence de la stratégie de communication du MSP                                                                             | Document de la stratégie de communication du MSP                 | DTIC           |
|                                                                                                                       |  | Mettre en place le système de gestion électronique des situations d'urgence interconnecté avec le DHIS2                                | % de FOSA utilisant le système de gestion des situations d'urgences                                                           | Logiciel de gestion des situations d'urgence<br>DHIS2            | DTIC<br>DGSSSa |
|                                                                                                                       |  | Mettre en place le système de gestion électronique des ressources humaines de la santé interconnecté avec le DHIS2                     | Nombre de directions départementales et hôpitaux généraux utilisant le système de gestion des ressources humaines de la santé | Logiciel de gestion des ressources humaines de la santé<br>DHIS2 | DTIC<br>DGAR   |
|                                                                                                                       |  | Mettre en place le système de gestion hospitalière électronique intégrant le dossier médical du patient et interconnecté avec le DHIS2 | Existence d'un système de gestion hospitalière électronique                                                                   | Logiciel de gestion hospitalier<br>DHIS2                         | DGSSSa<br>DTIC |
|                                                                                                                       |  | Digitaliser les FOSA publiques                                                                                                         | Nombre d'hôpitaux généraux publics digitalisés ;<br>Nombre d'HRD digitalisés ;<br>Pourcentage des CSI publics digitalisés     | Rapport d'activités de la DTIC                                   | DTIC<br>DEP    |

|                                                                                               |                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                        |                              |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Résultat attendu n °8 : Régularité dans la réalisation des études, enquêtes et recherches     | Etudes et enquêtes dans le domaine de la recherche en santé           | Renforcer les capacités des acteurs chargés de la réalisation des études, en collaboration avec les autres Institutions (IRSSA, FSSA, INS etc...)                            | Nombre des acteurs en charge de la réalisation des études dont les capacités sont renforcées                                                                                           | Rapport de formation         | DEP                                  |
|                                                                                               |                                                                       | Réaliser les enquêtes (EDS, MICS, HHFA (ex SARA), carte sanitaire, comptes nationaux, annuaire statistique sanitaire, enquête SMART, enquête nationale couverture vaccinale) | Nbre d'enquêtes réalisées (EDS, MICS, ECOM, HHFA (ex SARA), carte sanitaire, comptes nationaux, annuaire statistique sanitaire, enquête SMART, enquête nationale couverture vaccinale) | Rapports d'enquêtes          | DEP<br>DGSSSa<br>DISER<br>PEV<br>INS |
| Sous-programme 1.2 : Amélioration de la coordination et du partenariat du secteur de la santé |                                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                        |                              |                                      |
| Résultats attendus                                                                            | Lignes d'actions prioritaires                                         | Contenu des lignes d'actions                                                                                                                                                 | Indicateurs de suivi                                                                                                                                                                   | Source de vérification       | Structures responsables              |
| Résultat attendu n°9 : La coordination et le partenariat du secteur sont renforcés            | Renforcement de la coordination et du partenariat du système de santé | Organiser régulièrement les réunions du Conseil national de santé                                                                                                            | Nombre de réunions du Conseil national de santé tenues                                                                                                                                 | Comptes rendus               | Cabinet MSP<br>IGS<br>DEP            |
|                                                                                               |                                                                       | Organiser régulièrement les réunions de CCIA                                                                                                                                 | Nombre de réunions tenues sur le nombre de réunions planifiées par le CCIA                                                                                                             | Comptes rendus               | PEV                                  |
|                                                                                               |                                                                       | Organiser 4 assemblées générales du fonctionnement du CCN par an                                                                                                             | Nombre d'assemblées générales tenues sur le nombre d'assemblées                                                                                                                        | Comptes rendus/Procès-verbal | DEP<br>CCN                           |

|  |  |                                                                                                                |                                 |                |      |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|------|
|  |  |                                                                                                                | générales planifiées par le CCN |                |      |
|  |  | Organiser régulièrement les réunions de la plateforme de production des RHS avec tous les ministères impliqués | Nombre de réunions tenues       | Comptes rendus | DGAR |

| Programme n°2 : Promotion d'un meilleur état de santé et du bien-être de la population                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |                                                                                         |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Sous-programme 2.1 : Amélioration de la gouvernance et du pilotage de la promotion de la santé                                                     |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |                                                                                         |                         |
| Résultats attendus                                                                                                                                 | Lignes d'actions prioritaires                                                                          | Contenu des lignes d'actions                                                                                                                                                        | Indicateurs de suivi                                                                 | Source de vérification                                                                  | Structures responsables |
| <b>Résultat attendu n°1 :<br/>La gouvernance et le pilotage en promotion de la santé sont renforcés</b>                                            | <b>Renforcement de la gouvernance en promotion de la santé</b>                                         | Elaborer la stratégie nationale de la promotion de la santé                                                                                                                         | Existence d'une stratégie nationale de la promotion de la santé                      | Document de la stratégie nationale de la promotion de la santé                          | CTS PNDS<br>DGSSSa      |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                        | Former les équipes chargées de la promotion de la santé                                                                                                                             | % des ECD disposant d'un personnel de santé formé sur la promotion de la santé       | Rapport de formation/DGSSSa                                                             | CTS PNDS<br>DGSSSa      |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                        | Assurer le suivi et la supervision formative des équipes de promotion de la santé dans les DS                                                                                       | Nombre de suivi et de supervision effectifs                                          | Rapport DGSSSa                                                                          | DGSSSa<br>DGPOP         |
| <b>Résultat attendu n°2 :<br/>Le cadre juridique et institutionnel relatif à la gestion de la santé environnementale est renforcé et harmonisé</b> | <b>Renforcement et harmonisation du cadre juridique et institutionnel de la santé environnementale</b> | Elaborer le code de l'hygiène publique                                                                                                                                              | Existence du code de l'hygiène publique                                              | Document du code de l'hygiène publique validé                                           | DGSSSa<br>DHPS          |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                        | Élaborer un guide de procédures et des directives de surveillance et de contrôle de la qualité du sol, de l'air ; de l'eau de boisson, des boissons, des aliments et des eaux usées | Existence d'un guide de procédures et des directives de surveillance et de contrôle. | Document du guide de procédures et des directives de surveillance et de contrôle validé | DGSSSa<br>DHPS          |

|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                        |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                      | <b>Mise en place des directives, normes et procédures de gestion de la santé environnementale en rapport avec le contexte actuel</b>                                                                                                                             | Élaborer un manuel des normes et des procédures de gestion de la santé environnementale                                                                                                                | Existence du manuel des normes et des procédures de gestion de la santé environnementale | Document normatif des normes et des procédures de gestion de la santé environnementale | DGSSSa<br>DHPS |
|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Former les comités d'hygiène en matière de santé environnementale                                                                                                                                      | Nombre de comités hygiène formés en matière de la santé environnementale                 | Rapport de formation                                                                   | DGSSSa<br>DHPS |
| <b>Résultat attendu n°3 : Les services d'hygiène disposent d'un laboratoire de l'hygiène publique d'analyses de l'eau de boisson, des aliments, des eaux usées et des contrôles environnementaux</b> | <b>Acquisition du matériel adéquat, des réactifs, des milieux de culture et d'autres fournitures nécessaires pour la surveillance et le contrôle de la qualité de l'eau, de l'air, du sol, de l'eau de boisson, des boissons, des aliments et des eaux usées</b> | Réhabiliter le laboratoire de l'hygiène publique                                                                                                                                                       | Existence d'un laboratoire de l'hygiène publique réhabilité                              | Rapport DGSSSa                                                                         | DGSSSa         |
|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Acquérir le matériel adéquat, les réactifs, les milieux de culture et autres fournitures pour la surveillance et le contrôle                                                                           | Disponibilité du matériel, des réactifs, des milieux de culture et autres fournitures    | Rapport DGSSSa                                                                         | DGSSSa<br>DHPS |
|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Élaborer un guide des modules de formation du personnel en matière de prélèvements, de mode opératoire et d'interprétation des résultats d'analyse de l'eau de boisson, des aliments et des eaux usées | Existence d'un guide des modules de formation                                            | Document du guide des modules de formation                                             | DGSSSa<br>DHPS |
| <b>Résultat attendu n °4 : La qualité de l'offre en</b>                                                                                                                                              | <b>Renforcement de la qualité de l'offre en matière de promotion de la santé</b>                                                                                                                                                                                 | Assurer la complétude du paquet des services en matière de promotion de la santé :                                                                                                                     | % de PTAB des 52 DS (208 au total en 3 ans) intégrant au moins une activité sur l'un ses | Rapport DGSSSa                                                                         | DGSSSa         |



|                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
|--------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <p><b>matière de promotion de la santé est améliorée</b></p> |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Paquet centré sur les maladies transmissibles prioritaires (Paludisme ; Maladies diarrhéiques ; IRA ; Parasitoses intestinales ; VIH/Sida et IST ; Tuberculose ; Hépatites ; Malnutrition ; Maladies Bucco-dentaires).</i></li> <li>- <i>Paquet centré sur les facteurs de risques des maladies non transmissibles prioritaires (Tabagisme ; Alcoolisme ; Inactivité physique ; Alimentation malsaine ; Pollution de l'air ; Traumatisme en rapport avec les accidents de voies publiques ; Toxicomanie).</i></li> <li>- <i>Paquet centré sur les maladies évitables par la vaccination prioritaires (Rougeole ; Cholera ; Poliomyélite ; Fièvre jaune ; Covid-19 ; Monkey pox).</i></li> <li>- <i>Paquet lié au marketing de l'offre des services publics (Promotion de la médecine traditionnelle)</i></li> <li>- <i>Paquet centré sur les Maladies Tropicales Négligées (Onchocercose ; Schistosomiase ; Trypanosomiase ; Lèpre, Pian et Ulcère de Buruli).</i></li> </ul> | <p>éléments du Paquet centré sur les facteurs de risques des maladies non transmissibles prioritaires dans la totalité de ses aires de santé ;</p> <p>% de PTAB des 52 DS (208 au total en 3 ans) intégrant au moins une activité sur l'un des éléments du Paquet centré sur les maladies évitables par la vaccination prioritaire dans la totalité de ses aires de santé ;</p> <p>% de PTAB des 52 DS (208 au total en 3 ans) intégrant au moins une activité sur l'un des éléments du Paquet centré sur les Maladies Tropicales Négligées (MTN) : Onchocercose ; Schistosomiase ; Trypanosomiase ; Lèpre ; Pian et Ulcère de Buruli</p> |  |  |
|--------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|  |                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |                                                                              |                                                           |                          |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
|  |                                                                                                             | Approvisionner les ECD en supports et outils pour la promotion de la santé                                                                                                 | % ECD dotées en supports et outils pour la promotion de la santé             | Rapports des DS<br>Rapport DGSSSa                         | DDSSSa                   |
|  |                                                                                                             | Intensifier la promotion de la planification familiale dans les milieux féminins (marchés, églises, entreprises, ministères et établissements scolaires et universitaires) | Taux de couverture en Planification Familiale dans chaque District Sanitaire | Rapports des DS<br>Rapport DGSSSa                         | DGPOP<br>DGSSSa          |
|  | <b>Acquisition des matériels et des équipements adéquats pour la gestion des déchets biomédicaux (GDBM)</b> | Réviser le document de gestion des déchets biomédicaux (GDBM)                                                                                                              | Disponibilité du document de gestion des déchets biomédicaux (GDBM) révisé   | Document de gestion des déchets biomédicaux (GDBM) révisé | DGSSSa<br>DHPS<br>PNLINO |
|  |                                                                                                             | Former le personnel de santé et les techniciens de surface des FOSA sur la GDBM                                                                                            | Nombre de personnel de santé et techniciens de surface formés en GDBM        | Rapport DGSSSa                                            | DGSSSa<br>DHPS<br>PNLINO |
|  |                                                                                                             | Doter les FOSA de matériels et des équipements nécessaires pour la GDBM (EPI, Boîtes de sécurité, poubelles, sacs poubelles, etc.)                                         | % des FOSA dotées en matériels e équipements de la GDBM                      | Rapport DGSSSa                                            | DGSSSa<br>DHPS<br>PNLINO |
|  |                                                                                                             | Construire les incinérateurs de Montfort dans les CSI à PMAE                                                                                                               | % des FOSA disposant des incinérateurs de Montfort par DS                    | Rapport DGSSSa                                            | DGSSSa<br>DHPS<br>PNLINO |
|  |                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |                                                                              |                                                           |                          |

|                                                                                                            |                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                 |                                |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                            |                                                                                    | Installer des incinérateurs modernes dans les HR et les HG                              | % des HR et HG dotés incinérateurs modernes                                                     | Rapport DGSSSa                 | DGSSSa<br>DHPS<br>PNLINO |
|                                                                                                            |                                                                                    | Doter les FOSA des installations sanitaires répondant aux normes et standards           | % des FOSA disposant des installations sanitaires qui répondent aux normes et standards         | Rapport DGSSSa                 | DGSSSa<br>DHPS<br>PNLINO |
|                                                                                                            |                                                                                    | Construire des stations d'épuration des eaux usées (STEP) dans les HR et HG             | % des HR et HG dotés de stations d'épuration des eaux usées                                     | Rapport DGSSSa                 | DGSSSa<br>DHPS<br>PNLINO |
|                                                                                                            |                                                                                    | Construire les forages                                                                  | Nombre de forages construits                                                                    | Rapport DGSSSa                 | DGSSSa                   |
| Sous-programme 2.2 : Amélioration du cadre et/ ou mode de vie des populations                              |                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                 |                                |                          |
| Résultats attendus                                                                                         | Lignes d'actions prioritaires                                                      | Contenu des lignes d'actions                                                            | Indicateurs de suivi                                                                            | Source de vérification         | Structures responsables  |
| Résultat attendu n°5 :<br>L'implication de la communauté en matière de promotion de la santé est renforcée | Renforcement de l'implication de la communauté en matière de promotion de la santé | Élaborer la stratégie nationale de communication pour la promotion de la santé          | Existence de la stratégie nationale de communication pour la promotion de la santé              | Rapport DGSSSa                 | DGSSSa                   |
|                                                                                                            |                                                                                    | Former les RHS de DS en techniques de communication en matière de promotion de la santé | Nombre de DS ayant des RHS formées en techniques de communication pour la promotion de la santé | Rapport DGAR<br>Rapport DGSSSa | DGAR<br>DGSSSa           |

|  |  |                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                                 |                 |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
|  |  | Former les équipes de DDSSSa et DDPOP sur l'auto responsabilité et l'autodétermination des communautés dans la gestion de leur santé | Nombre des ECD et EGD formés sur l'auto responsabilité et l'autodétermination des communautés dans la gestion de leur santé | Rapport DGSSSa<br>Rapport DGPOP | DGSSSa<br>DGPOP |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|

| Programme n°3 : Amélioration de l'accès équitable des populations aux paquets de services essentiels de qualité                                                      |                                                |                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                        |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Sous-programme 3.1 : Renforcement de l'offre de soins et services de santé                                                                                           |                                                |                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                        |                         |
| Résultats attendus                                                                                                                                                   | Lignes d'actions prioritaires                  | Contenu des lignes d'actions                                                                                  | Indicateurs de suivi                                                                                                   | Source de vérification                                                 | Structures responsables |
| <b>Résultat attendu n°1 :<br/>La couverture du pays en DS ayant une équipe cadre de district et une équipe de gestion fonctionnant dans les normes est améliorée</b> | <b>Revitalisation des districts sanitaires</b> | Former les membres des 52 équipes cadres de district (ECD) sur le développement d'un district sanitaire (DS)  | Nombre des équipes cadres de district (ECD) ayant des membres formés sur le développement d'un district sanitaire (DS) | Rapport de formation sur le développement d'un district sanitaire (DS) | DGAR<br>DGSSSa          |
|                                                                                                                                                                      |                                                | Elaborer les pré-plans de couverture des 52 DS par découpage des DS en aires de santé.                        | Nombre de DS ayant élaboré un pré-plan de couverture par découpage du district sanitaire en Aires de Santé             | Différents pré-plans des couvertures des DS en AS                      | DGSSSa                  |
|                                                                                                                                                                      |                                                | Acquérir 4 unités de cliniques mobiles                                                                        | Nombre d'unités de cliniques mobiles acquises                                                                          | Procès-verbaux de réception                                            | DEP<br>DGAR             |
|                                                                                                                                                                      |                                                | Doter des moyens roulants, nautiques et autres équipements bureautiques dans 52 DS                            | % de DS possédant au moins 1 moyen de supervision                                                                      | Procès-verbaux de réception des moyens de supervision                  | DEP<br>DGAR             |
|                                                                                                                                                                      |                                                | Aménager 4 services clés (maternité, Bloc opératoires, services des urgences et laboratoires) des 51 hôpitaux | Nombre de services clés aménagés                                                                                       | Rapport des travaux                                                    | DEP<br>DGAR             |

|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                            |                                          |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   | de district, y compris leur équipement                                                                    |                                                                            |                                          |                       |
|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   | Construire et équiper 6 centres de santé de prise en charge des malades mentaux                           | Nombre de centres de santé construits et équipés                           | Rapport des travaux de finition          | DGAR<br>DGSSSa<br>DEP |
|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   | Construire et équiper 5 centres de prise en charge des personnes âgées                                    | Nombre de centres de santé construits et équipés                           | Rapport des travaux de finition          | DGAR<br>DGSSSa<br>DEP |
| <b>Résultat attendu n°2 :<br/>La couverture sanitaire du pays en services de santé de premier échelon (SSPE) capables d'offrir les paquets des services essentiels est améliorée</b> | <b>Développement les aires de santé conformément au plan de couverture des 52 DS (PSE conformément aux normes du système de santé intégré de district (SSID))</b> | Elaborer un document de nomenclature des actes et de leur tarification                                    | Existence d'un document de nomenclature des actes et de leur tarification  | Document de nomenclature des actes       | DGSSSa                |
|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   | Réhabiliter 150 CSI dans les 52 DS, y compris leur équipement                                             | Nombre de CSI réhabilités et équipés                                       | Procès-verbaux de réception des ouvrages | DEP<br>DGAR           |
|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   | Organiser les ateliers de formation des prestataires de CSI sur des activités de soins de santé primaires | % des prestataires de CSI formés aux activités de soins de santé primaires | Rapports de formation                    | DGSSSa<br>DGPOP       |
|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   | Développer au moins 25% des aires de santé de chaque DS                                                   | % des aires de santé développées dans chaque DS                            | Rapports d'activités                     | DGSSSa                |

|  |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                   |                      |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                   | Intégrer/décentraliser les techniques de base de la prise en charge de certaines maladies non transmissibles (HTA/AVC, diabète, lésions précancéreuses) et des maladies mentales dans le PMA de services de santé de premier échelon. | % des maladies non transmissibles dont la prise en charge a été intégré dans le PMA de services de santé de premier échelon.<br><br>% des maladies mentales dont la prise en charge a été intégré dans le PMA de services de santé de premier échelon. | Rapport d'activités                                                               | DGSSSa               |
|  |                                                                                                                                                                                                   | Réaliser une supervision formative trimestrielle dans quelques CSI de chaque DS sur la prise en charge de certaines maladies non transmissibles par des spécialistes venus des hôpitaux généraux                                      | % des CSI ayant bénéficié d'une supervision par des spécialistes venus des hôpitaux généraux                                                                                                                                                           | Rapports de supervision réalisée par des spécialistes venus des hôpitaux généraux | DGSSSa               |
|  | <b>Instauration de l'approche « pangouvernementale » dans certains DS à faible indicateurs de santé, notamment dans les départements de la Likouala, du Pool, la Cuvette-ouest et la Lékoumou</b> | Tenir les réunions de suivi des indicateurs de performances et des revues périodiques chaque trimestre                                                                                                                                | Nombre des réunions de suivi des indicateurs de performances et des revues périodiques tenues par trimestre dans chaque DS                                                                                                                             | Comptes rendus des réunions relatives au suivi des indicateurs performances       | DGSSSa<br>DGPOP      |
|  |                                                                                                                                                                                                   | Réaliser une enquête partielle démographique de santé tous les 2 ans (2024 et 2026) dans les DS évoluant dans le cadre de l'approche « pangouvernementale ».                                                                          | Nombre d'enquêtes partielles démographiques de santé réalisées                                                                                                                                                                                         | Rapports d'activités des DDSSSa,                                                  | DEP<br>INS<br>DGSSSa |

|  |                                                                                             |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |              |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|
|  | <b>Mise en place de l'approche de la santé à base communautaire dans les aires de santé</b> | Former les 12 DDSSSa, les 12 DDPOP et les 52 médecins – chefs des équipes cadre de DS sur l'offre de paquets de service de santé à base communautaire                             | <p>Nombre des DDSSSa formées sur l'offre de paquets de service de santé à base communautaire ;</p> <p>Nombre des DDPOP formées sur l'offre de paquets de service de santé à base communautaire ;</p> <p>Nombre des médecins chefs des équipes cadres formées sur l'offre de paquets de service de santé à base communautaire.</p> | Rapports de formation        | DGSSSa DDPOP |
|  |                                                                                             | Former les relais communautaires sur l'offre de paquets de service de santé à base communautaire                                                                                  | % d'aires de santé disposant au moins d'un binôme de relais communautaires formés                                                                                                                                                                                                                                                 | Rapports des DDSSSa et DDPOP | DGSSSa DDPOP |
|  |                                                                                             | Créer un réseau de clubs de dialogue sur l'autonomisation communautaire dans la gestion des pathologies chroniques (HTA, Diabète, Cancer et tuberculose) et la santé reproductive | % d'aires de santé faisant partie d'un club de dialogue sur l'autonomisation                                                                                                                                                                                                                                                      | Rapports des DDSSSa et DDPOP | DGSSSa DDPOP |



|                                                                                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Résultat attendu n°3 :<br/>La couverture sanitaire<br/>du pays en hôpitaux de<br/>district capables d'offrir<br/>des soins d'urgences 24<br/>h/24 est améliorée</b> | <b>Amélioration de l'offre du<br/>PCA des 31 FOSA de<br/>première référence<br/>(hôpitaux de district)</b> | Réhabiliter :<br>31 maternités,<br>31 services d'accueil et<br>urgences<br>31 blocs opératoires, y<br>compris leur équipement                                                                                    | Nombre d'hôpitaux de<br>référence ayant bénéficié<br>de la réhabilitation de<br>leurs maternités (34<br>hôpitaux) ;<br>% de services d'accueil-<br>urgences réhabilités<br>% de blocs opératoires<br>réhabilités ; | Procès-verbaux de<br>réception des<br>ouvrages ;<br>Rapport des travaux<br>de réhabilitation | DGAR<br>DEP           |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                            | Transformer 22 CSI à PMAE en<br>structures de santé capables<br>de servir de FOSA de référence<br>dans les DS sans hôpital de<br>district (capables de prendre<br>en charge des urgences<br>médicochirurgicales) | % de CSI à PMAE<br>transformés en FOSA<br>capables de servir de<br>FOSA de référence dans<br>les DS sans hôpital de<br>district                                                                                    | Rapport d'évaluation                                                                         | DGSSSa<br>DEP<br>DGAR |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                            | Equiper 31 laboratoires en<br>matériel basique en vue<br>d'offrir les examens basiques<br>(automate d'hématologie,<br>automate de biochimie,<br>automate d'immunologie,<br>microscope binoculaire)               | % de laboratoire dotés<br>en matériel basique en<br>vue d'offrir les examens<br>basiques                                                                                                                           | Procès-verbaux de<br>réception des<br>ouvrages                                               | DEP<br>DGAR           |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                            | Acquérir des équipements<br>d'imagerie dans les 12<br>hôpitaux de districts                                                                                                                                      | Nombre d'hôpitaux de<br>district équipés en<br>matériel d'imagerie<br>médicale                                                                                                                                     | Procès-verbaux de<br>réception                                                               | DEP<br>DGAR           |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                            | Intégrer l'usage des trois types<br>d'outils (Schémas<br>thérapeutiques standardisés,                                                                                                                            | Nombre d'hôpitaux de<br>référence ayant intégré<br>l'usage des trois types                                                                                                                                         | Rapport d'activités                                                                          | DGPOP                 |

|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |                                                             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        | partogrammes, directives, document d'auto-évaluation de la qualité des SONUC) dans les 34 hôpitaux de référence                                                                                                                                                                                         | d'outils : schémas thérapeutiques standardisés, partogrammes et outils d'auto-évaluation des soins obstétricaux néonataux d'urgence (34 Hôpitaux) |                                                             |             |
|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        | Elaborer un guide national de référence et de contre référence                                                                                                                                                                                                                                          | Existence d'un guide national de référence et contre référence                                                                                    | Document du guide national de référence et contre référence | DGSSSa      |
|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        | Organiser les ateliers de formations des prestataires des services des maternités, des services d'accueil-urgences, des pharmacies et des blocs opératoires sur l'offre des prestations d'un PCA (SONUC, PCIMNE, Schémas thérapeutiques standardisés, gestion des médicament, SNIS, supervision, etc.). | Nombre d'ateliers de formations des prestataires des soins et services organisés sur l'offre des prestations d'un PCA ;                           | Rapports de formation                                       | DGSSSa      |
| <b>Résultat attendu n°4 : La couverture sanitaire du pays en établissements capables d'offrir les soins de spécialités essentiels de qualité et à moindre coût est améliorée</b> | <b>Finalisation des travaux de construction de 8 HG départementaux (2 par an) y compris le Maintien des HG préexistants (CHU de Brazzaville, Dolisie, 31 juillet Owando, Adolphe Sicé, Loandjili et Blanche Gomes)</b> | Achever les travaux de construction de deux (2) unités d'hémodialyse : 1 au CHU de Brazzaville et 1 à l'HG Adolphe Sicé de Pointe-Noire                                                                                                                                                                 | Nombre d'unités d'hémodialyse fonctionnelles                                                                                                      | Rapport de travaux de finition                              | DEP<br>DGAR |
|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        | Achever l'unité de néphrologie du CHU de Brazzaville, y compris son équipement                                                                                                                                                                                                                          | Disponibilité du service de néphrologie du CHU                                                                                                    | Rapport de travaux de finition                              | DEP<br>DGAR |

|  |  |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |                                |             |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|
|  |  |                                                                                                                                                         | de Brazzaville, y compris son équipement                                                                                                                                                         |                                |             |
|  |  | Moderniser les services des urgences des 6 hôpitaux généraux préexistants (CHU-B, Dolisie, 31 juillet Owando, Adolphe Sicé, Loandjili et Blanche Gomes) | Nombre d'hôpitaux généraux dont les services des urgences ont été modernisés (6 hôpitaux : CHU-B, Dolisie, 31 juillet Owando, Adolphe Sicé, Loandjili et Blanche Gomes (6 hôpitaux généraux)     | Rapport de travaux de finition | DEP<br>DGAR |
|  |  | Achever les travaux de construction des 8 hôpitaux généraux départementaux                                                                              | Nombre d'hôpitaux généraux départementaux dont les travaux sont achevés.                                                                                                                         | Rapport travaux de finition    | DEP<br>DGAR |
|  |  | Doter les 8 hôpitaux généraux départementaux en équipements répondant aux normes                                                                        | Nombre d'hôpitaux généraux départementaux dotés d'un équipement répondant aux normes (8 hôpitaux généraux)                                                                                       | Procès-verbaux de réception    | DEP<br>DGAR |
|  |  | Doter les hôpitaux du matériel et équipements répondant aux normes de prise en charge de l'urgence médico-chirurgicale, pédiatrique et obstétricale     | Nombre d'hôpitaux généraux dotés en équipements répondant aux normes de prise en charge des urgences médico-chirurgicales pédiatriques et obstétricales (6 hôpitaux : CHU-B, Dolisie, 31 juillet | Procès-verbaux de réception    | DEP<br>DGAR |

|                                                                                               |                                                                          |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                                                    |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                               |                                                                          |                                                                                                                                                                  | Owando, Adolphe Sicé, Loandjili et Blanche Gomes)                                                                                                                         |                                                    |                         |
|                                                                                               |                                                                          | Organiser 4 formations des prestataires de soins dans les hôpitaux sur l'accueil, la prise en charge humanisée des patients, la référence et la contre référence | Nombre des formations de prestataires de soins organisées dans les hôpitaux sur l'accueil, la prise en charge humanisée des patients, la référence et la contre référence | Rapport de formation                               | DGSSSa<br>DGPOP         |
|                                                                                               |                                                                          | Acquérir des équipements de biologie moléculaire de dépistage anténatale de la drépanocytose pour le CNRD                                                        | Disponibilité des équipements de biologie moléculaire de dépistage anténatale de la drépanocytose                                                                         | Procès-verbaux de réception                        | CNRD                    |
|                                                                                               |                                                                          | Acquérir des équipements d'hémoglobino (Capillarys, HPLC/Biorad) pour le CNRD                                                                                    | Disponibilité des équipements d'hémoglobino (Capillarys, HPLC/Biorad)                                                                                                     | Procès-verbaux de réception                        | DGAR<br>DEP<br>CNRD     |
|                                                                                               |                                                                          | Rendre opérationnel dans chaque DS le système de référence et contre référence                                                                                   | Nombre de DS disposant d'un système de référence et contre référence opérationnel                                                                                         | Rapport d'activités des DS                         | DGSSSa<br>DTS           |
| <b>Résultat attendu n°5 :<br/>L'accès aux médicaments, produits sanguins labiles, vaccins</b> | <b>Amélioration de l'accès des populations aux médicaments, vaccins,</b> | Actualiser la politique nationale des médicaments                                                                                                                | Existence de la politique nationale des médicaments actualisée                                                                                                            | Document de la Politique nationale des médicaments | DGSSSa<br>CAMEPS<br>DPM |

|                                                                 |                                         |                                                                                                                                  |                                                                                                       |                                                           |                  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|
| et technologies dans les structures de dispensation est garanti | autres produits de santé et technologie | Réviser une fois pendant la période de mise en œuvre du PNDS la liste nationale des médicaments essentiels et génériques (LNMEG) | Existence de la liste nationale des médicaments essentiels et génériques.                             | Liste nationale des médicaments essentiels et génériques. | CAMEPS<br>DPM    |
|                                                                 |                                         | Approvisionner les pharmacies de districts sanitaires en médicaments et produits de santé essentiels                             | % des fonds mobilisés/décaissés pour l'achat d'un stock de médicaments répondant aux besoins des FOSA | Compte financier de la CAMPES<br>Rapport de la CAMPES     | CAMEPS<br>DPM    |
|                                                                 |                                         |                                                                                                                                  | Nombre de jours de rupture de chaque antigène dans les dépôts départementaux du PEV                   | Rapport de la CAMPES                                      | CAMEPS<br>DPM    |
|                                                                 |                                         | Créer des dépôts relais départementaux                                                                                           | Nombre de dépôts de relais départementaux créés                                                       | Rapport d'activités                                       | DGSSSa<br>CAMEPS |
|                                                                 |                                         | Renforcer les capacités logistiques de la CAMEPS afin d'assumer ses missions d'approvisionnement des FOSA                        | Taux de satisfaction des besoins en produits sanguins sécurisés par les FOSA par département          | Bordereaux de livraison des FOSA                          | CAMEPS           |
|                                                                 |                                         | Réhabiliter des locaux pouvant abriter 51 pharmacies de DS                                                                       | Nombre de locaux pharmaceutiques des DS réhabilités                                                   | Rapport des travaux                                       | DEP<br>DGAR      |
|                                                                 |                                         | Doter 51 pharmacies de district en stocks de                                                                                     | % de DS ayant bénéficié d'un stock initial de MEG                                                     | Procès-verbaux de réception                               | CAMEPS<br>DEP    |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                |               |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  |  | médicaments essentiels et génériques (MEG)                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                |               |
|  |  | Actualiser les supports/outils standards de gestion des MEG dans les 51 pharmacies de DS                                                                                                                                                              | Disponibilité des outils standards de gestion des MEG actualisés.                                                                        | Rapport d'activités                                                            | DPM           |
|  |  | Actualiser les fiches de poste de responsabilité pharmaceutique et les manuels des procédures (pour les techniques d'approvisionnement, le stockage et la distribution des produits de santé ainsi que les procédures administratives et financières) | Disponibilités des fiches de poste et manuels des procédures actualisés                                                                  | Fiches des postes de responsabilité pharmaceutique ;<br>Manuels des procédures | DPM<br>CAMEPS |
|  |  | Mettre en place la pharmacie à usage interne dans 71 FOSA                                                                                                                                                                                             | Nombre des FOSA ayant mis en place la pharmacie à usage interne                                                                          | Rapport d'activités                                                            | DPM           |
|  |  | Elaborer un guide national de gestion pharmaceutique                                                                                                                                                                                                  | Existence d'un guide national de gestion pharmaceutique                                                                                  | Document du guide national de gestion pharmaceutique                           | DPM           |
|  |  | Mettre en place 71 chariots d'urgences contenant des médicaments de première nécessité dans les services d'urgences des 50 FOSA                                                                                                                       | Nombre des FOSA ayant mis en place des chariots d'urgence contenant des médicaments de première nécessité dans leurs services d'urgences | Rapports d'activités                                                           | DGSSSa        |

|  |                                                                             |                                                                                                                                                    |                                                                                                                |                                                                                 |                          |
|--|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  |                                                                             | Mettre en place la commission d'homologation des médicaments, autres produits de santé et technologie                                              | Existence d'une commission d'homologation des médicaments                                                      | Note de service mettant en place la commission d'homologation des médicaments ; | DGSSSa<br>DPM            |
|  |                                                                             | Élaborer une stratégie d'encadrement de la pharmacopée utilisée dans la médecine traditionnelle                                                    | Existence d'une stratégie d'encadrement de la pharmacopée.                                                     | Document de la stratégie d'encadrement de la pharmacopée ;                      | DGSSSa<br>DPM            |
|  |                                                                             | Élaborer une stratégie de lutte contre la résistance aux antibiotiques                                                                             | Existence d'une stratégie de lutte contre la résistance aux antibiotiques                                      | Document de la stratégie de lutte contre la résistance aux antibiotiques        | DGSSSa<br>DPM            |
|  |                                                                             | Créer une Autorité Nationale de régulation des Médicaments ou ANR (suite logique signature Traité portant création Agence Africaine du Médicament) | Existence d'un décret portant création et fonctionnement de l'Autorité Nationale de Régulation des Médicaments | Journal Officiel                                                                | CABINET<br>DGSSSa<br>DPM |
|  |                                                                             | Créer des laboratoires de contrôle qualité (des médicaments, des aliments et de l'eau)                                                             | Existence des textes juridiques portant création et fonctionnement des laboratoires de contrôle qualité ;      | Journal Officiel                                                                | CABINET<br>IGS           |
|  | <b>Amélioration de l'accès des patients aux produits sanguins sécurisés</b> | Augmenter le nombre de structures de dispensation des produits sanguins sécurisés (de 44 à 52 PTS)                                                 | Nombre de structures de dispensation des produits sanguins supplémentaires créés,                              | Rapport d'activités                                                             | CNTS                     |

|  |  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                            |      |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|  |  | Valider la stratégie nationale de la promotion du don de sang et du référentiel sur les bonnes pratiques de la transfusion sanguine (normes ISO sur la transfusion sanguine) | Existence de la stratégie nationale de la promotion du don de sang et du référentiel.                     | Document de la stratégie nationale de la promotion du don de sang et du référentiel validé | CNTS |
|  |  | Organiser une soirée de téléthon chaque année pour mobiliser les financements innovants nécessaires au renforcement de la chaîne de froid et à l'acquisition des intrants    | Nombre de soirée de téléthon organisé pendant la période de mise en œuvre du PNDS 2023-2026               | Comptes rendus de la soirée ;                                                              | CNTS |
|  |  | Améliorer le niveau du plateau technique du CNTS, y compris les réactifs et autres intrants                                                                                  | Disponibilité du plateau technique performant au sein du CNTS, y compris les réactifs et autres intrants. | Procès-verbal de réception des équipements, y compris les réactifs et autres intrants      | CNTS |
|  |  | Acquérir des moyens logistiques pour augmenter les capacités de production de sang.                                                                                          | Nombre de véhicules acquis                                                                                | Procès-Verbal de réception                                                                 | CNTS |



|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                                            | <b>Approvisionnement en vaccins et intrants nécessaires aux activités d'immunisation des cibles</b><br>(Amélioration la disponibilité des vaccins et intrants nécessaires aux activités d'immunisation des populations cibles) | Doter les centres fixes de vaccination publics et privés en chaîne de froid dans les centres fixes de vaccination                                                | % de centres fixes de vaccination publics disposant d'une chaîne de froid aux normes PQS renouvelé ;<br><br>% de centres fixes de vaccination privés disposant d'une chaîne de froid aux normes Performance Qualité et Sécurité (PQS) renouvelé | Rapport du PEV                                                                   | PEV                        |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                | Approvisionner régulièrement les dépôts départementaux en vaccins (une fois par trimestre, soit 4 fois par an).                                                  | Nombre de jours de rupture de chaque antigène dans les dépôts départementaux du PEV                                                                                                                                                             | Rapports des DDPOP<br><br>Rapports d'activités de DS                             | DGPOP<br><br>PEV<br>DGSSSa |
| <b>Résultat attendu n°6 : L'offre des analyses biomédicales est améliorée dans le pays</b> | <b>Renforcement du plateau technique du LNSP pour être en conformité avec ses nouvelles missions de l'Institut National de Santé Publique</b>                                                                                  | Finaliser les études de faisabilité du projet QUANTUM                                                                                                            | Disponibilité des études de faisabilité                                                                                                                                                                                                         | Document d'études de faisabilité du projet                                       | DGSSSa                     |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                | Renouveler les équipements du LNSP pour être conforme aux standards internationaux en matière de détection et de riposte face aux risques et urgences sanitaires | Nombre d'équipements du LNSP renouvelés                                                                                                                                                                                                         | Procès-verbaux de réception                                                      | LNSP                       |
|                                                                                            | <b>Renforcement de la qualité des laboratoires périphériques</b>                                                                                                                                                               | Elaborer un Manuel normatif de bonnes pratiques des techniques de laboratoires périphériques qui servira à la                                                    | Existence d'un manuel normatif de bonnes pratiques des techniques de laboratoires périphériques                                                                                                                                                 | Manuel normatif de bonnes pratiques des techniques de laboratoires périphériques | DGSSSa                     |

|                                                                                                                                                    |                                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                                                                           |                                                                                |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                 | régulation, à la supervision et au contrôle                                                   |                                                                                                                                           |                                                                                |                      |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                 | Organiser des missions d'appui technique chaque trimestre dans les laboratoires périphériques | Nombre de missions d'appui technique réalisées                                                                                            | Rapport de mission d'appui technique                                           | CABINET<br>DGSSSa    |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                 | Doter les laboratoires périphériques en équipements adéquats (104 à raisons de 2 par DS)      | % de laboratoires périphériques dotés en équipements adéquats (104 à raisons de 2 par DS)                                                 | Procès-verbal de réception                                                     | DGAR<br>DEP          |
| Sous-programme 3.2 : Amélioration de l'accès financier aux soins et services de santé des populations                                              |                                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                                                                           |                                                                                |                      |
| Résultat attendu n°7 :<br>La couverture des soins de santé des populations par l'assurance maladie universelle est améliorée à l'échelle nationale | Mise en exploitation de l'assurance maladie universelle destinée à couvrir toutes les catégories de populations | Elaborer les documents normatifs sur la nomenclature des actes et la tarification des soins   | Disponibilité des documents normatifs sur la nomenclature des actes et la tarification des soins                                          | Documents normatifs sur la nomenclature des actes et la tarification des soins | DEP                  |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                 | Mettre en place les critères d'accréditation des structures de santé                          | Disponibilité des critères d'accréditation des structures de santé                                                                        | Document des critères d'accréditation                                          | DGSSSa               |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                 | Suivre les FOSA conventionnées à la CAMU (évaluations périodiques)                            | Taux de couverture de la population par l'assurance maladie universelle ;<br><br>Nombre de structures de santé conventionnées par la CAMU | Rapport de suivi                                                               | DEP<br>DGSSSa<br>IGS |

|  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                                                                                               |                                                            |                 |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                         | Informatiser toutes les structures de santé conventionnées                                                          | Pourcentage des structures de santé informatisées                                                                                             | Rapport d'activités                                        | DGSSSa<br>DTIC  |
|  | <b>Mobilisation du financement de la vaccination, des urgences et catastrophes et des initiatives de gratuité ainsi que pour des médicaments essentiels génériques, réactifs, consommables et autres produits de santé de la CAMEPS</b> | Mettre en place des mécanismes de mobilisation des financements innovants de la santé                               | Nombre de taxes instituées sur les biens et produits de consommation                                                                          | Journal officiel                                           | DEP             |
|  |                                                                                                                                                                                                                                         | Sécuriser les fonds issus du recouvrement des coûts dans les structures de santé                                    | Nombre de structures de santé ayant mis en place des mesures de sécurisation des fonds (multiplicité des signatures pour la sortie des fonds) | Compte financier des structures de santé ;                 | DEP<br>IGS      |
|  |                                                                                                                                                                                                                                         | Sécuriser le financement des initiatives de gratuités                                                               | Part du budget du secteur santé décaissée pour les gratuités (multiplicité des signatures pour la sortie des fonds)                           | Compte financier des programmes                            | DEP<br>IGS      |
|  |                                                                                                                                                                                                                                         | Etendre l'approche de financement basée sur la performance (PBF) dans la motivation des prestataires dans les 52 DS | Pourcentage des structures de santé bénéficiant du PBF par DS                                                                                 | Rapport d'activités des DS ;<br>Rapport financier des DS ; | DGSSSa ;<br>DEP |

Sous-programme 3.3 : Renforcement des programmes de santé de la mère, de l'enfant, des jeunes et des adolescents

|                                                                                                                                           |                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                   |                                                                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Résultat attendu n°8 :<br/>La couverture du pays en FOSA offrant des soins et services de la reproduction de qualité est améliorée</b> | <b>Renforcement du suivi anténatal de la femme</b>  | Actualiser et valider le plan de repositionnement de la Planification Familiale (PF)                                                                                       | Existence du plan de repositionnement de la planification familiale (PF) actualisé et validé                      | Plan de repositionnement validé                                 | DGPOP<br>DGSSSa |
|                                                                                                                                           |                                                     | Poursuivre l'intégration de la PF dans tous les CSI publics, confessionnels et dans certaines FOSA privées dans les 52 DS (62,3% à 100%)                                   | % de FOSA de premier échelon offrant toutes les méthodes contraceptives modernes                                  | Rapports d'activités des DS                                     | DGPOP<br>DGSSSa |
|                                                                                                                                           |                                                     | Approvisionner régulièrement les FOSA en contraceptifs modernes et technologie (40,7% à 100%)                                                                              | Nombre de jours de ruptures pour chaque contraceptif dans les pharmacies de DS                                    | Rapports d'activités des DS                                     | DGPOP<br>DGSSSa |
|                                                                                                                                           |                                                     | Intensifier la promotion de la planification familiale dans les milieux féminins (marchés, églises, entreprises, ministères et établissements scolaires et universitaires) | Taux d'utilisation de la contraception moderne                                                                    | Rapports d'activités des DS                                     | DGPOP<br>DGSSSa |
|                                                                                                                                           | <b>Renforcement de la qualité du suivi prénatal</b> | Promouvoir l'application des normes et procédures, directives et outils du suivi prénatal                                                                                  | % de FOSA réalisant les soins prénataux selon les normes                                                          | Rapports d'activités des DS/DDSSSa<br>Rapport des enquêtes HHFA | DGPOP<br>DGSSSa |
|                                                                                                                                           |                                                     | Rendre disponible le paquet complet des moyens et intrants de prévention des pathologies intercurrentes de la femme enceinte dans toutes                                   | Proportion des femmes enceintes ayant bénéficié de la troisième dose de traitement préventif intermittent (TPI 3) | Rapports d'activités des DS/DDSSSa<br>Rapport des enquêtes HHFA | DGPOP<br>DGSSSa |

|  |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |                     |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  |                                                                                                 | les FOSA offrant les soins et services de suivi prénatal                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |                     |
|  |                                                                                                 | Augmenter la couverture des DS en FOSA offrant la PTME                                                                                              | % de FOSA publiques offrant les soins et services de suivi prénatal ayant intégré les activités de PTME<br><br>% de FOSA privées offrant les soins et services de suivi prénatal ayant intégré les activités de PTME | Rapports d'activités des DS/DDSSSa<br><br>Rapport des enquêtes HHFA | DGSSSa              |
|  |                                                                                                 | Doter l'ensemble des 52 DS des 12 DDSSSa en échographes afin de rendre accessible les examens de suivi prénatal y compris l'échographie             | % de femmes enceintes ayant bénéficié de tous les examens de suivi prénatal y compris l'échographie                                                                                                                  | Rapports d'activités des DS/DDSSSa<br><br>Rapport des enquêtes HHFA | DGSSSa              |
|  | <b>Promotion de l'accouchement propre et de qualité dans les FOSA offrant les accouchements</b> | Poursuivre la formation des prestataires des accouchements sur l'accouchement propre et sur les SONUB/SONUC (Likouala et Cuvette ouest en priorité) | Nombre des prestataires des accouchements formés sur les SONUB/SONUC et sur l'accouchement propre                                                                                                                    | Rapports d'activités des DS/DDSSSa<br><br>Rapport des enquêtes HHFA | DGPOP<br><br>DGSSSa |

|                                                                                                                                            |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                  |                                                                 |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                | Conduire (niveau central) 4 supervisions formatives par année des équipes chargées de la mise en œuvre du programme sur l'accouchement propre et sur les SONUB/SONUC | Nombre supervisions formatives réalisées par année auprès des équipes chargées de la mise en œuvre du programme sur l'accouchement propre et sur les SONUB/SONUC | Rapports d'activités des DS/DDSSSa<br>Rapport des enquêtes HHFA | DGPOP<br>DDPOP<br>DGSSSa |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                | Intégrer les audits des décès maternels et néonataux dans toutes les formations sanitaires publiques et privées et au niveau communautaire.                          | Nombre des audits des décès maternels et néonataux réalisés dans les formations sanitaires publiques et privées et au niveau communautaire                       | Rapports d'activités des DS/DDSSSa<br>Rapport des enquêtes HHFA | DGPOP<br>DGSSSa          |
| <b>Résultat attendu n°9 :<br/>La couverture en FOSA offrant les soins et services de santé des adolescents et les jeunes est améliorée</b> | <b>Amélioration de la qualité des soins curatifs de l'enfant dans les FOSA de 1<sup>er</sup> et de 2<sup>ème</sup> échelon</b> | Rendre disponible la PCIMNE dans tous les districts sanitaires, tant au niveau communautaire qu'institutionnel                                                       | Nombre des districts sanitaires ayant des FOSA de 1 <sup>er</sup> échelon faisant la PCIMNE                                                                      | Rapports d'activités des DS/DDSSSa<br>Rapport des enquêtes HHFA | DGSSSa<br>DGPOP          |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                | Généraliser la stratégie « Tri-Evaluation- Traitement – d'Urgence (TETU) » dans tous les hôpitaux de référence de district (HRD)                                     | % de HRD (FOSA de 2 <sup>ème</sup> échelon) appliquant le TETU dans chaque district sanitaire                                                                    | Rapports d'activités des DS/DDSSSa<br>Rapport des enquêtes HHFA | DGPOP<br>DGSSSa          |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                | Doter toutes les maternités en équipements de réanimation des nouveau-nés                                                                                            | % de maternités dotées des équipements de                                                                                                                        | Rapports d'activités des DS/DDSSSa                              | DEM<br>DEP               |

|  |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                        |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                        | réanimation des nouveau-nés                                                                                                                           | Rapport des enquêtes HHFA                                                                                                               |                        |
|  | <b>Amélioration de l'offre des services de vaccination, de supplémentation à la vitamine A et du déparasitage systématique</b> | Poursuivre l'intégration des services de vaccination de routine dans les FOSA privées de chaque DS                                                                                     | % de FOSA privées offrant les services de vaccination de routine dans chaque DS<br><br>Taux de couverture vaccinale DTC-HepB-Hib3 et Rougeole-Rubéole | Rapports d'activités des DS/DDSSSa<br><br>Rapport des enquêtes HHFA                                                                     | DGSSSa<br>PEV<br>DGPOP |
|  |                                                                                                                                | Réaliser des activités supplémentaires de vaccination (AVS) chaque année si les données de surveillance épidémiologique confirment une épidémie (poliomyélite, rougeole, fièvre jaune) | Nombre d'activités supplémentaires de vaccination (AVS) réalisées par an en cas d'épidémie.                                                           | Rapports d'activités PEV                                                                                                                | PEV                    |
|  |                                                                                                                                | Introduire la deuxième dose de vaccin polio inactivé injectable (VPI2) dans le calendrier vaccinal national                                                                            | % d'enfants ayant reçu la deuxième dose de VPI2 au 31 décembre 2023                                                                                   | Rapports d'activités PEV<br><br>Rapport de l'évaluation post introduction (PIE) de la deuxième dose de vaccin polio injectable inactivé | PEV                    |
|  |                                                                                                                                | Introduire deux nouveaux vaccins (Hépatite B à la naissance et le vaccin contre le cancer du col de l'utérus) dans le calendrier vaccinal national                                     | Nombre de nouveau vaccin introduit dans le PEV de routine<br><br>% d'enfants ayant reçu la dose de naissance du                                       | Rapports d'activités PEV<br><br>Rapport de l'évaluation post                                                                            | PEV<br>DGPOP           |

|  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |                     |
|--|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | vaccin contre l'hépatite B au 31 décembre 2023, 2024, 2025 et 2026<br><br>% d'enfants (9 à 13 ans) ayant reçu le vaccin contre le cancer du col de l'utérus au 31 décembre 2023, 2024, 2025 et 2026                                                                             | introduction de chaque vaccin<br><br>Formulaire conjoint OMS-Unicef (Joint Reporting Form ou JRF) sur les données de vaccination |                     |
|  |                                            | Élaborer la stratégie nationale de vaccination pour la période 2023-2026 conformément au Programme global pour la vaccination à l'Horizon 2030                                                                                                                                       | Existence de la stratégie nationale de vaccination                                                                                                                                                                                                                              | Document de stratégie nationale de vaccination validé                                                                            | PEV<br>DGPOP<br>DEP |
|  | <b>Amélioration de l'état nutritionnel</b> | Former le personnel des FOSA des 52 DS sur la promotion de (i) l'allaitement maternel exclusif de l'enfant, (ii) une bonne alimentation chez la femme enceinte ; (iii) une bonne alimentation chez la femme allaitante ; (iv) l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE) | Nombre d'agents de santé formés sur la promotion de : (i) l'allaitement maternel exclusif de l'enfant, (ii) une bonne alimentation chez la femme enceinte ; (iii) une bonne alimentation chez la femme allaitante ; (iv) l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE) | Rapport de formation                                                                                                             | DGSSSa<br>DHPS      |
|  |                                            | Former le personnel à tous les niveaux sur le dépistage et la prise en charge des cas de malnutrition (frustré, modérée                                                                                                                                                              | Nombre d'agents de santé formés sur (i) le dépistage et (ii) la prise en charge des cas de                                                                                                                                                                                      | Rapport de formation                                                                                                             | DGSSSa<br>DHPS      |
|  |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |                     |



|  |                                                                                            |                                                                                                                            |                                                                                                     |                                                                              |                     |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  |                                                                                            | et aiguë) dans l'ensemble des FOSA                                                                                         | malnutrition (frustrée, modérée et aiguë) dans l'ensemble des FOSA                                  |                                                                              |                     |
|  |                                                                                            | Étendre les unités de prise en charge de la malnutrition dans l'ensemble des FOSA des DS                                   | % de FOSA qui disposent d'une unité de prise en charge de la malnutrition                           | Rapports des DS et des DDSSa                                                 | DGSSSa<br>DHPS      |
|  |                                                                                            | Doter en équipements et intrants les unités de prise en charge de la malnutrition dans les FOSA                            | % FOSA dont les unités de prise en charge de la malnutrition sont dotées en équipements et intrants | Procès-Verbal de réception                                                   | DGAR<br>DEP<br>DHPS |
|  |                                                                                            | Réviser le protocole national de prise en charge de la malnutrition aiguë en y intégrant les nouvelles directives de l'OMS | Existence du protocole révisé sur la prise en charge de la malnutrition aiguë                       | Document du protocole révisé                                                 | DGSSSa<br>DHPS      |
|  |                                                                                            | Elaborer une stratégie nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle (SNSAN)                                         | Existence d'une stratégie nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle (SNSAN)               | Document de la SNSAN validée                                                 | DGSSSa<br>DHPS      |
|  | <b>Augmentation de la couverture du pays en centres de santé scolaire et universitaire</b> | Valider la stratégie nationale de la santé scolaire et universitaire                                                       | Existence de la stratégie nationale en santé scolaire et universitaire validée                      | Document de la stratégie nationale de santé scolaire et universitaire validé | DGPOP<br>DEP        |
|  |                                                                                            | Élaborer un manuel des normes et directives d'offre de la santé scolaire et universitaire                                  | Existence d'un manuel des normes et directives d'offre de la santé scolaire et universitaires       | Document des normes et directives d'offre de santé                           | DGPOP               |

|  |  |                                                                                                                                      |                                                                                        |                            |             |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|
|  |  |                                                                                                                                      |                                                                                        | scolaire et universitaires |             |
|  |  | Aménager les locaux des 12 centres de santé scolaire et universitaire dans les chefs-lieux de département, y compris leur équipement | Nombre de centres de santé scolaire et universitaire aménagés et équipés (12 au total) | Procès-verbal de réception | DGAR<br>DEP |

**Programme n°4 : Renforcement de la sécurité sanitaire, gestion des épidémies et autres situations d'urgence**

**Sous-programme 4.1 : Gestion des épidémies selon le RSI**

| Résultats attendus                                                                                           | Lignes d'actions prioritaires    | Contenu des lignes d'actions                                                                                                                   | Indicateurs de suivi                                                                                                            | Source de vérification                                                          | Structures responsables |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Résultat attendu n°1 : Les capacités du pays en matière d'alerte rapide des épidémies sont renforcées</b> | <b>Préparation aux épidémies</b> | Mettre en place les antennes du COUSP dans les 11 départements, y compris leur équipement                                                      | Nombre d'antennes de COUSP départementaux mises en place                                                                        | Rapport des travaux de finition ;<br>Procès-verbal de réception des équipements | CABINET<br>DGAR         |
|                                                                                                              |                                  | Former les membres des ECD et des DDSSSa sur la mise en œuvre des dispositions du RSI (détection, prévention et riposte),                      | Nombre des membres des ECD et des DDSSSa formés sur la mise en œuvre des dispositions du RSI (détection, prévention et riposte) | Rapport de formation                                                            | DGSSSa<br>DELM          |
|                                                                                                              |                                  | Former les ECD et les DDSSSa sur la surveillance intégrée des maladies et riposte (SIMR) impliquant la communauté et les FOSA du secteur privé | Nombre des membres des ECD et des DDSSSa formés sur la SMIR ;                                                                   | Rapport de formation                                                            | DGSSSa<br>DELM          |

|  |  |                                                                                                            |                                                                                                          |                                                               |                         |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  |  | Rédiger un manuel de procédures de gestion des urgences de santé publique                                  | Existence d'un manuel de procédure de gestion des urgences de santé publique                             | Manuel de procédure de gestion des urgences de santé publique | DGSSSa<br>COUSP<br>DELM |
|  |  | Sécuriser les financements recommandés par l'OMS sur les urgences et catastrophes                          | Sécurisation du Financements sur les urgences et catastrophes                                            | Rapports d'activités                                          | DEP<br>DGSSSa<br>DGPOP  |
|  |  | Pré-positionner les médicaments et intrants de riposte des épidémies dans les chefs-lieux des départements | Disponibilité des médicaments et intrants de riposte des épidémies dans les chefs-lieux des départements | Rapports d'activités                                          | DGSSSa                  |
|  |  | Étendre la surveillance épidémiologique dans toutes les aires de santé.                                    | % des aires de santé réalisant la surveillance épidémiologique                                           | Rapports d'activités des DS et DELM                           | DGSSSa<br>DELM          |
|  |  | Assurer le suivi de la mise en œuvre du plan d'action national de sécurité sanitaire (PANSS) 2023-2026     | Nombre de suivis effectifs                                                                               | Rapport de suivi                                              | DGSSSa<br>DHPS<br>DELM  |

|                                                                                                                                |                                                                            | Etendre la liste des maladies d'origine alimentaire dans la SIMR                                | Nombre de maladies d'origine alimentaire ajoutées dans SIMR                             | Liste des maladies d'origine alimentaire dans la SIMR                  | DGSSSa<br>DHPS<br>DELM         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Sous-programme 4.2 : Gestion des catastrophes et autres événements de santé en fonction des dispositions du RSI</b>         |                                                                            |                                                                                                 |                                                                                         |                                                                        |                                |
| <b>Résultats attendus</b>                                                                                                      | <b>Lignes d'actions prioritaires</b>                                       | <b>Contenu des lignes d'actions</b>                                                             | <b>Indicateurs de suivi</b>                                                             | <b>Source de vérification</b>                                          | <b>Structures responsables</b> |
| <b>Résultat attendu n°2 : Les capacités de gestion des catastrophes et autres risques sanitaires nationaux sont améliorées</b> | <b>Prévention et ripostes contre les catastrophes et autres événements</b> | Élaborer la cartographie des risques et catastrophes sanitaires                                 | Existence de la cartographie de risques et des catastrophes sanitaires                  | Document de la cartographie des risques et des catastrophes sanitaires | DGSSSa<br>DELM                 |
|                                                                                                                                |                                                                            | Rendre disponible le document de la cartographie des risques et des catastrophes au sein des DS | Nombre de DS disposant de la cartographie de risques, y compris les scénarii de riposte | Rapports d'activités                                                   | DGSSSa<br>DELM                 |
|                                                                                                                                |                                                                            | Appuyer l'élaboration des plans blancs dans tous les hôpitaux                                   | Nombre d'hôpitaux généraux ayant élaborés des plans blancs                              | Rapports d'activités                                                   | DGSSSa                         |
|                                                                                                                                |                                                                            | Organiser les simulations des ripostes                                                          | Nombre de simulations des ripostes réalisées                                            | Rapports de simulation                                                 | DGSSSa<br>DELM                 |

|                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                               |                 |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
|                                                            |                                                                                                                                            | Former les membres des Equipes Cadre de DS à la gestion des épidémies et catastrophes                                | Nombre des Equipes Cadre de DS ayant à leur sein des membres formées à la gestion des épidémies et catastrophes                                 | Rapport de formation          | DGSSSa<br>DGPOP |
|                                                            |                                                                                                                                            | Former les membres des ECD des DS sur la prise en charge des cas des maladies à potentiel épidémique connues         | Nombre des Equipes Cadre de DS ayant à leur sein des membres formées sur la prise en charge des cas des maladies à potentiel épidémique connues | Rapport de formation          | DGSSSa<br>DELM  |
|                                                            | <b>Renforcement des services de santé de détection dans les points d'entrées (aéroports, Beach, ports secondaires, points d'accostage)</b> | Installer les portiques dans les points d'entrées au Congo (aéroports, Beach, ports secondaires, points d'accostage) | Nombre de points d'entrée capables de détecter les signes de l'épidémie                                                                         | Rapports DELM                 | DGSSSa<br>DELM  |
|                                                            |                                                                                                                                            | Mettre en place des postes de santé médicalisés dans les points d'entrée au Congo                                    | Nombre de points d'entrée possédant des postes de santé médicalisés                                                                             | Rapports DELM                 | DGSSSa<br>DELM  |
| <b>Résultat attendu n° 2 : La cartographie des risques</b> | <b>Élaboration de la cartographie des</b>                                                                                                  | Elaborer un manuel de la cartographie des                                                                            | Existence d'un manuel de la cartographie des                                                                                                    | Manuel de la cartographie des | DGSSSa          |

|                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                             |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|
| <b>environnementaux pour la santé est disponible</b>                                                                     | <b>risques environnementaux au niveau national</b>                                  | risques environnementaux au niveau national                                                                                                       | risques environnementaux au niveau national                                                                                          | risques environnementaux au niveau national | DHPS           |
|                                                                                                                          |                                                                                     | Former les agents des services de santé et environnement (DHPS) à l'élaboration et à l'évaluation de la cartographie des risques environnementaux | Nombre des agents d'hygiène formés                                                                                                   | Rapport de formation                        | DGSSSa<br>DHPS |
| <b>Résultat attendu n° 3 : La population est informée et sensibilisée sur la prévention des risques environnementaux</b> | <b>Mise en place d'un Système d'Alerte et d'informations aux populations (SAIP)</b> | Organiser des campagnes de proximité sur les risques environnementaux                                                                             | Nombre de DS ayant réalisé au moins une campagne de proximité organisées sur la prévention des risques environnementaux dans l'année | Rapports des DS                             | DGSSSa<br>DHPS |
|                                                                                                                          |                                                                                     | Mettre en place le Système d'Alerte et d'Informations aux Populations dans chaque DS                                                              | Nombre de DS ayant mis en place le Système d'Alerte et d'Informations aux Populations                                                | Rapports des DS                             | DGSSSa<br>DHPS |
| <b>Résultat attendu n°4 : Un système de surveillance de la contamination des aliments</b>                                | <b>Mise en place des sites sentinelles de surveillance de la</b>                    | Elaborer les directives sur les bonnes pratiques d'hygiène et                                                                                     | Existence de directives sur les bonnes pratiques d'hygiène et                                                                        | Document de directives sur les              | DGSSSa<br>DHPS |

|                                                                                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                      |                            |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|
| <b>fondé sur des sites sentinelles et d'un réseau des laboratoires performants est mis en place</b> | <b>contamination des aliments dans les villes de Brazzaville, Pointe Noire, Dolisie, Nkayi, Mossendjo, Gamboma, Oyo, Pokola et Ouessou</b> | de sécurité sanitaires des aliments                                                                                                                                                                                                                               | de sécurité sanitaires des aliments                                                                                                                                                                  | bonnes pratiques d'hygiène |                |
|                                                                                                     |                                                                                                                                            | Rendre opérationnels les sites sentinelles de surveillance de la contamination des aliments                                                                                                                                                                       | Nombre de sites sentinelles de surveillance de la contamination des aliments rendus opérationnels (9 au total Brazzaville, Pointe Noire, Dolisie, Nkayi, Mossendjo, Gamboma, Oyo, Pokola et Ouessou) | Rapports des DS            | DGSSSa<br>DHPS |
|                                                                                                     |                                                                                                                                            | Former 60 agents d'hygiène (30 à Brazzaville et 30 à Pointe Noire) sur les systèmes de qualité et de sécurité sanitaire des aliments (pratiques généraux d'hygiène alimentaire, les systèmes d'analyse des risques – points critiques pour leur maîtrise (HACCP)) | Nombre des agents d'hygiène formés sur les systèmes de qualité et de sécurité sanitaire des aliments                                                                                                 | Rapport de formation       | DGSSSa<br>DHPS |
|                                                                                                     |                                                                                                                                            | Acquérir 500 kits d'analyse microbiologique des                                                                                                                                                                                                                   | Nombre de sites sentinelles de surveillance de la                                                                                                                                                    | Rapports DHPS              | DGSSSa<br>DHPS |



|  |  |                                                                                      |                                                                                           |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | aliments pour les sites sentinelles de surveillance de la contamination des aliments | contamination des aliments ayant été dotés en kits d'analyse microbiologique des aliments |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

## CHAPITRE VIII : CADRE DE MISE EN OEUVRE DU PNDS

---

### VIII.1 Cadre institutionnel de mise en œuvre du PNDS

Le PNDS 2023-2026 sera mis en œuvre à tous les niveaux du système de santé du Congo à travers des plans de travail annuels ou plans opérationnels qui s'appuieront sur les quatre programmes retenus. Les organes de mise en œuvre du PNDS intervenant dans la coordination, le pilotage, le suivi et l'évaluation sont :

#### VIII.1.1. Les organes techniques de suivi du PNDS et son secrétariat

##### VIII.1.1.1. Le comité technique de suivi du PNDS (CTS-PNDS)

Tenant compte des dispositions du décret n°2018/268 du 2 juillet 2018 qui rattachent au cabinet du ministère en charge de la santé les structures opérationnelles chargées de la mise en œuvre du PNDS, le comité technique de suivi du PNDS trouve son ancrage directement au cabinet. Il est dirigé par le ministre en charge de la santé. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté ministériel.

##### VIII.1.1.2. Le Secrétariat du comité technique de suivi du PNDS (SCTS-PNDS)

Le secrétariat du CTS du PNDS est l'organe permanent de suivi de la mise en œuvre du PNDS. Il est assuré par le Directeur des études et de la planification. Ce dernier est chargé de l'appui technique aux structures opérationnelles de mise en œuvre du plan et la coordination des projets avec les agences de coopération. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté ministériel.

#### VIII.1.2. Les organes de coordination du PNDS

La coordination de la mise en œuvre du PNDS sera réalisée à travers les organes suivants :

- **Au niveau national**
  - **Le Conseil national de santé**

Il s'agit d'un organe consultatif chargé de donner des avis et recommandations relatifs à l'amélioration des conditions de vie des populations. Il propose des orientations sur les choix stratégiques pour la mise en œuvre de la Politique Nationale de Santé (PNS). La participation de l'ensemble des secteurs ministériels et de la société civile au conseil national de santé permettra la prise en compte de leurs contributions en vue d'atteindre les résultats visés par le PNDS 2023-2026.

- **Le Comité de pilotage du PNDS**

Le comité de pilotage du PNDS est l'organe de coordination, d'orientation, de contrôle, de programmation et d'évaluation. A ce titre, il est chargé notamment de : (i) évaluer la mise en œuvre, (ii) approuver les plans opérationnels annuels, (iii) assurer la liaison avec les organisations non gouvernementales, les agences de coopération bi et multilatérale, (iv) aider à la mobilisation des ressources et à la coordination des aides extérieures et (v) formuler les recommandations sur la mise en œuvre du plan. La composition et les modalités de fonctionnement de cet organe sont fixées par voie réglementaire.

- **Au niveau départemental**
  - **Conseils départementaux de la santé**

Selon l'article 20 de la loi n°10/2003 du 6 février 2003, portant transfert des compétences aux collectivités locales, les départements ont pour mission de : (i) participer à l'établissement de la tranche départementale de la carte sanitaire nationale, (ii) élaborer et exécuter les plans d'urgence de santé et d'hygiène, (iii) assainir le milieu en hygiène général, (iv) gérer les aides sociales aux

personnes vulnérables et (v) construire ou acquérir, équiper, entretenir, gérer et assurer la maintenance des installations des crèches, garderies d'enfants, postes de santé, centres de santé intégrés, centres de promotion et réinsertion sociale.

Les directions départementales de la santé et les directions départementales de la population veilleront à l'élaboration, la validation, la mise en œuvre et l'évaluation semestrielle des Plans opérationnels annuels dans une approche participative et axée sur les résultats. Au terme de chaque exercice annuel de planification, les directions départementales de la santé et les directions départementales de la population transmettront à la direction des études et de la planification leurs plans opérationnels annuels en vue d'une compilation nationale et une analyse aux fins de prise de décision. De même, elles transmettront au secrétariat du comité technique du suivi du PNDS les rapports de leurs évaluations annuelles.

- **Au niveau des districts sanitaires**
  - **Les équipes cadres des districts sanitaires**

Les districts sanitaires constituent les unités de base pour la planification opérationnelle et la mise en œuvre des interventions dans leur globalité. A ce titre, ils sont chargés de : (i) élaborer les Plans opérationnels annuels du PNDS 2023-2026 en partenariat avec les organes de participation communautaire, (ii) organiser la mise en œuvre et le suivi régulier des opérations, (iii) organiser les réunions trimestrielles de revue du développement des aires de santé et (iv) produire les rapports de mise en œuvre et les transmettre aux départements sanitaires.

- **Le Comité de Gestion du district sanitaire**

Le comité de gestion (COGES) est l'organe cogestion du district sanitaire. Il regroupe les membres de l'Equipe-Cadre du district, le directeur de l'hôpital de district et les représentants des populations. Sa composition et ses missions sont précisées dans un texte réglementaire. Le COGES du district est dirigé par l'autorité administrative locale où est implanté le siège du district.

- **Le Comité de Gestion de l'hôpital de district**

Le comité de gestion (COGES) est l'organe de cogestion de l'hôpital de district. Il regroupe les membres de l'équipe administrative de l'hôpital et le Médecin-chef du district sanitaire. Sa composition et ses missions sont précisées dans un texte réglementaire. Le COGES de l'hôpital de district est dirigé par le médecin-chef du district.

- **La fédération des comités de santé**

La fédération des comités de santé est l'organe consultatif du district sanitaire. Il regroupe les membres des bureaux des comités de santé d'un district sanitaire. Sa composition et ses missions sont précisées dans un texte réglementaire. La fédération des comités de santé du district sanitaires est dirigée par un président élu par ses pairs.

- **Le comité de santé (COSA)**

Le Comité de santé est l'organe de cogestion du centre de santé intégré. Il regroupe les représentants des populations de l'aire de santé. Sa composition et ses missions sont précisées dans un texte réglementaire. Le COSA est dirigé par un président élu en assemblée générale.

### **VIII.1.3. Responsabilités dans la mise en œuvre du PNDS**

- **Rôle du gouvernement**

Le Gouvernement est responsable de l'atteinte des objectifs du présent PNDS. Il mobilisera les ressources internes et externes nécessaires à la mise en œuvre de ce PNDS.

Le Ministère de la Santé et de la Population assurera la gestion des ressources mises à sa disposition pour l'atteinte des objectifs du plan en liaison avec les Ministère en charge des Finances, du Budget, et de la comptabilité publique, du ministère en charge de l'économie, du Plan,

de la Statistique et de l'Intégration régionale, des partenaires techniques et financiers, de la société civile et du secteur privé. Le Ministre de la Santé et de la Population informera annuellement le Gouvernement de l'évolution de la mise en œuvre du PNDS sur la base du rapport annuel de performances du secteur ou du rapport du Conseil National de Santé.

#### ▪ **Rôle des différents niveaux de la pyramide sanitaire**

Le présent PNDS sera mis en œuvre aux trois niveaux du système national de santé selon les attributions de chacun d'eux :

**Le niveau central** de l'administration sanitaire va, en plus de la finalisation de la réforme en cours (élaboration/actualisation des politiques, stratégies, textes réglementaires et normes) assurer l'encadrement des départements et districts sanitaires dans leur rôle d'organisation des soins de santé primaires. Tout ceci implique la mise en place d'un noyau des formateurs du niveau central, avec des compétences nécessaires dans la gestion des soins de santé primaires et au besoin avec l'expertise internationale sur la gestion axée sur les résultats, la négociation, la contractualisation, l'élaboration des stratégies sous-sectorielles, la production de l'information stratégique et le suivi, et l'évaluation des politiques, plans et stratégies. Enfin, le niveau central assurera la mobilisation des financements extérieurs dans le cadre des initiatives globales de la santé.

**Le niveau départemental** assurera un encadrement technique de proximité et logistique des districts sanitaires et services de santé à caractère départemental (HG, HD, CSI) pour la mise en œuvre des orientations stratégiques définies par le niveau central. A cet effet, les directions départementales de la santé et de la population seront renforcées avec des équipes cadres répondant au profil des postes. Elles seront dotées de compétences en matière de planification, d'exécution, de suivi budgétaire et de passation de marchés.

**Le district sanitaire** est le niveau opérationnel de mise en œuvre des interventions du PNDS. Dans ce cadre, le renforcement de la performance du système de santé de district s'avère nécessaire. Pour y parvenir, il sera indispensable de renforcer i) les capacités gestionnaires des équipes cadres de district (ECD), ii) les capacités cliniques, techniques et gestionnaires des services de santé de manière à améliorer la disponibilité et l'accessibilité des paquets d'interventions à haut impact sur la réduction de la morbidité et de la mortalité en particulier de la mère et de l'enfant.

#### ▪ **Rôle des autres ministères**

L'implication des autres ministères se fera à travers les actions suivantes :

- **Primature** : coordonner les contributions de tous les ministères et des partenaires techniques et financiers impliqués dans le secteur santé par la tenue régulière de Conseil National de Santé conformément aux dispositions des textes en vigueur. Elle favorise la mobilisation des ressources et fait le suivi de la mise en œuvre des recommandations du conseil national de santé.
- **Ministère en charge de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale** : accélérer la mise en exploitation de l'Assurance Maladie Universelle et favoriser l'intégration des agents de santé selon le besoin exprimé par le ministère en charge de la santé.
- **Ministères en charge des Finances et du Budget** : mettre à la disposition des différents ministères, les ressources financières nécessaires à la réalisation des interventions programmées dans le PNDS qui relèvent de leurs responsabilités et Renforcement de la sécurité sanitaire, gestion des épidémies et autres situations d'urgence.
- **Ministères de l'intérieur et de la décentralisation** : mettre en œuvre les dispositions de la décentralisation et de la fonction publique territoriale, Renforcement de la sécurité sanitaire, gestion des épidémies et autres situations d'urgence et veiller à la bonne gestion des ressources transférées.

- **Ministère en charge de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des grands travaux** : finaliser les travaux de construction/réhabilitation des infrastructures programmées dans le PNDS, notamment les hôpitaux généraux.
- **Ministère en charge du plan et des statistiques** : appuyer le MSP dans la réalisation des études/enquêtes (EDS, RHPH, MICS, SARA, Couverture vaccinale, ECOM, annuaires statistiques et comptes de la santé.
- **Ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Economie Numérique** : Collaboration pour l'exploitation des TIC
- **Ministère en charge de l'Agriculture et de l'élevage** : collaboration pour l'amélioration de l'alimentation et la nutrition et Renforcement de la sécurité sanitaire, gestion des épidémies et autres situations d'urgence
- **Ministères de l'environnement** : partenariat pour le renforcement de l'approche One Health environnement santé
- **Ministères chargés des enseignements primaire, secondaire, technique et supérieur** : appuyer le MSP dans la formation des ressources humaines pour la santé (FSSA, CIESPAC), la recherche (IRSSA, CHU, FSSA, ...) et la santé scolaire et universitaire.

#### VIII.1.4. Modalités de mise en œuvre du PNDS

##### ▪ Alignements des plans stratégiques des programmes de santé

Une fois le PNDS adopté par le gouvernement, les plans stratégiques des programmes de santé devront être révisés pour s'aligner au PNDS qui se fera, à la fois, sur le cycle de planification et sur le contenu, c'est-à-dire, sur les objectifs et les résultats attendus du PNDS auxquels ces programmes de santé devront désormais contribuer ainsi que sur les programmes, les sous-programmes et les résultats attendus de ces derniers.

##### ▪ Planification opérationnelle à tous les niveaux du système de santé

La mise en œuvre du PNDS se fera à travers l'élaboration et la mise en œuvre des plans de travail annuel ou d'action opérationnels (PAO) par toutes les structures et tous les niveaux du Ministère de la Santé et de la Population. Ces plans se feront en fonction des missions des structures concernées. Ils auront une durée de mise en œuvre d'une année avec un cycle de planification correspondant au cycle de planification du gouvernement. L'alignement se fera en fonction des programmes et sous-programmes du PNDS.

Les plans des districts sanitaires et ceux des structures opérationnelles (hôpitaux généraux, et autres structures qui offrent les prestations tels que le CNTS, le CTA du VIH/Sida, etc.) serviront à la mise en œuvre des interventions prioritaires retenues. Les plans d'action opérationnels des directions des directions générales et directions centrales et des programmes et départementales incluront des actions d'appui technique aux niveaux immédiatement inférieurs pour renforcer leurs capacités dans la mise en œuvre de leurs plans.

#### VIII.1.5. Mesures et réformes nécessaires

Un certain nombre des réformes sont nécessaires pour permettre une mise en œuvre efficace du PNDS. Il s'agit de : la mise en œuvre des budgets-programmes, la revitalisation du DS pour la promotion des soins de santé primaires centrés sur la personne, la décentralisation et l'assurance-maladie universelle.

##### ▪ Mise en œuvre du budget programme

La République du Congo a initié ces dernières années une profonde réforme de son système de gestion des finances publiques, sur la base des six (06) directives du cadre harmonisé de gestion des finances publiques de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), transposées en droit national. À cet effet, un plan national 2020 - 2029 de la réforme du système de gestion des finances publiques a été adopté, prévoyant la formation continue du

personnel des ministères et autres institutions publiques, tout en assurant l'accompagnement du passage d'un « budget des moyens » au « **budget en mode programme** ».

Pour ce faire, le Gouvernement, qui a pris l'engagement de basculer effectivement au budget programme le 1<sup>er</sup> janvier 2024, par note de service N°0024 PM-CAB du 12 juillet 2023 a désigné le Ministère de la Santé et de la Population, avec cinq autres ministères comme ministères pilotes d'implémentation du budget programme.

Le passage du « budget des moyens » au « budget en mode programme » étant conditionné à l'élaboration d'un certain nombre de documents dont le plan stratégique du ministère.

Le budget-programme sera un outil essentiel pour faire des progrès vers la couverture universelle en santé. Sa mise en œuvre est effective à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2024 selon les instructions du Gouvernement de la République. Il permettra de lier les résultats aux moyens/ressources qui seront mis à dispositions des différentes structures et différents acteurs aux résultats attendus de ces derniers. Il se fera sur base des quatre programmes budgétaires du Gouvernement. Les différents programmes et sous programmes seront logés dans les structures du ministère de la santé et de la population en fonction de leurs missions respectives. Ces structures seront comptables à la fois des résultats négociés dans le Cadre de Dépense sectoriel à Moyen terme (CDS-MT) et des ressources mises à leur disposition pour la réalisation de ces derniers.

Les structures responsables des programmes seront dotées des moyens institutionnels (réformes structurelles et fonctionnelles) pour leur permettre de réaliser les résultats qui leur seront exigés.

Le projet de décret portant approbation des programmes et dotations budgétaires de l'Etat a été adopté en conseil des ministres et il s'appuie sur la loi organique n°36-2017 du 3 octobre 2017 relative aux lois de finances, a instauré le principe de la gestion budgétaire pluriannuelle axée sur la performance dans la mise en œuvre des politiques publiques. À cet égard, les crédits budgétaires sont dorénavant alloués par programme et/ou par dotation. Subséquemment, le programme ou la dotation budgétaire constitue la nouvelle unité de découpage fonctionnelle de vote des crédits.

Les outils à utiliser pour la mise en œuvre du budget-programme sont les suivants :

- le Plan Stratégique des ministères sectoriels (PSM) ;
- le Cadre de Dépense à Moyen Terme (CDMT) ;
- le Projet Annuel de Performance (PAP) ;
- le Rapport Annuel de Performance (RAP) ;
- le Plan d'Engagement (PE) ;
- le Plan Pluri-Annuel Complet (PPAC).

Le Ministère de la santé et de la population se doit d'appliquer les directives afin de s'arrimer aux pratiques internationales en cours dans le domaine de la gestion budgétaire et pour une mise en œuvre effective des lois organiques relatives aux lois de finances (LOLF).

Pour l'année 2024, tous les outils en lien avec la mise en œuvre du budget programme ont été élaborés sur la base des éléments du PNDS 2023-2026.

- **Revitalisation du district sanitaire**

Le ministère de la santé et de la population a fait de la revitalisation du district sanitaire une priorité. Cette réforme consistera à passer d'un système de santé hôpitalo-centré à un système de santé de district. Cette réforme nécessitera une révision de la clé de répartition du budget de l'Etat entre les différents échelons des soins en privilégiant les deux échelons (CSI et Hôpital de référence de district) où sont censés trouver solution plus de 80% des problèmes de santé de la population.

- **Mise en œuvre effective de la décentralisation**

La réforme relative à la décentralisation est nécessaire pour soutenir la revitalisation du district sanitaire qui est un axe essentiel du PNDS. Cette réforme devrait permettre de concrétiser le transfert des ressources dont les districts sanitaires ont besoin pour leur développement. Parmi ces ressources, il y a les ressources humaines pour la santé dont la rétention en milieu rural passe par la mise en place de la fonction publique territoriale.

- **Mise en exploitation de l'assurance maladie universelle (AMU)**

Celle-ci est essentielle pour l'atteinte des résultats inscrits dans le PNDS. Elle nécessite l'implication de plusieurs ministères dont celui de la santé, du travail, de la sécurité sociale, des finances, et de la décentralisation. Des progrès dans le fonctionnement de l'assurance maladie passent par une meilleure coordination de tous les ministères impliqués au sein du gouvernement.

- **Procédures administratives, financières et comptables, contrôle de gestion**

Dans un souci d'efficacité et de transparence de gestion, le Ministère de la Santé et de la Population renforcera des mécanismes opérationnels de contrôle et procédera à des contrôles et des inspections à tous les échelons de la pyramide sanitaire.

- **Procédures administratives, financières et comptables**

Les procédures de gestion administrative, financière et comptable seront améliorées, disséminées et appliquées à tous les niveaux du système de santé. A cet effet, un manuel de procédures financières et comptables sera élaboré. Ce manuel définira clairement les responsabilités dans l'imputation des ressources, le calendrier de transmission et de publication des rapports d'exécution du budget.

En ce qui concerne les structures autonomes, le manuel de procédures sera mis à jour en tenant compte des réformes administratives. L'application de ces manuels de procédures nécessitera le renforcement des capacités des agents en charge de la gestion financière et comptable. De plus les membres des conseils d'administration, des comités de direction et les administrateurs des hôpitaux et autres responsables impliqués dans la gestion seront formés sur la bonne gouvernance et sur les mécanismes de contrôle et d'audit interne. Pour faciliter le suivi des données financières et comptables, un tableau de bord retraçant les situations financières interne et externe du ministère sera élaboré.

#### **VIII.1.6. Modalités de contrôle de gestion**

Les actions de l'Inspection Générale de la Santé seront renforcées en rapport avec l'Inspection Générale des Finances et l'Inspection Générale d'Etat. L'Inspection Générale de la Santé poursuivra le contrôle administratif, financier et sanitaire des établissements et services relevant du Ministère de la Santé et de la Population, y compris la diffusion de la législation, de la réglementation et des normes en vigueur.

En outre, la Direction Générale de l'administration et des Ressources (DGAR), veillera, en liaison avec l'Inspection Générale des Finances, au suivi de la régularité des opérations comptables et financières des établissements et services. Les autres directions de moyens, la DI, la DEM et la

DARH vont respectivement assurer l'inventaire régulier du patrimoine du Ministère en charge de la santé ainsi que le contrôle annuel des effectifs.

Les directions départementales de la Santé et de la population seront chargées en rapport avec la DGAR d'assurer le contrôle des opérations comptables et financières des établissements de leur circonscription. Le Cabinet s'assurera chaque année de la qualité du contrôle interne du Ministère de la Santé et de la Population.

### VIII.1.7. Conditions de succès et gestion des risques

#### VIII.1.7.1. Conditions de succès

L'efficacité de la mise en œuvre repose sur les principales conditions suivantes :

- **Eviter les conflits d'intérêt dans les nominations aux postes de responsabilité**
- **Le respect de l'engagement politique** pris au plus haut niveau en faveur d'une forte implication du budget dans le social, la santé en particulier et pour la réalisation des ODD. Cela devra se traduire en termes (i) de renforcement de leadership national, ii) de mobilisation suffisante des ressources nécessaires, (iii) de régulation et de contrôle efficace à tous les niveaux ;
- **L'engagement des PTF pour un réel accompagnement dans la mise en œuvre ;**
- **la redéfinition du niveau de négociation des financements** avec les partenaires doit être officialisée par un « Compact national » pour une meilleure prévisibilité des ressources externes ;
- **Le renforcement de la participation communautaire** ; le partenariat communautaire dans le système de santé étant un élément clef permettant de réduire les disparités dans l'accès aux soins de santé de base et garantissant un certain « contrôle citoyen » sur la mise en œuvre de cette stratégie sectorielle. A cela, il faudra associer des initiatives de renforcement des capacités des familles à être elles-mêmes les moteurs du changement des comportements nécessaires à l'amélioration de leur état de santé.

#### VIII.1.7.2. Analyse et gestion des risques et menaces

| Domaines                   | Risques potentiels                                                                                              | Mesures de mitigation                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Gouvernance             | 1.1. Echech de mise en œuvre de la réforme sur la gouvernance en santé décidée depuis les assises d'Ewo en 2016 | ▪ Finaliser les textes d'application                                                                                                                                                                                                   |
|                            |                                                                                                                 | ▪Vulgariser le document du PNDS 2023-2026 ainsi que les textes d'application                                                                                                                                                           |
|                            |                                                                                                                 | ▪Renforcer la culture de redevabilité (reddition des comptes) à tous les niveaux de la pyramide sanitaire                                                                                                                              |
|                            |                                                                                                                 | ▪ Assurer la coordination des organes de mise en œuvre du PNDS                                                                                                                                                                         |
| 2. Financement de la santé | 2.1. Crise financière pendant la mise en œuvre du PNDS 2023-2026                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rendre disponible des ressources financières nécessaires pour la mise en œuvre du PNDS</li> <li>▪Elaborer le COMPACT national pour un appui technique et financier des partenaires</li> </ul> |



| Domaines                                                                                                            | Risques potentiels                                                     | Mesures de mitigation                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                     |                                                                        | ▪ Réviser les textes traitant les mécanismes de gestion des fonds issus des recouvrements des coûts                                           |
|                                                                                                                     |                                                                        | ▪Renforcer les mécanismes de gestion des fonds dans les FOSA                                                                                  |
|                                                                                                                     |                                                                        | ▪Assouplir les procédures de décaissement des allocations budgétaires des structures de santé planifiées de manière progressive               |
|                                                                                                                     | 2.2. Insuffisance des ressources pour la revitalisation du DS          | ▪Développer des districts sanitaires de manière progressive                                                                                   |
|                                                                                                                     |                                                                        | ▪Mobiliser des ressources locales à partir du principe de la responsabilité sociétale des entreprises et des collectivités locales            |
|                                                                                                                     | 2.3. Retard dans la mise en œuvre du Budget                            | ▪Faire le plaidoyer au plus haut niveau de l'Etat pour les dispositions particulières de financement du PNDS                                  |
|                                                                                                                     |                                                                        | ▪Respecter les cycles de planification des interventions à tous les niveaux                                                                   |
|                                                                                                                     |                                                                        | ▪Décaisser des allocations budgétaires dans les délais                                                                                        |
|                                                                                                                     | 3. Médicaments Essentiels Génériques                                   | 3.1. Contre-performance de la CAMEPS de satisfaire les besoins des formations sanitaires en médicaments, réactifs et autres produits de santé |
| ▪Respecter les opérations de gestion de la CAMEPS                                                                   |                                                                        |                                                                                                                                               |
| ▪Contractualiser avec une centrale de la sous-région dans la collaboration des approvisionnements des FOSA du pays. |                                                                        |                                                                                                                                               |
| ▪Mettre en œuvre le plan de développement des ressources humaines                                                   |                                                                        |                                                                                                                                               |
| 4. Ressources Humaines en Santé                                                                                     | 4.1. Insuffisance du personnel de santé dans les formations sanitaires | ▪Respecter des dispositions de la loi sur la fonction publique territoriale                                                                   |
|                                                                                                                     |                                                                        | ▪Mettre en œuvre le plan de développement des ressources humaines                                                                             |
|                                                                                                                     |                                                                        | ▪ Contractualiser les agents selon les besoins                                                                                                |

| Domaines                   | Risques potentiels                                                                                    | Mesures de mitigation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Informations sanitaires | 5.1. Manque de cohérence sur les données produites à différents niveaux du système                    | ▪Renforcer les supervision-formatives de la gestion des données dans toutes structures sanitaires (privées et publiques)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                            |                                                                                                       | ▪Implémenter le DHIS2 dans toutes formations sanitaires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                            |                                                                                                       | ▪ Tenir régulièrement des réunions d'harmonisation et de validation des données à tous les échelons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6. Prestations             | 6.1. Apparition de plusieurs épidémies, catastrophes et autres événements sanitaires à forte létalité | ▪ Actualiser le plan national de prévention, de préparation, de riposte contre les épidémies, urgences sanitaires, catastrophe et autres évènements de santé                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                            | 6.2. La sous-utilisation des services de santé                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>•Affecter les ressources selon les besoins</li> <li>•Soutenir la supervision des équipes des formations sanitaires au niveau des districts et du département pour garantir la qualité des soins et des services de santé</li> <li>•Intensifier la sensibilisation sur les problèmes de santé au niveau des communautés</li> <li>•Développer l'assurance maladie universelle</li> </ul> |

## CHAPITRE IX : ESTIMATION BUDGETAIRE

Ce chapitre présente le coût global du financement nécessaire pour la mise en œuvre du PNDS 2023-2026. Cette présentation des besoins en ressources financières pour le PNDS comprend : i) l'hypothèse d'estimation des coûts, (ii) l'évaluation des besoins en ressources financières, (iii) les scénarii de financement et (iv) les sources potentielles de financement.

### IX.1. Hypothèse d'estimation des coûts

L'évaluation des coûts du PNDS 2023-2026 s'est faite à l'aide de l'outil « OneHealth ». Les données de base retenues ont été tirées des rapports officiels. Les données des enquêtes ont été privilégiées quand elles existent ; à défaut des données des enquêtes, celles des annuaires statistiques ont été retenues.

La procédure de budgétisation qui consistait à retenir des interventions « traceurs » par niveau de prestations en rapport avec la politique nationale de santé a été appliquée de couverture adéquate et de couverture effective. En outre, elle a permis de définir les stratégies, de fixer des objectifs et de déterminer les impacts en les liant aux coûts des interventions pour chaque phase pour la mise en œuvre des interventions qui ont un impact sur la santé de la population.

### IX.2. Estimation des besoins en ressources financières

#### IX.2.1. Budget global du PNDS 2023-2026

Le coût global estimatif pour la mise en œuvre du PNDS 2023-2026 s'élève à 817, 644 milliards de franc CFA. La figure ci-dessous donne l'évolution annuelle du besoin de financement du PNDS 2023-2026. Elle montre également une évolution croissante du budget entre 2023 et 2026. La programmation d'infrastructures à réaliser en début de la période du PNDS 2023-2026 explique la hausse du budget de 2023 à 2026.

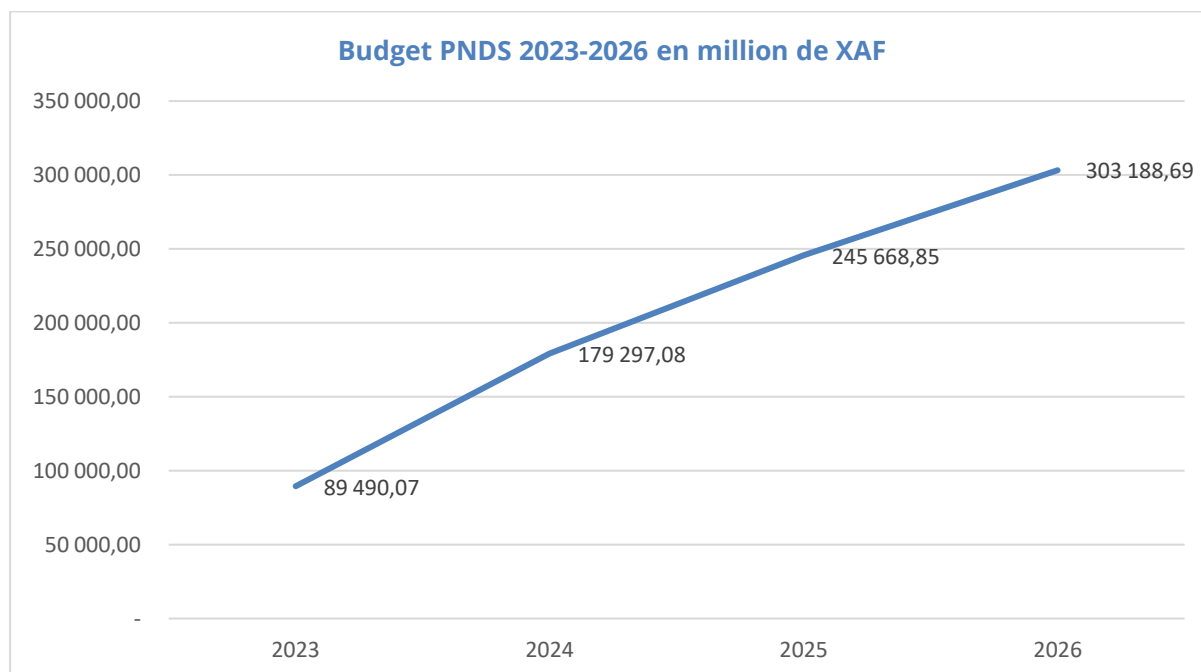


Figure 15 : Evolution du budget du PNDS 2023-2026

## IX.2.2. Budget par programme du PNDS 2023-2026

La cartographie budgétaire réalisée avec l'outil OneHealth a permis d'obtenir le budget selon les programmes du PNDS. Le tableau ci-après récapitule le budget reparti par programme du PNDS.

**Tableau 12 : Répartition du Budget par programme du PNDS (en millions de FCFA)**

| PROGRAMMES                                                                                                                       | Année<br>2023    | Année<br>2024     | Année<br>2025     | Année<br>2026     | Total             | %             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>Programme n°1 :</b><br><i>Renforcement de la gouvernance et du financement du secteur santé</i>                               | 34 097,67        | 35 055,92         | 34 831,67         | 34 559,92         | 138 545,18        | 16,9%         |
| <b>Programme n° 2 :</b><br><i>Promotion d'un meilleur état de santé et du bien-être de la population</i>                         | 12 940,33        | 80 266,35         | 150 777,86        | 224 879,74        | 468 864,28        | 57,3%         |
| <b>Programme n°3 :</b><br><i>Amélioration de l'accès équitable des populations aux paquets de services essentiels de qualité</i> | 20 512,07        | 35 758,82         | 30 995,32         | 26 007,04         | 113 273,25        | 13,9%         |
| <b>Programme n° 4 :</b><br><i>Renforcement de la sécurité sanitaire, gestion des épidémies et autres situations d'urgence</i>    | 21 940,00        | 28 216,00         | 29 064,00         | 17 742,00         | 96 962,00         | 11,9%         |
| <b>Total</b>                                                                                                                     | <b>89 490,07</b> | <b>179 297,08</b> | <b>245 668,85</b> | <b>303 188,69</b> | <b>817 644,70</b> | <b>100,0%</b> |

Le tableau 12 ci-dessus montre la répartition du budget par programme du PNDS 2023-2026. Le programme n°1 : renforcement de la gouvernance et du financement du secteur de la santé est estimé à 138, 545 milliards de FCFA sur les quatre années. Le programme n°2 : Promotion d'un meilleur état de santé et du bien-être de la population pour les quatre prochaines années va coûter 468,864 milliards de FCFA. Le programme n°3 : amélioration de l'accès équitable des populations aux paquets de services essentiels de qualité est évalué à 113,273 milliards et le programme n°4 : renforcement de la sécurité sanitaire, gestion des épidémies et autres situations d'urgence est estimé à 96, 962 milliards.

Selon la figure 16 ci-dessous, le programme n°1 représente 17% du budget ; le programme n°2, 57% ; le programme n°3, 14% et le programme n°4, 12%.

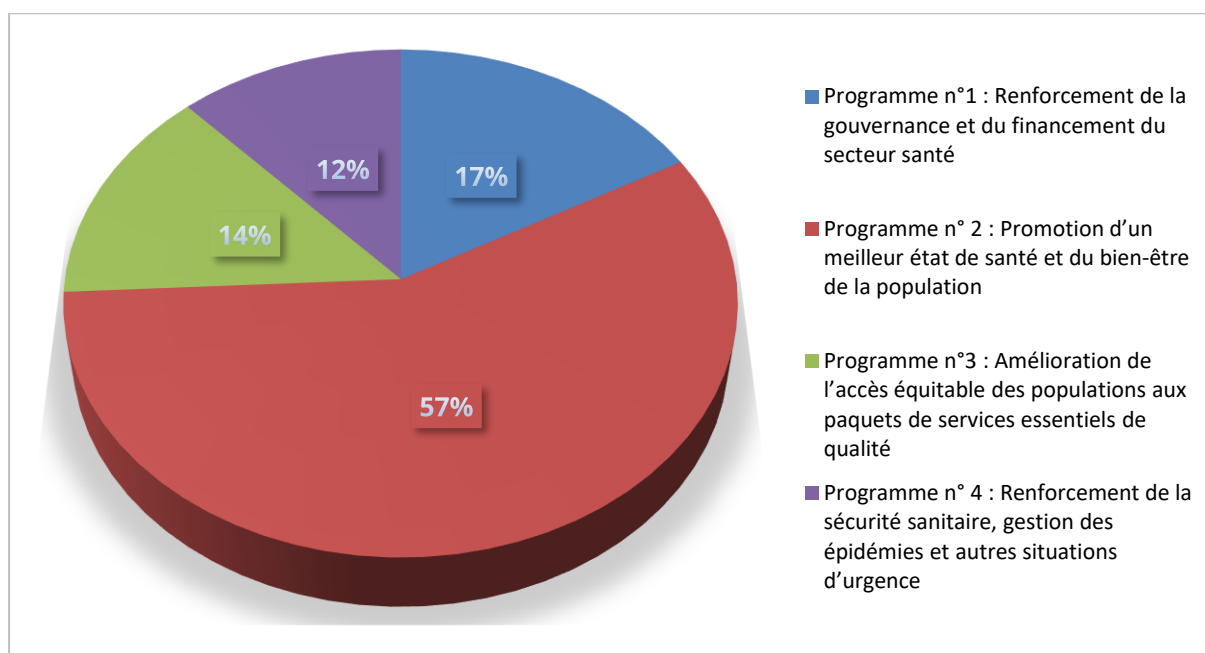


Figure 16 : Répartition du budget en fonction des programmes du PNDS 2023 - 2026

### IX.1.3. Budget par sous-programme du PNDS 2023-2026

Tableau 13 : Répartition du budget par sous-programme PNDS (en millions de FCFA)

| SOUS-PROGRAMMES                                                                                                            | Année 2023 | Année 2024 | Année 2025 | Année 2026 | Total      | %       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|
| <b>Sous-programme 1.1 :</b><br><i>Renforcement du cadre juridique, administratif et financier.</i>                         | 33 956     | 33 971     | 33 956     | 33 931     | 135 813    | 16,61%  |
| <b>Sous-programme 1.2 :</b><br><i>Amélioration de la coordination et du partenariat du secteur de la santé</i>             | 15         | 15         | 15         | 15         | 60         | 0,01%   |
| <b>Sous-programme 2.1 :</b><br><i>Amélioration de la gouvernance et du pilotage en matière de la promotion de la santé</i> | 7764,198   | 48159,81   | 90466,716  | 134927,844 | 281318,568 | 34 ,38% |
| <b>Sous-programme 2.2 :</b><br><i>Amélioration du cadre et/ ou mode de vie des populations</i>                             | 5176,132   | 32106,54   | 60311,144  | 89951,896  | 187545,712 | 22,92%  |
| <b>Sous-programme 3.1 :</b><br><i>Renforcement de l'offre de soins et services de santé</i>                                | 10 361     | 23 485     | 18 810     | 15 751     | 68 406     | 8,37%   |

|                                                                                                                                       |               |                |                |                |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Sous-programme 3.2 :</b><br><i>Amélioration de l'accès financier aux soins et services de santé des populations</i>                | 2 450         | 3 741          | 3 784          | 2 578          | 12 554         | 1,54%          |
| <b>Sous-programme 3.3 :</b><br><i>Renforcement des programmes de santé de la mère, de l'enfant, des jeunes et des adolescents</i>     | 7 760         | 8 591          | 8 460          | 7 737          | 32 549         | 3,98%          |
| <b>Sous-programme 4.1 :</b><br><i>Gestion des épidémies selon le Règlement Sanitaire International (RSI)</i>                          | 15 640        | 20 060         | 21 760         | 12 410         | 69 870         | 8,55%          |
| <b>Sous-programme 4.2 :</b><br><i>Gestion des catastrophes et autres événements de santé en fonction des dispositions du RSI 2005</i> | 6 300         | 8 156          | 7 304          | 5 332          | 27 092         | 3,31%          |
| <b>Total</b>                                                                                                                          | <b>89 490</b> | <b>179 297</b> | <b>245 669</b> | <b>303 189</b> | <b>817 645</b> | <b>100,00%</b> |

## IX.2. Scénarii de financement du PNDS 2023-2026

Afin de consolider les acquis et d'évaluer les capacités du pays à financer le PNDS 2023-2026, l'élaboration de trois scénarii de l'espace budgétaire a été nécessaire.

Les trois (03) scénarii proposés sont les suivants :

- ✓ un scénario minimum « Statu quo » qui repose sur les tendances de financement actuelles ;
- ✓ un scénario « augmentation du budget de la santé de 10% à l'horizon 2026 » ;
- ✓ un scénario « respecter la déclaration d'Abuja l'horizon 2026 ».

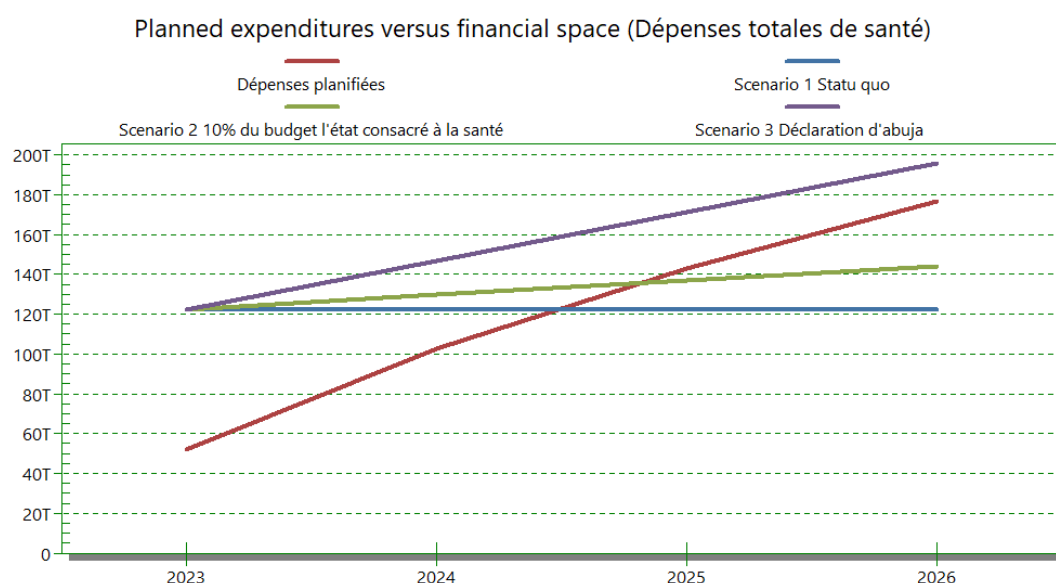


Figure 17 : Scénarii de financement du PNDS 2023-2026

Pour la mise en œuvre du PNDS 2023-2026, le Ministère de la santé et de la population développera des plaidoyers dans le cadre du processus d'accélération de l'atteinte des ODD liés à la santé à travers la mise en œuvre du PND.

Le plaidoyer à l'endroit de l'Etat va s'inscrire dans la nécessité d'honorer les engagements d'Abuja qui vise l'accroissement vers les 15 % de la part du Budget Santé dans le Budget Général de l'Etat. Ce plaidoyer va s'articuler aussi autour du renforcement des mécanismes innovants pour mobiliser des ressources additionnelles à l'échelle nationale en faveur du secteur de la santé. En retour, le Ministère de la Santé et de la Population doit garantir la gestion efficiente de l'ensemble des ressources et particulièrement des ressources financières mobilisées pour la mise en œuvre du PNDS 2023-2026.

Cette gestion sera basée sur les principes de la responsabilité et de la redevabilité mutuelle à travers le renforcement du mécanisme de suivi et de contrôle et de revue périodique des dépenses publiques de santé. Les outils de gestion et de suivi financiers modernes de l'exécution budgétaire seront mis à contribution à cet effet. Par ailleurs, les audits financiers annuels de l'ensemble des financements seront systématisés afin de renforcer l'obligation de rendre compte, de même que les contrôles par les organes de l'Etat.

## CHAPITRE X : PLAN DE SUIVI ET EVALUATION

---

Le plan de suivi et évaluation du PNDS 2023-2026 est un document évolutif qui décrit toutes les activités de suivi et d'évaluation. C'est un outil de mesure de la performance des activités inscrites dans le PNDS 2023-2026. Il est conçu pour suivre les activités des principaux programmes retenus dans le PNDS et évaluer leur succès. C'est aussi un cadre de référence structuré qui montre : De quelle information a-t-on besoin ? Comment cette information est-elle définie ? Où trouve-t-on cette information ? Quelle est sa valeur initiale ? Quelle valeur veut-on atteindre ? Quelle est la fréquence ou la périodicité de la collecte ? Qui est chargé de la collecte ?

Le présent chapitre du plan de suivi et évaluation comporte les principales parties suivantes :

- l'objectif général et les objectifs spécifiques ;
- le cadre institutionnel de suivi et d'évaluation du PNDS 2023-2026 ;
- Mécanismes de suivi et d'évaluation ;
- Cadre conceptuel de suivi et évaluation du PNDS 2023-2026 ;
- Indicateurs de suivi et d'évaluation ;
- Cadre des résultats du PNDS 2023-2026 ;
- Sources des données ;
- Gestion des données ;
- Rétro-information.

### X.1. OBJECTIFS

#### X.1.1. Objectif général

Le plan de suivi et évaluation a pour objectif d'éclairer la conduite et le pilotage des actions du PNDS 2023-2026 et de faciliter ainsi la prise de décision.

#### X.1.2. Objectifs spécifiques

Les objectifs spécifiques du plan consistent à :

- collecter, analyser et communiquer des informations relatives à l'exécution des actions inscrites dans le PNDS afin de repérer les éventuels dysfonctionnements au cours de la mise en œuvre et apporter des correctifs nécessaires ;
- apprécier les progrès réalisés dans la mise en œuvre des actions du PNDS par rapport aux résultats escomptés et aux objectifs fixés ;
- mesurer le niveau d'atteinte des résultats par rapport aux résultats escomptés et aux objectifs fixés ;
- rendre compte aux différentes parties prenantes des résultats des actions mises en œuvre ;
- contribuer à la prise de décision concernant la poursuite ou non des actions (réorientations techniques, réallocation des fonds, ajustement des objectifs programmés) et ;
- renforcer les capacités opérationnelles des structures et des organes en matière de suivi et évaluation pour leur permettre d'assurer un suivi efficace des actions à tous les niveaux du système de santé.

### X.2. Cadre institutionnel de suivi et évaluation du PNDS

Le cadre institutionnel de suivi et évaluation des actions inscrites dans le PNDS, devra impliquer des organes de coordination aux trois niveaux de la pyramide sanitaire. Ce dispositif institutionnel de suivi et évaluation permet de décrire, par niveau du système de santé, l'organisation, le fonctionnement ainsi que les rôles et responsabilités des différents acteurs dans la collecte, l'analyse, la prise de décision et la diffusion de l'information stratégique.



### **X.2.1. Cadre institutionnel au niveau central**

Au niveau central, le suivi et évaluation comporte deux volets : le volet stratégique assuré par le Comité de Pilotage et le volet thématique par un comité technique de suivi des plans.

#### **X.2.1.1. Le Comité de pilotage (COFIL)**

Le Comité de pilotage est un organe de suivi et évaluation, placé sous la présidence du Ministre de la Santé et de la population qui convoque et anime les réunions dudit comité. Celui-ci se réunira deux (02) fois l'année pour statuer sur les résultats de l'évaluation à mi-parcours et de l'évaluation finale. Ce Comité dispose d'un Comité Technique de suivi (CTS) et d'un Secrétariat Technique permanent.

##### **X.2.1.1.1. Missions**

Le COFIL a pour missions de : (i) donner les orientations politiques pour la mise en œuvre des activités du PNDS, (ii) assurer le plaidoyer pour la mobilisation des ressources auprès des Partenaires Techniques et Financiers nationaux et internationaux en vue de mettre en œuvre le PNDS et (iii) valider les différents documents et rapports élaborés par le comité technique de suivi des plans. Par ailleurs, il décidera des orientations à donner à la suite de la mise en œuvre de la stratégie en fonction des recommandations des différents rapports qui lui seront soumis.

##### **X.2.1.1.2. Composition**

Le (COFIL) est composé de : (i) Inspecteur Général de la Santé, (ii) Directeurs généraux chargés de la santé, de la population, de l'administration et des Ressources et (iii) Membres du cabinet du ministre en charge de la santé.

#### **X.2.1.2. Le comité technique de suivi**

Le comité technique de suivi de la mise en œuvre du PNDS est placé sous la responsabilité du Directeur Général des Soins et Services de Santé (DGSSSa). Il se réunit tous les trois (03) mois et est appuyé par le secrétariat technique permanent.

##### **X.2.1.2.1. Missions**

Le comité technique de suivi, qui implique l'ensemble des acteurs et partenaires techniques et financiers du secteur de la santé, a pour missions de: (i) veiller à la mise en œuvre du PNDS, (ii) assurer la coordination nationale de l'exécution des différents plans et programmes , (iii) donner des avis techniques sur la mise en œuvre des plans annuels, (iv) organiser les revues annuelles du Ministère de la santé et de la Population, (v) valider les rapports de progrès du PNDS et d'adopter les différents plans (triennaux, annuels) et (vi) valider les différents documents élaborés.

##### **X.2.1.2.2. Composition**

Le Comité technique de suivi (CTS) est composé de : (i) Directeur Général des Soins et Services de Santé (DGSSSa), (ii) Directeur Général de la population (DGPOP), (iii) Directeur Général de l'Administration et des Ressources (DGAR), (iv) Directeurs rattachés au Cabinet, v) Conseillers du ministre en charge de la santé, et (vi) Inspecteur des services médicaux et paramédicaux (ISMP).

#### **X.2.1.3. Le secrétariat technique permanent**

Le secrétariat technique permanent est chargé de veiller à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation des actions du PNDS en collaboration avec les autres parties prenantes. Il est placé sous la coordination de la Direction des études et de la planification.

##### **X.2.1.3.1. Missions**

Le secrétariat technique permanent est l'organe chargé de l'animation et de la coordination du dispositif de suivi et évaluation du PNDS. Il aura pour missions de : (i) préparer les réunions du CTS,

(ii) rédiger les rapports et procès-verbaux des réunions, (iii) assurer la coordination technique de l'élaboration des plans annuels (2023, 2024, 2025 et 2026) alignés au PNDS, (iv) organiser les revues annuelles du PNDS, (v) organiser/faciliter les évaluations du PNDS (à mi-parcours, annuelles et finales) et (vi) veiller à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation du PNDS en collaboration avec les autres parties prenantes.

#### **X.2.1.3.2. Composition**

Le secrétariat technique permanent est composé de : (i) Directeur des études et de la planification (DEP), (ii) Directeur de l'Information Sanitaire, de l'Évaluation et de la Recherche (DISER), (iv) Directeur Général des Soins et Services de Santé (DGSSSa) et (v) Directeur Général de la Population (DGPOP).

### **X.2.2. Cadre institutionnel au niveau départemental**

Le cadre institutionnel au niveau départemental est constitué de la coordination départementale, le comité technique départemental de suivi et le secrétariat technique départemental.

#### **X.2.2.1. Coordination départementale du suivi-évaluation du PNDS**

La coordination départementale est un organe de consultation et de prise de décision au niveau départemental. Elle est placée sous la coordination du Préfet du Département.

##### **X.2.2.1.1. Missions**

La coordination départementale a pour missions de : (i) s'assurer de la mise en œuvre du suivi et de l'évaluation du PNDS, (ii) coordonner la réalisation du suivi et de l'évaluation du PNDS au niveau départemental et (iii) donner les orientations et superviser l'organisation, à la date échue, des revues départementales du PNDS 2023-2026.

##### **X.2.2.1.2. Composition**

La coordination départementale du suivi et évaluation du PNDS est composée de : (i) Préfet du département, (ii) Directeur Départemental des Soins et Services de la Santé (DDSSSa), (iii) Directeur départemental de la population (DDPOP), (iv) Inspecteur Départemental de la Santé, (v) Président du Conseil Départemental, (vi) Médecins chefs de district sanitaire et (vii) Représentant de la Société Civile et autres partenaires concernés dans la mise en œuvre du PNDS.

#### **X.2.2.2. Le comité technique départemental de suivi et évaluation du PNDS**

Le comité technique départemental est un organe de mise en œuvre du suivi et de l'évaluation. Il est placé sous la présidence du Directeur Départemental des Soins et Services de Santé.

##### **X.2.2.2.1. Missions**

Le comité technique départemental a pour missions de : (i) veiller à la mise en œuvre du suivi et de l'évaluation et (ii) transmettre au secrétariat du comité technique du suivi du PNDS les rapports de leurs évaluations annuelles.

##### **X.2.2.2.2. Composition**

Le comité technique départemental se compose de : (i) Directeur Départemental des Soins et Services de Santé, (ii) Directeur départemental de la Population ; (iii) Membres des Équipes Cadre de Districts Sanitaires (ECD) et (iv) Membres du bureau de la Fédération des comités de santé (FECOSA).

### **X.2.2.3. Le secrétariat technique départemental de suivi et évaluation du PNDS**

Le secrétariat technique départemental est un organe d'appui à la mise en œuvre du suivi et de l'évaluation. Il est assuré par le Directeur départemental de la santé assisté des Médecins chefs des districts sanitaires du département.

#### **X.2.2.3.1. Missions**

Le secrétariat technique départemental a pour missions de : (i) préparer les réunions du comité technique départemental de suivi et de l'évaluation, (ii) rédiger les rapports et procès-verbaux des réunions de suivi et évaluation, (iii) faciliter les évaluations du PNDS (à mi-parcours, annuelles et finales) et (iv) veiller à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation du PNDS en collaboration avec les autres parties prenantes au niveau du département.

#### **X.2.2.3.2. Composition**

Le secrétariat technique départemental se compose de : (i) Chef de service administratif et financier (SAF), (ii) Chef de service des actions sanitaires (SAS) , (iii) Chef de service des études et de la planification (SEP) , (iv) Chef de service de l'épidémiologie et des grandes endémies , (v) Gestionnaire des données , (vi) Représentant de la Direction départemental de la Population (DDPOP) et (vii) Représentant de l'inspection départementale de la santé et autres partenaires au niveau du département.

### **X.2.3. Cadre institutionnel au niveau périphérique**

Le cadre institutionnel au niveau périphérique est constitué par la coordination, le comité technique et le secrétariat technique du district sanitaire.

#### **X.2.3.1. La coordination du district sanitaire**

La coordination du district sanitaire est un organe de consultation et de prise de décision au niveau du district sanitaire. Elle est placée sous la coordination du Sous-Préfet du district/ Maire d'arrondissement ou de communauté urbaine.

##### **X.2.3.1.1. Missions**

La coordination du district sanitaire a pour missions de : (i) s'assurer du suivi de la mise en œuvre effective et de l'évaluation du PNDS 2023-2026, et (ii) coordonner la réalisation du suivi et de l'évaluation du PNDS 2023-2026 au niveau périphérique.

##### **X.2.3.1.2. Composition**

La coordination du suivi et de l'évaluation au niveau du district sanitaire est composée de : (i) Sous-Préfet du district/ Maire d'arrondissement ou de la communauté urbaine, (ii) membres des équipes cadres des districts sanitaires, (iii) membres du bureau du comité de Gestion du district sanitaire et les membre du bureau de gestion de l'hôpital de district, (iv) membres de l'équipe de gestion et (v) les membres du bureau de la fédération des comités de santé du district et (vi) membres du bureau du comité de santé.

#### **X.2.3.2. Le comité technique du district sanitaire**

Le comité technique du district sanitaire est un organe en charge de suivi et de l'évaluation. Il est placé sous la présidence du médecin chef du district sanitaire.

##### **X.2.3.2.1. Missions**

Le comité technique du district sanitaire a pour missions de : (i) veiller à la mise en œuvre du suivi et de l'évaluation, et (ii) transmettre à la direction départementale leurs rapports de suivi et d'évaluation

#### **X.2.3.2.2. Composition**

Le comité technique du district sanitaire se compose de : (i) Médecin chef du district sanitaire, (ii) Membres des Équipes Cadre de Districts Sanitaires (ECD) et (iii) Membres du bureau de la Fédération des comités de santé (FECOSA).

#### **X.2.3.3. Le secrétariat technique du district sanitaire**

Le secrétariat technique du district sanitaire est un organe d'appui à la mise en œuvre des activités de suivi et d'évaluation. Il est assuré par les membres de l'équipe cadre du district sanitaire.

##### **X.2.3.3.1. Missions**

Le secrétariat technique du district sanitaire a pour missions de : (i) préparer les réunions de suivi et de l'évaluation du comité technique du district sanitaire, (ii) rédiger les rapports et procès-verbaux des réunions de suivi et de l'évaluation, (iii) faciliter les évaluations du PNDS (à mi-parcours, annuelles et finales) et (iv) veiller à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation du PNDS en collaboration avec les autres parties prenantes au niveau du district sanitaire.

##### **X.2.3.3.2. Composition**

L'équipe cadre du district sanitaire fait office du secrétariat technique du district sanitaire, laquelle équipe est consacrée par le décret n°2020-551 du 15 octobre 2020 portant attribution, organisation et fonctionnement des organes de gestion du district sanitaire.

#### **X.2.4. Rôle des principales institutions et parties prenantes**

##### **X.2.4.1. Rôle des responsables du niveau central**

Le ministre de la santé et de la population est responsable de la réalisation des objectifs du **PNDS 2023-2026**. Il valide le plan de suivi et évaluation tout en s'assurant de sa mise en œuvre. Le ministre de la santé et de la population est responsable de la mobilisation des financements internes et externes nécessaires au suivi et à l'évaluation dudit plan.

De par son rôle régulateur, le Ministre en charge de la santé affirme son leadership et coordonne toutes les interventions de suivi et évaluation.

##### **X.2.4.2. Rôle des responsables du niveau intermédiaire du Système de santé (DD et Médecins chefs des DS).**

Les Directeurs Départementaux, dans le cadre de leurs responsabilités sont chargés : (i) de coordonner l'élaboration du plan d'action annuel départemental et du district sanitaire et leur mise en œuvre, (ii) d'organiser quatre (04) réunions de monitoring regroupant les DS et (iii) produire les rapports périodiques d'exécution des plans.

Une réunion trimestrielle est organisée sous la présidence des Préfets pour faire le point sur la mise en œuvre du PNDS. Ces réunions sont sanctionnées par un rapport qui est transmis au Secrétariat technique permanent du PNDS.

##### **X.2.4.3. Rôle des autres parties prenantes**

Les Partenaires Techniques et Financiers au développement sont représentés au sein du Comité Technique de suivi du PNDS. Ils accompagnent les efforts du Gouvernement et fournissent l'appui nécessaire pour la mise en œuvre et la réalisation du suivi évaluation du PNDS.

### X.3. Mécanismes de contrôle, de suivi et d'évaluation

#### X.3.1. Contrôle de la mise en œuvre du PNDS

Dans un souci d'efficacité et de transparence du système de santé, le Ministère de la santé et de la population renforcera les mécanismes de contrôle et procédera à des contrôles et des inspections à tous les échelons de la pyramide sanitaire.

Ainsi, les procédures de gestion administrative, financière et comptable d'une part, les mécanismes de contrôle et d'audit d'autre part, seront diffusés pour être appliqués à tous les niveaux du système de santé. Ceci se fera par le renforcement des actions de l'Inspection Générale de la Santé en liaison avec l'Inspection Générale des Finances et l'inspection de l'Etat.

Le contrôle de la conformité des activités sera assuré principalement par l'Inspection Générale de la Santé qui est chargée de procéder à tout contrôle administratif, financier et sanitaire des établissements et services relevant du Ministère, et de veiller à la diffusion ainsi qu'à l'application de la législation, de la réglementation et des directives, de façon générale des normes en vigueur.

#### X.3.2. Suivi de la mise en œuvre du PNDS

Le Suivi ou Monitoring est un processus séquentiel et systématique de collecte et d'examen ou analyse des données, procédures et pratiques. Nécessite la détermination d'indicateurs pour chaque activité pendant le processus de planification. Il permet de répondre aux questions essentielles suivantes : Est-ce que les activités prévues progressent conformément au plan établi ? La manière dont les activités sont mises en œuvre permet-elle d'atteindre les objectifs ? Les ressources prévues sont-elles utilisées selon le plan ?

Le suivi de la mise en œuvre du PNDS s'appuiera sur les indicateurs et cibles définis au niveau des différents programmes. Cette rubrique est assortie d'un cadre des résultats (ou de mesure des performances) élaboré sur la base d'un nombre restreint d'indicateurs traceurs parmi ceux choisis pour apprécier les résultats escomptés de la mise en œuvre du PNDS.

#### X.3.3. Supervision

La supervision est un processus périodique qui vise à aider le personnel à améliorer sa prestation après, soit une évaluation par un superviseur externe, ou par les pairs, soit par l'auto-évaluation. Il consiste en une détection des déficiences de performances éventuelles, en un feedback (rétro-information), en une remédiation et des encouragements du personnel.

La supervision formative ou de soutien est un processus qui permet d'aider le personnel à améliorer sa prestation en impliquant un transfert de compétences, de connaissances, d'attitudes entre le *superviseur et l'agent supervisé*. Elle garantit des prestations de qualité.

Les supervisions seront renforcées à tous les niveaux de la pyramide sanitaire selon la périodicité définie dans cette rubrique. Celles-ci s'effectueront ainsi qu'il suit :

- le niveau central ou national supervise les équipes des directions départementales (soins et services de santé et population) ;
- les directions départementales à leur tour supervisent les équipes-cadres de districts sanitaires ;
- les équipes cadre de district (ECD) réalisent les supervisions des agents des équipes de santé des services de santé de premier échelon (centre de santé intégrés, centres médicaux sociaux des entreprises/sociétés, cabinets médicaux, cabinets de soins infirmiers, etc.) ;
- les équipes de santé des services de santé de premier échelon, supervisent les activités des relais communautaires dans les aires de santé.

En dehors de cette hiérarchisation, les visites conjointes de supervision avec les partenaires peuvent être réalisées dans les départements et districts sanitaires selon les besoins. Chaque visite de supervision est assortie d'un rapport de supervision contenant les domaines, les objectifs, les techniques utilisées, les écarts/problèmes identifiés, les suggestions et recommandations faites et qui font l'objet d'un plan de résolution.

#### **X.3.4. Revue**

Une revue est une activité de mise au point de l'état d'avancement d'une intervention, d'un projet, d'un programme ou d'une politique ». Elle a pour objectif de « redresser les écarts au protocole ou d'améliorer les points faibles » identifiés afin d'atteindre de manière optimale les objectifs fixés.

Des revues (semestrielles et annuelles) seront organisées à tous les niveaux de la pyramide pour servir de cadre de réflexion en vue de veiller à l'efficacité de la mise en œuvre du PNDS. Celles-ci sont précédées des activités de monitoring au niveau du district sanitaire.

Sur la base du PNDS 2023-2026, chaque structure du MSP, direction générale, centrales, programme ou projets élaborera un plan d'action annuel (PAO) ou plan de travail annuel (PTA). Celui-ci devrait bénéficier d'une revue semestrielle (*juin de chaque année*) du PNDS 2023-2026 et d'une revue annuelle (*fin novembre de chaque année*). Les rapports de ces évaluations serviront à l'élaboration des plans de travail annuels (PTA) suivants.

A l'issue de chaque revue, le Secrétariat Permanent du PNDS élaborera un rapport avec des recommandations précises qui doivent être traduites en actions dans les plans opérationnels et en assurera le suivi.

#### **X.3.5. Evaluation**

Une évaluation est un examen périodique de l'état d'une politique, d'un programme, ou d'un projet portant sur la performance, l'efficacité, et l'efficience. Elle comprend les quatre (4) principales étapes suivantes : Mesure (performance réalisée, résultats) ; Comparaison avec les indicateurs ; Analyse (jugement de valeur basé sur le seuil de satisfaction) et Décision.

Elle signifie la comparaison à une référence (gold standard), c'est-à-dire une mesure permettant de savoir si les résultats, les effets ou le(s) impact(s) attendus d'une intervention, d'un projet, d'un programme ou d'une politique sont atteints. **Elle se fait sur la base des indicateurs.**

Deux types d'évaluation de la mise en œuvre du PNDS sont prévues : une évaluation à mi-parcours (juin 2025) et une évaluation finale (2026)

##### **X.3.5.1. Évaluation à mi-parcours**

Une évaluation à mi-parcours du PNDS intervient à la fin du mois de juin 2025. Cette évaluation sera interne. Son objectif est de renforcer ou réorienter au besoin les orientations stratégiques. Elle porte à la fois sur les processus et les progrès réalisés (en termes d'amélioration des couvertures) vers les résultats d'impact attendus. L'évaluation à mi-parcours visera aussi bien l'appréciation du niveau d'atteinte des objectifs intermédiaires du PNDS que des aspects administratifs, financiers et techniques de mise en œuvre des plans d'action opérationnels.

##### **X.3.5.2. Évaluation finale**

Une évaluation finale du PNDS sera effectuée en juin 2026, selon l'esprit de l'évaluation conjointe, de préférence externe. Elle utilisera les données des différentes enquêtes nationales qui auront été réalisées telles que MICS, EDS, SERO PREVALENCE, SARA, ENCV, etc. Elle portera aussi sur les financements mobilisés annuellement et globalement par rapport aux montants prévus en utilisant les résultats de revue des dépenses publiques de santé ainsi que les Comptes de la Santé.

## X.4. Cadre conceptuel de suivi et évaluation du PNDS 2023-2026

Le cadre conceptuel de suivi et évaluation du PNDS 2023-2026 s'inspire de celui du PND 2022-2026. Il est structuré en cinq (05) grands domaines d'indicateurs à savoir : les intrants (ressources), les processus(activités), les extrants (produits), les effets (résultats) et l'impact (voir figure ci-dessous).



C'est un cadre fondamental d'un plan de suivi et évaluation qui permet de poser les questions adéquates pour prendre en compte les événements associés et déterminer ainsi les indicateurs correspondants. Il s'agit essentiellement des questions listées dans la matrice d'orientation de la gestion axée sur les résultats ci-après :

|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Qu'est ce qui est investi ou a été investi pour l'atteinte des objectifs fixés ou des résultats escomptés ?<br>« Indicateurs d'intrants ou de ressources » | Il s'agit de déterminer les intrants (ressources financières, humaines et matérielles) utilisés pour mettre en œuvre les activités du PNDS.                         |
| Qui est-ce qui a été fait ou réalisé ?<br>« Indicateurs de processus ou d'activités »                                                                      | Il s'agit de déterminer les activités mises en œuvre sur le terrain.                                                                                                |
| Qu'est ce qui a été produit ?<br>« Indicateurs d'extrants ou de produits »                                                                                 | Il s'agit de déterminer les résultats immédiats c'est-à-dire les produits et services issus de la mise en œuvre des activités.                                      |
| Quels sont les résultats à court et moyen termes ?<br>« indicateurs d'effets ou de résultats »                                                             | Il s'agit de déterminer les effets ou les changements résultant directement de l'utilisation des produits et services. Ces effets sont déterminés à la fin du PNDS. |
| Quels sont les résultats à long terme ?<br>« Indicateurs d'impact »                                                                                        | Il s'agit de déterminer l'impact positifs et négatifs, résultant directement ou indirectement, intentionnellement ou non, des interventions du PNDS.                |

## X.5. Indicateurs de suivi et d'évaluation

### X.5.1. Définition et caractéristiques de l'indicateur

Un indicateur est une variable quantitative ou qualitative qui permet : (i) d'observer les évolutions d'un phénomène, en le positionnant par rapport aux objectifs fixés ; (ii) de mesurer les changements produits par une intervention de développement par rapport à ce qui était prévu et ; (iii) d'apprécier la performance d'un programme de développement.

Un bon indicateur doit être « SMART », répondant à 5 critères : (i) **Spécifique** : cible clairement ce que l'on est supposé mesurer ; (ii) **Mesurable** (ou objectivement observable) : en termes de quantité et/ou qualité ; (iii) **Accessible** : qu'il est possible de mesurer avec des moyens et à un coût acceptable ; (iv) **Raisonné** : pertinent au projet et exploitable pour les besoins des utilisateurs ; (v) **Temporel** : valable dans le temps du projet.

### X.5.2. Indicateurs clés

Les indicateurs retenus pour le suivi et l'évaluation des actions du PNDS 2023-2026 sont répartis en deux grands groupes : (i) les indicateurs de suivi qui comprennent les indicateurs d'intrants, d'activités et de produits et (ii) les indicateurs d'évaluation qui sont les indicateurs d'effets et d'impact.

### X.5.3. Processus de sélection des indicateurs clés pour le suivi et l'évaluation

Les indicateurs clés retenus pour le suivi sont tirés du cadre logique du PNDS 2023-2026. Ces indicateurs clés ont été sélectionnés selon la théorie de changement spécifique à chaque programme dudit PNDS.

La théorie du changement du PNDS 2023-2026 prévoit que la République du Congo enregistrera des progrès réels d'ici 2026 en matière de santé, alignés sur les ODD avec l'appui des partenaires au développement.

## X.6. Cadre des résultats du PNDS 2023-2026

Le cadre des résultats du PNDS 2023-2026 est élaboré sur la base d'un nombre restreint d'indicateurs traceurs parmi ceux choisis pour apprécier les résultats escomptés de la mise en œuvre dudit plan. Ce cadre est présenté par programme et sous-programme, composantes retenues en fonction des orientations stratégiques et comprend : les résultats attendus du PNDS 2023-2026, les indicateurs pour chaque énoncé de résultat et les valeurs de référence de ces indicateurs ainsi que leur évolution dans le temps pendant la période couverte par ledit plan.



### X.6.1. Cadre des résultats du premier programme du PNDS 2023-2026

Le cadre de résultats du premier programme du PNDS 2023-2026 se présente comme suit :

| Programme n°1 : Renforcement de la gouvernance et du financement du secteur santé                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |             |            |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| Sous-programme 1.1 : Renforcement du cadre juridique, administratif et financier                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |             |            |             |             |
| Résultats attendus                                                                                                        | Indicateurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Evolution des indicateurs |             |            |             |             |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Base line                 | 2023        | 2024       | 2025        | 2026        |
| <b>Résultat attendu n°1 : La gouvernance des structures de santé est améliorée à tous les niveaux du système de santé</b> | ▪ Existence d'un texte juridique portant création et fonctionnement du comité technique de suivi de la mise en œuvre du PNDS                                                                                                                                                                                                              | Non                       | Non         | Actualisé  | Oui         | Oui         |
|                                                                                                                           | ▪ Existence d'un texte juridique portant création et fonctionnement du secrétariat technique de suivi du PNDS                                                                                                                                                                                                                             | Non                       | Non         | Elaboré    | Oui         | Oui         |
|                                                                                                                           | ▪ Existence des textes juridiques portant création et fonctionnement des organes de mise en œuvre du PNDS au niveau central : Conseil national de santé, Comité de pilotage                                                                                                                                                               | Non                       | Non         | Actualisé  | Oui         | Oui         |
|                                                                                                                           | ▪ Nombre d'organes de mise en œuvre du PNDS 2023-2026 rendus fonctionnels au niveau départemental : Conseil départemental de la santé (CDS = 12) ; Equipes cadres du DS (ECDS = 52) ; Equipe de gestion du DS (EGDS = 52) ; Comité de gestion de l'HRD (CGHRD = 34) ; Fédération des COSA (FD-CO-SA = 52) et Comité de santé (COSA : 384) | 5/12 (CDS)                | 5/12 (CDS)  | 3/12 (CDS) | 2/12 (CDS)  | 2/12 (CDS)  |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ECDS : 32/52              | ECDS: 34/52 | ECDS: 2/52 | ECDS : 8/52 | ECDS : 8/52 |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EGDS : 47/52              | EGDS: 49/52 | EGDS: 1/52 | EGDS : 1/52 | EGDS : 1/52 |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |             |            |             |             |

|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             |                  |                  |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             | CGHRD:<br>16/34  | CGHRD:<br>16/34  | CGHRD:<br>4/34   | CGHRD:<br>6/34   | CGHRD:<br>8/34   |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             | COSA:<br>258/384 | COSA:<br>295/384 | COSA :<br>30/384 | COSA :<br>30/384 | COSA :<br>29/384 |
|                                                                                                                                               | ▪ Existence des textes juridiques portant création et fonctionnement des comités départementaux de suivi du PNDS                                                            | Non              | Non              | Actualisé        | Oui              | Oui              |
| <b>Résultat attendu N°2 : Les organes de pilotage, de coordination et de partenariat à tous les niveaux sont fonctionnels.</b>                | ▪ Nombre de sessions de formation organisées en management pour les membres des organes de pilotage, de coordination et de partenariat (Au total : 3 sessions de formation) | DND              | DND              | 0                | 3                | 0                |
| <b>Résultat attendu N°3 : Le processus de planification stratégique et opérationnelle est amélioré à tous les niveaux du système de santé</b> | ▪ Disponibilité du référentiel de formation sur la GAR                                                                                                                      | Non              | Non              | Oui              | Oui              | Oui              |
|                                                                                                                                               | ▪ Nombre de sessions de formation organisées sur la planification, le suivi et l'évaluation à tous les niveaux du système de santé (Au total : 4 sessions de formation)     | 0                | 0                | 2                | 2                | 0                |
|                                                                                                                                               | ▪ % des structures de santé ayant des plans (opérationnels ou stratégiques) alignés au PNDS 2023-2026                                                                       | DND              | DND              | 50%              | 100%             | 100%             |
| <b>Résultat attendu n°4 : Les effectifs</b>                                                                                                   | ▪ Existence d'un plan de développement (recrutement et formation continue) des ressources humaines                                                                          | Non              | Non              | Elaboré          | Oui              | Oui              |

|                                                                                                        |                                                                                                     |                   |            |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>des Ressources Humaines en Santé en termes de quantité et en qualité sont équilibrés</b>            | ▪ Ratio médecin-population                                                                          | 0,9/10 000 (2022) | 0,9/10 000 | 1/ 10 000  | 1,2/10 000 | 1,5/10 000 |
|                                                                                                        | ▪ Ratio infirmier-population (IDE/ 1.000 hab)                                                       | 7,8/10 000 (2022) | 7,8/10 000 | 7,9/10 000 | 8/10 000   | 8/10 000   |
|                                                                                                        | ▪ Ratio sage-femme-population (SF/5.000 femmes en âge de procréer)                                  | 2,5/5 000 (2022)  | 2,5/5 000  | 2,7/5.000  | 2,9/5 000  | 3/5 000    |
|                                                                                                        | ▪ Densité médecin, sage-femme et infirmier pour 1000 habitants                                      | 0,87 (2022)       | 0,87       | 0,90       | 1          | 1,20       |
| <b>Résultat attendu n°5 : Le financement de la santé en termes de quantité et qualité est efficace</b> | ▪ Part du budget alloué au MSP par rapport au budget national                                       | 7%                | 7%         | 15%        | 15%        | 15%        |
|                                                                                                        | ▪ Taux de décaissement du budget de l'état pour l'ensemble des structures du MSP                    | DND               | DND        | 95%        | 95%        | 95%        |
|                                                                                                        | ▪ % des formations sanitaires ayant intégrées le FBP comme mode de financement                      | 0%                | 0%         | 25%        | 50%        | 75%        |
|                                                                                                        | ▪ %des FOSA ayant signé une convention avec la CAMU                                                 | 0%                | 0%         | 25%        | 50%        | 75%        |
|                                                                                                        | ▪ Part des ménages dans le financement de la santé                                                  | 52%               | 52%        | 30%        | 25%        | 20%        |
| <b>Résultat attendu n° 6 : Le système d'information sanitaire permettant la planification, le</b>      | ▪ Existence du rapport d'évaluation de l'applicabilité du plan stratégique de développement du SNIS | Non               | Non        | Elaboré    | Oui        | Oui        |
|                                                                                                        | ▪ %des FOSA publiques utilisant le DHIS2                                                            | DND               | DND        | 50%        | 60%        | 80%        |

|                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                          |                          |                                |                                |                                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|
| <b>suivi et l'évaluation est performant</b>                                                                                                                                                                                  | ▪ % des FOSA privées utilisant le DHIS2                                                                                                                                                  | DND                      | DND                            | 50%                            | 60%                            | 80%          |
| <b>Résultat attendu n° 7 : Le système de santé dispose d'une infrastructure informatique de communication supportant les principaux sous systèmes d'informations sanitaires digitalisés et interfacés les uns aux autres</b> | ▪ Nombre d'hôpitaux généraux publics digitalisés                                                                                                                                         | 2/10<br>(Ngoyo et Djiri) | 2/10<br>(Ngoyo et Djiri)       | 3/10                           | 3/10                           | 2/10         |
|                                                                                                                                                                                                                              | ▪ Nombre d'HRD digitalisés                                                                                                                                                               | 0/34                     | 0/34                           | 20/34                          | 10/34                          | 4/34         |
|                                                                                                                                                                                                                              | ▪ Pourcentage des CSI publics digitalisés                                                                                                                                                | 0%                       | 0%                             | 25%                            | 50%                            | 75%          |
| <b>Résultat attendu n° 8 : Régularité dans la réalisation des études, enquêtes et recherches</b>                                                                                                                             | ▪ Nbre d'enquêtes réalisées (EDS, MICS, ECOM, HHFA (ex SARA), carte sanitaire, comptes nationaux, annuaire statistique sanitaire, enquête SMART, enquête nationale couverture vaccinale) | 0                        | 2 HHFA et Comptes de la santé) | 3 (EDS, ECOM, Carte sanitaire) | 2 HHFA et Comptes de la santé) | 2(EDS, ECOM) |
| <b>Sous-programme 1.2 : Amélioration de la coordination et du partenariat du secteur de la santé</b>                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                          |                          |                                |                                |                                |              |
| <b>Résultat attendu N°9 : La coordination et le partenariat du secteur est renforcée</b>                                                                                                                                     | ▪ Nombre de réunions tenues sur le nombre de réunions planifiées par le CCIA                                                                                                             | 0                        | 0                              | 4                              | 4                              | 4            |
|                                                                                                                                                                                                                              | ▪ Nombre d'assemblées générales tenues sur le nombre d'assemblées générales planifiées par le CCN (au total : 4 assemblées générale par an à organiser)                                  | DND                      | 4                              | 4                              | 4                              | 4            |

### X.6.2. Cadre des résultats du deuxième programme du PNDS 2023-2026

Le cadre de résultats deuxième programme du PNDS 2023-2026 se présente comme suit :

| Programme n°2 : Promotion d'un meilleur état de santé et du bien-être de la population                                                         |                                                                                                                                                                                  |                           |      |          |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|----------|----------|----------|
| Sous-programme 2.1 : Amélioration de la gouvernance et du pilotage de la promotion de la santé                                                 |                                                                                                                                                                                  |                           |      |          |          |          |
| Résultat attendus                                                                                                                              | Indicateurs                                                                                                                                                                      | Evolution des indicateurs |      |          |          |          |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                  | Base line                 | 2023 | 2024     | 2025     | 2026     |
| <b>Résultat attendu n°1 : La gouvernance et le pilotage en promotion de la santé est renforcée</b>                                             | ▪ Existence d'une stratégie nationale de la promotion de la santé                                                                                                                | DND                       | Non  | Elaboré  | Oui      | Oui      |
|                                                                                                                                                | ▪ % des ECD disposant d'un personnel de santé formé sur la promotion de la santé                                                                                                 | DND                       | 50%  | 75%      | 95%      | 100%     |
| <b>Résultat attendu n°2 : Le cadre juridique et institutionnel relatif à la gestion de la santé environnementale est renforcé et harmonisé</b> | ▪ Existence du code de l'hygiène publique                                                                                                                                        | Non                       | Non  | Elaboré  | Oui      | Oui      |
|                                                                                                                                                | ▪ Existence du manuel des normes et des procédures de gestion de la santé environnementale                                                                                       | Non                       | Non  | Elaboré  | Oui      | Oui      |
| <b>Résultat attendu n°3 : Les services d'hygiène disposent de laboratoires l'analyses des eaux de boisson, des eaux usées et des aliments</b>  | ▪ Existence d'un laboratoire de l'hygiène publique                                                                                                                               | Non                       | Non  | Existant | Existant | Existant |
| <b>Résultat attendu n°4 : La qualité de l'offre en matière de promotion de la santé est améliorée</b>                                          | ▪ % de PTAB des 52 DS (208 au total en 3 ans) intégrant au moins une activité sur l'un ses éléments du Paquet centré sur les facteurs de risques des maladies non transmissibles | DND                       | DND  | 25%      | 50%      | 75%      |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |     |     |     |      |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|
|  | prioritaires dans la totalité de ses aires de santé : Tabagisme ; Alcoolisme ; Inactivité physique ; Alimentation malsaine (sucre, graisse et sel) ; Pollution de l'air ; Traumatisme en rapport avec les accidents de voies publiques ; Toxicomanie/ Consommation de drogue                                           |     |     |     |     |      |
|  | ▪ % de PTAB des 52 DS (208 au total en 3 ans) intégrant au moins une activité sur l'un des éléments du Paquet centré sur les maladies évitables par la vaccination prioritaire dans la totalité de ses aires de santé : Rougeole ; Cholera ; Poliomyélite ; Fièvre jaune ; Covid-19 ; Monkey pox.                      | DND | DND | 75% | 95% | 100% |
|  | ▪ % de PTAB des 52 DS (208 au total en 3 ans) intégrant au moins une activité sur l'un des éléments du Paquet centré sur les Maladies Tropicales Négligées (MTN) : Onchocercose ; Schistosomiase ; Trypanosomiase ; Lèpre ; Pian et Ulcère de Buruli                                                                   | DND | DND | 75% | 95% | 100% |
|  | ▪ % de PTAB des 52 DS intégrant au moins une activité sur l'un des éléments de la demande des soins et services spécifiques (208 au total en 3 ans) : Gratuité du paludisme et Usage de la MIILDA ; Fréquentation des services de Planification Familiale ; Vaccination des enfants de 0 à 11 mois ; PVVIH/Sida et TBC | DND | DND | 75% | 95% | 100% |

|                                                                                                                |                                                                                                                               |     |     |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                                                                | ▪% des FOSA disposant d'un incinérateur de Montfort par DS                                                                    | DND | DND | 80%                | 95%                | 100%               |
| <b>Sous-programme 2.2 : Amélioration du cadre et/ ou mode de vie des populations</b>                           |                                                                                                                               |     |     |                    |                    |                    |
| <b>Résultat attendu n°5 : L'implication de la communauté en matière de promotion de la santé est renforcée</b> | ▪ Existence de la stratégie nationale de communication pour la promotion de la santé                                          | Non | Non | Elaboré            | Oui                | Oui                |
|                                                                                                                | ▪ Nombre de DS ayant des RHS formées en techniques de communication pour la promotion de la santé                             | DND | DND | 10/52 DS           | 30/52 DS           | 12/52 DS           |
|                                                                                                                | ▪ Nombre des ECD et EGD formés sur l'auto-responsabilité et l'autodétermination des communautés dans la gestion de leur santé | DND | DND | 15/52<br>(ECD+EGD) | 20/52<br>(ECD+EGD) | 17/52<br>(ECD+EGD) |

### X.6.3. Cadre des résultats du troisième programme du PNDS 2023-2026

Le cadre de résultats du troisième programme du PNDS 2023-2026 se présente comme suit :

| Programme n°3 : Amélioration de l'accès équitable des populations aux paquets de soins et services essentiels de qualité                                                       |                                                                                                                        |                           |        |                     |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|---------------------|-----------------|-----------------|
| Sous-programme 3.1 : Renforcement de l'offre de soins et services de santé                                                                                                     |                                                                                                                        |                           |        |                     |                 |                 |
| Résultat attendus                                                                                                                                                              | Indicateurs                                                                                                            | Evolution des indicateurs |        |                     |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        | Base line                 | 2023   | 2024                | 2025            | 2026            |
| <b>Résultat attendu n°1 : La couverture du pays en DS ayant une équipe cadre de district et une équipe de gestion est améliorée</b>                                            | Nombre des équipes cadres de district (ECD) ayant des membres formés sur le développement d'un district sanitaire (DS) | DND                       | DND    | 10/52               | 30/52           | 12/52           |
|                                                                                                                                                                                | ▪ Nombre des EGD ayant une équipe de Gestion complète                                                                  | 27/47(2022)               | 27/47  | 5/47                | 10/47           | 5/47            |
|                                                                                                                                                                                | ▪ Nombre de DS ayant élaboré un pré plan de couverture découpage du district sanitaire en Aires de Santé               | DND                       | DND    | 15/52               | 25/52           | 12/52           |
|                                                                                                                                                                                | ▪ Nombre de centres de santé de prise en charge des personnes âgées construits et équipés                              | DND                       | DND    | 2                   | 2               | 2               |
| <b>Résultat attendu n°2 : La couverture sanitaire du pays en services de santé de premier échelon (SSPE) capables d'offrir le paquet des services essentiels est améliorée</b> | ▪ Nombre de CSI réhabilités et équipés dans les 52 DS (Au total : 150 CSI à réhabiliter)                               | 68/150(2022)              | 68/150 | 2/150               | 70/150          | 10/150          |
|                                                                                                                                                                                | ▪ % des CSI rationalisés                                                                                               | DND                       | DND    | 4%<br>(24 CSI /OMS) | 14%<br>(48 CSI) | 21%<br>(72 CSI) |
|                                                                                                                                                                                | ▪ Existence d'un document de nomenclature des actes et de leur tarification                                            | Non                       | Non    | Non                 | Elaboré         | oui             |



|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |     |      |         |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------|-------|-------|
| <b>Résultat attendu n°3 :<br/>La couverture<br/>sanitaire du pays en<br/>hôpitaux de district<br/>capables d'offrir des<br/>soins d'urgences 24<br/>h/24 est améliorée</b>                                       | ▪ Existence d'un guide national de référence et contre<br>référence                                                                                                                                                               | Non | Non  | Elaboré | Oui   | Oui   |
|                                                                                                                                                                                                                  | ▪ Nombre d'hôpitaux de référence ayant bénéficié de la<br>réhabilitation de leurs maternités (34 hôpitaux)                                                                                                                        | DND | 0/34 | 15/34   | 12/34 | 7/34  |
|                                                                                                                                                                                                                  | ▪ Nombre d'hôpitaux de district équipés en matériel d'imagerie<br>médicale (Au total : 12 hôpitaux de district à équiper)                                                                                                         | DND | DND  | 5 HRD   | 4 HRD | 3 HRD |
|                                                                                                                                                                                                                  | ▪ Nombre d'hôpitaux de référence ayant intégré l'usage des<br>trois types d'outils : schémas thérapeutiques standardisés,<br>partogrammes et outils d'auto-évaluation des soins<br>obstétricaux néonataux d'urgence (34 Hôpitaux) | DND | DND  | 0       | 34/34 | 0     |
| <b>Résultat attendu n°4 :<br/>La couverture<br/>sanitaire du pays en<br/>établissements<br/>capables d'offrir les<br/>soins de spécialités<br/>essentiels de qualité<br/>et à moindre coût est<br/>améliorée</b> | ▪ Nombre d'hôpitaux généraux départementaux dotés d'un<br>équipement répondant aux normes (Au total : 8 hôpitaux<br>généraux à équiper)                                                                                           | DND | 2    | 2       | 2     | 2     |
|                                                                                                                                                                                                                  | ▪ Nombre d'unités d'hémodialyse fonctionnelles (1 unité au<br>CHU de Brazzaville et une autre à l'Hôpital Général Adolphe<br>Sicé de Pointe-Noire (Au total : 2 unités d'hémodialyse)                                             | 0   | 0    | 2       | 0     | 0     |
|                                                                                                                                                                                                                  | ▪ Nombre d'hôpitaux généraux dont les services des urgences<br>ont été modernisés (6 hôpitaux : CHU-B, Dolisie, 31 juillet<br>Owando, Adolphe Sicé, Loandjili et Blanche Gomes (Total : 6<br>hôpitaux généraux)                   | 0   | 0    | 2       | 2     | 2     |
|                                                                                                                                                                                                                  | ▪ Nombre d'hôpitaux généraux dotés en équipements<br>répondant aux normes de prise en charge des urgences<br>médico-chirurgicales pédiatriques et obstétricales (6 hôpitaux :                                                     | 0   | 0    | 2       | 2     | 2     |

|                                                                                                                                                               |                                                                                                     |     |     |            |     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------|-----|-----|
|                                                                                                                                                               | CHU-B, Dolisie, 31 juillet Owando, Adolphe Sicé, Loandjili et Blanche Gomes)                        |     |     |            |     |     |
|                                                                                                                                                               | ▪ Disponibilité des équipements de biologie moléculaire de dépistage anténatale de la drépanocytose | 0   | 0   | Disponible | Oui | Oui |
|                                                                                                                                                               | ▪ Disponibilité des équipements d'hémoglobinoase (Capillarys, HPLC/Biorad)                          | 0   | 0   | Disponible | Oui | Oui |
| <b>Résultat attendu n°5 :<br/>L'accès aux médicaments, produits sanguins labiles, vaccins et technologies dans les structures de dispensation est garanti</b> | ▪ Existence de la politique nationale des médicaments révisée                                       | Non | Non | Actualisée | Oui | Oui |
|                                                                                                                                                               | ▪ Existence d'un décret portant création de l'Autorité Nationale de Régulation des Médicaments      | Non | Non | Oui        | Oui | Oui |
|                                                                                                                                                               | ▪ Existence d'un décret portant création du laboratoire de contrôle de la qualité des médicaments   | Non | Non | Oui        | Oui | Oui |
|                                                                                                                                                               | ▪ Existence de la stratégie de lutte contre la résistance aux antibiotiques                         | Non | Non | Elaborée   | Oui | Oui |
|                                                                                                                                                               | ▪ Existence de la liste nationale des médicaments essentiels et génériques (LNMEG) actualisée       | Non | Non | Actualisée | Oui | Oui |
|                                                                                                                                                               | ▪ Taux de satisfaction des commandes des FOSA par la CAMEPS                                         | DND | DND | 50%        | 75% | 95% |
|                                                                                                                                                               | Nombre des FOSA ayant mis en place la pharmacie à usage interne (Au total : 71 FOSA)                | DND | DND | 10         | 40  | 21  |

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |     |      |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                        | Nombre des FOSA ayant mis en place des chariots d'urgence contenant des médicaments de première nécessité dans leurs services d'urgences (Au total : 50 FOSA) | DND | DND  | 10                | 30                | 10                |
|                                                                                                                                                        | ▪ Taux de satisfaction des besoins en produits sanguins sécurisés par les FOSA par département                                                                | DND | DND  | 50%               | 75%               | 95%               |
|                                                                                                                                                        | ▪ Nombre de jours de rupture de chaque antigène dans les dépôts départementaux du PEV                                                                         | DND | DND  | Moins de 15 jours | Moins de 15 jours | Moins de 10 jours |
| <b>Résultat attendu n°6 : l'offre des analyses biomédicales est améliorée dans le pays</b>                                                             | ▪ % de laboratoires périphériques disposant des équipements adéquats (104 à raisons de 2 par DS)                                                              | DND | DND  | 20%               | 50%               | 75%               |
| <b>Sous-programme 3.2 : Amélioration de l'accès financier aux soins et services de santé des populations</b>                                           |                                                                                                                                                               |     |      |                   |                   |                   |
| <b>Résultat attendu n°7 : La couverture des soins de santé des populations par l'assurance maladie universelle est améliorée à l'échelle nationale</b> | ▪ Taux de couverture de la population par l'assurance maladie universelle                                                                                     | DND | DND  | 0,1 %             | 1%                | 2 %               |
|                                                                                                                                                        | ▪ Taux d'utilisation des documents normatifs sur les actes de soins de santé (Conduites Thérapeutiques Recommandées)                                          | 0%  | 0%   | 15%               | 40%               | 65%               |
|                                                                                                                                                        | ▪ Nombre de structures de santé conventionnées par la CAMU                                                                                                    | 0   | 54   | 108               | 200               | 225               |
|                                                                                                                                                        | ▪ Nombre des structures de santé digitalisées dans le cadre du fonctionnement de la CAMU                                                                      | 0   | 54   | 108               | 200               | 225               |
|                                                                                                                                                        | ▪ % des structures de santé formées à la production du panier de soins de la CAMU et à la gestion des assurés                                                 | 0%  | 50 % | 70 %              | 80 %              | 90 %              |
| <b>Sous-programme 3.3 : Renforcement des programmes de santé de la mère, de l'enfant, des jeunes et des adolescents</b>                                |                                                                                                                                                               |     |      |                   |                   |                   |

|                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |               |        |           |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------|
| <b>Résultat attendu n°8 :<br/>La couverture du pays en FOSA offrant des soins et services de la reproduction de qualité est améliorée</b>  | ▪ Existence d'un plan de repositionnement de la planification familiale (PF) actualisé et validé                                              | Non           | Non    | Actualisé | Oui     | Oui     |
|                                                                                                                                            | ▪ % de FOSA de premier échelon offrant toutes les méthodes contraceptives modernes                                                            | 62,3% (2022)  | 62,3%  | 75%       | 90%     | 100%    |
|                                                                                                                                            | ▪ Taux d'utilisation de la contraception moderne                                                                                              | 2,2 % (2021)  | DND    | 10%       | 15%     | 20%     |
|                                                                                                                                            | ▪ Proportion des femmes enceintes ayant bénéficié de la troisième dose de traitement préventif intermittent (TPI 3)                           | 27%           | 27%    | 65%       | 80%     | 95%     |
|                                                                                                                                            | ▪ Ratio de décès maternels pour 100.000 NV                                                                                                    | 414 (2022)    | 304    | 194       | 94      | <70     |
|                                                                                                                                            | ▪ Taux de mortalité néonatale pour 1 000 NV                                                                                                   | 27,2‰ (2022)  | 20,2‰  | 13,7‰     | 7,2 ‰   | <7,2 ‰  |
|                                                                                                                                            | ▪ Taux de mortalité infanto-juvénile pour 1 000 NV                                                                                            | 58,7 ‰ (2022) | 40,4 ‰ | 35,13 ‰   | 29,86 ‰ | 24,59 ‰ |
|                                                                                                                                            | ▪ % de FOSA publiques et privées de 1er échelon par DS offrant la prise en charge intégrée des maladies du nouveau-né et de l'enfant (PCIMNE) | 38,8% (2020)  | DND    | 45%       | 50%     | 60%     |
| <b>Résultat attendu n°9 :<br/>La couverture en FOSA offrant les soins et services de santé des adolescents et les jeunes est améliorée</b> | ▪ Taux de couverture vaccinale DTC-HepB-Hib3 et Rougeole-Rubéole (RR1)                                                                        | 78% (2022)    | 83%    | 85%       | 88%     | 95%     |
|                                                                                                                                            | ▪ Existence de la stratégie nationale de vaccination                                                                                          | Non           | Non    | Elaboré   | Oui     | Oui     |
|                                                                                                                                            | ▪ % de FOSA qui disposent d'une unité de prise en charge de la malnutrition dotés en équipements et intrants                                  | DND           | DND    | 30%       | 50%     | 75%     |

|  |                                                                                                 |                              |         |         |         |         |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|---------|---------|---------|
|  | Existence d'une stratégie nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle                   | Non                          | Non     | Elaboré | Oui     | Oui     |
|  | Prévalence de la malnutrition aigüe chez les enfants de 0-59 mois                               | 5,3%<br>(enquête SMART 2022) | 5,3%    | 3%      | 2%      | 1%      |
|  | ▪ Existence de la stratégie nationale en santé scolaire et universitaire validée                | Non                          | Non     | Validée | Oui     | Oui     |
|  | ▪ Nombre de centres de santé scolaire et universitaire aménagés et équipés (12 au total)        | DND                          | DND     | 3       | 5       | 4       |
|  | ▪ Taux de grossesse chez les adolescentes de 10 à 14 ans et de 15 à 19 ans pour 1 000 habitants | 22,66 ‰<br>(2022)            | 20,24 ‰ | 17,82 ‰ | 15 ,4 ‰ | 12,98 ‰ |

#### X.6.4. Cadre des résultats du quatrième programme du PNDS 2023-2026

Le cadre de résultats du programme n°4 du PNDS 2023-2026 se présente comme suit :

| Programme n°4 : Renforcement de la sécurité sanitaire, gestion des épidémies et autres situations d'urgence                          |                                                                                                                   |                           |      |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|-------|-------|-------|
| Sous-programme 4.1 : Gestion des épidémies selon le Règlement Sanitaire International (RSI)                                          |                                                                                                                   |                           |      |       |       |       |
| Résultat attendus                                                                                                                    | Indicateurs                                                                                                       | Evolution des indicateurs |      |       |       |       |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                   | Base line                 | 2023 | 2024  | 2025  | 2026  |
| <b>Résultat attendu n°1 : Les capacités du pays en matière d'alerte rapide des épidémies sont renforcées</b>                         | ▪ Nombre d'antennes de COUSP départementaux mises en place                                                        | 0                         | 0    | 2     | 5     | 4     |
|                                                                                                                                      | ▪ Nombre des ECD formées sur la mise en œuvre des dispositions du RSI (détection, prévention et riposte)          | DND                       | DND  | 10/34 | 20/34 | 4/34  |
|                                                                                                                                      | ▪ Nombre de DS dans lesquels la préparation aux épidémies est effectuée selon le RSI                              | DND                       | DND  | 10/52 | 20/52 | 22/52 |
| Sous-programme 4.2 : Gestion des catastrophes et autres événements de santé en fonction des dispositions du RSI                      |                                                                                                                   |                           |      |       |       |       |
| <b>Résultat attendu n°2 : Les capacités de gestion des catastrophes et autres risques sanitaires sont nationales sont améliorées</b> | ▪ Nombre d'hôpitaux généraux ayant élaborés des plans blancs                                                      | DND                       | DND  | 4/10  | 4/10  | 2/10  |
|                                                                                                                                      | ▪ Nombre des Equipes Cadre de DS ayant à leur sein des membres formées à la gestion des épidémies et catastrophes | DND                       | DND  | 10/34 | 20/34 | 4/34  |
|                                                                                                                                      | ▪ % de points d'entrée capables de détecter les signes des épidémies courantes du pays                            | DND                       | DND  | 50%   | 70%   | 90%   |
| <b>Résultat attendu n° 3 : La cartographie des</b>                                                                                   | ▪ Nombre de DS disposant de la cartographie de risques, y compris les scénarii de riposte                         | 0                         | 0    | 13/52 | 26/52 | 13/52 |

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |     |       |       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|-------|-------|
| <b>risques environnementaux pour la santé est disponible</b>                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nombre de plans multi risques et spécifiques en rapport avec la cartographie des risques réalisée dans le pays</li> </ul>                                                                                              | 0   | 0   | 4     | 4     | 4     |
| <b>Résultat attendu n°4 : La population est informée et sensibilisée sur la prévention des risques environnementaux</b>                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nombre de DS ayant mis en place le Système d'Alerte et d'Informations aux Populations</li> </ul>                                                                                                                       | DND | DND | 10/52 | 42/52 | 0/52  |
|                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nombre de DS ayant réalisé au moins une campagne de proximité organisées sur la prévention des risques environnementaux dans l'année</li> </ul>                                                                        | 0   | 0   | 26/52 | 10/52 | 16/52 |
| <b>Résultat attendu n°5 : Un système de surveillance de la contamination des aliments fondé sur des sites sentinelles et d'un réseau des laboratoires performants est mis en place</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nombre de sites sentinelles de surveillance de la contamination des aliments rendus opérationnels (9 sites au total : Brazzaville, Pointe Noire, Dolisie, Nkayi, Mossendjo, Gamboma, Oyo, Pokola et Ouesso)</li> </ul> | 0   | 0   | 3     | 3     | 3     |
|                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nombre de sites sentinelles de surveillance de la contamination des aliments ayant été dotés en kits de travail (9 sites au total)</li> </ul>                                                                          | 0   | 0   | 3     | 3     | 3     |

## **X.7. Source des données**

Différentes sources d'informations alimenteront la matrice de suivi et d'évaluation. Les principales sources de données pour le calcul des principaux indicateurs sont les suivantes :

### **X.7.1. Données de routine**

Les données de routine sont des données collectées au niveau des structures sanitaires et au niveau communautaire à travers des supports de collecte (registres de consultations curatives, registres d'hospitalisation, fiches de consultations prénatales, rapports mensuels d'activités des relais communautaires, ...).

Les informations sur l'enregistrement continu des naissances et des décès sont fournies par les services d'Etat Civil.

### **X.7.2. Données d'enquêtes et d'études**

D'autres sources alimenteront la matrice des données de suivi et évaluation du PNDS, particulièrement pour ce qui est des indicateurs d'effets et d'impact. Il s'agit entre autres des :

- enquêtes telles que l'enquête démographique de santé (EDS), l'enquête à indicateurs multiples (MICS), l'enquête HHFA (ex. SARA), l'enquête nutritionnelle nationale et autres ;
- comptes de la santé ;
- annuaires des statistiques sanitaires.

## **X.8. Gestion des données**

La gestion de données concerne la collecte, le stockage, le traitement et l'analyse de données. Elle sera renforcée aux différents échelons de la pyramide sanitaire afin d'améliorer la disponibilité et la qualité des données alimentant la matrice de suivi et évaluation du PNDS.

### **X.8.1. Collecte des données**

La collecte des données se fera de deux manières dans le pays : (i) la collecte de routine et (ii) la collecte par enquêtes et études.

#### **X.8.1.1. Collecte de routine**

La collecte des données de routine consiste à collecter de façon quotidienne les données au niveau communautaire, des CSI et des HRD. Les HG n'utilisent pas encore les outils standardisés. Les outils de collecte actuellement utilisés appellent actualisation et standardisation à un certain niveau. Aussi, l'utilisation du DHIS-2 doit être étendu à tous les niveaux de la pyramide sanitaire.

#### **X.8.1.2. Collecte des données par enquête et étude**

La collecte des données par enquêtes et études consiste à collecter des données de manière périodique conjointement pour certaines avec les autres parties prenantes afin d'alimenter et renforcer le système de suivi et évaluation. Des études et des enquêtes seront menées afin d'alimenter et renforcer le système de suivi et évaluation. Ces études et enquêtes permettent d'évaluer le niveau d'atteinte des objectifs des stratégies et interventions pendant la période de mise en œuvre du PNDS 2023-2026.

### **X.8.2. Base de données**

Afin de disposer d'une base de données pour la gestion des informations, le Ministère de la santé a expérimenté le logiciel de gestion de l'information sanitaire « DHIS2 ». L'objectif visé à travers l'utilisation du DHIS2 est de permettre aux décideurs d'avoir la bonne information sanitaire en temps réel, sur les indicateurs de santé suivis, les risques d'épidémie et le fonctionnement global



du système sanitaire. Le déploiement du logiciel dans l'ensemble des districts sanitaires (processus en cours) va permettre de gérer efficacement les données et informations à tous les niveaux du système de santé.

### **X.8.3. Traitement des données**

Le traitement des données se fait à tous les niveaux de la pyramide sanitaire

#### **X.8.3.1. Mécanisme de contrôle de la qualité des données**

La qualité des données est un critère important dans l'appréciation des performances d'un programme. Le dispositif de contrôle de la qualité de données constitue de ce fait un cadre judicieux pour juger de la fiabilité des données en accord avec un ensemble standard d'approches, de techniques de collecte et de rapportage des données.

Pour assurer le contrôle de la qualité des données, les procédures et actions suivantes sont entreprises : (i) les personnes chargées de la collecte des données sont formées à l'utilisation des différents outils mis à leur disposition, ce qui leur permet de collecter des données fiables et exactes ; (ii) les registres, les fiches de collecte des données et autres outils standardisés sont distribués à tous les points de collecte des données ; (iii) un logiciel de gestion de toutes les données est mis en place ; (iv) les supervisions formatives sont instaurées à tous les niveaux et incluent la triangulation des données avec leurs sources pour déceler et corriger les éventuelles erreurs ; (v) un audit annuel de la qualité des données est instauré et (vi) un protocole de correction des erreurs et des données manquantes sera élaboré et appliqué par tous les acteurs qualifiés.

#### **X.8.4. Analyse des données**

L'analyse et la synthèse des données seront une composante essentielle du suivi et évaluation du PNDS 2023-2026. Cette analyse se fera par les unités de suivi et évaluation du PNDS des différents niveaux de la pyramide sanitaire.

Au niveau du district, l'unité de suivi et évaluation saisit les données transmises par les structures sanitaires du district à partir du logiciel DHIS2, les traite et produit les tableaux de bord des indicateurs traceurs du PNDS puis élabore un rapport trimestriel de progrès du district ;

Au niveau départemental, l'unité de suivi et évaluation consolide les données des tableaux de bord des indicateurs traceurs du PNDS transmises par les districts sanitaires, les traite, les analyse et élabore un rapport trimestriel de progrès du département ;

Au niveau central, cette analyse est faite par l'unité de suivi et évaluation (rôle joué par le Secrétariat technique Permanent du PNDS) consolide les données des tableaux de bord envoyés par les départements. Cette analyse portera essentiellement sur la cohérence des données transmises par les départements et sur les données nationales consolidées à partir du logiciel DHIS2.

### **X.9. Rétro information**

La rétro information est indispensable pour l'amélioration de la performance des acteurs à différents niveaux. Elle permet d'améliorer la qualité des données. Chaque structure qui envoie un rapport reçoit une rétro information (feedback) systématique. Ces informations concernent (i) la confirmation de l'arrivée du rapport, (ii) la qualité des données reçues (écriture, manquants, cohérence et exactitude des données), (iii) le commentaire sur l'analyse et l'interprétation des informations reçues, (iv) un ou plusieurs tableaux récapitulatifs des données d'une ou plusieurs structures en vue de la comparaison des performances. La généralisation de l'outil DHIS2 améliorera le mécanisme de rétro information.

## CONCLUSION

Le présent Plan National de Développement Sanitaire (PNDS 2023-2026), élaboré selon l'approche participative et inclusive est le cadre stratégique de mise en œuvre du PND 2022-2026. Il vise à mettre en place un système de santé amélioré et plus résilient, susceptible de promouvoir la santé, de prévenir la maladie et de la prendre en charge, et d'assurer la sécurité sanitaire. En effet, les objectifs cibles du PNDS 2023-2026 sont voulus cohérents avec les Objectifs de Développement Durable, la couverture sanitaire universelle et l'objectif du triple milliard décidé à la 13ème assemblée générale de l'OMS.

Le financement des lignes d'action retenues dans le présent plan exige un engagement politique, l'adhésion des partenaires, l'implication de la société civile (associations, ONG) et les ordres professionnels ainsi que les sociétés savantes afin que les résultats escomptés soient atteints.

## REFERENCES

|    |                                                                                                                                                                                           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Projet de société de SEM <b>Denis SASSOU N'GUESSO</b> , Président de la République du Congo, Chef de l'Etat « <b>Ensemble poursuivons la marche</b> »                                     |
| 2  | Ministère du plan, de la statistique et de l'intégration régionale du Congo : plan national de développement 2022-2026                                                                    |
| 3  | Ministère du plan, de la statistique et de l'intégration régionale du Congo : Rapport sur la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable (ODD), Mai 2018                         |
| 4  | Ministère de la santé et de la population du Congo, Programme Elargi de Vaccination : Plan Pluri Annuel Complet 2018-2022                                                                 |
| 3  | Ministère de la santé et de la population du Congo, Programme Biennal de Développement Sanitaire : Document de mise en œuvre du PND 2012-2016 dans le secteur de la santé, septembre 2014 |
| 5  | Ministère de la santé et de la population du Congo : Plan stratégique multisectoriel de lutte antitabac au Congo 2018- 2022, avril 2018                                                   |
| 6  | Ministère de la santé et de la population du Congo, Centre De Traitement Ambulatoire de Brazzaville : Rapport d'Activités 2017                                                            |
| 7  | Ministère de la santé et de la population du Congo : Rapport technique sur l'Analyse rapide du système d'information lié à la mise en œuvre de la SIMR au Congo, Mai 2018                 |
| 8  | Ministère de la santé et de la population du Congo : Comptes de la santé 2019- 2020                                                                                                       |
| 9  | Ministère de la santé et de la population du Congo : plan stratégique national de lutte contre la tuberculose 2023-2027                                                                   |
| 10 | Ministère de la santé et de la population du Congo : plan stratégique national de lutte contre le paludisme 2023-2027                                                                     |
| 11 | Ministère de la santé et de la population du Congo : plan stratégique national de lutte contre le VIH/Sida 2023-2027                                                                      |
| 12 | Ministère de la santé et de la population du Congo : plan stratégique national de lutte contre le cancer 2022-2026                                                                        |
| 13 | Ministère de la santé et de la population du Congo : Rapport de la Revue du secteur de la santé au CONGO, juin 2018                                                                       |
| 14 | Ministère de la santé et de la population du Congo, Politique nationale de la santé du CONGO 2018-2023                                                                                    |
| 15 | Ministère de la santé et de la population du Congo : Carte sanitaire nationale du CONGO, édition 2015                                                                                     |
| 16 | Ministère de la santé et de la population du Congo : Découpage des districts sanitaires, mai 2017                                                                                         |

|    |                                                                                                                                                                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | République du Congo : Revue de la gestion des dépenses publiques et de la responsabilité financière (PEMFAR) (banque mondiale, Congo, 2015)                                                                          |
| 18 | Ministère de la santé et de la population : plan stratégique intégré de la santé de la reproduction maternelle, néonatale, infantile, des adolescents et la nutrition du Congo (psi SRMNIA) 2022-2026                |
| 19 | Ministère de la santé et de la population du Congo : Annuaire statistiques sanitaires 2015 -2016 et 2017-2018                                                                                                        |
| 20 | Ministère du plan, de la statistique et de l'intégration régionale : RGPH- 5 en 2023                                                                                                                                 |
| 21 | Ministère du plan, de la statistique et de l'intégration régionale du Congo, Enquête par grappes à indicateurs multiples MICS 2014- 2015                                                                             |
| 22 | Enquêtes Démographiques et de Santé (EDSI et EDS II)                                                                                                                                                                 |
| 23 | Ministère de la santé et de la population du Congo : Analyse du coût, du financement et de la Mise en place du panier de soins de l'Assurance Maladie Universelle en République du Congo (banque mondiale), mai 2017 |
| 24 | Ministère de la santé et de la population du Congo, : Rapport de la revue finale de la feuille de route pour accélérer la réduction de la mortalité maternelle néonatale et infantile 2008- 2015                     |
| 25 | SITAN- Unicef 2017                                                                                                                                                                                                   |
| 26 | Cadre de planification et de budgétisation du 13 <sup>ème</sup> PGT(OMS), 2018                                                                                                                                       |
| 27 | Ministère de la santé et de la population du Congo : Rapport des assises d'Ewo, décembre 2016                                                                                                                        |
| 28 | Ministère de la santé et de la population du Congo : Rapport de l'atelier de validation du plan annuel 2018 et de l'évaluation annuelle du programme élargi de vaccination, février 2018.                            |